

terapia familiar

ESTRUCTURA, PATOLOGIA
Y TERAPEUTICA
DEL GRUPO FAMILIAR

2

ALFREDO A. CANEVARO

Un modelo de ficha clínica familiar

AURORA PEREZ T.

El niño, la familia, el pediatra

OCTAVIO FERNANDEZ MOUJAN Y

CRISTINA RAVAZZOLA DE MAZIERES

Grupo de padres

JUAN A. YARIA

Análisis de un caso clínico: el triángulo roto

IVAN BOSZORMENYI-NAGY

Visión dialéctica de la terapia familiar intergeneracional

JOSEF DUSS-VON WERDT, HELM STIERLIN y

ROSMARIE WELTER-ENDERLIN

Enseñanza y aprendizaje de la terapia de familia

E. F. THEBAUD

Hijos y padres en un mundo cambiante

Referencias africanas

DAVID RUBINSTEIN

Aspectos ecológicos en la psicoterapia de la esquizofrenia

Un desafío para el terapeuta

J. C. NOCETTI, O. FERNANDEZ MOUJAN Y A. CANEVARO

Ateneo Clínico

terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica
del grupo familiar

Año 1 - N° 2 - Diciembre de 1978

Director

Dr. Alfredo A. Canevaro

Comité de Redacción

Lic. Stella Maris Molina
Dr. Rafael Skiadaressis

Consejo de Redacción

Jorge García Badaracco (Buenos Aires)
Isidoro Berenstein (Buenos Aires - Tel Aviv)
Juan C. Nocetti (Buenos Aires)
Iván Boszormenyi-Nagy (Filadelfia)
Alberto Serrano (Buenos Aires - San Antonio, Texas)
Jacques Rudrauf (París)
Helm Stierlin (Heidelberg)
Maurizio Andolfi (Roma)
Richard Sauber (Massachusetts)
Robin Skynner (Londres)
Mara Selvini Palazzoli (Milán)
Raymundo Macías (México)
Guillermo Vidal (Buenos Aires)
Reynaldo Perro (Rosario, Argentina - St. Etienne, Francia)
David Rubinstein (Filadelfia)
Donald Bloch (Nueva York)

Director Administrativo

Alberto Cattán

Asesor Editorial

Alfredo Carlino

Cuidado de la edición

Nilda Finetti

Diseño de tapa

Douglas Wright

TERAPIA FAMILIAR es una publicación cuatrimestral de Editorial ACE S.R.L. (ef), Gorostiaga 1731, Bs. Aires, Argentina. Acogida a la protección de las Convenciones Internacional y Panamericana sobre derechos de autor. Nombre de la Revista registrado como marca. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 1382769.

Compuesto y armado en *Linotipia Pontalti*, Fraga 49/53, e impreso en los Talleres Gráficos *Garamond S.C.A.*, Cabrera 3856, Capital Federal en diciembre de 1978

Tarifa reducida 3053 - Franqueo pagado 339
Número del Registro Internacional
de Publicaciones Científicas ISSN 025-5905

Indice

Editorial	7
ALFREDO A. CANEVARO	
Un modelo de ficha clínica familiar	11
AURORA PEREZ T.	
El niño, la familia, el pediatra	28
OCTAVIO FERNANDEZ MOUJAN	
CRISTINA RAVAZZOLA DE MAZIERES	
Grupo de padres	44
JUAN ALBERTO YARIA	
Análisis de un caso clínico: El triángulo roto	77

IVAN BOSZORMENYI-NAGY

Visión dialéctica de la terapia familiar intergeneracional 90

E. F. THEBAUD

Hijos y padres en un mundo cambiante. (Referencias africanas) 111

DAVID RUBINSTEIN

Aspectos ecológicos de la psicoterapia de la esquizofrenia.
Un desafío para el terapeuta 123

JOSEF DUSS-VON WERDT

HELM STIERLIN

ROSMARIE WELTER-ENDERLIN

Enseñanza y aprendizaje de la terapia de familia 146

JUAN CARLOS NOCETTI

OCTAVIO FERNANDEZ MOUJAN

ALFREDO A. CANEVARO

Ateneo clínico 168

Libros 197

Congresos 218

Editorial

Si recurrimos al origen arcaico de la palabra epistemología (teoría del conocimiento del saber científico) veremos que nos lleva a: epístemai (alrededor de, en torno a) y a synístemai (reunión, conjunto), algo así como: tomar distancia para observar mejor un conjunto o reunión de cosas.

Es sin duda una cualidad indispensable del terapeuta alternar entre la toma de distancia necesaria para comprender y el compromiso emocional profundo necesario para curar. En ese flujo y reflujo existe como una relación inversa que surge de ampliar o reducir el campo de lo observado. Es probable que la terapia familiar haya nacido de este proceso necesario del conocimiento y esto nos obliga a pensar en su campo de estudio y de trabajo.

Así como en cada individuo existe una intersubjetividad genérica que lo une a sus semejantes y una intersubjetividad familiar

que lo une a sus parientes, dentro de ese conjunto resalta indudablemente lo específico, lo intransferible de cada ser humano.

Si en el plano de la técnica nos lleva a trabajar con el individuo o con el grupo familiar es una elección que no abandona la visión estructural de este conjunto pero que tampoco confunde sus distintos niveles de integración.

Se puede tratar a una familia desde un individuo o a éste en una familia, pero hay que saber por qué, cómo y cuándo. Así como no es lo mismo un individuo que un grupo, tampoco lo son la terapia individual y la del grupo familiar. La semejanza en las diferencias y la diferencia en las semejanzas.

Esto permitirá una síntesis enriquecedora de cada uno de estos enfoques sin que la confusión impida el diálogo, ya que éste es el mejor antídoto contra la simbiosis. O la prueba de que ésta no es tal...

Las dificultades personales y familiares que nos llevan a la elección de una tarea fundamentalmente reparatoria, son también la fuente emocional poderosa que la nutre. De ahí la importancia fundamental de la maduración personal del terapeuta y de la diferenciación entre formación e información.

La terapia familiar, como joven especialidad, está recorriendo su difícil camino y es necesario redefinirla permanentemente. Una disciplina científica no es lo mismo que un movimiento sociológico y, por lo tanto, menos sujeta a una moda. La fascinación que ejerce, como nueva esperanza, es engañosa si no va acompañada de la prudencia y de la sedimentación de la experiencia. De ahí que, sin ocultar la satisfacción que nos inspira el creciente interés por esta disciplina, alertamos desde estas páginas contra el peligro de un boom que pueda despertar reactivamente el rechazo de quienes más la necesitan. El peligro de una visión pseudomoral puede llevar a invertir la situación y pasar de la secular acusación al loco, a la acusación a la familia, visiones igualmente parciales, ya que cuando se comprende que no hay buenos y malos sino que todos lo son un poco, recién se está en condiciones de trabajar con el conjunto.

Por lo tanto, y para terminar, importa saber que trabajar en terapia familiar no presupone necesariamente la búsqueda de una etiopatogenia, sino también la utilización de poderosos mecanis-

mos de solidaridad que, una vez activados, pueden dar un giro copernicano a situaciones aparentemente irreversibles.

Si bien algo admonitorio y no por eso menos necesario, el editorial de este número viene preñado de un profundo reconocimiento por todos aquéllos que nos alientan y que hacen posible la existencia de esta revista.

El Director

EDITORIAL

If we go back to the origin of the word epistemology (theory of scientific knowledge) we see that it leads us to: epistēmae, from (epi) around, about and steme (synisteme) grouping, set, something like: taking one's distance from a group of things in order to observe them better.

The therapist's capacity to alternate between taking the necessary distance to understand and making the deep emotional commitment necessary to cure is indispensable. In this ebb and flow there is an inverse relationship arising from the enlargement or reduction of the observed field. It is probable that family therapy originated in this necessary process of knowledge and this obliges us to think about its field of study and work.

Since in every individual there exists a generic intersubjectivity uniting him with his own kind and a familial intersubjectivity linking him to his kin, it is within this context that what is unquestionably specific and non-transferable in each human being emerges.

If on the technical level we work with the individual or with family group, we do not thereby abandon the structural vision of this context, but neither do we confuse its different levels of integration.

A family may be treated through an individual or viceversa, but we must know why, how, and when. Just as an individual is not the same as a group, so individual therapy differs from group therapy. Similarity of differences and difference of similarities.

This permits an enriching synthesis of each of these focuses without the dialogue being blocked by confusion, since dialogue is the best antidote against symbiosis. Or the proof that the latter is not the case...

The personal and family difficulties that lead us to choose a task that is basically one of repairing, are also the powerful emotional source that

nourishes it. Hence the fundamental importance of the therapist's personal maturity and of the distinction between formation and information.

Family therapy as a young science is following a difficult path and it is necessary to redefine it constantly. A scientific discipline is not the same as a sociological movement and is thus less subject to changing fashions. The fascination it evokes as a new hope is deceiving if it is not accompanied by prudence and the weight of experience. For this reason, although we do not deny the satisfaction we feel at the growing interest in this discipline, we wish to sound a warning in these pages against the danger of a boom that might provoke a negative reaction on the part of those who are most in need of it. The danger of a pseudomoral vision may invert the situation, passing from the age-old accusation of the insane person to accusation of the family. These visions are equally partial. It is only when we understand that there are not good people and bad people, but rather that we are all a little of each that we are capable of working with the group.

It is thus important to know that working in family therapy does not necessarily presuppose the search for an etiopathogeny, but more importantly the utilization of powerful mechanisms of solidarity which, once activated, can cause a Copernican revolution in apparently irreversible situations.

Although this editorial is somewhat —necessarily— admonitory, it is imbued with profound recognition for all those who are encouraging us and making possible the existence of this review.

The Editor

Un modelo de ficha clínica familiar*

ALFREDO A. CANEVARO

Presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar
Co-director de Clínica Psiquiátrica, O'Higgins 2328, Buenos Aires (1428)

El relevamiento de datos que conforman la historia clínica ha sido en la medicina biológica una de las fuentes más utilizadas para establecer el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades. Se ha centrado en la información suministrada por el individuo enfermo y/o sus familiares, y sólo excepcionalmente se ha estudiado a éstos, en casos de transmisiones genéticas de enfermedades familiares (como, por ejemplo, la hemofilia, la porfiria aguda paroxística, etc.).

La medicina psicológica se ocupó de estudiar el desarrollo psicopatológico del individuo, centrándose en sus conflictos y en las manifestaciones intrapsíquicas o conductuales de aquéllos.

* Agradezco al doctor Isidoro Berenstein su generosa colaboración al suministrarme material de una ficha clínica por él desarrollada y que yo incluyo parcialmente en este trabajo.

Los familiares seguían siendo una fuente de información importante para esclarecer ciertos parámetros necesarios para el entrevistador.

Los progresos del psicoanálisis, la teoría de la comunicación y, en general, de las ciencias sociales, enriquecieron notablemente el estudio y la comprensión del individuo enfermo, extendiendo la observación a áreas grupales más extensas y básicamente la del medio familiar originario y circundante del paciente.

Esto, si bien aumentó las posibilidades de comprensión y tratamiento de los problemas psiquiátricos, complejizó la instrumentación operativa de los conocimientos que surgían de ampliar el campo observado. La transformación cualitativa del problema dio lugar a nuevas técnicas de abordaje terapéutico, que no necesariamente se acompañaron de modificaciones necesarias en los pasos previos del diagnóstico situacional.

Así es como quienes trabajamos con la incorporación del grupo familiar en el universo terapéutico, carecemos de datos que, objetivamente y en forma retrospectiva, nos ilustren sobre cómo era el medio familiar de un paciente y sus relaciones interpersonales y mucho menos aún sobre las vicisitudes de ese grupo humano y las diversas manifestaciones psicopatológicas de sus integrantes a través del curso vital de aquél.

Asimismo, es necesario pautar los datos que registramos en las entrevistas que nos muestran cómo ese grupo humano está interactuando en la tarea que tiene que enfrentar.

Por eso queremos introducir para su experimentación y mejoramiento un modelo de ficha clínica familiar que pueda subsanar algunas de esas carencias, combinando la anamnesis con la entrevista psicológica realizada por un equipo, en lo posible multidisciplinario, con el fin de poder integrar en un estudio diacrónico y sincrónico de ese grupo familiar, una visión más estructural y dinámica de éste. Del proceso terapéutico que efectúe ese grupo familiar y de los estudios periódicos que se realicen, surgirá un perfil que nos mostrará mucho más dinámicamente los cambios estructurales profundos, posibilitando las predicciones terapéuticas, así como las correcciones técnicas a efectuarse a lo largo de ese camino.

Fundamentos clínico-teóricos

Los puntos nodales que subyacen a esta ficha familiar son aquéllos que determinan no sólo la *estructura del grupo familiar*, sino también el *proceso* o sea, cómo funciona frente a circunstancias críticas de origen interno o externo en su curso vital y la *continuidad histórico-genética* que le confiere un sello particular a ese grupo familiar.

El perfil psicológico resultante de este amplio mosaico de información nos permitirá tener una idea aproximada de un grupo familiar, comprender la emergencia de brotes psicóticos o psicopáticos y de pacientes órgano-psicóticos, así como prever alteraciones en otros miembros aparentemente sanos, porque en la redistribución de las ansiedades a lo largo del proceso terapéutico sufren crisis de integración de aspectos disociados y/o reprimidos.

Si bien generalmente tomamos contacto con un grupo familiar a través del llamado "paciente designado", la visión estructural de este grupo nos permitirá evaluar cómo la misma patología se da en áreas de expresión distinta, aun cuando tenga un mismo valor simbólico.

Así por ejemplo, el estudio más acabado de los distintos integrantes y subsistemas del grupo familiar, nos puede mostrar cómo simultáneamente un mismo conflicto puede expresarse a través de un brote psicótico en un miembro, una alteración somática en otro, o una actuación psicopática o sociopática en un tercero.

La posibilidad de tener presente una visión estructural del sistema familiar nos permite rápidamente detectar los puntos de urgencia o preverlos a lo largo del proceso terapéutico.

Las situaciones de pérdida en su variada gama (familiares, país de origen, status socioeconómico, etc.) y su consiguiente trabajo de duelo, mejor o peor elaborado, negado, desplazado, duelos patológicos, etcétera y, en general, la dificultad para aceptar los cambios como expresión de un decurso vital insoslayable, son un buen ejemplo de lo que queremos significar en cuanto a la posible expresión patológica por parte de *todos* los integrantes de ese grupo familiar de un monto de sufrimiento muy alto y difícil de elaborar.

Estructura del grupo familiar

Ahora convendría detenernos en esclarecer el significado que le damos a la palabra "estructura", ya que ésta puede tener un uso variado y polisémico.¹ Además, como bien dice Roumeguère (3), la noción de estructura es una noción *comprometida*, es epistemológica al máximo. Cada investigador compromete una forma, una estructura de pensamiento, inserta su pensamiento en el nivel de la realidad.

El origen etimológico es del latín *struere*, construir, y se asocia inmediatamente con lo arquitectónico, con la ordenación de las partes de un edificio. Por analogía (siglos XVII y XVIII), al hablar de los seres vivos: modo como un conjunto concreto, espacial, es considerado en sus partes, en su organización, forma observable y analizable que presenta los elementos de un objeto. (2) Cuando Lagache historia el uso de este término en psicología, lo ubica como una reacción contra el atomismo y, desde ahí, emparentado con la Psicología de la Forma. Dice: "Los principios de la teoría de la forma (o de la Gestalt) se aplican no sólo a la psicología, sino a todas las ciencias, incluso la física. En psicología, la teoría de la forma rechaza la idea de elementos simples cuya composición explicaría el conjunto. Conjunto y partes son contemporáneos. El conocimiento del conjunto no puede ser deducido del conocimiento de las partes, ni éste puede ser completo sin referencia al conjunto. Es desde esta perspectiva que el 'estructuralismo' ha llegado a ser uno de los rasgos dominantes de la psicología contemporánea. Implica no sólo el rechazo de elementos simples —una percepción, una imagen, un sentimiento en sí mismo están estructurados— sino el de las antinomias de la psicología del siglo XIX — organismo o ambiente, individuo o sociedad, conducta o conciencia, psíquico o somático, pasado o presente, maduración o aprendizaje, etcétera, se trata de emplear estos conceptos no en una oposición que los aísla, sino en su articulación recíproca.

¹ Para el lector interesado, la Ed. Paidós publicó los resultados de un Coloquio Internacional de la Unesco en 1959 sobre los sentidos y usos del término *estructura* en la ciencia del hombre. Véase la bibliografía de pág. 25.

La relación de los hechos se impone *como la norma de re-constituir conjuntos y no de coleccionar datos aislados*². La explicación se aparta de la causalidad unilineal y de las teorías unilaterales que derivan de ella (biologismo, psicologismo, sociologismo) y la preocupación dominante pasa a ser la de 'la interacción de los determinantes' de la 'red de causalidad'.

El concepto de estructura se aplica a objetos psicológicos de dimensión variada — estructuras de la personalidad, de la situación, del ambiente, del grupo; la estructura más comprensiva es de 'campo psicológico', es decir, el campo de las interacciones del organismo y su ambiente (K. Lewin).

En todos estos empleos la idea de estructura es la de una *unitas multiplex*. Ella inspira la construcción de *modelos* que se distinguen del fluir de los fenómenos o de los procesos por caracteres de latencia, de cohesión interna, de autonomía relativa, en fin, de una resistencia al cambio que no excluye recomposiciones estructurales".

Me he extendido largamente en la cita de este autor, porque considero que es el desarrollo más completo del significado histórico de esta palabra en la psicología.

Aplicada a los grupos familiares, esta noción se imbrica con la de sistema, palabra que está nucleando toda intervención sobre el conjunto, en el "aquí y ahora" sin preocuparse demasiado por la historia de ese grupo. Toda la influencia de la aplicación de la Teoría General de los Sistemas de Von Bertalanffy a la terapia de grupo familiar, originando lo que ya se está llamando "terapia sistémica" en otras partes del mundo, hace que tengamos que profundizar las semejanzas y las diferencias de estos distintos usos.

Roger Bastide, sin embargo, no es partícipe de esta postura cuando dice: "Vemos, pues, que la noción de 'estructura' es una noción fecunda para las disciplinas que la emplean, dado que este término es un *término de enlace*, uno de esos términos que buscan, por encima de las barreras, una unificación terminológica de las diversas ciencias del hombre. Subsiste una oposición irreducible: la del modelo y concreto, de relaciones latentes y relaciones

² La bastardilla es mía.

reales y esta oposición la volvemos a encontrar en todas las disciplinas..."³. Continúo con Bastide "se debe registrar este doble sentido, sin tomar parte de la 'querella' de quienes la emplean, aunque reconociendo que uno y otro pueden revestir muchos aspectos o, al menos, matices (aspectos y matices que se esfumarían, creemos, si se distinguieran más cuidadosamente las estructuras de los conceptos vecinos como 'sistemas' 'organizaciones' 'formas', para las ciencias concretas y a su vez 'modelos estructurales' de las otras especies de modelos para los estructuralistas)."

Para ir aproximándonos a la clínica, que es donde estos modelos tienen que ser integrados necesariamente en aras de la función terapéutica, vamos introduciendo otras definiciones que nos acercan a este problema clínico teórico. Por ejemplo, siguiendo a Miller (citado en) la *estructura* es la disposición estática de las partes de un sistema en un momento del espacio tridimensional. Es un corte sincrónico del sistema en un momento dado. *Proceso* es el cambio dinámico de un sistema con el tiempo. Es el estudio diacrónico de ese sistema. Esta definición, operativa para el registro de lo real, no es suficiente para un nivel más abstracto, dado que hay distintos grados de generalidad de las estructuras. Como dice Girod (3) el sociólogo pretende describir relaciones dinámicas concretas que se manifiestan por transformaciones visibles de los elementos, modificaciones que dependen de las relaciones y se hallan organizadas por una reglamentación general que se puede llamar estructura. De esta primera estructura se pueden abstraer estructuras más generales, como las de Lévi-Strauss.

Este autor es citado ampliamente por Berenstein, quien intenta integrar la antropología estructural y el psicoanálisis aplicado al estudio y tratamiento del grupo familiar, en un excelente libro. (4)

Berenstein retoma los conceptos claves de Lévi-Strauss de estructuras elementales de parentesco, o sea, los vínculos de alianza (esposo-esposa), filiación (padres-hijos) y consanguinidad

³ En francés, a diferencia del español, hay dos adjetivos distintos que permiten mostrar un dualismo, encerrado en español en una sola palabra, *Structural* remite a la estructura como sintaxis y *Structurel* remite a la estructura como realidad. Jean Pouillon, citado en (2).

(hermanos) para tratar de encontrar la estructura latente que se evidencia en los datos empíricos que nos dan las relaciones familiares y en especial la relación de la familia conyugal con la familia materna.⁴

Nuestra obligación como clínicos es integrar operativamente los distintos niveles de significación de las relaciones familiares tales como se nos presentan en la consulta, combinando permanentemente la estructura con el proceso, el corte sincrónico con el diacrónico, siendo el terapeuta el pivote que permita integrar estos distintos niveles de significación, *presentes* siempre, ya sea en el relato, ya en la disposición espacial, en el uso del tiempo, etc., de manera tal que se convierta en el hilo conductor que ayude a encontrar sentido a fenómenos aparentemente inconexos.

En este trabajo no es pertinente desarrollar más estos conceptos, sino tratar de crear en el lector la inquietud por temas clínico-teóricos y ayudarlo a encontrar un modelo de ficha clínica familiar que le permita sistematizar un conjunto de datos.

Obviamente, cada investigador procesará estos datos según su esquema referencial teórico-clínico, pero lo que pensamos que es insoslayable en este modelo es pensar conjuntos, favoreciendo una óptica sistémica que obliga a salir de una causalidad unidireccional simplista. Con esto se habrá logrado gran parte del cometido. Explicar detenidamente cada ítem y su ejemplificación clínica merecería un libro especialmente dedicado a ello, por lo que pido disculpas al lector por ciertas perplejidades que no pueden ser evitadas. Esperemos que esas frustraciones enriquezcan el pensamiento.

Entrevista del grupo familiar

El cuadro que resulta de la combinación entre dos personas que por el vínculo de alianza intercambian y transmiten el bagaje genético y cultural de sus grupos familiares de origen, es obviamente multiforme, y estará codeterminado por la influencia di-

⁴ Una síntesis enriquecedora de este libro la dan S. Molina y R. Skiadarensis en el N°1 de *Terapia Familiar*, Ed. ACE, Bs. As.

recta de los grupos familiares en cuestión. No obstante, el conocimiento que el psicoanálisis nos ha dado de las relaciones de objeto intrapsíquicas, o la familia interna, nos permite afirmar que, aun cuando ambos grupos familiares no estén en contacto personalmente, serán recreados fantasmáticamente en la relación, a través de la transferencia entre ambos cónyuges y también con su descendencia y personajes significativos que convivan con ellos.

Esta concepción está implícita en mi manera de entender el encuentro con el grupo familiar en la consulta. Por su manera de agruparse, podríamos diferenciar empíricamente dos tipos de grupos: la familia cohesiva o centrípeta y la familia dispersiva o centrífuga. La combinación de estos dos grupos familiares de origen, a través del vínculo de alianza, crea un nuevo campo psicológico, que es el que esta ficha pretende estudiar.

La presencia o ausencia, física o en el relato, de personajes significativos de esos grupos familiares, está condicionando un campo estructural real y virtual que, como un fenómeno de figura-fondo, tiene que estar permanentemente presente en el terapeuta, que debe conducir activamente la entrevista para explorar los distintos puntos significativos.

Por medio de la anamnesis (del griego: conmemoración) podemos extraer del relato conjunto y compartido del grupo familiar la visión histórica de éste. A la par que de la observación de la disposición espacial, de la utilización del tiempo y, en general, de los mecanismos de acción de ese grupo (quién habla, cómo, interacción de distintos subsistemas, etc.), iremos detectando o infiriendo los conflictos evitados, las disociaciones o segregaciones patológicas, los emergentes grupales y finalmente las reglas del juego en ese grupo humano.

La ayuda de la contratransferencia y su aplicación operativa es sumamente importante, como en todo proceso psicoterapéutico, por lo que es valioso analizarla en el equipo.

De una correcta evaluación de todos estos datos surgirá claramente la definición del problema, los objetivos terapéuticos perseguidos y la estrategia adecuada para conseguirlos.

Ficha familiar

Familia (Apellidos paterno y materno)
Domicilio
Teléfono
Equipo entrevistador
Terapeutas individuales
Terapeutas familiares

Presentación (quiénes y cómo suministran la información)

Motivo de consulta

Identidad

A) FAMILIA NUCLEAR

(padre, madre, hijos)

Integrantes

Nombres Completos	Parentesco	Edad	S	Nac.	Ocup.	Educ.	Observaciones
Parientes y no parientes que convivan bajo el mismo techo							
Animales. Nombres, a quién pertenecen, qué significan.							

Identidad grupal (status socioeconómico, movilidad social, grupos de pertenencia, clubes, barrio)

B) FAMILIA AMPLIADA

Integrantes

FAMILIA MATRILINEAL

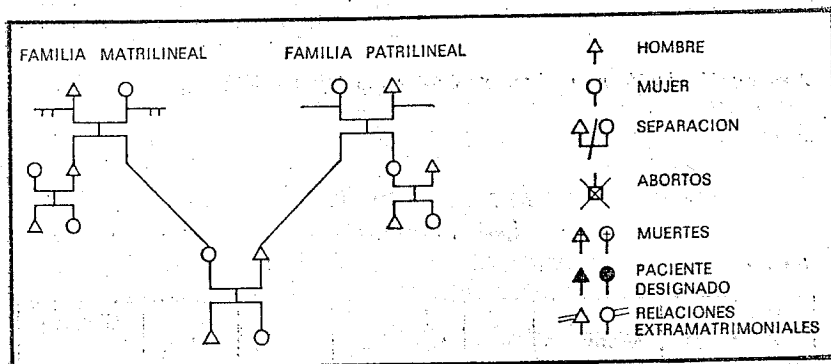
Nombres Completos	Parentesco	Edad	S	Nac.	Relig.	Ocup.	Educ.	Lugar de resid.

FAMILIA PATRILINEAL

Nombres Completos	Parentesco	Edad	S	Nac.	Relig.	Ocup.	Educ.	Lugar de resid.

Identidad grupal (igual que en A y discriminando por grupos matrilineal y patrilineal).

Genograma



HISTORIA FAMILIAR

- familia ampliada* (mat. y pat.) países de origen, migraciones, muertes: cuándo y por qué, líderes grupales, características personales, personajes significativos no familiares. Por lo menos hasta abuelos o bisabuelos.
- familia nuclear* (conocimiento de la pareja, casamiento, nacimientos de los hijos, muertes posibles, vicisitudes económicas).

SITUACION ACTUAL (familia nuclear y aquéllos que convivan bajo el mismo techo)

- Distribución espacial:**
 - dibujo de la vivienda actual y anteriores, lugares donde duermen, comen, etc.
 - dibujo de la mesa del comedor, lugares que ocupan.
- Utilización del tiempo:**
 - Trabajo
 - Libre
 - Fin de semana
 - Vacaciones (juntos y por separado [diagrama])
- Caracterología individual de cada uno de los integrantes:**
 - Informe psicopatológico
 - Enfermedades, órganos afectados
 - Hobbies
 - Reacción ante el stress, tensión o crisis
- Relaciones parentales (conyugales)**
 - Paternofiliales
 - Fraternas
 - Con las familias de origen y exogrupo

- Producción económica y circulación del dinero en la estructura familiar. Pago del tratamiento.*
- Miedos, expectativas y anhelos de cada uno consigo mismo, con los demás o sobre la familia. ¿A quién se consideran parecidos físicamente y en carácter? Eventualmente se pueden pedir fotografías representativas del grupo familiar.*

A realizar por el equipo entrevistador

- Distribución espacial en el momento de la entrevista (diagrama).
- Descripción de la entrevista dinámicamente (interacción, quién habla y cómo; formación de subsistemas).
- Sentimientos contratransferenciales (grupales o individuales).
- Impresión diagnóstica y pronóstica.
- Informes de la asistente social y de la psicóloga.

Seguimiento

Configuración dinámica de la estructura familiar.*

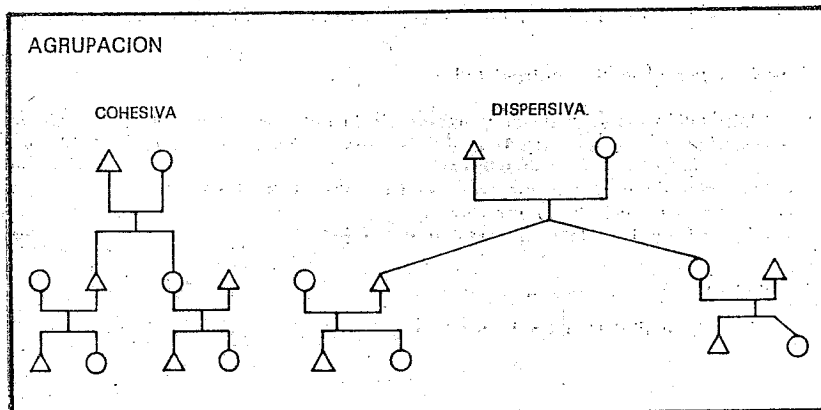
* Sin poder por ahora desarrollar ni fundamentar adecuadamente, en forma tentativa, vamos a incluir un diseño que grafique una representación del investigador que pueda incluir 1) fenómenos observables empíricamente derivados del campo psicológico formado por las personas del grupo familiar; 2) hechos dinámicos que, estando contenidos en ese campo observado, no pueden ser probados sino indirectamente mediante ciertas manipulaciones o incluyendo el tiempo como variable esclarecedora (relaciones de fuerza, tensión, formaciones de subsistemas, etc.) y finalmente 3) construcciones del observador, que son abstracciones más o menos generalizadas que suponen aproximaciones teóricas de distintos esquemas referenciales destinadas siempre a una conceptualización esclarecedora.

Conceptos como campo psicológico, Gestalt, y especialmente todos los estudios de Kurt Lewin sobre espacio vital (tensiones, vectores, locomoción, regiones, etc.), sólo pueden ser nombrados para dar una idea de una configuración dinámica que, recortada arbitrariamente de un contexto más amplio, tienda a mostrar espacios reales y virtuales en los que se integran elementos de la realidad externa e interna de un grupo de personas que además están unidas por una relación de parentesco y una historia compartida.

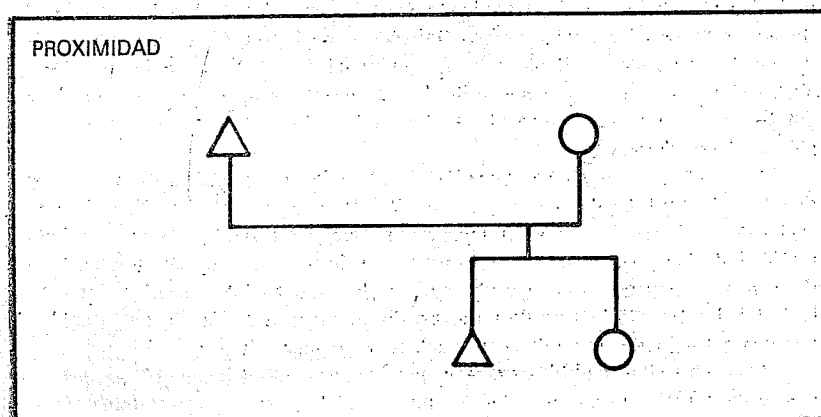
Esta situación multideterminada puede ser graficada con fines prácticos, como un modelo que nos permita pensar, dialogar y trazar estrategias terapéuticas y, además, mostrarnos didácticamente a lo largo del tiempo modificaciones estructurales posibles.

Para esto debemos recurrir a un código gráfico que intente representar esquemáticamente y con el peligro de un inevitable reduccionismo, ciertas variables que condicionan la situación. Por ahora consideramos los siguientes:

Código gráfico



De acuerdo con su manera de agruparse, podemos tener dos tipos de familia, cohesiva o centrípeta y dispersiva o centrífuga.



Significado de la relación vincular que denote mayor o menor grado de simbiosis-autismo o compromiso emocional.

DIMENSION OBJETAL



Que caracterice al objeto idealizado o denigrado, con mayor o menor relevancia de acuerdo con sus características, autoridad, poder, etc.

TENSION, DIRECCION Y COMPROMISO EMOCIONAL

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1) → Unidireccional | 4) --→ Poco compromiso emocional |
| 2) ⇌ Didireccional | 5) → Marcado compromiso emocional |
| 3) ↔ Ambivalencia | |

Vectores que indican la tensión o desnivel en el potencial relacional, que dan como resultado la forma de agrupación, centrípeta o centrífuga.

Ejemplo: *Paciente designado*: joven drogadicto, 20 años.

Estructura familiar

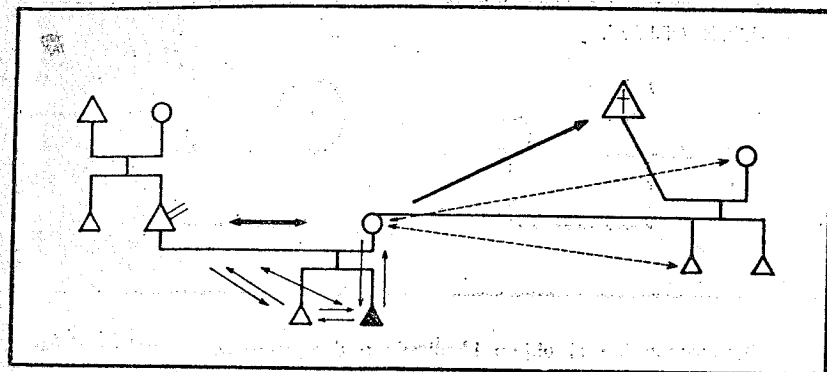
Familias de origen

paterno: cohesiva centrípeta de tipo patriarcal. Fuertes vínculos simbióticos.

materno: dispersiva centrífuga. Padre muerto idealizado, madre desdibujada. Vínculos emocionales poco estrechos.

Familia nuclear

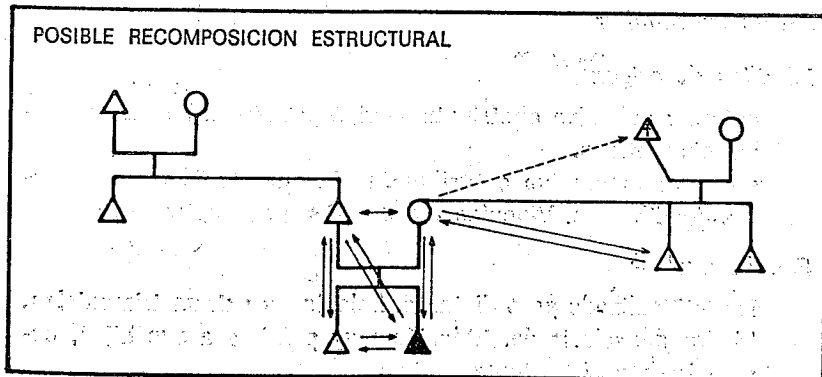
Padre idealizado pero distante. Relaciones extramatrimoniales. Madre desvalorizada. Relación muy próxima a sus hijos, especialmente el paciente designado.



Estrategia terapéutica: De-simbiotización madre-hijo, trabajando en función de la proyección del objeto interno idealizado (abuelo materno) de la madre en el paciente designado.

- Mayor acercamiento padre-hijo, en función del paso anterior, procurando que el hijo no se haga cargo de los sentimientos hostiles de la madre hacia el padre.
- Revisión de la relación conyugal, intensamente ambivalente.
- Trabajar sobre el vínculo de la madre con sus hermanos con el fin de clarificar posibles desplazamientos sobre los hijos de necesidades emocionales vinculadas con su familia de origen y disminuir su aislamiento psicológico y emocional, que recarga su vínculo maternal.

POSIBLE RECOMPOSICION ESTRUCTURAL



Este ejemplo, si bien parcial, nos mostraría un momento del proceso terapéutico y nos ayudaría a revisar, en función de los resultados obtenidos, la estrategia más adecuada a seguir.

Bibliografía

1. ACKERMAN, N., *Familia y conflicto mental*, Hormé, Buenos Aires, 1976.
2. AUZIAS, J. M., *El Estructuralismo*, Editorial Alianza, Madrid, 1969.
3. BASTIDE, R. (compilador), *Sentidos y usos del término estructura en las ciencias del hombre*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1971.
4. BERENSTEIN, I., *Familia y enfermedad mental*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1976.
5. BERENSTEIN, I., "Familia y estructura familiar", Relato Oficial en el 1er. Congreso Argentino de Psicopatología del Grupo Familiar, Buenos Aires, junio 1970.
6. CANEVARO, A. A., "Inclusión del grupo familiar en el proceso terapéutico", Jornadas sobre Psicología Institucional, F.A.P., Mendoza, octubre de 1973.
7. GARCIA BADARACCO, J., PROVERBIO, N. y CANEVARO, A. A., "Terapia en Comunidad Terapéutica (Grupo Familiar Múltiple y Grupo Familiar Nuclear)". En *Patología y Terapéutica del Grupo Familiar* (Comp. C. E. Sluzki, I. Berenstein, H. Bleichmar e I. Maldonado Allende), Buenos Aires, Acta, 1970.
8. PETERFREUND, E. y SCHWARZT, J. T., *Información, sistemas y psicoanálisis*, Ed. Siglo XXI, México, 1976.
9. WOLMAN, B., *Teorías y sistemas contemporáneos en psicología*, Ed. Martínez Roca, Barcelona, 1968.

SUMMARY

This model of a family clinical life is an attempt to get away from the traditional model of a clinical history focusing on the individual patient, by taking into account all members of the family system, whether they live together under the same roof or are linked by a system of kinship.

The goal is to systematize a set of data pertaining to a longitudinal slice of this system in a diachronic vision (process), at the same time systematizing information about the transversal slice, or cross-section, in a synchronic vision (structure).

For this purpose certain data must be gathered, if possible, in an interview with a therapeutic team, relating to:

—*identity* (of the nuclear family and the extended family, both matrilineal and patrilineal).

—Family history (both sides).

—Present situation (nuclear family) which studies various items.

a) spatial distribution

b) time utilization

work

free

week-end

vacations

c) Individual characterology of each member (illnesses, hobbies, etc.)

d) Interpersonal relations

conjugal

paterno-filial

fraternal

with original family

beyond the group

—Economic production and circulation of money in the family structure.

—Fears, expectations, and desires of each person regarding himself and others.

Later, to be carried out by the interviewing team:

a) Spatial distribution at the time of the interview (diagram).

b) Description of the interview, dynamically (interaction, who is speaking and how? subsystems).

c) Counter-transference feelings (individual and group).

d) Diagnostic and prognostic impression.

e) Reports by the social worker and psychologist.

f) Follow-up.

Finally a tentative design is presented showing graphically the "dynamic configuration of the family structure, i.e., a representation of the observer grouping: 1) empirically observable clinical phenomena deriving from the psychological field formed by the family group; 2) *dynamic* phenomena contained in the observed field which cannot be proven except by certain indirect manipu-

lations (relationships of power, tension, formation of subsystems: alliances and coalitions); 3) constructions of the observer which are generalized abstractions supposing theoretical approximations from different referential schemes for the purpose of a clarifying conceptualization.

The idea is to sketch a dynamic configuration which, taken *arbitrarily* from a larger context, tends to indicate real and virtual spaces in which elements of the external and internal reality of a group of people living under the same roof and joined by a relationship of kinship and a shared history come together. Using this model one can think about, discuss, and trace therapeutic strategies, and over a period of time, study possible structural modifications.

El niño, la familia, el pediatra

Trabajo publicado en la Revista del Hospital de Niños ,
Volumen XIX, Nº 76, octubre 1977.

AURORA PEREZ T.

Médica. Miembro titular en función didáctica de la Asociación
Psicoanalítica Argentina. Médica consultora del Servicio de Psicopatología
del Hospital de Niños. M. T. de Alvear 2320, 1º E,
Buenos Aires, República Argentina.

La familia como matriz de la humanización

El medio natural por el cual se genera, organiza y mantiene la vida del humano es la trama familiar. El ser humano es el ser vivo de más alto nivel de complejidad de organización psicológica. Esta característica le permite afrontar su supervivencia con muchos más recursos que otras especies vivas. Pero también el costo es mayor. El ser humano nace con un alto grado de indefensión fáctica. Con muchas áreas inmaduras. Es una unidad biológica incompleta. El nacimiento extrauterino marca formalmente su reconocimiento como individuo, siendo este evento, el nacer, el episodio más violento quizás en toda la historia de su individuación.

Al separarse del cuerpo de la madre y ofrecerse morfológicamente diferenciado, puede ser percibido como un individuo de la

especie. No obstante, no está habilitado ni siquiera para sobrevivir por sus propios medios. Depende absolutamente de individuos maduros de la especie para preservar su vida. Aún más, para poder ser reconocido como humano, diferente de un organismo vivo en supervivencia simplemente, deberá ir acuñando procesos en el nivel de lo psíquico y en esto consistirá su humanización progresiva. La humanización se produce en el íntimo intercambio del bebé con las personas de su alrededor. Del interjuego entre sus pulsiones a llenar con el medio proveedor surgirá el poder preservar la vida, instalándose así las bases del psiquismo temprano, el inicio del órgano mental. El desarrollo de este órgano y su maduración es de armado postnatal. El adulto en contacto con el niño mantiene un ligamen con él y éste con aquél. Este ligamen afectivo se traduce en un vínculo que actúa a modo de cordón umbilical, no tangible pero vigoroso vehículo transportador de resoluciones y frustraciones afectivas, de codificaciones, de modelos para manejar la angustia, etcétera. Con este elemento, el vínculo, cargado de significaciones (fantasías) tanto por el polo bebé como por el polo adulto, se inicia la estructuración del órgano mental. Se nace con rudimentos de estructura psíquica, pero operantes, y con una programación interna a desarrollar. Aunque morfológicamente sea un individuo, para sobrevivir necesita del otro, tiene que depender. La placenta biológica intrauterina queda ahora transformada en una placenta igualmente real, tan real que sin ella se muere; pero al mismo tiempo tan intangible que hemos necesitado de la observación y el estudio de situaciones de atipia de este hecho para darnos cuenta de su existencia y vigencia. Así, nos lo han mostrado Spitz y Bowlby, por ejemplo, o el estudio de los retardos de maduración, las enfermedades mentales, las oligotimias que nos enfrentan con etiologías como la carencia afectiva o la privación emocional.

La trama íntima de la placenta familiar que lleva a la estructuración humana está formada por un conglomerado emocional que usa como elemento la fantasía y que se estructura en una relación calificada, el vínculo entre sujeto y objeto. De todo lo que se produzca y de cómo se produzca y de lo que no se produzca y de cómo no se produzca entre los dos polos dependerá que el órgano mental se estructure adecuadamente o no.

La relación va proveyendo al sujeto de modelos de resolución de sus necesidades físicas y psíquicas. Se nutre emocional y afectivamente para tener un yo seguro y eficiente. Se nutre a través de los procesos de identificación con sus padres para tener una identidad coherente. Se nutre de codificaciones para el manejo de las emociones, del amor, del odio, de la agresión, de la ternura, de lo erótico. De lo que angustia, de lo que deprime. De cómo hay que defenderse mejor. Así la trama familiar se convierte en un laboratorio metabolizador emocional permanente de cuya eficacia dependerá el mantenimiento y preservación de la salud y cuyo fracaso instalará la enfermedad mental o física, eventualmente la muerte o la locura.

Si describiéramos un circuito emocional desde que se origina lo intrasubjetivo planteado como una necesidad a llenar, de hambre, por ejemplo, pero categorizada como una emoción angustiosa de muerte, hasta que se cierra nuevamente el circuito con la satisfacción, categorizada con una sensación de bienestar, de plenitud vital, podríamos establecer todo un recorrido equivalente a una metabolización emocional. Esta transcurre tanto dentro del sujeto como en el campo interpersonal al dirigirse al objeto, que recibe la demanda, la elabora dentro de sí, la decodifica y le da una resolución posible. Al resonar con la angustia de muerte transmitida, provee su respuesta según la propia codificación de esa emoción, devolviendo tranquilidad. Esto no sólo a través del alimentar en sí mismo, sino además proponiendo un modelo para afrontar la vivencia angustiosa con una posible resolución opositora de gratificación y plenitud. De esta manera un sujeto y un objeto, a través de un vínculo, son casi magos que manejan la muerte, la transforman en vida y ambos convergen en el sentimiento de satisfacción mutua de haber resuelto todo un circuito emocional. Este es el operar de la placenta familiar que sutilmente promueve como logro la paulatina maduración del yo, lo que a su vez permitirá su progresivo desarrollo.

Si un bebé es abandonado emocionalmente no madurará bien, no comerá bien, no dormirá bien. Así, el proceso de su humanización se verá perturbado.

La familia, a través de estos mecanismos, permite hacer de un animal acosado por mandatos biológicos inapelables, e irre-

solubles por sí, un bebé humano, con vivencias de plenitud y vida, gracias a otro humano que resolvió su necesidad y permitió así la transformación. Esto funda la llamada "naturaleza social" del hombre. Las progresivas transformaciones lo irán proveyendo de mecanismos mediadores que regularán sus propias demandas per-

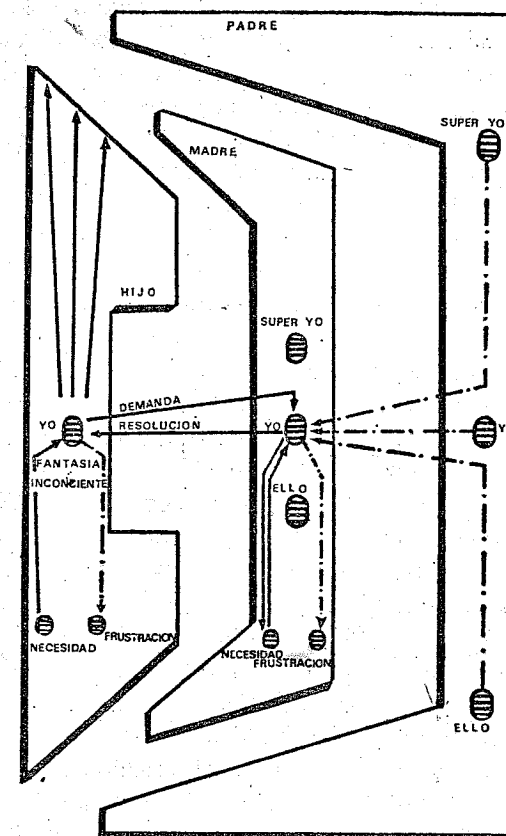


Figura 1

Familia. Metabolización emocional en trama familiar. Hijo demanda sobre padres. Estos resuelven proveyendo tranquilidad y margen de frustración. Hijo más o menos satisfecho. Padres reasegurados con cierto margen de frustración.

mitiéndole preservarse y necesitando preservar al otro. Así el grupo familiar es la matriz humana del progresivo proceso de humanización (Fig. 1).

El hecho de que el grupo familiar se mantenga en íntima interrelación se debe a una comunidad de intereses. Por un lado los padres podrán oponerse a su propia finitud a través de trascenderse en el tiempo por los hijos. Por otro lado se opondrán también a la finitud por su inscripción psicológica, al contribuir al armado del órgano mental de sus hijos. Estos, dentro de la trama, podrán sobrevivir, arquitecturar su órgano mental y acceder a la integración de su programación individual. Esto nos enfrenta con otra función placentaria de la familia: formar individuos, ser matriz de individuación.

La familia como matriz de la individuación

La estructura familiar está constituida por dos sistemas en convivencia estable que modelan entre sí una relación continente-contenido. Ambos sistemas están en crecimiento y desarrollo. El continente o periferia de este organismo vivo, la familia, está constituido por la pareja parental, núcleo original. El contenido está representado por los hijos, grupo pediátrico. Ambos sistemas deben completar trayectos vitales. El continente, cimentar y enriquecer su individuación haciéndose cargo de las funciones de sostén físico y psíquico del sistema contenido y de sí mismo. Deben autocontenerse y contener. Esto pone a prueba sus logros como individuos y la plena autonomía como hombre o mujer adultos con el ejercicio de todos los roles sexuales y parentales. El contenido debe acceder al logro de su individuación, es decir, la posesión de una programación psicológica que le vaya sustentando progresivamente el ejercicio de funciones, según su momento evolutivo y modelos de ser para futuros desempeños. Todos deben poder seguir viviendo bien y resolviendo sus necesidades evolutivas.

El sistema continente debe contenerse a sí mismo para continuar su maduración, pero en este período el crecimiento y la maduración son más lentos.

El sistema contenido va haciendo su desarrollo y maduración en forma mucho más acelerada, planteando sucesivas urgencias de necesidades a resolver.

Esta configuración plantea características especiales. Presenta un vector simétrico: todos deben sobrevivir y vivir bien; y otro vector de básica asimetría, planteado por la indefensión del grupo pediátrico, el cual se ve compelido a depender del grupo parental durante mucho tiempo. Este fenómeno de prolongada interrelación de ambos sistemas es lo que permite la consecución de los complejíssimos procesos interhumanos que conducen al armado evolutivo del órgano mental, con el logro de la individuación y autonomía.

Así, el trasfondo de la crianza es una situación asimétrica en relación de dependencia. El continente parental posee un movimiento de rotación sobre sí mismo, del cual resulta la integración sexual de la pareja y la aceptación definitiva de la unisexualidad, afirmando la individuación en cada uno de los sexos. Tiene además otro movimiento de rotación alrededor del contenido, los hijos, lo cual provee a los padres de la gratificación de ser adultos cuidadores, fundadores, sostenedores de la vida, habiendo hecho posible la trascendencia de su propia finitud en hijos continuadores.

El contenido, hijos, tiene un movimiento de rotación sobre su eje demandando la resolución de sus necesidades, mostrándolas, luchando por su resolución; en definitiva, luchando por su integración. Presenta también otro movimiento de rotación alrededor de la pareja parental, requiriendo su presencia estable, su registro sensorial, su contacto, etcétera.

Así, la trama familiar es muy dinámica (Fig. 2), tiene varios ejes de movimiento y dos velocidades de maduración. Es por esto que, al acceder al grupo familiar, las variables a observar pueden ser muchas. El faro que guía la direccionalidad, sin embargo, es dar vida, mantenerla y preservarla. De aquí que para los médicos sea una necesidad poder abordarla. Es más: el grupo humano familiar tiene una convocatoria esencial, ser el odre que provee la realística vivencia de la no finitud biológica, y, al generar lo psicológico, se perenniza al trascender más allá de la muerte individual a través de sus creatividades. Por lo tanto la constitución, emergencia y permanencia de la familia no es un fenómeno contingente al cual

desde una postura racional o intelectual se lo podría considerar útil, necesario u obsoleto e inoperante. La familia es un organismo vivo al servicio de mantener la vida y preservarla en cada uno de sus miembros. Tiene como funciones humanizar e individuar y yugular la inmediatez.

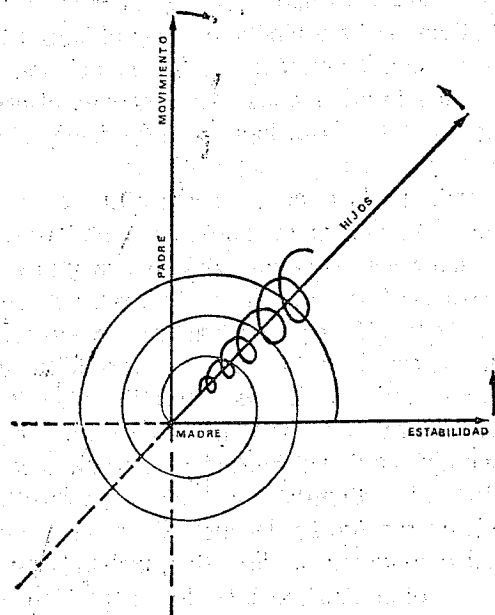


Figura 2

Familia. Individuación. Madre y padre demarcando el sistema continente. Hijos como sistema contenido. Espirales y flechas marcando los distintos ejes de rotación. Las líneas de puntos dan cuenta de las posibilidades de detenerse en la individuación-maduración, regresar, desviar el desarrollo.

La dinámica microscópica de esto es el establecimiento y desarrollo de vínculos entre los miembros del grupo. La individuación proveniente del sistema de crianza será el producto de la dependencia útil ofrecida por la placenta familiar para que, desde la dependencia extrema al nacer, progresivamente se articulen las

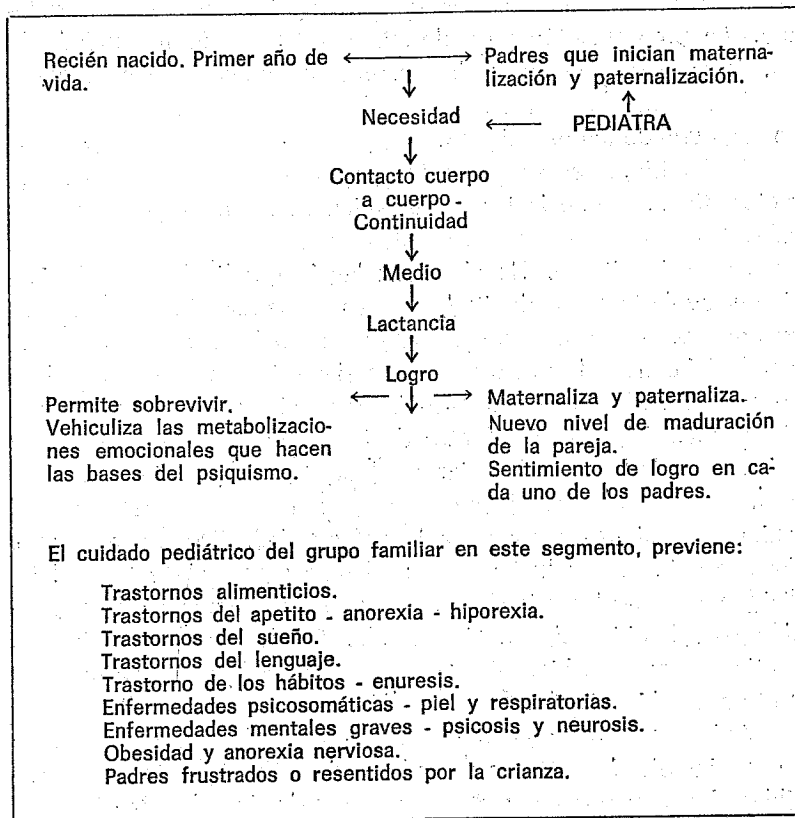
funciones de la individuación, bipedestación, marcha, lenguaje, control esfinteriano, aprendizaje de códigos universales, etcétera.

La situación asimétrica permitirá el desarrollo pleno de los procesos de identificación con las figuras parentales, en machimbre con los requerimientos personales. El sutil modo como se instrumenta a sí mismo en el interjuego microsocioal, interpersonal, será el resultado de los circuitos de metabolización de las emociones. La programación para dirimir emociones de hostilidad, de ira, de agresión, de amor, de ternura, de miedo, provee el cómo resolver dentro de sí y en función del otro, el mandato contenido en cada una de las emociones.

La familia, al establecer vínculos que funcionan con estas características, asume la tarea mesiánica de preservar lo impreservable. Aunque sea una tarea destinada a fracasar, porque la muerte es inevitable. No obstante, las longitudinales metabolizaciones evolutivas de plenitud proveen bienestar. Por lo tanto, si las emociones y situaciones no son bien resueltas, sea porque la demanda del contenido es excesiva para el continente, sea porque éste no sabe contener flexiblemente la demanda y queda la angustia sin resolver, ésta actúa dentro de la unidad biológica como una noxa. Cuando la trama familiar no alberga, no metaboliza, no transforma adecuadamente, la atmósfera familiar se enrarece, se intoxica y comienza a aparecer la enfermedad. Esta no es nunca física o psíquica exclusivamente; además compromete todo el individuo y a todos los miembros. Es una señal de alarma de que en el órgano familiar algo está pasando. Puede ser que el sistema continente no esté bien dispuesto o que el contenido exija mucho u otras combinaciones.

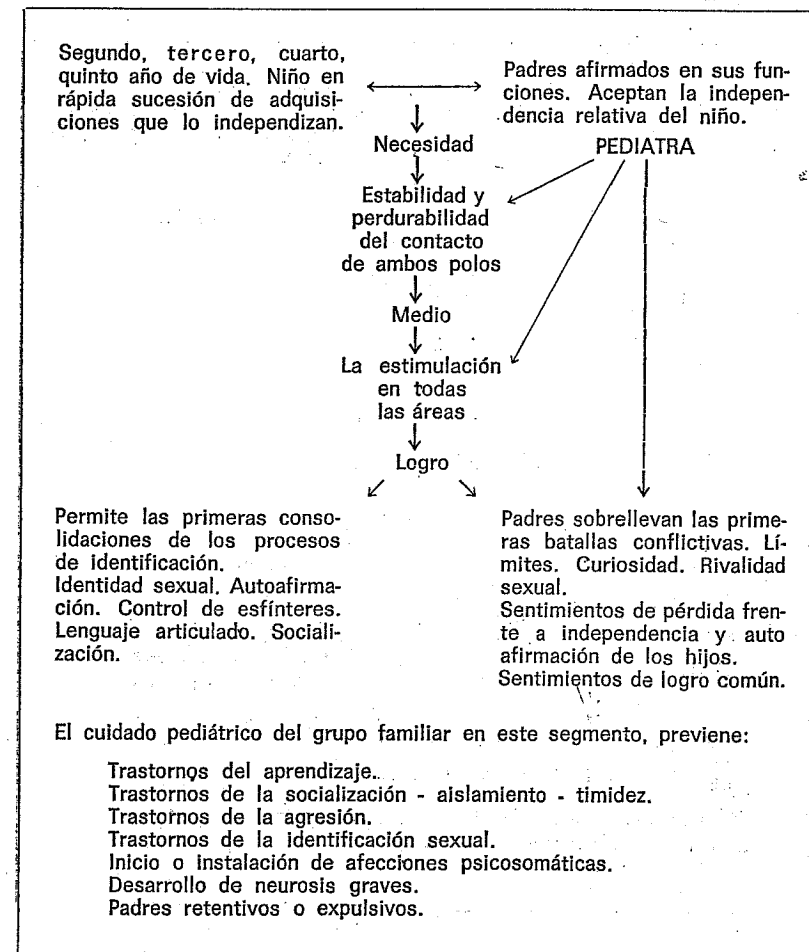
Así se va perturbando el clima de salud e insensiblemente se van instalando *patterns* de enfermedad. No obstante, estos posibles desencuentros ofrecen alguna escala de relativización, según el momento evolutivo en que se produzcan. Para las distintas metas a lograr hay requerimientos específicos según las edades. Si intentáramos lograr un patrón o marco referencial para cada edad según las necesidades o necesidad esencial a respetar en cada una de ellas, quizá pudiéramos ayudar a la familia a no enfermar, a no perturbar sus procesos, a no enfermar individuos que, una vez enfermos, enfermarán a su vez a los que les rodeen.

Si tomáramos segmentos evolutivos desde el nacimiento hasta la adolescencia, creo que sería posible perfilar para cada uno de ellos la necesidad base a respetar, cruzada siempre por la vigencia de una trama familiar capaz de humanizar e individualizar.



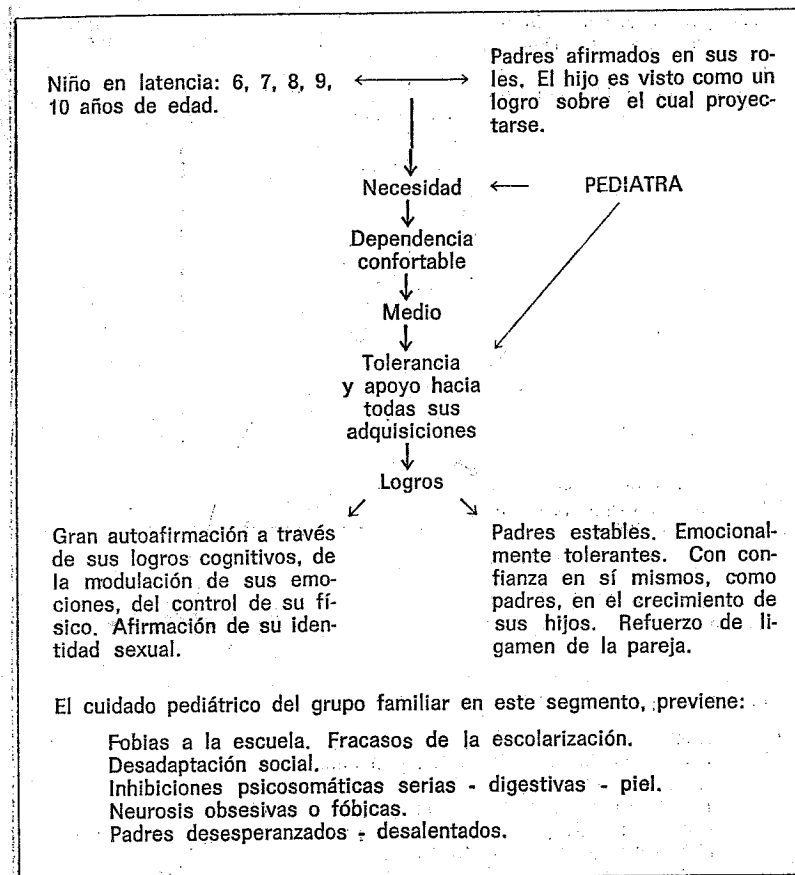
Primer segmento evolutivo

En mi opinión esta propuesta permitiría redimensionar la medicina, en especial la pediatría, ya que abre el campo de etiologías no tenidas en cuenta en el desajuste de la salud y la producción de la enfermedad y por lo tanto introduce campos nuevos



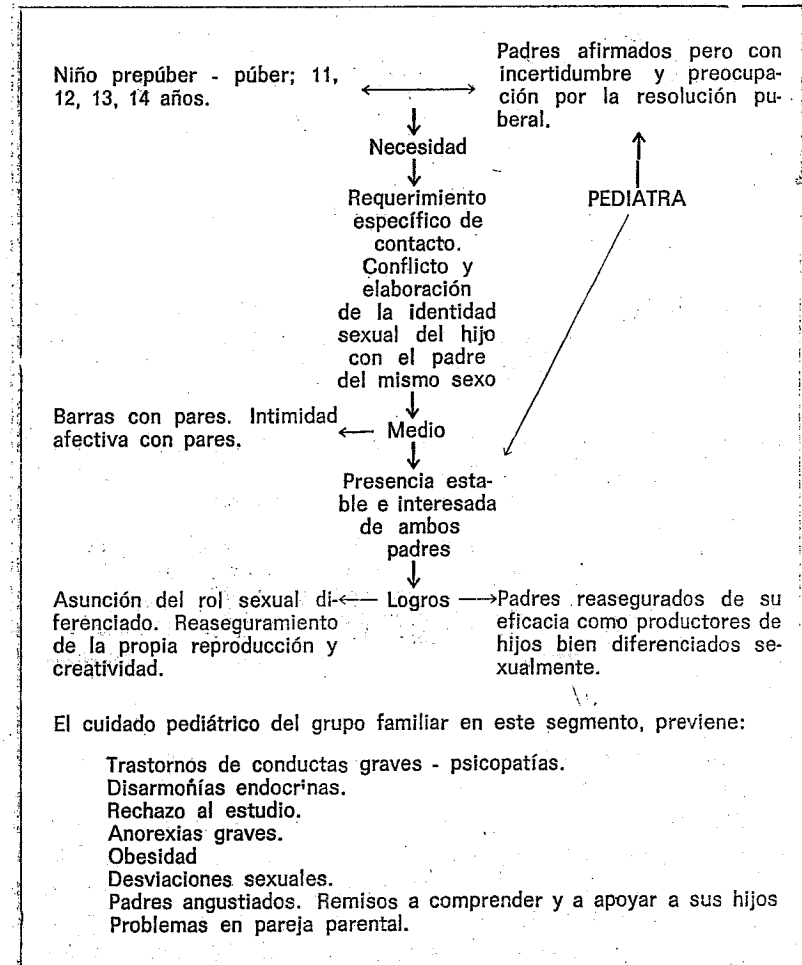
Segundo segmento evolutivo

de prevención y tratamiento. Si tomáramos como ejemplo un trastorno del sueño, un buen abordaje pediátrico sería estudiar aspectos neurológicos, si la alimentación es suficiente o no, etcétera, y proceder a su tratamiento según este abordaje. Pero si de acuerdo con un repaso semiológico de la familia el pediatra en-

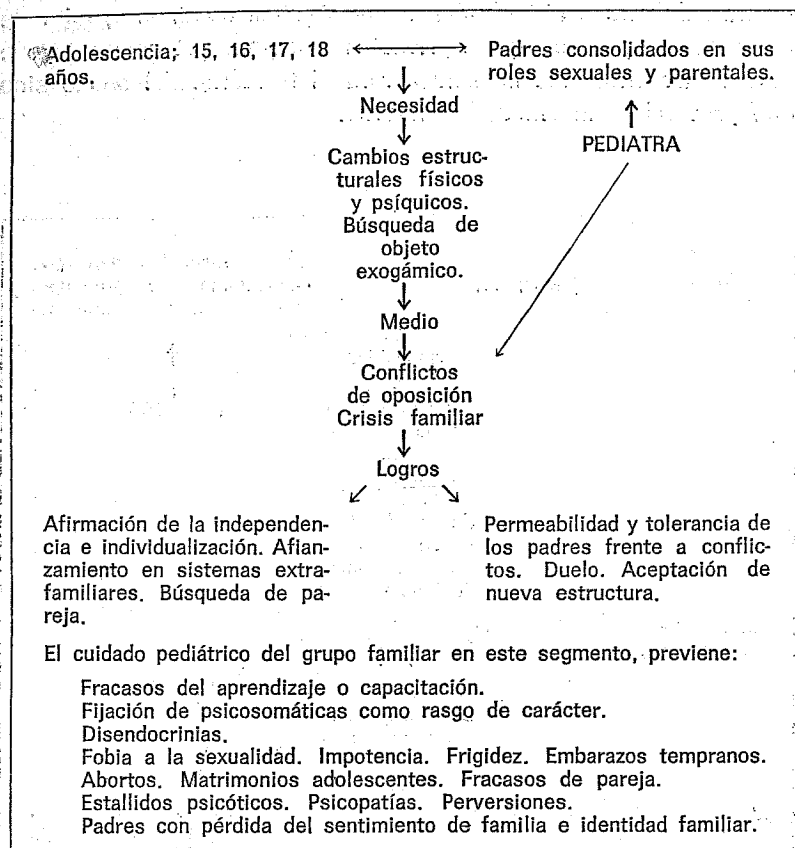


Tercer segmento evolutivo

cuenta déficits o dificultades en el sistema continente, falta de contacto cuerpo a cuerpo o privación emocional, la corrección de este factor etiológico no sólo curará el trastorno del sueño sino que prevendrá enfermedades futuras.



Cuarto segmento evolutivo



Quinto segmento evolutivo

Semiología de la familia

Para finalizar, quisiera decir que el pediatra que actualmente se postule a sí mismo sólo como un médico de niños, no está siendo justo consigo mismo y con su tarea. Ningún pediatra atiende a un niño. Por su función es el vector natural para penetrar en la familia. Su presencia es requerida a través de la codificación que los padres hacen de lo que creen es un estado de enfermedad de su hijo. Esta es ya una primera mediación entre él y el asigna-

do paciente, el niño. La relación médico-paciente presenta en la pediatría esta particularidad. Lo que es más, la perdurabilidad del contacto entre médico y paciente depende de la relación que establezca el pediatra con los padres del niño. Por lo tanto es necesaria esta primera toma de conciencia: *Ningún pediatra atiende a un niño; atiende a una familia.* De no poder él codificar a ésta, se expondrá a errar diagnósticos y a equivocarse pronósticos. Y a que su permanencia como médico de ese niño se vea imposibilitada. Por todo esto considero necesario que el pediatra articule en su bagaje médico conocimientos de la semiología de la familia. Estos elementos semiológicos los podemos agrupar en cinco grandes categorías de datos a tener en cuenta.

En primer lugar, el *origen*. De dónde proviene la pareja parental. Cómo fueron sus familias de origen. Desde dónde y desde quiénes provienen. Cómo fueron sus padres.

En segundo lugar, la *constitución* de la pareja. Cómo se constituyó. Cuánto tiempo lleva de constituida. Qué edades tenían al constituirse. Qué edades tienen en el momento. Qué tipo de personalidad presentan. Qué capacitación tienen. Qué ocupaciones desempeñan. Qué actividades desarrollan. Si tienen familia numerosa. En qué términos afectivos se encuentran con ella. Cuántos hijos tienen. Situación de esos hijos.

En tercer lugar, la *integración* de la familia. Debe tenerse muy en cuenta el grado de integración de la familia. Si existen ambos padres. Si ambos conviven con sus hijos. Si convive un solo padre. Cuál de ellos. Si la convivencia con ambos o con un solo padre es inestable o estable. De acuerdo con la integración, cómo es la organización de la familia. Cómo es el desempeño de los roles materno-paternos en relación con sus aptitudes y con sus ocupaciones. Quién y cómo y de qué áreas se ocupan de sus hijos.

En cuarto lugar, el *estado madurativo* de la familia. En este ítem el pediatra deberá tener en cuenta que la familia es un organismo vivo con evolución propia y por ende con logros madurativos. Este hecho plantea causas intrínsecas de desajuste. Así, deberá tener en cuenta si la pareja está bien consolidada o no. Si se encuentra atravesando una de sus normales crisis de maduración. Por ejemplo, si está frente a su primer hijo, cómo se está

dando el desempeño de las funciones de maternalización y paternalización. Si está sobre el segundo o el tercer hijo, cómo absorbe el impacto disruptivo. Cómo sobrelleva la pareja éstas y otras situaciones liberadoras de ansiedad. Cómo asume los logros de la individuación de los hijos. Si el duelo que significa lograr el crecimiento es abarcable o desequilibra la homeostasis familiar. A qué mecanismos apela para reestructurar ésta. Si está frente a la pubertad o la adolescencia y la crisis familiar a que conlleva. Si la pareja enfrenta su climaterio vital, etcétera.

Luego deben tenerse en cuenta causas extrínsecas del desajuste, muertes, reveses económicos, ocupacionales, mudanzas, intervenciones quirúrgicas, enfermedades de los padres. Accidentes.

En quinto lugar, la *perspectiva* que se otorga a sí misma la familia. Tiene que ver con las fantasías con que se viven y proyectan a sí mismo hacia el futuro. Qué valores jerarquizan y privilegian. Qué esperan de sus hijos. Qué les exigen. Qué se exigen a sí mismos como padres. Qué estilo de crianza prefieren. Qué sistemas de cuidados establecen. Qué criterio de salud tienen, cómo lo aplican. Deberá evaluar también el grado de logro entre lo anhelado y lo producido, etcétera.

Finalmente, todo este conglomerado semiológico deberá ser anotado mentalmente por el pediatra. Incorporarlo como dato patrón, confrontarlo en cada una de sus intervenciones sobre el grupo familiar y cruzarlo como variable según cuál sea la operante en cada circunstancia, con la situación del niño. De allí, extraer el verdadero diagnóstico pediátrico. Y esto le permitirá trabajar con el respaldo etiológico productor de una atención médica integral de un ser humano (Fig. 3).

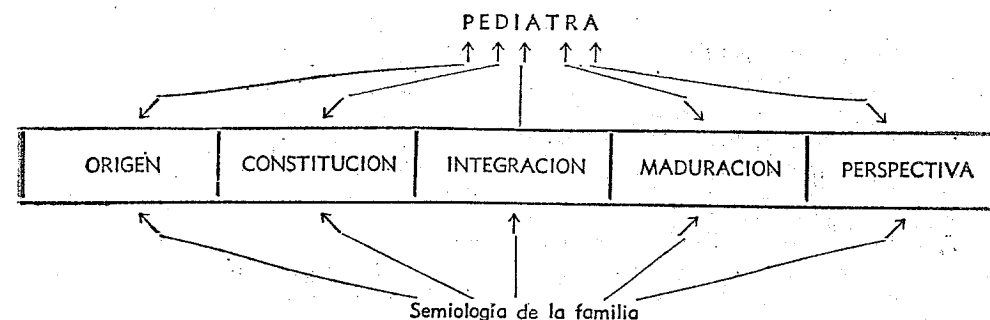


Figura 3

Datos semiológicos de la familia que el pediatra debe tener presentes para cruzarlos como variable en el diagnóstico

SUMMARY

Humans have the most complex psychological organization of all living beings. They may be perceived as individuals of the species when, being separated from the body of the mother, they are morphologically differentiated. But they are absolutely dependent upon mature individuals of the species to preserve their lives, and in fact, in order to be recognized as human, they must undergo certain psychic processes. Humanization then is produced in the intimate interchange between the baby and the people who surround him. The interplay between his hunger for filling and the providing medium lays the foundation for early psychism, the structuring of the mental organ. The affective bond between adult and child becomes a link acting very much as the umbilical cord, an intangible but vigorous vehicle for transporting affective resolutions and frustrations, etc., providing the child with models for resolving his physical and psychic needs. The failure of the familial matrix will introduce mental or physical illness, perhaps even death or insanity. The "social nature" of man is based on progressive transformations that provide him with mediating mechanisms that regulate his own demands, permitting him to preserve himself and requiring him to preserve the other.

The family serves not just as a matrix for humanization, but for individuation as well. This dynamic matrix has several axes of movement and two speeds of maturation (slow for the containing system, fast for the contained one). There are specific requirements at each for the different goals that are to be attained. Taking these into account in a semiology of the family allows the pediatrician access to new areas of prevention and treatment.

Grupo de padres

OCTAVIO FERNANDEZ MOUJAN

Médico Psiquiatra. Psicoanalista. Director del Centro Médico Psicológico
Buenos Aires. Oro 2630, Buenos Aires, República Argentina.

CRISTINA RAVAZZOLA DE MAZIERES

Médica psiquiatra. Psicoterapeuta del Centro Médico Psicológico
Buenos Aires. Oro 2630, Buenos Aires, República Argentina.

Introducción

Creemos que el surgimiento de la adolescencia dentro del grupo familiar es un desafío a la capacidad de efectuar cambios estructurales que permiten a padres e hijos buscar una nueva forma de comunicación y juntos alcanzar "la nueva" identidad familiar y personal.

"La crisis de la adolescencia" coincide con "la crisis de la edad media de la vida" de los padres. Esto convierte a la familia en el ámbito fundamental para entender y superar este proceso existencial y a veces psicopatológico.

Cada vez estamos más convencidos de la importancia de la inclusión de los padres en el tratamiento de los hijos adolescentes. Esta inclusión no la fundamos solamente en la necesidad de entender, desde los padres, la crisis adolescente y ayudarlos a

facilitar todo lo posible una ayuda eficaz. Además pensamos que la crisis es también de los padres y de la familia.

Ayudar a los padres a entender su propia crisis ante el hijo adolescente, los ayudará sin duda a rescatar la pareja matrimonial como núcleo fundamental de la familia en un nuevo período: la adolescencia de los hijos.

Por extensión natural los padres llegan a encontrarse con su propia crisis personal ante la "edad media" de la vida.

La toma de conciencia y el apoyo mutuo entre los padres, es lo que nos llevó a proponerles reunirse con ellos en un grupo. De esta manera, ayudando a los padres a enfrentar *ellos* la crisis, hemos evitado "delegaciones" perniciosas a terceros del cuidado de los hijos, en momentos cruciales para la vida familiar.

Pensamos que:

Así como al adolescente el grupo de padres le proporciona el ámbito de desarrollo por excelencia, donde puede explorar, ensayar, comparar e intercambiar conductas, vivencias e imágenes indispensables para el proceso de construcción de su identidad, así también los padres de hijos adolescentes pueden encontrar en el grupo de parejas de pares una estructura terapéutica adecuada para la elaboración de las propias circunstancias vitales que se dan en ellos, paralelamente a las de sus hijos.

Esta *crisis de identidad* de toda la familia, que se da en las tres áreas, biológica, psicológica y social, forma parte del proceso que culmina con la "entrega" del hijo a la sociedad, lo que constituye el segundo parto: la adolescencia, el parto social, desde una madre-familia, hacia un tercero social, proceso para el cual es necesario que en el seno de la familia se produzcan modificaciones sustanciales del modelo simbiótico madre-hijo de las primeras etapas de la vida.

El grupo de padres proporciona un espacio, un ámbito transicional que representa, por un lado, el medio social con sus valores y su cultura, y por el otro lado a los propios padres, que pueden verse a sí mismos participando en el proceso de "retención" y "entrega" de sus propios hijos y los de los otros.

A lo largo del proceso grupal, los padres van viendo a los hijos como hijos de todos, tomando a los hijos de los otros como hijos propios, creando un espacio común, neutral, donde hay mayor

discriminación y distancia, y pueden manejar sus emociones con más objetividad. Se hace la experiencia de "compartir" el hijo, mirarlo con los ojos de otros padres, y es esta imagen devuelta por los compañeros, pares, la que los ayuda a crear una imagen más integrada, menos fragmentada, del hijo adolescente en tanto persona. Ya no se toman como "ofensas" personales los trastornos de conducta, sino como intentos patológicos de una mayor autonomía.

Los otros padres rescatan aspectos del hijo que los propios padres no pueden ver, cegados por las ilusiones que han depositado en ellos.

En el grupo se posibilita la confrontación de las distintas organizaciones familiares que lo componen. Paulatinamente, el grupo va introduciéndose en esas familias, creando con la confluencia en su seno de las imágenes de hijo y de pareja aportadas por todos, una imagen nueva, que hemos llamado "el hijo común". La serie de fenómenos terapéuticos que se inscriben en el proceso que describimos permiten a cada familia una apertura progresiva hacia la comunidad, lo que significa salir de un mundo íntimo, "materno", para relacionarse con otros representantes sociales, con lo que los padres van entendiendo y realizando el mismo proceso que paralelamente deben realizar sus hijos, al desprenderse de la relación simbiótica primitiva e integrarse, con características diferentes en cada etapa, en el mundo de los otros.

Dinámica de las sesiones

Los grupos de padres evolucionan generalmente a lo largo de cuatro períodos a veces claramente definidos y que comúnmente se suceden unos a otros.

El primer período está dedicado al tema de los hijos y hablan exclusivamente de este tema. Es un momento básico, muy importante para la creación del clima de cohesión y confianza necesario para lograr los objetivos del trabajo.

El segundo período se centra en el vínculo de los padres con los hijos y se imbrica generalmente con el tercero, en el que el grupo se dedica a la relación de los padres entre sí.

Y finalmente el cuarto período se define por la predominancia de preocupaciones que ahora tienen que ver con cada uno de los miembros del grupo como persona, teniendo en cuenta que cada uno está pasando por su propia "crisis de la edad media de la vida".

El pasaje de cada momento al siguiente marca jalones de mucha relevancia en la evolución de los grupos.

Hay grandes variaciones entre los distintos grupos pero pueden rescatarse algunos fenómenos más comunes.

En las primeras sesiones hay dificultades para presentar a los hijos al grupo. Supone presentarse como padres y como familia y es necesario previamente una labor de coordinación terapéutica que les dé confianza y les disminuya sus ansiedades y sus culpas. Mientras tanto los hijos quedan "retenidos", guardados muy celosamente por sus padres.

Las primeras manifestaciones tienen una modalidad defensiva. Los padres cuentan experiencias en que se muestran como "modelos" para ser tomados en cuenta por los otros, o hazañas patológicas del hijo expresadas en forma muy distante con respecto a ellos mismos para no ser relacionados con ellos. Es decir, se defienden del grupo como un representante de lo ajeno, lo temido, lo peligroso.

También en ese período buscan al coordinador como un padre ejemplar, que les transmita normas salvadoras, semejantes a las vividas como provenientes de la autoridad * segura e inapelable de los propios padres de la infancia.

Vienen con la creencia de que la crisis que están pasando se superará con un orden impuesto. Buscan normas para aplicarlas pero se dan cuenta de que esto no basta, que el fenómeno es mucho más complejo y que ellos mismos se encuentran involucrados.

Durante este período en el que el grupo se maneja "retentivamente" con los hijos, la dinámica grupal aparece plena de dramatizaciones espontáneas de los roles padre-hijo, o de los roles madre-hijo. Casi no hay relatos. El hijo es sentido "adentro" de los padres y proyectado en algún interlocutor, generalmente otro padre miembro del grupo, que se hace cargo de la proyección.

* Este concepto de autoridad se desarrolla en otra parte del mismo trabajo.

Al señalarse las ansiedades y los temores de los padres de "entregar" a su hijo al grupo, se va permitiendo el proceso gradual de creación de ese espacio común, visualizado cada vez más como ámbito de elaboración de la nueva situación de la familia que hace que la pareja tenga que encontrar nuevos sentidos al vínculo matrimonial, ahora ya no justificado sólo como núcleo de crianza de hijos. Muchas veces las conductas patológicas de los hijos adolescentes sirven para prolongar la situación de la familia de crianza y proteger a los padres del enfrentamiento como pareja.

En el grupo se cuestionan roles genéricos de madre y padre. Al principio las madres aparecen aferradas al rol de madres de hijos pequeños, "dueñas" de los hijos, no dispuestas a dejar acercar a los maridos a este campo propio de dominio sobre los hijos, "área de influencia" doméstica, y de la cual el hijo adolescente necesita salir.

Pero ahí es donde necesita la ayuda del padre, el que siempre salió del seno de la casa pero que es hasta ahora un desconocido que nunca entró y tironeó del hijo para desprenderlo del ámbito antro-materno.

Es en el grupo de padres donde la madre se encuentra con muchas madres, no todas con la misma intensidad de temor a desprenderse del hijo que las ayuda a esconderse detrás de él, y también hay muchos padres, no todos con la misma culpa de sacar, arrancar ese hijo de adentro de la madre, (que pierde así la fantasía incestuosa de haber concebido el hijo con su propio padre). El hijo necesita que el padre asuma, fortalecido en el grupo por sus pares, el rol de compañero de la madre, partero de su propio hijo, que lo reclame y le dé derecho a una existencia en la realidad. La intervención de los otros va poniendo una distancia útil entre los miembros de la pareja, que van reconociendo un padre-marido-genérico y una madre-mujer también genérica.

Así puede verse cómo en diferentes etapas de la evolución de la pareja, la mujer ha oficiado como madre de sus hijos y también de su propio marido, a veces asustado e inerte frente a la fragilidad y a la gran necesidad de los hijos cuando pequeños; y cómo el hombre jugó el rol de padre de sus hijos y también de su pro-

pia mujer, apoyada como y con los hijos en él que salía fuera de los límites de la familia a conseguir los suministros necesarios.

Quizá como realidad puntual esta situación aparezca siempre en nuestra estructura familiar, pero para que el adolescente pueda ir volcándose al medio social más amplio, saliendo de los límites de la familia, necesita que los padres sean capaces de verse en sus propias dificultades, no usándose para realizar fantasías edípicas infantiles sino funcionando como compañeros pares que son, capaces de asumir sus potencias pero también de enfrentar con valentía sus impotencias (madre de Diana que no puede ir a inglés cuando Diana deja el colegio, madre de Marcelo que renuncia a una carrera universitaria pero sigue casi con él la del marido hasta que, al querer rendir exámenes, se da cuenta cuánto le cuesta y se asusta y deja).

De esta manera aparece la "pareja común", en la cual confluyen las parejas del grupo, así como antes había aparecido el "hijo común", cuyo primer indicio es el nombre de los hijos de unos en boca de los otros padres. Ejemplo: una madre le dice a un padre en un grupo, al hablar este último de su hijo Pablo, "cuando vos decís Pablo, al principio me costó entender que hablabas de *mi* Pablo porque al decirlo vos sonaba diferente". Otra le dice: "no es *tu* Pablo es *nuestro* Pablo." Se ríen todos.

Esto permite, en nuestra experiencia, una evolución del hijo adolescente sin fracturas generacionales penosas e irreparables y la consecución de un proceso en los padres de un cuestionamiento beneficioso en cuanto a su propia vida presente y futura, ahora sí ya como personas y como pareja.

En algunos casos, una vez finalizados los grupos, los padres han seguido una terapia personal, y a veces los hijos se incorporaron a tareas terapéuticas al mismo tiempo o posteriormente.

De cualquier manera, creemos que la experiencia del grupo de padres es modificadora y efectiva de por sí.

En las últimas sesiones se hace evidente que el grupo ha adoptado a todos los hijos como hijos del grupo y hay un reconocimiento cada vez más objetivo de parte de todos, de lo que cada familia trae.

"Ya sé, ustedes me van a decir que tengo que darle la llave de casa a Sandra" dice Sara "pero todavía no me animo".

"Date un plazo para pensar en *tus* miedos y hablalo con ella" le dice Ana.

Los vínculos rígidos no son solamente producto de cuestiones formales; tienen que ver con cuestiones psicológicas, que se revisan y modifican al crearse el "hijo común" y la "pareja común"; entonces las relaciones dejan de ser complementarias y descubren el "área de influencia" común donde creemos que se produce el verdadero proceso transformador.

El hijo adolescente deja de ser el depositario de las angustias que se podrían mezclar con las de la familia, el matrimonio y las personales de cada uno.

El adolescente deja entonces de expresar problemas que le son ajenos y recupera a sus padres más *unidos* y su familia en su máximo potencial de contener y elaborar cambios.

Indicaciones

Hemos visto, de acuerdo con nuestra experiencia, que las familias que más se benefician con la técnica del grupo de padres son aquellas en las que se dan las condiciones que pasamos a describir:

a) Las estructuras familiares esquemáticamente constan de una madre sobreprotectora, estrechamente ligada a los hijos, que juega con estos roles delegados en ella por el padre, quien se mantiene hasta cierto punto ausente, no vinculado directamente con los hijos.

En la medida en que la familia mantiene sus roles rígidamente y no puede realizar un proceso de revisión y modificación con la adolescencia de los hijos se intensifican los procesos defensivos de la estructura familiar tal como está, y esto es a costa de tremendos desgastes, grandes rebeldías o sometimientos alienantes.

Una estructura familiar puede haber funcionado exitosamente durante la niñez, pero es la rigidez, el no cambio, la imposibilidad de "reacomodación" de la familia, al llegar los hijos a la adolescencia y los padres a la edad media de la vida, lo que hace que se cristalicen en su seno una o varias patologías de sus componentes. Los padres rígidos no permiten el acceso a

la familia de los valores y normas de la cultura adolescente que les movilizan, en esa etapa también crítica para los padres, todos los temores a perder su rol protagónico familiar y a tener que ceder el lugar a la generación siguiente. Los padres en el grupo de padres se solidarizan y pueden ayudarse a aceptar estos cambios inevitables, pero muy penosos de sobrellevar.

b) El grupo provee de pares y resulta eficaz terapéuticamente también a aquellos padres abrumados por conductas muy violentas y antisociales de los hijos, que los llevan a situaciones de violencia incontrolable, para cuyo control necesitan recurrir a las instituciones de la comunidad que cumplen con esa función que ellos no supieron asumir, y que necesitan ser contenidos y reforzados en esos aspectos de su rol por un ámbito más próximo a la propia familia, que les dé seguridad sin el monto de culpa y de impotencia que implican las soluciones institucionales.

c) También hemos incluido padres cuyos hijos, motivadores de la consulta, se niegan a ser tratados y el único abordaje posible se vislumbra a través de los padres.

d) Padres en cuya consulta aparece encubierto un temor al destino de la pareja, una vez cumplido su rol de pareja de crianza, que necesitan redefinirse como pareja, descubrir un objetivo para la pareja más allá de la crianza de los hijos a la que han estado dedicados.

e) Familias cuyo funcionamiento denota la inclusión del hijo en el seno de la pareja de los padres, donde no sólo los padres deben elaborar los progresivos desprendimientos del hijo adolescente, sino que tienen que hacer un proceso, indispensable para el adolescente, de valoración y defensa de la privacidad de la pareja, proceso que vemos que se cumple más fácilmente en el grupo de padres que en las terapias familiares, en las que el hijo está presente.

Queremos señalar como *contraindicaciones*, específicamente en la adolescencia: a) la inclusión de padres o madres separados, debido a la necesidad del adolescente de visualizar a sus padres unidos y fortalecidos entre ambos, y también por la necesidad de los padres de asumir roles sexualmente bien definidos frente al hijo adolescente, que demanda esto como indispensable para el

proceso de adquisición de su propia identidad sexual definida; y b) si las edades de los hijos no resultaran realmente pares, de tal manera que los padres no pudieran compartir francamente con los otros su momento como padres.

Conceptualizaciones teóricas sobre la dinámica y el efecto terapéutico

Trataremos de conceptualizar algunos aspectos que consideramos centrales para entender la dinámica de estos grupos y sus efectos terapéuticos.

Ya dijimos que al comienzo de las sesiones la tarea era la "entrega" del hijo-problema, y que luego se daba lo que podríamos llamar el surgimiento de la imagen del "hijo común". Posteriormente se ponen mucho más sobre el tapete los conflictos en la pareja de los padres como tarea a resolver. Esto último da pie para que la "crisis de la edad media" de ambos padres se plantee claramente, al constituirse individualmente como "partes" de una totalidad que es el Grupo.

Esto que ponemos cronológicamente, marca los énfasis, lo que no quiere decir que se den los tres niveles (hijo-problema, pareja matrimonial y padres y madres) que interactúan separadamente, pero que están presentes simultáneamente; pero no se hacen conscientes simultáneamente y menos aún se constituyen en "el centro" del problema del propio proceso grupal.

Partimos de la idea de que la familia como grupo, para cumplir con su función de criar a los chicos, requiere de una estructura particular diferente de la que necesita para ayudar a sus hijos a ir "saliendo" hacia su propia vida.

La primera función (crianza) requiere roles mucho más fijos y separados de padre y madre, y el rol del hijo aparece como centro del seno familiar y, hasta diríamos, constituye la familia como tal.

Nos es importante diferenciar pareja matrimonial de grupo familiar; la primera está integrada dentro de la segunda y esta última nace al constituirse el nuevo centro organizador: el hijo. Los hijos organizan la estructura familiar al proponer a sus pa-

dres, unidos por el vínculo matrimonial, tener que modificar sus roles y disponerlos también para la crianza. Esta estructura se desarrolla sin grandes modificaciones hasta que el primer hijo llega a la adolescencia (no hasta que llega a la pubertad) pues cuando llega se produce dentro del seno (estructura) familiar un cambio fundamental en su función: ayudar al hijo a integrarse socialmente y constituir una nueva familia donde ellos mismos serían los padres.

Sostenemos que es recién desde los "15 años" cuando los hijos plantean una crisis muy particular en el seno familiar, es la que nos interesa tratar aquí someramente y poder así entender mejor qué pasa en un grupo de padres de hijos "adolescentes".

Tenemos que considerar cuatro aspectos en la consulta de estos padres: 1) características del hijo-problema; 2) otros hijos; 3) rol de la madre; 4) rol del padre. Generalmente nos encontramos que los roles del padre y de la madre son muy rígidos, como así también el del hijo-problema, el cual presenta un "síntoma" cargado de significación. Encontramos a las madres adheridas a las funciones típicas del hogar, muy desconectadas del rol del marido fuera del hogar para proveer el sustento. Los padres, por otro lado, se mantienen alejados del hogar, sirviéndose de sus esposas como intermediario para "comunicarse" con sus hijos. Cada uno mantiene un "área de influencia" que podríamos categorizar esquemáticamente como "dentro" y "fuera" del hogar y el trabajo social respectivamente. Encontramos un hiato entre ambas áreas que explica determinadas conductas patológicas del hijo-problema.

El hijo denuncia la ausencia de una fluida comunicación entre la familia y la sociedad, que muchas veces también denuncia una análoga incomunicación entre el padre y la madre. Este hijo puede rebelarse al rol materno y dedicarse a una actividad social exagerada, que fácilmente degenera en una desadaptación social y familiar, lo que agrava mucho más sus propios problemas. Puede también presentar una fuerte inhibición social que le impida iniciar su propio camino hacia la juventud y la socialización afectiva y laboral; estos adolescentes también fácilmente degeneran en desadaptaciones familiares y sociales de otras características, algunas de las cuales describimos en otro lugar

de este trabajo, donde ejemplificamos algunos de nuestros pacientes.

El problema lo caracterizamos sintéticamente como que el hijo-problema denunciaría la rigidez en la estructura de los roles sociales familiares, que provocaría en el hijo adolescente un "salto en el vacío" de consecuencias, generalmente, negativas: porque no se desarrolla por la inhibición o porque realiza hiperdesarrollos compensatorios.

Los padres vienen desorientados porque han perdido la orientación que hasta ahora tenían durante la educación de los hijos pequeños. Pretenden valerse de una orientación normativa social que compense la ausencia de una comunicación fluida con el afuera. Por esto en las primeras sesiones insisten en las normas que les resolverán el problema.

Como decíamos, hay un "vacío" entre la estructura familiar y la social. Les cuesta entender que "perder" al hijo dentro del "grupo familiar" es recuperarlo dentro del "grupo social".¹

El grupo de padres aportaría el espacio intermedio entre ambos grupos, convertiría ese vacío desorientador en un espacio que proporciona los elementos para el surgimiento de una "autoridad" que, sin oponerse a la social, propone "objetivos de vida" propios, que les permite entrar en un diálogo con las presiones sociales, y poder entonces orientarse desde lo más interior del seno familiar.²

Antes de profundizar sobre este tema de "la autoridad" diremos que el grupo de padres se constituye como una zona ilusoria que se ofrece como si fuera el grupo social, al hacer posible la entrega del hijo real y el "deseado" en un contexto imaginario que va permitiendo dar un rodeo a la dura realidad del desprendimiento y del cambio. Estas figuras imaginarias son: el "hi-

¹ Suponemos que esto tiene que ver con la teoría kleiniana del "pasaje" de la madre al padre en la primera infancia.

² Cuando decimos que la familia es la base de la sociedad, lo decimos en un triple sentido: 1) por su origen histórico 2) porque proporciona una imagen de "autoridad interior" insobornable que permite un "mundo interno" capaz de mayor decisión y 3) su estructura y sus miembros constituyen el primer ámbito social.

jo común", las parejas matrimoniales en común y los padres y madres en un grupo común.

Como podemos observar, se constituyen tres configuraciones que van modificando la rigidez con que se presentan estas familias en conflicto. La primera nueva estructura surge con "el hijo común", que rompía con el viejo vínculo con "el hijo-problema" fuertemente adherido a la vieja estructura familiar que denuncia, pero que simultáneamente agrava, su rigidez de roles. Además no aportaba ninguna nueva "autoridad".

La segunda nueva estructura la aportan las parejas matrimoniales en común, lo que rompe el rígido vínculo de roles sociales que impedía una mejor comunicación entre los padres y, lo que era peor, se unen en el problema pues temen un cambio entre sus roles por carecer de vida interior en la pareja, que los oriente, ante una eventual crisis. El grupo como unión de matrimonios fortalece a éstos como tales y les permite afrontar con coraje un cambio necesario, que solos sería imprudente realizar, pues llevaría a enfrentar lo que podría hacerse confrontando.

Por último tenemos la tercera nueva estructura, que es un grupo de padres y madres, que los enfrenta como personas ante sus propias rigideces y conflictos con el pasado. Nos es común funcionar como un grupo terapéutico donde surge la necesidad de analizar la crisis de la edad media de cada uno de los padres, íntimamente ligada a "la crisis de la adolescencia".³

La "crisis de la edad media" también propone un triple duelo, como para los adolescentes: 1) Los padres están, generalmente, alrededor de los 40-45 años, que en el nivel biológico significa un declinar del cuerpo. El cuerpo, como para los adolescentes, es una preocupación que hay que superar. 2) Los padres tienen que dejar la vieja estructura familiar centrada en la crianza de los hijos que, cuando es problemática, descentra la atención de los problemas propios del vínculo matrimonial. En algunos casos el "hijo-problema" llega a ser necesario para ocultar serios problemas en el matrimonio. Demás está decir que para el adolescente también es problemático dejar la vieja estructura familiar.

³ Cuando hablamos de crisis nos referimos a crisis vitales, que generalmente promueven los cambios fundamentales en la vida personal.

El tercer centro de cambio está en la realización personal. Como el adolescente, los padres, especialmente las madres, se plantean su futuro una vez que sus hijos no necesitan de sus cuidados. Pero lo que les es más duro afrontar, es tomar conciencia de lo no realizado en la mitad de cada vida. Es básico ayudar a aceptar las limitaciones y pérdidas para enfrentar lo que falta sin lamentos y temores, generalmente puestos en la vejez y la muerte.

Son conocidos por nosotros los temores adolescentes por la muerte y el futuro; muchas veces encubiertos, pero siempre presentes en cualquier forma sintomática.

Lo común es que, tanto a los 40 años como a los 15, "lo desconocido" se presenta amenazante cuando no nos podemos desprender de compensaciones caracterológicas que encubren un miedo al cambio, por carecer de "imagen" interior de "autoridad". Así volvemos al tema de "la autoridad" y a entender mejor la necesidad de una imagen interior orientadora. Está claro cómo padres e hijos tienen muchos motivos para estar confundidos cuando están en crisis, y lo importante que es discriminar familia y matrimonio, crisis adolescente y de la edad media y, junto con esta discriminación, poder descubrir una nueva integración establecida por necesidades sociales y surgidas de la propia estructura personal (identidad), vincular (matrimonio) y grupal (familia).

A esta integración proponemos llamarla "autoridad".

La "autoridad" (no social) proviene de la tradición familiar, la experiencia de la propia familia y la aportada por los adolescentes. El pasado aporta sus "objetivos de vida" orientadores a través de los abuelos; el presente hace su aporte a través de los padres y la cultura actual que representan y también está presente el futuro, que aportan los adolescentes como representantes de la nueva generación.

Es una imagen orientadora que hay que captar, no una norma que hay que acatar; es en el grupo donde esta imagen se constituye desde su propia estructura mítica que se va captando desde los aportes, primero de un "hijo común" que es una imagen vivenciada luego de ser "entregado" (el hijo real y el deseado) y rescatado por el grupo, como fruto de una elaboración de desprendimiento.

Tenemos presente cuando una madre le dijo a otra, luego que ésta costosamente había hablado de las conductas graves de su hija "¡a pesar de todo lo malo que contaste de ella, qué polenta y ganas de ser que tiene!". La madre de la paciente comentó que sintió mucho alivio luego de hablar. Nosotros decimos: y de haber "entregado" y "rescatado" su hija, en una nueva imagen que le aportaba el grupo. El grupo enseña a "ver" lo que por ansiedad y confusión no pueden ver.

Lo objetivado del hijo en una nueva imagen que le aporta el grupo permite la discriminación y la tolerancia a la "renuncia" del hijo por ser transaccional. Y también permite a los padres tomar conciencia de cómo problemas que les son personales o del vínculo matrimonial influyen en los problemas del hijo.

El otro nivel estructurante del grupo es "el grupo de matrimonios", donde también surge una nueva imagen, la de la pareja común, que también surge del campo imaginario del grupo, influido permanentemente por las rigideces de cada matrimonio en particular, lo que permite una nueva forma de comunicarse no tan social y mucho más como parte de un todo, lo que quita el carácter de ofensa personal a cualquier crítica.

Recordamos una sesión en la que se estaba "descubriendo" la importante influencia de la entrada del padre en "la mesa familiar" (área de influencia materna) y durante un espacio importante los padres, en tono irónico, marcaban a dos madres ridículas que les hacían rechazar la hora del encuentro en la mesa (se referían a ciertos modales). Todo fue tomado a risa por el grupo, que se había dividido en hombres y mujeres como una "gran pareja"; el grupo diluyó lo que podía tomarse como ofensa personal, porque lo personal no existía sino a través de la imagen del matrimonio común. Este clima de experiencia común nos entregó una imagen de madres aceptando su temor de compartir su área de influencia, por dudas respecto a qué será de ellas si ese rol no las absorbe. Esta tolerancia era posible porque la imagen grupal de "la madre" la constituían otras madres que ya habían pasado por ese trance y, aunque no fuera así, porque apareció un nuevo "objetivo de vida" orientador, es decir una "autoridad" surgida del símbolo "la mesa" como lugar común y de encuentro que todos los padres tenemos que facilitarnos y facilitar a nuestros hijos.

Por último nos queda comentar el tercer nivel estructural del grupo y también formador de imagen de autoridad, es el grupo como unidad de personas. La "participación" de cada uno en una experiencia común inconsciente, que llega a manifestarse al concretarse en una imagen que se puede interpretar. Lo que nos interesa profundizar son las "escenas" que tienen que ver con la "crisis de la edad media" pues son las que los padres más necesitan discriminar de las surgidas ante la "crisis" de los hijos adolescentes.

La madre de una adolescente muy grave comenta en una sesión que uno de los terapeutas no la atendió como debía ante una crisis grave de la hija (crisis que podía pasar ante ojos profanos como psicótica, pero evidentemente era una histérica con núcleos psicóticos) y lo hubiera acusado si la hija se hubiera suicidado; luego, en el relato, comenta que el marido dormía aunque la hija estuviera en pleno ataque. Los otros padres le devuelven con otra interpretación los hechos que ella misma había relatado, más algunas aclaraciones de los hechos dados por el terapeuta. En un momento pudimos interpretar un hecho que se hacía evidente, que la madre de la adolescente estaba acusando a su marido de presunto asesino por no intervenir en la relación de ella con su hija, que si seguía así terminaría con la muerte de su hija (al poco tiempo ella realiza un aborto contra la opinión de su marido y con el apoyo de su propio padre). Lo que queremos rescatar aquí es la imagen de autoridad que surge de esta sesión. El rol fundamental del padre como discriminación de la simbiosis madre-hija (reflejo de la adhesión de la madre a su propia familia); rol difícil de asumir por la culpa que trae en un primer momento ("asesino"). Su no intervención no sólo no permite que la hija se discrimine de la madre, sino que tampoco su esposa se discrimine de su familia de origen.

Este es un caso típico de cómo los problemas personales de la madre y también del padre (por su tímida intervención) determinan la enfermedad de la hija y el grupo, como "grupo terapéutico", permite esclarecerlo, ayudando así a toda la familia. Después de esta sesión la imagen de "autoridad" de un padre discriminador ("partero" lo llamamos en otra sesión) se hizo fundamental.

Como vemos, no es una autoridad social tipo norma exterior, sino que surgió del mismo seno del grupo y marcó un claro obje-

tivo: discriminar para rescatar la vida personal. No sólo del hijo sino también (en este caso) de la propia madre, que confesó no saber hacer otra cosa que criar chicos menores.

Toda "imagen" es fundamentalmente "una configuración espacio-temporal con sentido" sobre la que se desarrollan escenas que expresan el conflicto subyacente en todas sus formas.

Nosotros partimos de la idea central de que estos grupos los forman matrimonios con enormes rigideces en sus roles, lo que hace que el cambio sea vivido, no como un desarrollo o crecimiento, sino como una catástrofe ante "el vacío" que hay entre "el afuera" y "el adentro" del grupo familiar.

Los conflictos parten de este "hiato" (disociación) entre el afuera y el adentro, el antes y el después, lo personal y lo común. Dentro de esta estructura patológica (por su carácter rígido), básicamente desorientadora, surge la necesidad de un espacio intermedio que los integre a través de lo imaginario, creando una imagen de "autoridad" que oriente desde la relación. Este espacio imaginario intermedio tiene, como vemos, una función básicamente integradora.

Esto explica por qué nos interesa el grupo de padres de adolescentes en sus tres niveles terapéuticos: (hijo común, pareja común y grupo común) pues cada uno de ellos resuelve la disociación tan marcada. El "hijo común" rompe "el de antes" y "el de después" como separados. Construye un hijo que es el mismo de la infancia y de la adolescencia, el deseado y el real, el de la madre y el del padre (como imagen). Se construye un matrimonio que rompe con la rigidez del padre "afuera" y la madre "adentro"; ambos están adentro y afuera y ambos, unidos, están dentro y fuera de la familia, es decir, reconocen una autonomía relativa respecto de los hijos (intimidad). Construye además un grupo común haciendo pedazos la antinomia individuo-grupo, familia-sociedad, padre-madre e hijos. Todos participan de un todo del que surgen las "imágenes" orientadoras, no impuestas, sino compartidas.

La responsabilidad compartida entre los padres en el grupo se convierte en la vida cotidiana en responsabilidad compartida entre marido y esposa y entre padres e hijos adolescentes. Lo que era enfrentamiento gira hacia confrontaciones con un "objetivo de vida" compartido.

Ejemplo clínico

Pasaremos a referir una de nuestras experiencias, relatando en primer lugar cómo se constituyó el grupo, y luego la síntesis de una sesión, con su comentario correspondiente, así como a desarrollar más detalladamente los pasos en la evolución de una de las parejas miembro del grupo.

Vamos a hacer una breve reseña de cada uno de los núcleos familiares que componen el grupo, con una descripción diagnóstica de los hijos por los cuales se efectuaron las consultas, un diagnóstico familiar y una ubicación acerca de las características de los padres.

Al principio este grupo sesionó con tres matrimonios: los G., Tomás y Mónica; los C., Sara y Emilio y los B., Pedro y Ana.

Los G. consultaron fundamentalmente por la hija mayor, Diana, de 16 años, que había estado en tratamiento psicológico desde los 4 años. Era nerviosa, muy miedosa, tartamudeaba, funcionaba muy mal en el colegio, mostraba gran hostilidad con su madre principalmente, también con su padre y sus hermanos y no había logrado superar el síntoma que más angustiaba a su madre: la enuresis. Tiene dos hermanos menores, Elena, de 15 años y Julio, de 10.

El padre interviene poco en el diálogo y es la madre la que se muestra muy ansiosa y preocupada, muy alarmada ante las experiencias amorosas de la hija, que relata como si fueran vividas por ella misma.

Tomás y Mónica se casaron muy jóvenes, se conocen prácticamente desde niños y acerca de sus respectivas familias de origen relatan que la de Mónica era muy rígida y muy formal, con normas muy estrictas, mientras que en la de Tomás las relaciones eran más laxas, más permisivas.

El es comerciante, ella es ama de casa, con dificultades para emprender tareas fuera del hogar. Tomás es un padre ausente, al que le cuesta intervenir y participar, y Mónica es quien toma decisiones en la familia. Diana reclama insistentemente la presencia y la participación del padre, pero éste está acostumbrado a delegar ese rol en Mónica.

Se les indicó el grupo de padres porque habían probado gran cantidad de tratamientos sin ningún resultado y Diana se negaba a probar una vez más.

La decisión se tomó en función de algunos índices tales como:

- 1) el estrecho vínculo entre la madre y la hija;
- 2) la deficiente relación de la madre y el padre con respecto a los hijos;
- 3) el hecho de que era posible abordar la situación desde los padres.

Los C., Sara y Emilio, consultaron por su hija Sandra. Tienen 2 hijos, Sandra, de 18 años, y Luis, un año menor. Emilio y Sara han sido siempre muy dedicados a su trabajo y son una pareja aparentemente armónica.

En las primeras sesiones Sara estaba muy poco dispuesta a dialogar, muy dolorida pero a la vez resentida con la hija, que había sido ejemplar hasta los 15 años cuando, a raíz de un viaje de los padres, comienzan las conductas descontroladas de Sandra (fugas, promiscuidad, drogas) que los llevan a mantenerla encerrada, y hasta a recurrir a la custodia policial.

Consultan porque temen que Sandra repita esa conducta y que ellos no sean capaces de controlarla.

La relación entre Sandra y su mamá era muy hostil. Emilio, muy obsesivo, muy meticuloso y rígido, se relaciona con los hijos mientras puede establecer pautas muy concretas de conducta (a través de temas escolares, por ejemplo). Sara está también muy frustrada en cuanto a realizaciones personales y desearía completar algunos estudios, pero no se anima a aflojar la vigilancia que ejerce sobre Sandra.

Se trata de una típica familia desbordada por la conducta de la hija, donde la violencia familiar no es elaborada, sino incrementada. Los padres sólo pueden "reaccionar" ante las conductas de la hija, no pueden decidir ni tomar iniciativa alguna.

Estos padres, muy rígidos, necesitan a su vez un ámbito que los contenga y contenga las imágenes de Sandra y les permita respuestas más elaboradas, menos reactivas, ámbito que se logra en la relación con los otros padres del grupo.

Los A., Pedro y Ana, vienen al grupo mandados por el tera-

peuta de su hijo. Esteban es hijo único; tiene en este momento 17 años y han consultado por un problema escolar.

Los padres, muy ansiosos y con grandes expectativas acerca del hijo, muy temerosos de que estas expectativas se vean frustradas, muy temerosos de que su hijo resulte alguien mediocre y poco valioso, consultan asustados por la evolución escolar de Esteban. A la vez, la madre está muy preocupada por la relación de Esteban con su novia Laura, porque lo somete y lo maneja, según su versión.

Se indicó un grupo terapéutico para el hijo con el criterio de analizar sus relaciones con sus pares y sus relaciones familiares, teniendo en cuenta la gran necesidad de esta experiencia para este hijo único. Según el terapeuta de Esteban, para éste en ningún momento apareció la relación con Laura como problema. Para él su problema serio era la posibilidad de establecer relación con pares, su cambio de colegio, su necesidad de un rendimiento intelectual diferente del que hasta ahora había tenido y su relación con sus padres, que aparentemente se manejaba así: como una relación simbiótica con la madre, muy apegados madre e hijo; un diálogo permanentemente instalado entre la madre y el hijo, pero en el cual el padre no tenía ninguna cabida.

Pedro, el padre, es obstetra. Trabaja mucho y aparentemente tiene poco tiempo para relacionarse con su hijo. En realidad, lo que aparece a través de las entrevistas de esta familia en un principio es como un temor muy grande del padre de acercarse al hijo y una conducta ya muy estructurada de los tres, por la cual Esteban aparece prácticamente como un hijo de Ana, pero casi nada como un hijo de Pedro. A su vez Ana, tan preocupada por la absorbente Laura de Esteban, se presenta llena de proyectos personales que no puede concretar, limitada a su rol de mamá de un hijo muy necesitado de ella.

Vimos que se hacía imperiosa la modificación del vínculo tan estrecho madre-hijo y la reconstrucción de la familia, ahora con la presencia y la intervención del padre, es decir, que esta estructura rígida, relación simbiótica entre la madre y el hijo por un lado, padre ausente por otro, perdiera dureza y pudieran sobrevenir así los cambios necesarios para el desarrollo de los tres.

Para esto, creemos que el grupo proporciona a los padres

alianzas con otros padres del mismo sexo, a Pedro otros padres que lo ayuden a afianzarse como padre, y a Ana otras madres que le garanticen la supervivencia de Esteban si se desprende de él, se anima a delegarlo al padre, y a realizar sus propios proyectos vitales.

Más adelante se incorporan los H., Jorge y Marta. Jorge es médico, traumatólogo; y Marta ha sido ama de casa hasta el comienzo de este año. Se presentan muy angustiados por el problema de su hijo Manuel, que es el mayor, de 19 años. Tienen tres hijos: Manuel, Mabel y Celia (de 16 y 9).

Manuel también aparece como un chico muy rechazante, muy hostil con los padres, especialmente con la madre, muy necesitado también de la calidad determinante de la actitud de su papá, que no logra, salvo a través de situaciones críticas.

Hubo episodios de grandes rebeldías, con conductas muy opuestas a los valores familiares.

Salió con grupos de adolescentes de conductas dudosas e hizo intentos violentos y penosos de irse de su casa.

La familia tenía características semejantes a los B., Manuel y su madre excesivamente ligados y un padre que había sobredelegado en su esposa su rol.

Comenzaron haciendo una terapia familiar que incluía a Manuel y sus padres, con el objetivo de que el padre tuviera una entrada efectiva en el seno de la familia y se indicó a Manuel un grupo terapéutico.

Más adelante pensamos que el grupo ayudaría al padre a definir, identificar, valorar y asumir su rol paterno y a la madre a delegar roles asumidos en momentos de necesidades de los hijos muy diferentes de las actuales, ya que eran roles muy rígidos y difíciles de movilizar con otras técnicas.

Los P., Juan y Ema, consultan por tres hijos varones, pero especialmente por el mayor, Gabriel, que es el que ha tenido más problemas y en este momento parece ir superándolos. Gabriel presentaba conductas muy rebeldes, de mucho aislamiento y de gran hostilidad también hacia los padres.

En todo momento se negó a recibir tratamiento y finalmente se indicó a los padres entrevistas, que permitieran afianzar el vínculo entre ellos.

El padre aparece con una caracteropatía obsesiva y Ema es muy insegura, con rasgos histéricos. Juan funcionaba dedicado a su vida laboral y Ema muy sola, haciéndose cargo de sus tres hijos varones, muy conflictuada por verse casi en un espejo en las conductas de Gabriel.

Se indica el grupo de padres pensando en la necesidad de esta familia de *compartir* con otros padres la idea de una modificación de los roles familiares que implique una salida del estereotipo en que se encuentran.

En el grupo, Juan y Ema son los que menos participan. Ema parece muy angustiada; por momentos sigue el ritmo del grupo y por momentos se siente muy exigida y con bastantes dificultades de acceso al tipo de trabajo que el grupo está haciendo en este momento.

El diagnóstico de Diana G. corresponde a una caracteropatía histérica grave descompensada, con marcados rasgos orales. Enurética.

El diagnóstico de Sandra C. corresponde a un cuadro muy parecido al de Diana, una histeria grave, con conductas psicopáticas graves, sobre un fondo melancólico.

El diagnóstico de Esteban B. es un cuadro esquizoide con rasgos histéricos y fóbicos.

El diagnóstico de Manuel H. corresponde a un cuadro caracteropático fóbico con rasgos histéricos y obsesivos.

El diagnóstico de Gabriel P. corresponde a un cuadro francamente esquizoide, con fracaso escolar y laboral y fuertes dependencias infantiles. En este momento está instrumentando algunas defensas fóbicas y obsesivas.

Transcribimos una sesión resumida de un grupo de padres

El coordinador lee al grupo una tarjeta dejada por Ana para el grupo, con una poesía de K. Gibrán que se refiere a la no posesión del hijo, a su pertenencia y compromiso sólo con la vida y al rol de los padres, que les permite el desarrollo en tanto los aceptan como son y los apoyan y ayudan en un clima de alegría.

Cuenta que el hijo le había regalado hacía unos años un poster con la poesía, pero que recién ahora entiende esto. El grupo comenta que conocen la poesía pero que hay diferentes niveles de comprensión en cada uno acerca de lo que plantea.

Se hace un silencio y Marta cuenta que está contenta porque participó de una sobremesa con sus hijos en la que también participó Jorge y que estuvieron jugando un juego tonto de palabras, pero muy divertidos. Jorge confirma esto, asombrado de sí mismo.

Ema lo felicita y declara que ella no aguanta la sobremesa. Juan aclara que es porque a Ema le molestan los ruidos de los chicos al comer. Se ríen porque Ema dice que es histérica y cuenta que consiguió que los mayores mejoraran pero que ahora los ruidos los hace el más chico.

El grupo le aconseja no demostrar tanto que a ella le molesta porque quizá lo hagan por eso.

Tomás, Juan y Jorge comentan risueños acerca de las manías de sus mujeres (Marta con la canilla, Mónica con los modales en la mesa).

Mónica cuenta que se sintió mal, sin ganas de venir y por primera vez ni se había vestido y Tomás la estimuló para que viniera. No tenía ánimo para nada porque acababa de llegar de afuera y Diana no había ido a buscarla, sólo Elena y Julio con Tomás.

Marta dice que la comprende porque pasó una época en la que Manuel no quería saber nada de ella, hasta no le permitió que lo despidiera en un viaje, pero aceptó que fuera el padre.

Mónica dice que quizá lo que más le dolió fue que ya habían cenado cuando ella llegó y Tomás reafirma que ése fue su criterio porque tenían hambre y el avión podía retrasarse.

Se les señala que el grupo está en pleno proceso de cambio en lo que respecta al rol jugado por el padre, que se hace muy evidente en lo que comentan Marta y Jorge y francamente en la actitud de Tomás, que no necesitó que nadie lo trajera esta vez al grupo, sino que fue él el gestor de la venida de los dos al grupo y que los padres están experimentando placer por participar de la vida familiar.

El grupo asiente, Ema recalca la diferencia con la actitud de Tomás de dormirse en medio de la crisis de Diana que relató la sesión anterior.

Mónica cuenta que discutieron mucho en Punta del Este y Tomás dice que por primera vez prevaleció su criterio y compraron cosas de colores, que dieran alegría, que Mónica elegía todo marrón o negro, muy triste.

Se le señala que ésa no es una pelea con riesgo de separación sino al contrario.

Cuentan que provienen de hogares muy diferentes, que los padres de Mónica eran muy rígidos, muy formales y muy exigentes; que es diferente aprender normas con alegría y placenteramente que por obligación.

Se habla de que paralelamente a que los padres jueguen un rol en la familia, también eso permite que la mamá juegue un rol social.

Mónica habla de sus dificultades con inglés, ya que se queda libre, igual que lo que está pasando con Diana en el colegio.

Tomás cuenta que Mónica quiere que él intervenga en las dificultades escolares de Diana pero que él piensa que Diana ya es grande y no se la puede mandar como a un chico.

Cuentan que Diana tenía una entrevista en un jardín de infantes para trabajar ahí, iba a ir con una tía que no pudo ir y postergó todo para la semana próxima.

Mónica quiere ofrecerle ir con ella pero teme que la rechace.

El grupo le sugiere a Tomás que vaya él a averiguar y acompañe a Diana al jardín de infantes.

Se les señala que la tónica de esta sesión es la importancia de la intervención del padre en la familia con adolescentes, y los cambios evidentes de algunos de ellos, Tomás, Jorge, y antes Emilio.

Comentario de la sesión

Los fenómenos más sobresalientes son los siguientes:

1) En el grupo se plantean relatos de cambios en algunos y en otros no (imposibilidad, rigidez, dificultad).

2) El grupo toma en chiste las rigideces de algunas madres, lo que le permite señalarlas.

3) El grupo marca y "vive" cambios en las actitudes de algunos de sus miembros; en el seno del grupo.

4) Se entiende, viviéndolos, la importancia de los cambios en los padres para que sus hijos se sientan "personas" en un clima de "alegría" y participación, simbolizando en "la mesa" como lugar común, donde el padre "entra" en la familia.

5) Ana aparece como la madre que *pudo cambiar* un rol en la familia y que eso le permitió afirmar su rol social. Este cambio significa aceptar a los hijos como pertenecientes "a la vida" (como lo dice la poesía) y no como posesión de los padres. No poseer permite un clima de alegría, pues permite *participar*.

6) Marta y Jorge logran un clima de *participación*. La madre no posee y entonces el padre participa. Todos participan de la alegría de la vida en familia.

7) Ema no aguanta "la mesa", "lugar común" (participación), porque los chicos hacen ruido al comer. Ema se resiste a "abrir" su "área de influencia" al marido, al no crear un clima común de participación (desplaza en el comer su resistencia).

8) Mónica, igual que Ema, tiene "manías" que el marido comenta quejándose, igual que Juan.

9) Los padres, maridos en el grupo, se asocian y se apoyan entre sí, fortaleciéndose para tomar decisiones e intervenir más directamente en la vida de los hijos, participando ellos también de la familia.

Asimismo ejemplificamos el proceso terapéutico a través de la evolución en el grupo de una de las parejas que hemos descrito, Ana y Pedro B., quienes pasaron por diversas etapas que vamos a enumerar.

1) Sus primeras intervenciones se caracterizaron por ser efectuadas principalmente por Ana, quien hablaba de las dificultades escolares del hijo, y de su sometimiento a su novia, muy absorbente y posesiva, y de su encierro social, apoyada por Pedro, que asentía en voz casi inaudible.

Se veía una marcada diferencia en los roles padre y madre, y aparecía el rol del hijo disociado entre el hijo ilusorio y el hijo real, hijo problema que expresaba así el conflicto de los padres al no coincidir con las expectativas de éstos.

La figura de mujer-madre-novia-familia, absorbía al hijo, cuyo padre no ejercía un rol que le permitiera salir de su encierro y acceder al mundo social.

Estos padres intervinieron activamente en las situaciones traídas por todos los miembros del grupo. Fueron los primeros en incluir a su hijo en el espacio común grupal, aportando sus opiniones y dificultades a lo largo de toda una etapa de difícil consolidación grupal en la que todos "retenían" posesivamente al hijo de sus ilusiones.

En una imagen que describe su conducta de entonces, relatada por ellos más tarde, aparecen Ana y Pedro haciendo alternativamente de chofer para Esteban, que trabajaba como *disc-jockey*.

2) En un momento dado, posteriormente, Ana percibe su propia necesidad de tomar distancia de Esteban y asume depresivamente las características propias proyectadas en la novia de Esteban (posesiva, absorbente).

Se cuestiona sus roles, hasta ahora de "ama de casa" y "madre", que la definen sólo en el ámbito intrafamiliar y trae relatos e inquietudes referidas a vinculaciones grupales con pares y proyectos laborales.

3) Coincidentemente, el grupo vive una etapa de gran movilización y revisión de la distribución de roles en la pareja.

Los cambios con respecto a la distribución tradicional, una madre que se ocupa de su casa y de sus hijos, y un padre que sale al mundo social a buscar suministros, se hacen presentes en el grupo a través de la mayor y más directa participación de los padres, tal como describimos en otra parte de este trabajo.

Así y todo esta conducta no fue evidente en Pedro, salvo por la existencia de asociaciones y alianzas, aunque disimuladas, con los otros padres del grupo.

Cuando Ana estuvo de viaje, Pedro no concurrió al grupo; le costaba ocupar el terreno familiar que Ana iba dejando vacante, quedaba adherido a una modalidad muy pasiva de conducta, sin animarse a tomar iniciativas.

4) Se va produciendo en ellos un proceso en el que progresivamente van discriminando sus objetivos y sus proyectos vitales de los de su hijo.

Dice Ana en la sesión en la que cuenta por primera vez acerca de la empresa que está gestando en su trabajo en el campo: "yo estoy sembrando y haciendo todo lo necesario, preparando muy bien el terreno. Dentro de unos meses será la época de la cosecha, yo me siento tranquila. Si la cosecha fracasa, es el fracaso de la cosecha, no *mi* fracaso".

A medida que ambos padres logran pasar por este proceso de discriminación del hijo adolescente, se muestran más como personas, menos pendientes de los triunfos o fracasos escolares de Esteban, más libres. Consecuentemente, el hijo se hace cada vez más responsable de su desempeño. (Esteban hace, por su propia cuenta, un curso de Orientación Vocacional y decide su carrera).

5) Esta pareja de padres, muy movilizada, trae al grupo uno de los temas claves del tratamiento grupal.

Cuentan que habían colocado una mampara frente a su dormitorio, transformándolo en *suite* y comentan asombrados la reacción del hijo, que al regresar una noche tarde, muy enojado, golpea a patadas y puñetazos la mampara que él mismo había contribuido a poner.

Este tema, clave en el grupo, alude a la necesidad de privacidad de la pareja, a poder dejar los hijos fuera de ella y queda la palabra "mampara" instituida con esta significación en el código grupal.

En las sesiones que siguieron, los B. se fueron afirmando cada vez más en estos cambios, progresando en la línea de la discriminación entre ellos y el hijo, trayendo al grupo imágenes que lo representaban más objetivamente, a veces admitiendo con dolor realidades de Esteban que no coincidían con sus aspiraciones, pero sin sentirse involucrados en ellos.

6) El último tiempo de la terapia grupal de esta pareja se caracterizó por la modificación de la conducta de Pedro, más firme, más decidido, "haciéndose oír" en el grupo, así como en su familia, con su mujer y su hijo.

Los objetivos propuestos en un principio con ellos se habían cumplido. Fueron dados de alta del grupo, incluido en este desenlace un pedido expreso del hijo de un tratamiento individual para él, ahora sí preocupado por los conflictos por los que atravesaba.

La crisis de Esteban no modifica nuestro criterio de alta, ya que se encuentra ahora con padres más discriminados, más objetivos, y por lo tanto más contenedores, habiendo asumido una imagen de autoridad nueva en la familia.

Aspectos técnicos

Antes de hablar de técnica tendríamos que hablar brevemente de los objetivos terapéuticos a los cuales está supeditada dicha técnica:

Centremos los objetivos en:

1) Redefinición de roles, 2) asunción de las ansiedades presentes, tanto de los padres, como las provocadas por los hijos, de manera discriminada y 3) el logro de una "autoridad" fundamental orientadora en la situación de crisis familiar.

La redefinición de roles tiene que ver con el nivel psicosocial en que tenemos que trabajar. Suponemos que ante el emergente "adolescencia" cambia la estructura psicosocial para que la comunicación se haga más "concordante".

Esta estructura generalmente aparece en nuestra cultura como áreas de influencia del rol madre y padre. La madre "dentro" de la familia protege y cohesiona; el padre "fuera" de la familia mantiene y "abre" la familia.

El hijo adolescente aparece con su rol equidistante entre el padre y la madre. En la infancia estaba más cercano del rol materno.

Durante este período generalmente la intervención de los coordinadores es menor, se limitan a facilitar el intercambio, ayudar a la integración grupal y señalar o interpretar la redefinición de roles.

La elaboración de ansiedades está ligada al análisis de las fantasías inconscientes que en el grupo de padres preferimos llamar "conflictiva básica", pues preferimos trabajar en este nivel más psicológico con el grupo, como la familia ilusoria que se ha ido construyendo sobre la base del "hijo común" y "la pareja común".

La tristeza, el miedo y la culpa son para nosotros las emociones básicas que hemos trabajado en estos grupos.

El último nivel que analizamos es el mítico entendido como "símbolo vivo" (R. Guénon) en una escena estructurante e inconsciente que develamos y ponemos en palabras.

Este nivel, que consideramos fundante, integra en una "imagen" (configuración con sentido) de "autoridad", las tres generaciones: los padres de los padres, los padres presentes y los hijos de estos padres. Esta imagen que se va develando orienta la resolución de la conflictiva.

Estos tres niveles de análisis: psico-social, psicológico y mítico se dan simultáneamente pero tienen sus expresiones sucesivamente más claras.

Quizá lo más evidente para la observación es el momento en que se detecta la conflictiva básica y se la interpreta. Desde entonces el trabajo en el plano psicosocial va dejando lugar al "grupo psicológico". Paulatinamente nos vamos dando cuenta de la estructura mítica orientadora.

En la primera parte el grupo trae un tema con respecto a algo relacionado con el hijo-problema, menos frecuentemente que algo relacionado con la pareja de los padres o con alguno de ellos en particular.

Por ejemplo, uno comenta que su hijo, que nunca trabajó, ni estudió, ha empezado a hacerlo. El padre comenta que teme que no le vaya bien; la esposa le contesta "vos confiá en él y no volverá atrás".

Otros padres pueden hablar de sus temores a que a sus hijos no les vaya bien.

Generalmente se desarrolla un tema a partir de un inicio; pueden tocarse varios temas que aparentemente no tengan nada que ver. La tarea del coordinador es ir mostrando el problema común que va haciendo posible el logro de la integración grupal.

Este primer período "termina" cuando el coordinador puede interpretar cuál es la conflictiva básica que están planteando.

En ese mismo ejemplo una esposa le dice a su esposo "esta vez tuviste que tomar un sedante por miedo a que S. (la hija) no continúe o fracase en el estudio que comenzó". A veces es alguien de otro matrimonio que hace el "reajuste", aquí vemos que es dentro de la pareja.

Planteada la "conflictiva básica" la tarea suele centrarse más

en los padres, y hay entre ellos interesantes señalamientos, pues algunos ya ven su problema diferenciado de los hijos; otros insisten en que sólo el hijo tiene problemas.

Siguiendo el ejemplo mencionado, se interpretó como conflictiva básica lo siguiente: que esta vez estamos hablando del miedo que tenemos nosotros como padres cuando ellos empiezan a caminar. A veces tenemos que tomar un sedante, otras nos apoyamos mutuamente. Lo importante es descubrir que desprenderse de ellos nos da miedo y les damos confianza.

Suelen incluirse luego de esta interpretación los que aún no hablaron (en la sesión) pues ven facilitada la tarea al sentirse participantes a través de un grupo integrado, expresión de la familia ilusoria.

Empieza a hacerse más claro el nivel mítico a través de la "escena fundamental" que se va dramatizando inconscientemente. Tiene la característica de que nos incluye sensorialmente a través de "la imagen" que dará sentido a la sesión, aportando el aspecto de "autoridad" orientadora en la conflictiva planteada.

La tarea del coordinador es ayudar a que todos se incluyan en el campo terapéutico interpretando resistencias y logros en la integración. Tomar conciencia, en determinado momento, de cuál es la "imagen" que los está "orientando" a todos hacia la resolución del conflicto.

Esta "imagen" no se interpreta, sólo se ponen palabras que aludan a la dramática fundamental que ha resuelto la conflictiva, porque surge del "lugar" común.

Sigamos con nuestro ejemplo; una madre comenta que lo de ella no es miedo, es temor y que no puede controlarlo. Otra le dice que en una oportunidad ella también quiso irse y callar el problema de su hija porque le daba vergüenza, "entonces me dijeron: Como madre, ¿estará dispuesta a superar vergüenzas personales para ayudar a su hija? No lo dudé y fue cuando conté las cosas terribles que hacía S." (esto de ver lo propio en otros es muy frecuente). Todo el grupo apoya, otros tratan de racionalizar, al fin cuenta que su hija es una "carga" que está igual que antes, "tengo que ocultar su colchón todo orinado". El marido puntualiza las mejoras de la hija y ella termina diciendo "yo estoy muy mal", efecto del compartir y del reajuste del rol de su marido.

La madre del comienzo dice "cargamos con nuestros hijos como mochila al hombro, no los podemos poner frente a nosotros, como ellos son y gozarlos en sus cambios", otro padre dice "verlos en sus idas, vueltas y caminar tortuoso nos da miedo".

La sesión continúa cada vez más esclarecida como "guiada" desde adentro. Se plantea al final que otra hija roba en la familia. ¿Qué sería poner palabras a la imagen fundamental o escena mítica ejemplar?

Lo sensible estructurado como un símbolo vivo es la imagen de tener a los hijos cargados arriba, viviendo de nosotros, robando quizá, pero lo que es peor calmando nuestros temores y terrores de verlos yéndose y enfrentar nuestra soledad. Mientras los vivimos como cargas no los gozamos y tampoco nos asumimos.

Al final una madre dice triunfante "nuestros hijos tienen la llave de casa", todos los felicitan, era un viejo problema que esa familia tenía. Dicho ahí es algo más que un logro formal, es haber entendido el fondo del problema. Darles la llave es darles la confianza, la de ellos, que no se la daban por miedo.

Este es el último nivel donde trabajamos, el mítico, donde "la escena" simboliza vívidamente el significado de lo planteado y su resolución. "Sacarnos los hijos como mochila" y "darles la llave", no son más que la expresión del miedo paterno.

Tememos por ellos porque no confiamos en ellos y porque no confiamos tenemos que "cargar" con ellos calcando nuestros temores por ellos y nosotros mismos.

La nueva "autoridad" o ideal de vida estuvo durante toda la sesión como estructura fundante que tenía que ser captada, develada. ¿Cuál es esa autoridad?, el valor del temor de los padres, que cuando es asumido, no negado, ni proyectado nos alivia, pues orienta al hijo confiado en sus propias fuerzas para abrirse camino; porque tiene "la llave" que los padres guardaban hasta para cuando se hicieran adolescentes.

Esquemmatizando podríamos decir que al principio somos más "comunicólogos", luego más psicoanalistas y fenomenólogos. En la práctica no están separadas estas modalidades de trabajo.

Sintetizando, podríamos hacer el siguiente esquema:

PRIMERA ETAPA: De diálogo e intercambio social a raíz de un tema que va estableciendo un "lugar" común: el hijo de todos o la pareja de los padres que todos somos. Es una tarea de reajuste de roles y de integración. El terapeuta señala o interpreta en la línea de resistencias y logros en estos primeros objetivos.

SEGUNDA ETAPA: Ya lograda "la familia ilusoria" que es el grupo, se puede entender la "conflictiva básica" que se interpreta y permite una mayor participación, pues calma ansiedades.

TERCERA ETAPA: No está tan delimitada con respecto a la anterior; el terapeuta ayuda a resolver la conflictiva con interpretaciones orientadas desde una estructura surgida del campo imaginario. Esta estructura o escena mítica no se interpreta, sino que se devela, dando sentido a toda la sesión cuando la podemos "ver". Surge del "lugar" común fundamental, sin conflictos; por eso tiene "autoridad".

Una CUARTA ETAPA, que en realidad es un agregado que alude al trabajo de reajuste que hacemos de lo visto en el grupo, con el pequeño grupo que son cada pareja de padres.

Conclusiones

Pensamos que este abordaje clínico que hemos descripto tiene especial sentido en la época en que los hijos transitan la edad adolescente, como el momento en que la conexión clarificadora entre la familia y la sociedad resulta indispensable para el desprendimiento de los hijos de un ámbito de desarrollo al otro.

Estos grupos brindan posibilidades de permanente revisión de la imagen del hijo desde una y otra perspectiva vital, y permiten que en su seno tengan lugar múltiples y sucesivos fenómenos que, al ser vividos por los padres, dan a éstos mayor comprensión hacia los hijos y hacia sí mismos.

Creemos que los grupos de padres tienen una urgencia limitada en tiempo y en posibilidades tanto de abordaje como de cambio, y que los objetivos se cumplen a veces sin una resolución en cuanto a la sintomatología de los hijos.

Consideramos a los padres de alta en la medida en que, habiendo pasado por este proceso grupal, pueden hacerse cargo de

las intensas modificaciones familiares sin angustias, con una conducta comprometida pero discriminada, capaces de comprender lo que a ellos mismos les está pasando.

En algunos casos el desenlace significa el final de una terapia, en otros la derivación a una terapia individual de alguno de los padres, o una terapia específica de la pareja, esto último especialmente en los casos en que los conflictos familiares tienen relación con la intimidad de la pareja.

Bibliografía

- MARGARET MEAD, *Cultura y compromiso*, Granica.
 MIRCEA ELIADE, *Imágenes y símbolos*, Taurus.
 O. FERNANDEZ MOUJAN, "Familia y adolescencia", *Rev. Psic. Arg.*, XXX, 1973.
 JACQUES ELLIOTT, "La muerte y la crisis de la mitad de la vida", *Rev. Psic. Arg.*, XXIII, N° 4, 1966.
 ROMANO GUARDINI, *Las edades de la vida*.
 ERICK ERICKSON, *Infancia y sociedad*, Paidós, 1958.
 S. GONNOD, "Le jeu de rôle", *Bulletin de Psychologie*, N° 285, XXIII, 1966.
 G. LEMOINE, "L'imaginaire, le symbolique et le réel confrontés à l'expérience psychodramatique", *Bulletin de Psychologie*, N° 285, XXIII, 1970.
 JACQUES ELLIOTT, *La crisis de la edad media de la vida*.
 RENE GUENON, *Símbolos fundamentales de la Ciencia Sagrada*, EUDEBA, 1969.
 MIRCEA ELIADE, *Mitos, sueños y misterios*, Fabril Editora, 1961.
 O. DURAND, *La imaginación simbólica*, Amorrortu, 1971.
 MAURICE LEENHARDT, *Do Kamo*, Eudeba, 1961.
 P. TILLICH, "Naturaleza del lenguaje religioso", en *Teología de la cultura y otros ensayos*, Amorrortu, 1974.

SUMMARY

The advent of adolescence within the family group is a challenge to the capacity to effect structural changes that will allow parents and children to seek a new form of communication and together arrive at the "new" family and personal identity. The crisis of adolescence coincides with the crisis of middle age for the parents. For this reason it is vital that parents be included in the treatment of their adolescent children. The family's crisis of identity

forms part of the process culminating in the "handing over" of the child to society, and the parental group provides an appropriate therapeutic structure for working through this process. The group forms a transitional environment that represents both the social medium and the parents themselves. The parents see their children as everyone's children and take the others children as their own, creating a common, neutral space in which there is greater discrimination and distance where they can handle their emotions with more objectivity. The other parents rescue aspects of the child that his own parents cannot see. The group process permits a progressive opening up to the community for each family, which means leaving the intimate "maternal" world to relate to other social representatives. The parents thus are understanding and going through the same process that their children will similarly have to experience when they turn away from the primitive symbiotic relationship and, with differing characteristics at each stage, join the world of others.

Análisis de un caso clínico: El triángulo roto

JUAN ALBERTO YARIA

*Doctor en Psicología. Coordinador fundador de la Clínica Gradiva.
Rivadavia 5840, Buenos Aires, República Argentina.*

1. Objetivo del trabajo

En nuestra tarea clínica resulta ya una necesidad imperiosa el análisis de un material psicopatológico desde una perspectiva que incluya el análisis del sistema de relaciones familiares. Desde aquí se abre un horizonte promisorio en el campo estrictamente terapéutico de patologías graves, por ejemplo, como en el caso que analizaremos de situaciones melancólicas.

Nuestra formación como analistas parte de un concepto eminentemente individualista, que no tiene en cuenta lo suficiente el contexto intersubjetivo sobre el cual se despliega un texto expresado en la enfermedad y sus síntomas.

Frente a la noción de un individuo cerrado como una "mónada" se debe confrontar la noción de un sujeto que gira en torno a un orden simbólico transindividual, como se observa en el discurso

parental dentro de la dialéctica edípica. Esto es lo que hace decir a J. Lacan (1) lo siguiente: "... el lenguaje con su estructura preexiste a la entrada que hace en él cada sujeto en un momento de su desarrollo mental". Más adelante reitera estos conceptos: "...y también el sujeto, si puede parecer siervo del lenguaje, lo es más de un discurso en el movimiento universal del cual su lugar está ya inscripto en el momento de su nacimiento, aunque sólo fuese bajo la forma de su nombre propio".

Este sujeto unificado, que antes habíamos descripto como una entidad solipsista, se nos aparece entonces clivado en una vertiente manifiesta y en otra más profunda, inconsciente. El orden de lo inconsciente funciona desde una matriz simbólica-cultural que se mediatiza a través de la familia (2).

La noción de identificación nos muestra cómo precisamente el sujeto, más que algo dado como naturaleza, surge como constituido desde los otros (3). Este tránsito intersubjetivo va a quedar mediatizado y determinado por los denominados por Freud (4) complejos nodulares, o sea el complejo de Edipo y de castración. De la forma de inscripción de los complejos dependerán, incluso, las distintas nosologías psicoanalíticas: neurosis, perversiones y psicosis.

Freud descubre cómo el *infans*, desde su situación de "desamparo" inicial (5) y de inmadurez, crece en el marco de una familia. En ella se encontrará con objetos amados, odiados, idealizados y denigrados. Lugares de identificación y de alineación. Lugar de crecimiento o de detención. Lugar de pasaje hacia la cultura que lo espera o lugar de obturación narcisista.

En la psicosis observamos cómo se ha dado un tránsito frustrado hacia la hominización, ya que fracasa el acceso a la triangulación edípica. La metáfora del Padre (6) queda tachada en aras de un mundo narcisista que permanece incólume. La psicosis como patología del narcisismo implica un sujeto que queda atrapado y determinado por los deseos de los otros.

La independencia relativa de los objetos quedaría asegurada por la inclusión de un tercero que, castración mediante, posibilita el mundo del deseo. El psicótico, narcisismo mediante, vive girando en torno a los deseos de los otros (madre o cualquier otro ob-

jeto que con distintos nombres detente el falo). Como sujeto queda extraviado, es un extranjero.

Estos deseos de los otros tienen "nombre y apellido", se los encuentra en el marco de las relaciones familiares. En la familia del psicótico se pueden encontrar en código cifrado elementos de esa relación desiderativa alienada. El terapeuta debe comenzar a decodificar y descifrar, con lo cual se va colocando paulatinamente en un lugar simbólico. Lugar faltante en ellos, pero también requerido —aunque sea momentáneamente— como grupo en crisis.

F. Perrier nos dice (7): "... desde el lugar que ocupamos, el esquizofrénico tiene una historia, pero ésta no le pertenece. No es más que la de sus progenitores, de la misma manera que éstos no son más que niños mal estructurados bajo disfraces parentales. Es en efecto la novela familiar de cada uno de los padres lo que predestina la psicosis que hace del menor de los hijos el resultado aberrante de una colisión inconsecuente, el éxito biológico de un mal entendido. Hemos presentado al intruso fruto de esa unión, ese intruso que puede ser una carga, un imprevisto en su existencia y en su sexo, un objeto de estudio, un juguete inesperado, un extranjero de marca, una apuesta o un fetiche, *pero siempre alguien jamás reconocido en la virtual verdad de su propio devenir*. El rol preponderante de la madre, de hecho incontestable, no adquiere su sentido si no está articulado a toda la historia de una familia y connotado en la complementariedad de las debilidades paternas. Es a menudo del solo estudio de tres o cuatro generaciones de donde puede deducirse la fórmula psicótica condensada en ese esquizofrénico que parece nacido del desgraciado encuentro de dos progenies decadentes ..."

2. Reseña del caso clínico

Paciente de nombre María, de 52 años, que se interna en una institución privada luego de un intento de suicidio con altas dosis de psicofármacos. Se había separado hacía poco tiempo de su marido. El intento sobreviene cuando debía mudarse al departamento que le había comprado éste. Hasta ese momento vivía en la que había sido casa de sus padres, que hace varios años habían muerto.

La paciente comenta que le angustiaba el hecho de que la nueva pareja del marido había sido durante mucho tiempo la secretaria de él. La relación del marido con esta mujer había durado casi tres décadas, aun cuando la paciente lo haya negado psicológicamente. Comenta que estaba muy preocupada por atender a sus propios padres e hijos, mientras su marido hacía sus negocios.

Tiene tres hijos: hija mayor de treinta y dos años y dos varones mellizos menores.

3. Análisis del acto suicida

Una de las ideas que generalmente pongo en práctica es el análisis de las conductas actuadas como la representación de escenas familiares. Los elementos que componen el acto suicida funcionarían como verdaderos términos de comprensión de una temática que trasciende lo individual y que tiene su fundamento en una dramática familiar no elaborada. Orbita de la repetición de situaciones familiares conflictivas que emergen en el campo de la acción, en este caso autoagresiva.

Freud nos enseñaba que todo *acting* debía ser entendido desde el "mobiliario de los sueños" (8). El paciente "escenificaba" en el medio aquello que no podía ser simbolizado. La simbolización implica la elaboración y la rememoración. Escenificar en el medio (*to act out*): mostrar fuera, pero dentro de la causalidad de la compulsión a la repetición.

El entorno institucional debe tratar el *acting-out* autoagresivo como una formación imaginaria escenificada buscando la simbolización de la situación conflictiva expresada psicóticamente. Todos los recursos institucionales deben estar dedicados a ayudar al paciente y a su familia a encontrar el texto elidido. En esta formación imaginaria cada miembro de la familia funciona como un personaje ligado a la "novela familiar" del síntoma en cuestión. Por eso podemos decir que cada miembro de la familia ocupa un lugar en la escena.

De ahí que el análisis de un *acting* nos revele parte del conflicto subyacente en el grupo familiar.

Los términos del análisis serían:

- a) momento del intento de suicidio: en la época veraniega;
- b) la paciente debía mudarse;
- c) vivía en la casa de sus padres (ya muertos), puesto que cuando se separó fue a vivir ahí;
- d) la nueva vivienda había sido comprada por el marido;
- e) el intento de suicidio fue con altas dosis de medicación;
- f) llama a una amiga y le da el número de teléfono del hijo lo cual permite que se la interne.

Podríamos pensar esta situación como el elemento actual que nos remitiría a la trama simbólica familiar. Las situaciones que se muestran en el marco de lo "actual" y todas las situaciones desencadenantes se convierten en rutas que nos permiten investigar series antiguas elididas y no simbolizadas. Son las rutas que funcionan como verdaderos "términos índices". Con este último concepto me estoy refiriendo a la concepción de Peirce (9), en donde el primer término tiene una contigüidad de hechos con lo denotado en segundo término. Según la teoría lingüística, ejemplificar el indicio es reconstruir una historia para encontrar las conexiones. Lo que se muestra es un indicio de una historia que es menester reconstruir. El acto escenificado responde a un libreto que hay que desentrañar. En él existen un autor o varios autores, un apuntador, otros actores, etcétera.

Es una mudanza lo que no se puede realizar. Esta mudanza debe ser tomada en un sentido simbólico: lugar del desplazamiento de un objeto erótico perdido a otro. Eso sería lo que no se puede realizar.

Está sola, a nosotros analistas lo que nos interesa es la soledad del narcisismo. Rodeada de recuerdos quejumbrosos, muebles viejos pertenecientes a muertos idealizados (sus padres), su vida ya no tiene sentido. Quiere acompañar a los muertos venerados.

Para poder mudarse hay que aceptar una pérdida o varias pérdidas.

Quiere matarse en virtud de una maniobra de vuelta contra sí misma (10) dentro de la estructura del narcisismo, con todas las cargas ambivalentes (amor-odio), que deberían estar enfocadas en el objeto que la abandonó y la ofendió.

Freud en "Duelo y melancolía" (11) nos dice: "el objeto ha

quedado perdido como erótico aunque no ha muerto"; "el enfermo sabe a quién ha perdido pero no lo que con él ha perdido"; "en la melancolía su yo es indigno de estimación"; "la conciencia moral resalta el descontento sobre el yo"; "los reproches que dirige contra el yo son reproches dirigidos contra otra persona vueltos contra el yo"; "sus lamentos son acusaciones"; "hay una imposibilidad de desplazamiento de la libido de un objeto erótico a otro".

También Freud nos insiste en que en la melancolía la elección de objeto se realizó sobre una base narcisista, de tal manera que cuando surgiera alguna contrariedad la carga de objeto pudiera retroceder al narcisismo, en su fase oral canibalística. Acá es donde la pérdida del objeto constituye una excelente ocasión para hacer surgir la ambivalencia de las relaciones amorosas, recae el odio sobre el objeto pero dirigido contra sí.

El final propuesto por la paciente es la historia de una vida diseñada sobre identificaciones narcisistas con su padre y sus hijos. Ellos siguieron destinos distintos sobre el trasfondo mismo de la separación: el padre culminó su ciclo natural y los hijos comenzaron un ciclo cultural a través del desarrollo generacional: se casaron.

El acto suicida en su soledad nos muestra parte de un acontecer con la quiebra del narcisismo frente a la cría que creció y los padres que murieron. Sobre este "vacío" adquiere importancia la pérdida del marido. En realidad su vida con él estuvo signada por la frigidez. Sobre esto último Freud nos dice: "...para las mujeres narcisistas y que han permanecido frías para el hombre existe un camino que las lleva al amor objetivado. En el hijo al que dan la vida se les presenta una parte de su propio cuerpo como un objeto exterior al que pueden consagrar su pleno amor objetivado sin abandonar por ello su narcisismo..." (12).

Toda situación de separación implica una quiebra narcisista, una injuria narcisista. Los hijos funcionarían como "falo" que la completa.

En realidad a su marido lo perdió desde el inicio de su relación: lo eligió, nos dice, porque las mujeres "tenían que casarse". Lugar de una mera obligación social, pero al mismo tiempo nos refiere que no "era su ideal". Su ideal era el padre. Frente a él quedó ubicado como lo denigrado.

Como hace Freud, debemos distinguir entre el ideal (de acuerdo con las pautas del yo ideal) y la sublimación. Lo primero habla de una vinculación narcisista con el objeto, lo segundo de una inclusión en la cultura, renuncia y asunción del complejo de castración. Por lo tanto, en esta paciente el tránsito generacional no se cumplió adecuadamente, todo el decurso de su femineidad se halló alterado.

Además observamos que en la escena del *acting* llama a otra mujer para que se comunique con su hijo. Estructura un triángulo. ¿Es el triángulo roto lo que la descompensó? En el triángulo construido desde el narcisismo uno siempre queda muerto. El corolario de la puja y la rivalidad narcisista por el único lugar de prestigio es la muerte del intruso. Los triángulos con un excluido —como vamos a ver— tienen mucha incidencia en esta familia.

Por ejemplo, la unión paciente-padre implica la exclusión del marido que funciona en el decir de la paciente como un objeto muerto y denigrado: la unión de los mellizos con los objetos primarios da lugar a que uno de ellos se transforme en el triunfador maníaco y el otro en un melancólico que recibió los ataques del héroe; la unión del padre y la hija crea una situación en donde la paciente se siente muerta; la unión nueva pareja del marido-hija confirma la fantasía de la paciente de que "otra mujer ocupa mi lugar y ya no soy más abuela"; la unión madre-mellizo menor está en función de la "matanza del padre".

Estamos funcionando en el reino de las dualidades narcisistas con la asignación de la muerte al intruso. J. Lacan nos enseña cómo la muerte surge dentro de un juego especular con la muerte del rival.

Dentro de esta perspectiva podemos entender mejor la elección de este síntoma: la muerte buscada a través del suicidio. Muerte que es siempre búsqueda de fusión con el objeto.

Además la fecha elegida para el intento de suicidio no es ingenua, ya que nos remite a los veranos históricos en donde la fratría se unía sin el padre y con su madre.

4. Descripción de los fragmentos de una sesión familiar

Esta sesión es la segunda que se realiza y participan la paciente, la hija y uno de los mellizos. El marido solamente desea colaborar a nivel económico y el otro hijo está ausente del país.

Voy a realizar una división de la sesión en siete unidades temáticas que siguen la evolución de aquélla.

a) La sesión comienza con una pregunta del terapeuta acerca de cómo se sintieron después de la primera entrevista. El hijo hace un gesto y, al preguntarle el terapeuta qué quiere decir, responde con un "siempre me toca a mí". Inmediatamente se entabla una pelea entre hermano y hermana. El hermano condena la alianza de la hermana con la nueva pareja del padre y con el padre. Interviene la paciente que denuncia la angustia de que hubiera existido comunicación entre la hija y la nueva mujer del marido. La hija defiende de nuevo a la mujer: "la conocía desde que tenía 4 años", "cuando necesité trabajo ella me lo dio", "fue empleada de papá", "todos mis hermanos trabajaban con ella". La paciente habla de un trato indirecto con ella, para hablar con el marido lo hacía a través de la secretaria.

b) La paciente menciona que sintió más que la ausencia de la hija la ausencia de los nietos. Comenta: "de repente aparece una mujer ocupando mi lugar", "a mi primer nieto es al que quiero más". Pero inmediatamente dice: "pienso más como madre que como abuela". Recordemos que la hija es la primera hija. La hija le contesta: "los chicos seguirán teniendo mami". Se habla de la ruptura de la relación madre-hija, y de la incidencia de la nueva relación hija-nueva pareja del padre sobre la familia. La paciente tiene un error cuando se refiere a la hija "lo sentía lejos". El terapeuta, al intentar que asocie con ese error, da lugar a que la paciente comente: "existe mucha semejanza entre mi hija y mi marido, son semejantes".

c) La paciente realiza una llamada seductora al hijo, además lo llama por primera vez por su nombre y no por su sobrenombre. Se estructura un bando madre-hijo contra el padre y madre-hijo contra la hija.

El hijo dice que aceptaría que el padre saliera con una *vedette*, lo denigra. Comenta que el padre se fue con la hija.

d) La paciente comenta: "los mellizos son míos", "él quería que yo los abortara", "yo me siento muy identificada con mi hijo", "el padre siempre estaba afuera haciendo sus negocios".

Se realiza una alusión a la relación de la paciente con la institución desde el punto de vista transferencial: "ella con los pacientes (hijos) secreteando sin que los viejos (los coordinadores de la institución) supieran nada".

Inmediatamente el grupo asocia acerca de la incidencia del abuelo materno en la familia: "era el que mandaba y el que fijaba las pautas".

e) El abuelo materno tenía como sobrenombre papapa. Todos los miembros del grupo dicen: "papá más que papá." Todos lo idealizaban y mistificaban sus poderes. Es vivido como un "mago y brujo".

f) El próximo tema tiene que ver con la implicancia de la muerte del abuelo en la familia. La paciente comenta: "cuando se enteró que tenía la bestia negra (cáncer) se quiso tirar por el balcón", a la vez tiene un lapsus: "todavía ahora lo protejo de las olas". En la historia familiar ella funcionaba como la viuda y no la madre.

g) El abuelo tenía otra mujer, éste era un secreto familiar amparado por la paciente. Era una empleada del padre. En la fantasía de la familia la amante se había llevado todo el botín, ya que cuando murió todos pensaban que tenía mucho dinero y esto no fue más que "una ilusión".

5. Análisis de la sesión

La sesión comienza con un "siempre me toca a mí". Es precisamente el mellizo que en la historia familiar ocupó el lugar de un "muerto" frente a un héroe maníaco. J. Lacan, al hablar de la intrusión en relación con los gemelos nos dice: "... sabemos que múltiples mitos le atribuyen el poderío del héroe y de esa forma se restaura en la realidad la armonía del seno materno, aunque a costa de un fratricidio...". La familia que estudiamos se presenta

como un conjunto de victimarios y de víctimas. El mellizo y la paciente ocupan el lugar de víctimas.

Hegel nos dice que: "el individuo que no lucha por ser reconocido fuera del grupo familiar nunca alcanza, antes de la muerte, la personalidad. En materia de dignidad personal la única que puede brindar la familia es en el momento de la sepultura" (2).

La muerte aparecería como el lugar de la dignidad en donde el sujeto queda plasmado en un monumento. La muerte como el lugar de reconocimiento frustra. En la sesión la paciente busca ser reconocida por la hija. Este reconocimiento es excluyente: o ella o la otra. Si es la otra ella queda muerta.

En el mundo ilusorio fálico la hija le contesta que ella reconoce a otra mujer que le dio todo cuando ella era chica.

La intervención pienso que apunta a dos estratos. Por un lado a la negación familiar (durante 28 años el padre tuvo una amante) y por otro a un juego de dualidades imaginarias en donde todos participan. Desde este punto de vista el otro funciona como un apósito narcisista. La necesidad de exclusión tiene el objetivo de satisfacer el apetito sádico en donde el lugar del muerto cambia: que sea el padre, su marido.

La pareja del marido funciona como una verdadera *partenaire*: tanto la necesitaba que debía negar la situación. Campo de la necesidad de un objeto homosexual. Pero ahora es la hija la que espía lo que hace su *partenaire* con un hombre, ya no es más ella.

Ahora es la hija (su complemento fálico) la que se ha retirado también. Lo que anteriormente mencioné en punto b) se podría entender de la siguiente manera, realizando una interpretación del material de forma dramática: "en realidad vos como hija mayor sos lo más importante, mi primer nieto es al que quiero más pero yo hablo más como madre que como abuela, por lo tanto vos sos lo que más quiero en forma posesiva".

Con relación a esto, Freud, en *Introducción al Psicoanálisis* en un artículo denominado "Psicoanálisis y Psiquiatría" nos muestra un caso en donde la infidelidad supuesta del marido, creada en su celotipia era un gran engaño que estaba en función de conseguir el amor del yerno, pero esto encubría la búsqueda de la hija como complemento fálico.

La hija le responde en la sesión: "Los hijos seguirán tenien-

do mami". Es esta secuencia lo que importa: no son los nietos sino los hijos como complemento lo que está en juego.

La paciente se equivoca y dice, refiriéndose a la hija: "lo sentía lejos". Sobre la imagen del marido que está lejos funciona la imagen narcisista y por ende homosexual de la hija separada y unida fusionalmente a otro objeto homosexual.

Ella dice: "son semejantes mi hija y mi marido". En el plano del narcisismo no hay diferencias. La regresión narcisista es una disolución de las diferencias. Además es un juego de ausencias (que esté o no la hija) lo que no se puede significar, aquí estamos en pleno campo de la totalidad especular. La paciente luego realiza un juego: "ya que no te tengo a vos, hija, te tengo a vos, hijo...". El hijo le responde de la siguiente manera: "...sí, mamá, hay que matar a papá y a la *vedette*-hija que se encontró". La paciente sabe que para eso lo tiene al hijo, éste, desde el lugar oscuro del resentimiento como mellizo está siempre presto a ejecutar la orden de la jefa de la horda y realizar el parricidio.

Entonces ella responde: "los mellizos son míos..." La prueba perdida fue confirmada: "por mí viven, por él estarían muertos..." Dentro de esta dialéctica del discurso se puede pensar: "como para que no haya venganza".

El tratamiento institucional de la paciente es una réplica de lo que sucede en el ámbito familiar: ella protegiendo a sus críos (pacientes jóvenes) y derivándolos sutilmente contra los coordinadores. Además entabla alianzas de intensísimo acuerdo perverso con un paciente homosexual hasta lograr que éste cometa un *acting* que es secretamente apañado por ella.

Es que el secreto es fundamental, éste es la base de la alianza, del contrato matrimonial: "el que parece ser mi marido no lo es". Esta unidad de discurso la podríamos intercalar como lo latente de sus producciones. Siguiendo con esta línea podríamos decir: "es mi padre". Para la familia, ella funcionaba como la viuda cuando se murió el padre. Era "papapa", un doble padre: de ella y de sus hijos, o un solo padre para tantos hijos, en donde ella seguía siendo la primera. Todas las potencias del marido debían ser ocultadas. En el mito familiar el abuelo pagaba los largos veraneos, pero esto era una mistificación en función de lo que se debía defender; el repudio de alguien y la idealización del otro.

La defensa de él es la defensa de una imagen, y una imagen, por su esplendor, no resiste ninguna crítica.

El padre muere, pero antes quiere suicidarse. El destino del sujeto en el narcisismo es seguir el destino del objeto. La paciente también quiere suicidarse. Pero justo al lado de eso aparece el abuelo como un mago y como un brujo dador de vida: el "Shaman" que decía cuándo alguien debía nacer y cómo iba a nacer. Papel idealizado, mágico, por lo tanto irremplazable. El también tenía otra mujer, ella lo sabía y lo amparaba. Ocupaba el lugar de espía. Este lugar implicaba una satisfacción voyeurista pero a la vez un lugar de soborno del otro. También ella era una empleada del padre.

Como señala nuestro tango: "...la historia vuelve a repetirse".

Bibliografía

1. J. LACAN, "La instancia de la letra en el inconsciente", *Escritos I*, Siglo XXI, 1971.
2. J. LACAN, *La familia*, Homo sapiens, 1977.
3. J. LACAN, "El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica", *Escritos I*, Siglo XXI, 1971.
4. S. FREUD, "Proyecto de una Psicología para neurólogos", *Obras Completas*, tomo III, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1948.
5. S. FREUD, *Idem*.
6. J. LACAN, "De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis", *Escritos II*, Siglo XXI, 1974.
7. F. PERRIER, "Fundamentos teóricos de una psicoterapia de la esquizofrenia", *Carpeta de Psicoanálisis I. Psicoanálisis de la psicosis*, Editorial Letra Viva, 1978.
8. LAPLANCHE y PONTALIS, *Diccionario de Psicoanálisis*, Editorial Labor, 1970.
9. J. C. INDART, Ficha publicada. Título: "...Porqué (porqué) una 'taza' es el 'pecho' (?)", 1974.
10. S. FREUD, "Los instintos y sus destinos", *Obras Completas*, Tomo I, Editorial Biblioteca Nueva, 1948.
11. S. FREUD, "Duelo y melancolía", *Obras Completas*, Tomo I, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1948.
12. S. FREUD, "Introducción al narcisismo", *Obras Completas*, Tomo I, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 1948.

SUMMARY

This is an attempt to focus on a clinical case from a family perspective. María 52 years old, was admitted to a private institution after a suicide attempt with psychopharmaceuticals. She had separated from her husband not long before. She was troubled by the fact that her husband's new mate had been his secretary and had known him for 28 years. María has an older daughter, 32, and male twins, 30.

The pathology expressed by the patient is related to a series of hurts and conflicts that have not been resolved in the family circle. This has implications for group treatment since the chance to work through the psychosis must be given. The psychotic acting-out is considered to be the staging of a family situation which has been elided but which emerges abruptly in the dimension of compulsion to repetition. The institution functions as the place of transference of relationships with the primary objects.

One of the elements I wished to bring out is the constitution of a perverse triangularity with the death of the rival in the dimension of "narcissistic objectivity". Narcissism, the object fused with the ego, and the death of the intruder are active constellations in the fantasy of the patient and in the family structure. In this structure, the "incest taboo" as the ultimate constituent of family life functions with the continuous separation of the figure of the third legislator.

Visión dialéctica de la terapia familiar intergeneracional

Trabajo inédito, presentado en el 4º Simposio Internacional, Zurich, septiembre 30 - octubre 3, 1975. Institut für Ehe und Familie. Traducción de la Licenciada Elena Nicoletti.

IVAN BOSZORMENYI-NAGY

Director del Departamento de Psiquiatría Familiar del Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute, Henry Avenue and Abbottsford Road, Filadelfia, Pá., 19129 U.S.A.

En este trabajo se encara un tema que va mucho más allá de la técnica terapéutica y, sin embargo, al analizar las premisas de la teoría familiar intergeneracional, de la terapia familiar o de la psicoterapia en general, procura concentrarse en los aspectos prácticos de la estrategia terapéutica.

La descripción eminentemente técnica o instrumental de la psicoterapia implica el riesgo de una inevitable cuota de sobresimplificación, que no sólo lleva a pasar por alto las premisas personales básicas del terapeuta, sino que no alcanza a definir el problema de la extensión y jerarquía de la psicoterapia. Como el ciego, que después de haber palpado la cola del elefante declara que el animal se asemeja a la víbora, pensamos que las descripciones tradicionales de la psicoterapia, basadas en la psicología individual, tienden a confundir y subestimar el alcance de los fenómenos que proponen tratar.

Definición de alcances

Al entrar en el campo de las definiciones, la primera tarea consiste en establecer la diferencia entre dinámica *individual* o *psicológica* de tipo clásico y la dinámica *relacional* aquí propuesta. La alternativa teórica y práctica no es sólo otro modelo dinámico en el mismo plano, sino un "mecanismo" distinto o un plano sistémico diferente, más complejo. Así como la molécula de agua incorpora las características, tanto del oxígeno como del hidrógeno, el enfoque relacional abarca tanto los puntos de vista de la dinámica individual o psicológica, como los del plano transaccional sistémico.

La distinción entre los principios dinámicos relacionales y los individuales reviste gran significación práctica al planificar la estrategia terapéutica. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, la transición conceptual ha sido paulatina y ha abarcado desde la inducción de estados emocionales entre personas en estrecha relación y las actitudes proyectivas hasta las gratificaciones sustitutivas a través de la acción de otros. Estos fenómenos han sido descriptos antes que existiera la teoría dinámica relacional. Con todo, la mayor parte de estas percepciones transicionales de la dinámica relacional permanecen aún dentro del encuadre de la psicología individual, por lo que también podrían quedar englobadas bajo el título de "psicología transpersonal".

El segundo aspecto que requiere ser clarificado por medio de una definición se refiere a la diferencia entre *niveles profundos* y *niveles transaccionales* o *manifiestos* de la dinámica relacional. Lo corriente es que se establezca un contraste entre el punto de vista comunicacional o relacional-transaccional de la terapia familiar, y el enfoque psicológico-conductista de base individual. Nosotros, en cambio, queremos enfatizar la diferencia entre patrones visibles o manifiestos, o estructuras transaccionales, y la estructuración relacional basada en los niveles profundos éticos-existenciales de la vida. Nadie encontrará dificultades en distinguir entre la estructuración de la conducta cotidiana visible de un individuo y sus compromisos a largo plazo, que —sometidos a una dura prueba— podrían determinar la disposición de ese individuo a morir por una causa que despierta en él profunda

devoción. No es probable que las situaciones de la vida cotidiana hagan aflorar esos niveles de motivación desesperados o heroicos; pero no es ilógico suponer que en todos nosotros existe una conexión dinámica entre los patrones visibles de conducta y las estructuras motivacionales ético-existenciales más profundas. En este aspecto debería recomendarse una especial prudencia en el uso de la palabra "estructura" restringida a su significado de patrones visibles o manifiestos de función conductual o comunicacional de transacción.

El tercer punto de partida en materia de definiciones se refiere a la distinción entre la *teoría de la necesidad*, por una parte, y la *teoría ética*, por otra. Las determinantes éticas del comportamiento humano deben ser restituidas al rango de factores motivacionales de primer orden. Consideramos que es contraproducente —y destructivo en el terreno ético— basar la teoría motivacional exclusivamente en configuraciones de necesidades endógenas o internalizadas, autodirigidas por el individuo. De ninguna manera empleamos esta palabra con sus connotaciones moralistas, prejuiciosas o de autonegación puritana. Más bien pretendemos subrayar su significado relacional, por el cual se alude a la responsabilidad recíproca que liga a las personas. A nuestro juicio, cualquier enfoque que trate a los individuos en estrecha relación como simples objetos de sus respectivas necesidades, es incompleto.

La genuina preocupación por las necesidades del otro, como ser humano integral, como "sujeto", es un elemento esencial de la estructura motivacional profunda de cada miembro de una relación estrecha.

Tampoco es acertado encarar las obligaciones y expectativas éticas que inciden en el individuo como factores opuestos a sus necesidades autónomas de individuación. Si consideramos el problema con una perspectiva más amplia y dialécticamente más completa, veremos que —más que dár la espalda a los padres y a otras personas importantes en el terreno de la relación— la individuación es un proceso de permanente y maduro balancear las cambiantes lealtades hacia ellos. En resumen: la adecuada preocupación por el bienestar de su familia de origen es parte de la configuración de necesidades del individuo. Sin embargo, al mismo tiempo, es-

ta preocupación es fútil e irrelevante en el aspecto existencial, a menos que incluya y reconozca las necesidades de los objetos de tal preocupación.

Regla básica de la terapia intergeneracional dialéctica

Así como la "regla básica" de la terapia psicoanalítica surge de las premisas básicas de su exposición terapéutica razonada, la regla básica de la terapia intergeneracional dialéctica surge del precepto según el cual —cuando son confiables— las relaciones estrechas constituyen en sí el principal recurso para una acción terapéutica. De acuerdo con la teoría, la *reversión "conjuntiva"* del "*estancamiento relacional*" (relaciones que han sido interrumpidas, negadas, abandonadas, fijadas en forma rígida, etc.) puede brindar una estrategia más efectiva que los recursos psicológicos no desarrollados del individuo. Dado que la *conjunción relacional* constituye la regla básica de la terapia intergeneracional dialéctica, no se requieren criterios específicos para una familia en particular en lo que a indicaciones se refiere. Puede aplicarse al trabajo con cualquier familia, de la misma manera que el examen de las propias motivaciones inconscientes es la expectativa universal en la regla básica de la terapia psicoanalítica freudiana.

Una de las más importantes consideraciones prácticas y culturales con respecto a la regla básica de la conjunción se refiere a una secular tendencia histórica del Occidente industrializado: la glorificación del ideal del individuo independiente de la familia nuclear autónoma. Como resultado de complejas determinantes históricas, la civilización occidental se ha alejado casi por completo de los antiguos modelos de la gran familia o de la organización de la vida familiar en clanes. En lugar de eso se ha promovido una imagen idealizada de la familia nuclear, compuesta por padres e hijos. Todos los factores de nuestra cultura contemporánea han contribuido a ello. Es probable que la principal ideología de esta tendencia se base en una definición no dialéctica del concepto de libertad respecto de cualquier autoridad, así como en la necesidad de escapar de la dependencia confinatoria y de las implicaciones sexuales de la familia nuclear original.

Sin embargo, llevado al extremo, el modelo de familia nuclear no sólo priva a los jóvenes padres de una dependencia necesaria; también suprime la oportunidad de que los jóvenes adultos se preocupen por las necesidades reales de sus padres o abuelos. En resumen, es posible que la imagen exagerada de la familia nuclear represente la carga más pesada que debe soportar la familia contemporánea de Occidente y —en creciente medida— las familias de todas las culturas.

Uno de los conceptos básicos de la terapia intergeneracional dialéctica es el *estancamiento relacional*. Este concepto es equivalente al de patología, que por supuesto está ligado a la idea del individuo aislado. Como es lógico, por provenir del acervo conceptual de la medicina, el concepto de patología implica la antítesis de los procesos sanos de una vida en marcha, incluyendo el crecimiento. De la misma manera, el estancamiento relacional es la antítesis de las relaciones sanas, recíprocamente equilibradas. Uno de los principales esfuerzos "diagnósticos" o evaluativos de todo terapeuta debe estar encaminado a descubrir señales de estancamiento en las relaciones familiares inmediatas. Por supuesto, una relación padre-hijo sigue siendo estrecha aun cuando funcionalmente dé pruebas de estancamiento. Cuando el sistema de relación familiar muestra signos de estancamiento, puede esperarse que los miembros de la familia muestren signos de patología, según los criterios individualmente diagnosticables de su función.

Por ejemplo, cuando los adultos de la familia deciden que el suicidio de la abuela es un capítulo cerrado y un tema absolutamente intocable, tales circunstancias pueden señalar directamente un aspecto importante de estancamiento relacional. Una vez tomada esa decisión, se vuelve imposible una apertura honesta con respecto a asuntos vitales entre los miembros de la familia. Por ejemplo, a partir de ese momento, cada miembro se verá obligado a asumir en secreto —por así decirlo— su proceso de duelo no resuelto. De esa manera, las relaciones dejan de ser fuente de confianza mutua y de mutuo intercambio enriquecedor; por el contrario, se cargan de ansiedad y de un aire de sospecha y de amenaza. Los factores relacionales intrínsecos —implícitos en las condiciones que llevaron al suicidio de la

abuela— quedan así institucionalizados en la familia, a través del estancamiento manifiesto y a través de la costumbre de prohibir cualquier discusión abierta.

Sistemas de relación abiertos y cerrados

En un sentido simple, no dialéctico, sería fácil considerar la preocupación acerca de los miembros de la propia familia de origen, como confinamiento dentro de un sistema cerrado, en tanto que todas las relaciones con individuos ajenos a la familia serían constituyentes de un sistema abierto. En forma similar, no dialéctica, las actitudes occidentales contemporáneas dan por sentado que la relación de un individuo con sus padres y abuelos puede y debe ser abandonada o por lo menos rechazada, pues de lo contrario, ésta tiende a volverse confinatoria, autoritaria o "anticuada". Desde un simple punto de vista conductal-transaccional, el respaldo brindado a las relaciones "exteriores" debería, pues, resolver por sí mismo el conflictivo estado de relación del individuo con su familia de origen. Una perspectiva dialéctica más dinámica sugiere lo contrario: que precisamente la naturaleza estancada y desequilibrada de las relaciones de una persona con su familia de origen es lo que le impide establecer relaciones significativas con sus pares.

En ciertas familias, los abuelos u otros familiares cercanos son evitados o nunca se los menciona, salvo en términos de "respetuosas" y vacías generalidades. Quizá se los visite una vez al año, con motivo de alguna fiesta nacional o religiosa importante.

Por supuesto, ésta ofrece al terapeuta familiar intergeneracional un poderoso resorte terapéutico para abrir núcleos de estas cerradas áreas de la relación familiar. El terapeuta podrá luego inducir gradualmente patrones que lleven a una mutua confianza y a diálogos mutuamente enriquecedores entre los miembros de la familia.

El terapeuta individual clásico y el terapeuta familiar común de nuestra época reafirman el mito cultural de la civilización occidental cuando manejan el área de relaciones intergeneracionales, dentro de la familia de origen, como si se tratara de sistemas ce-

rrados. La habitual práctica profesional de relegar las relaciones con la familia de origen al rol de un simple "repaso histórico" impide que se las tome en cuenta como elemento de estrategias terapéuticas activas. La terapia dialéctica intergeneracional, en cambio, enfoca esta dinámica de relaciones verticales como la más importante fuente de recursos para planificar una estrategia terapéutica.

Por otra parte, sería un craso error considerar que la concentración terapéutica en núcleos de áreas relacionales estancadas significa indiferencia hacia las relaciones extrafamiliares que puedan mantener los miembros de la familia. Nada más lejos de la realidad.

El terapeuta intergeneracional experimentado sabe que el matrimonio, como tal, es una estructura relacional considerablemente más vulnerable que las relaciones intergeneracionales; en consecuencia, una de sus principales inquietudes consiste en acrecentar las posibilidades de matrimonio o de otras relaciones con pares, al liberarlas de las oscuras sombras de los estancamientos intergeneracionales.

En resumen, el máximo apoyo terapéutico que puede brindarse a una relación entre pares surge más de la acción a través de una liberación dinámica de recursos, que de cualquier discusión acerca de la obvia debilidad o "patología".

En la práctica es muy importante distinguir entre la recuperación del equilibrio en las relaciones con la familia de origen y las teorías evolucionistas de causa y efecto. El pensamiento causal puramente lineal está, por supuesto, totalmente reñido con la dialéctica: su aceptación nos llevaría a ver la familia como un sistema cerrado. La fundamentación "conjuntiva" del trabajo con relaciones intergeneracionales verticales se basa más en el modelo del enriquecedor impacto creativo de los recursos relacionales restituidos, que en la improductiva idea de "desmontar" las causas nocivas por medio de un análisis de la patología.

Dinámica intergeneracional versus dinámica transgeneracional

No debe confundirse el simple traspaso transgeneracional de aprendizajes, hábitos, valores, rasgos, cultura, estilo, etcétera, con un vital intercambio relacional, como puede ser el diálogo activo entre la generación de los padres y la de los hijos. Lo dialéctico de las relaciones intergeneracionales puede compararse con la inducción de magnetismo negativo en un metal, mediante la aproximación de polos magnéticos positivos de otro. Por ejemplo, recibir del otro implica la obligación de dar al otro y viceversa. Por el contrario, un simple traspaso de patrones se asemeja al traspaso de la misma clase de líquido de un recipiente a otro.

El concepto de lealtad en las familias

Desde un punto de vista dinámico, no hay nada más importante para las fuerzas que dan cohesión a las relaciones y a la familia, que la lealtad ganada a través del mérito. Nuestra definición de lealtad connota ante todo una expectativa grupal, es decir, una característica estructural de todo el sistema de relación, y sólo en segundo lugar, una característica psicológica de sus miembros individuales.

En términos generales, cualquier grupo puede mantener su cohesión merced a: 1) la coacción a través de un poder; 2) intereses comunes; 3) actitudes internalizadas de lealtad merecida por parte de sus miembros.

El terapeuta familiar se interesa, ante todo, por aquellos aspectos de la lealtad subyacentes a la patología de los miembros de la familia. La compulsión física a la lealtad se ha convertido un patrón familiar anacrónico en el contexto de la sociedad occidental contemporánea, sobre todo en la americana.

Cuando los hijos crecen, sus intereses primordiales dejan de coincidir con los de sus mayores: la existencia individual separada se convierte en centro de interés para ellos. En consecuencia, el principal conflicto familiar "patógeno" de nuestra era es el choque entre la lealtad internalizada y las demandas de individuación y de formación de unidades familiares nucleares. Los

miembros leales de una familia muestran una actitud positiva, confiable, hacia el ideal de una unión permanente. Esta lealtad no es un simple concepto descriptivo conductal; lo demuestra una observación muy corriente: los miembros que "cortan" radicalmente las relaciones con sus familias suelen experimentar un aumento de la culpa por "traición" o abandono. Esta culpa puede aflorar en forma de síntomas "patológicos" de lealtades invisibles, sin relación aparente con la unidad familiar.

Sería particularmente erróneo suponer que la lealtad dentro de un grupo reside por completo en las "psicologías" de sus miembros. Si bien es cierto que la responsabilidad y la capacidad de culpa de los miembros de la familia es un importante factor contribuyente, la lealtad no puede explicarse por completo sin recurrir al concepto de "libro mayor de méritos" (*ledger of merits*)¹. En consecuencia, el grado de lealtad de cualquier grupo está en relación con un patrimonio de devoción, de sacrificada contribución y de actitudes generosas, legado por sus predecesores históricos. La lealtad de una nación reside no sólo en la consideración que todos sus miembros vivos muestran por los intereses de los demás; también estriba en la continuidad —consciente o inconsciente— de obligaciones en cada miembro, como resultado de los actos meritorios de generaciones anteriores. De la misma manera, en las familias —y a pesar de todos los manifiestos esfuerzos por negarlo— los hijos deben su existencia y gran parte de su formación a los padres e, indirectamente, a los antepasados de sus padres. Y justamente porque no es dable esperar que los hijos retribuyan todo lo que han recibido de todas las generaciones anteriores, el alcance de sus obligaciones permanece indefinido e ilimitado.

Como lo indica la historia de la civilización, el péndulo oscila entre las tradicionales expectativas manifiestas de lealtad a los mayores y el patrón contemporáneo de manifiesta negación de toda obligación filial. Así, parecería ser que el mundo occidental o la sociedad americana experimentan una desintegración de la lealtad familiar. Sin embargo, desde nuestro punto de vis-

¹ Algo así como un Debe y Haber, un registro multigeneracional de méritos.

ta, es más importante discernir de qué manera operan las invisibles fuerzas de la lealtad entre el ser humano y su medio familiar formativo. En realidad, cuanto más se las niega, tanto mayor es el poder de esas fuerzas. Además, gran parte de las exploraciones y esfuerzos terapéuticos del terapeuta familiar se concentran en las variadas manifestaciones de lealtades familiares invisibles.

El "libro mayor" intergeneracional

El concepto de "libro mayor" intergeneracional subraya más las determinantes existenciales que las determinantes psicológicas de lo que el conductismo ha descripto como desplazamiento, proyección, fijación neurótica o, en resumen, distorsión de la realidad en las relaciones. El concepto de "libro mayor" llama la atención sobre el entrelazamiento existencial del destino de familias, generaciones e individuos. Visto dentro de un contexto intergeneracional, el individuo es el centro existencial de su complejo mundo de justicia humana (Buber). Si alguien comete una injusticia, espera que su acción resulte equilibrada por actos de reconciliación, compensación e, incluso, castigo. Alrededor de estas necesidades humanas esenciales se va a desarrollar el sistema legal y judicial, fundamento de una civilización organizada. Y, sin embargo ¿quién reparará las injusticias cometidas —a sabiendas o no— por una familia contra un niño de corta edad? Si la injusticia es grave, el resentimiento y la desconfianza se instalarán en la estructura básica de la personalidad de ese niño. Puede que —consciente o inconscientemente— ese ser quede profundamente convencido de su derecho existencial a extraer una compensación unilateral de casi todas las personas o del mundo en general. Lamentablemente, la persona más allegada al joven adulto así lastimado —con frecuencia su primer cónyuge— suele convertirse en blanco de semejante esfuerzo por restablecer el equilibrio perdido. Para la víctima es un pobre consuelo saber que quien le inflige los daños se siente intrínsecamente justificado al victimizar a otros.

Por supuesto, el "mecanismo" que sostiene tales registros

intergeneracionales de justicia, venganza desplazada o reparación, se apoya también en la psicología del individuo. Sus percepciones, sus primeros asomos de confianza elemental, su capacidad para dar y recibir, su capacidad para "usar" las relaciones, su memoria, su estimación del equilibrio entre frustraciones y gratificaciones, su sustrato biológico, las circunstancias de su ulterior experiencia de vida y las características de todos los que mantienen relaciones importantes con él, son factores importantes que, junto con el "libro mayor" intergeneracional, codeterminan el destino de sus relaciones cercanas.

Sin embargo, este "libro mayor" en sí, es más de naturaleza existencial que psicológica.

Significación terapéutica de los objetivos vitales a largo plazo versus objetivos vitales a corto plazo

Abrumado por la enorme y perturbadora complejidad de niveles en el entrelazamiento de los objetivos y motivaciones del hombre, el terapeuta familiar no puede menos que considerar ingenua y falaz la pretensión de imponer objetivos terapéuticos a corto plazo, en lugar de evaluar los objetivos intrínsecos de los miembros de la familia. Lo mismo podría afirmarse con respecto a la política de los organismos que, bajo la comprensible presión de realidades presupuestarias, tratan de declarar que sus clientes sólo pueden someterse a una breve psicoterapia. Lo cierto es que los progresos que puede hacer un individuo en un tiempo dado, en cuanto a la recuperación del equilibrio de su función, dependen de su fortaleza y de sus recursos relacionales. De la misma manera, en terapia familiar, el terapeuta debe considerar tanto los recursos del yo de cada miembro de la familia, como los recursos relacionales del sistema en conjunto. Por ejemplo, el terapeuta suele recibir referencias sobre algo que es etiquetado como esquizofrenia u otra condición psicótica de alguno de los miembros jóvenes. Podría suceder que, al cabo de pocas semanas —y pese a que las detenidas exploraciones de la crisis del paciente previas a la terapia familiar se han prolongado por meses— quede repentinamente en descubierto una relación incestuosa entre el paciente de-

signado y uno de los padres. Es casi predecible que en tales circunstancias, el síntoma psicótico del paciente designado experimente una mejoría drástica en el término de pocas semanas de tratamiento familiar. Cabe preguntarse ahora si la familia en conjunto tiene recursos para trabajar sobre los problemas relacionales básicos que llevaron primero al incesto y, secundariamente, a que se rotulara de psicótico a uno de sus miembros. Si la familia tiene recursos para semejante reequilibramiento y está dispuesta a emprenderlo, el principal factor que limita una terapia a largo plazo sería la disponibilidad de un terapeuta familiar competente.

El mérito como factor motivacional

La introducción del concepto de mérito —que es en esencia un concepto ético— como factor motivacional, se basa más en consideraciones sobre sistemas relacionales que en consideraciones de índole psicológica. Más específicamente, la fundamentación de la terapéutica basada en el mérito no es una elaboración sobre la psicología del superyó. Si bien es cierto que el pasaje de un individuo de la responsabilidad cargada de culpa al alivio de una conciencia limpia (basado en el mérito) está vinculado con la psicología del superyó, el mérito debe ser comprendido en el contexto de una estructura social dinámica. El mérito relacional o interpersonal de cualquier acto entre usted y yo depende de nuestra mutua evaluación del impacto de dicha acción sobre la totalidad de nuestros objetivos e intereses vitales. Así, el grado de presión ética para realizar o no realizar un determinado acto, o el grado de justicia en el toma-y-daca de nuestra relación está determinad^o por el "saldo" interpersonal de nuestra "cuenta corriente" ética, del "ámbito del entre nosotros" (Buber).

La teoría psicológica tradicional o individual expresa el concepto de motivación en términos positivistas o de poder, basados en la ventaja personal: salud, madurez, efectividad personal, dominio, autoactualización, adaptabilidad, madurez genital y capacidad para disfrutar. El concepto de mérito como principio motivacional, en cambio, está basado en prioridades éticas. La transición del en-

cuadre psicológico al ético requiere no sólo flexibilidad intelectual sino también una significativa inversión personal por parte del terapeuta. El costo de esta inversión puede ser medido en términos de la frustración del terapeuta por la desvalorización de sus anteriores inversiones "científicas" y técnicas, y en términos del enfrentamiento con sus propias relaciones personales más estrechas en un nivel existencial profundo.

Inferencias prácticas del "libro mayor de méritos"

Damos por sentado que el balance del "libro mayor" es una dinámica clave en las relaciones estrechas. El dar en forma unilateral, sin recibir el equivalente, puede llevar a una explotación desigual, incluso entre adultos; por ejemplo, en relaciones heterosexuales. Pero el "libro mayor" de méritos adquiere un significado muy especial en aquellas relaciones en las cuales una persona es asimétricamente responsable de otra. El recién nacido, por ejemplo, tiene una posición de mérito incondicionalmente alta, no porque haya realizado actos meritorios, sino por su solo desvalimiento. El desvalimiento del recién nacido, de por sí, ubica a sus padres en una situación de asimetría en cuanto a responsabilidades y obligaciones. Si no cumplen con su obligación, los padres quedan en deuda o pierden mérito. Desde el punto de vista psicológico, esta alteración del equilibrio relacional puede manifestarse luego en sentimientos de culpa por parte de los padres. Pero la culpa de los padres o la psicología del superyó es sólo un aspecto de la diferencia resultante entre las columnas de "justicia" y "explotación" en el libro mayor de méritos. Aunque desde el punto de vista del niño, la magnitud manifiesta del abandono o carencia puede ser idéntica no es lo mismo si el olvido se debe a la "egoísta" falta de ternura de los padres o si tiene su origen, por ejemplo, en el nacimiento de otro hijo con una grave lesión cerebral. En este último caso, el niño descuidado experimentará resentimiento por la falta de atención de los padres, pero el "debe y haber" de éstos y su responsabilidad no se verán afectados en la misma medida, porque es probable que el niño haga una "concesión" ética a los padres, por ser éstos víctimas de las circunstancias.

En el balance de mérito entre los dos sexos existe un interesante desequilibrio. Dada la mayor contribución de la mujer al proceso reproductivo, es decir al "haber" existencial entre las generaciones, la madre considera, intrínsecamente, que el padre del niño tiene una deuda implícita con ella. El embarazo, el parto, la lactancia y la atención del recién nacido sobrepasan en tal medida el peso de la contribución masculina al proceso de reproducción —tan fundamental desde el punto de vista ético—, que los padres pueden tener que llegar a extremos en materia de rendimiento en el trabajo y en la productividad cultural o financiera, etcétera, para "probarse" a sí mismos y recuperar la simetría existencial. Como resultado de esto, para las mujeres es siempre más fácil hacer sentir culpables a los hombres y los hombres son siempre más vulnerables a los sentimientos de culpa. En resumen, el balanceo de méritos —sobre todo las deudas en que se ha incurrido— es dinámica profunda, habitualmente eludida y negada, a través de la cual las vidas se entrelazan con sentido. El terapeuta debe ser capaz de contrastar e integrar este ámbito con el de los vínculos relacionales basados en sentimientos, necesidades personales, estilos interaccionales, etcétera.

Dinámica estructural versus motivación personal

El concepto de "libro mayor de méritos", con su implícito entrelazamiento de tragedias humanas, inmerecidas desdichas y maldiciones ancestrales, introduce el ámbito de las determinantes estructurales, no personales, de la vida humana. Estas determinantes trascienden, pero a la vez incluyen, el ámbito de motivaciones personales de los individuos intervinientes. Pero mientras que las motivaciones individuales pueden ser facetas conscientes o inconscientes de la mente del actor, las determinantes estructurales de relación no están en la mente de nadie, por lo tanto no pueden ser rotuladas de conscientes o inconscientes. Es más preciso pensar en ellas como visibles o relativamente invisibles.

Un típico ejemplo de determinantes estructurales es el conflicto de lealtades entre las obligaciones filiales de una persona

y su obligación de consagrarse ante todo a una relación matrimonial. Estos conflictos entre demandas de lealtad vertical o primaria y horizontal o secundaria en un individuo, pueden llevarlo ya sea a una nueva manera de balancear estas obligaciones conflictivas o a un patrón alternativo, según el cual sacrifica primero la relación filial y después la matrimonial. Este balanceo invisible es la determinante profunda de nuestros divorcios.

Otra determinante estructural de importancia en la relación familiar y en el desarrollo de la personalidad es lo que podríamos llamar "lealtad dividida". En primer lugar, en esta situación relacional —fundamentalmente mucho más destructiva— el niño no puede desarrollar su campo de sólidos vínculos de lealtad primaria o vertical. La atmósfera de traición y mutuo socavamiento que impera en la relación entre los padres hace que el hijo esté constantemente expuesto a un campo conflictivo en lo que se refiere a confianza básica en su familia de origen y en lo que se refiere a lealtad a ésta. No puede ser leal a ambos padres a la vez. La lealtad hacia uno de ellos significa, inevitablemente, deslealtad hacia el otro. Esta situación lleva a una creciente y destructiva parentalización del niño, que lo obliga a dar más y más de su fuerza estructural y de su devoción, para salvar la brecha que se produce en esa situación triangular entre él y sus padres.

Una vez que los recursos del niño se han agotado, esta actitud relacional básica, profundamente destructiva, puede llevarlo a una autodestrucción suicida, a una grave psicosis, a crímenes mayores y a otras salidas desesperadas. No es raro que la tercera generación —si la hay— resulte afectada por una influencia más destructiva aún que la experimentada por la segunda.

El contrato terapéutico

En un análisis final, el factor distintivo esencial entre la terapia familiar de cualquier clase y la terapia individual, reside en el aspecto contractual del compromiso asumido por el terapeuta, tanto en forma explícita como implícita. En síntesis, puede decirse que, mediante su contrato explícito, el terapeuta familiar celebra una alianza con todos los miembros accesibles de la familia,

especialmente con los responsables. En un sentido implícito, el terapeuta celebra un contrato con todos los miembros del sistema de relaciones cercanas, sin tener en cuenta si éstos concurren o no a la sesión. Por ejemplo, en el comienzo de una terapia puede bastar el contrato con los padres, para comprometer a toda la familia. Sin embargo, a la larga, todos los miembros de la familia deberán comprometerse éticamente con la terapia y nadie podrá hacerse cargo del compromiso de otro miembro. Como resultado de esto, el terapeuta también celebra un contrato implícito con una entidad relacional sistémica inherente y debe rendir un máximo de beneficio para toda la familia, con un mínimo de resultados perjudiciales. Por la misma razón, el terapeuta celebra un contrato implícito que se opone a los mecanismos relacionales sistémicos intrínsecamente destructivos y perjudiciales. Debe tratar de incluir en la terapia al mayor número posible de miembros de la familia y de comprometer sus esfuerzos en procura de un objetivo: el de beneficiarse no sólo ellos mismos sino también los demás integrantes del grupo familiar. No puede dejar de tener en cuenta a aquellos miembros de la familia que no concurren y no desean comprometerse en el proceso terapéutico. Si es un terapeuta familiar, por definición no puede sentirse satisfecho si su trabajo beneficia a ciertos individuos en perjuicio de otros miembros de la familia. Éticamente está obligado a favorecer incluso los intereses y el bienestar de los miembros ausentes o renuentes. Esto debe tener vigencia aun cuando las actitudes de dichos miembros y los roles familiares que les han sido adjudicados, los hagan aparecer como villanos.

Parcialidad multidireccional

Las descripciones tradicionales del rol terapéutico suelen presentarlo como idealmente neutro o imparcial. Sin cuestionar el valor de un debido grado de distancia y objetividad profesionales, la limitada definición técnica del rol terapéutico carece de significado desde nuestro punto de vista humanístico. El terapeuta deberá tratar de evitar el uso de la relación terapéutica en beneficio de sus propias necesidades personales. En este sentido, por su-

puesto, su rol deberá ser neutral y no ansioso, apasionado o vehementemente hostil. Por otra parte, en lo que se refiere a empatía, resulta una ventaja poder simpatizar o empatizar con el dolor del paciente, y desear que ese dolor se reduzca a un mínimo o sea reemplazado por satisfacción. Visto desde este punto de vista humanístico, el rol del terapeuta individual tradicional se limita a una toma de partido a favor de su paciente y nada más. Los rasgos contractuales manifiestos de su relación terapéutica —que se caracteriza por ser confidencial y por brindar completa atención y honesto servicio técnico— enfatizan en forma unilateral el rol de abogado del paciente.

Aunque los problemas de la contratransferencia terapéutica han sido tradicionalmente discutidos desde el punto de vista de la técnica, tales cuestiones adquieren significación ética a la luz de la competencia entre las necesidades personales del paciente y las del terapeuta. Si la hora de terapia se utiliza más que nada para servir a las necesidades personales del terapeuta o si —para decirlo más llanamente— el terapeuta usa al paciente para sus fantasías sexuales o de dependencia, su contrato ético se torna cuestionable.

Aun dejando de lado el hecho de que el paciente pueda o no resultar objetivamente dañado, la pretensión de suministrar un servicio profesional invocada por el terapeuta tiene que ser contrapuesta al "servicio personal" que éste obtiene de su paciente. Además, el terapeuta correría el riesgo de que su estrategia terapéutica fuera inconscientemente determinada por sus propias gratificaciones de necesidades, más que por la demanda de asistencia técnica del paciente. En resumen, las discusiones de la ética contractual de la psicoterapia individual de corte tradicional retornan a las raíces del antiguo juramento hipocrático, al definir las necesidades incontrolables del terapeuta (médico) como la principal posible fuente de riesgo para la prestación ética de servicios.

La situación cambia radicalmente cuando el terapeuta se enfrenta con la necesidad de celebrar un contrato para el tratamiento de varios miembros de una misma familia. Debido al entrelazamiento existencial de sus vidas, en los familiares cercanos existe una inevitable pugna de intereses, necesidades y reclamos de justicia en lo que se refiere a sus respectivas posiciones. Puesto que la

antitética naturaleza de sus mutuas expectativas y obligaciones está basada en la dialéctica de la realidad existencial, cualquier esfuerzo de ayuda simultánea brindado a dos o más partes, lleva implícito el riesgo de un conflicto de intereses. Esta circunstancia también establece una diferencia entre la terapia familiar y la psicoterapia de grupo. La dinámica de los grupos fortuitos se origina más en un compromiso emocional de tipo transferencial, artificialmente creado, que en una fundamental interdependencia ético-existencial entre sus miembros.

Aun cuando lo que se procura es un equilibrio de mutua confirmación y aprobación entre los miembros de la familia contendiente, el terapeuta familiar no puede evitar que se lo coloque en el rol de árbitro o de juez. Justamente porque el sentido de justicia familiar herido es el sustrato más frecuente de la desesperación, el suicidio y el asesinato, al terapeuta familiar le resulta imposible mantenerse ajeno a la presión de la apasionada demanda de los miembros de la familia contendiente, que reclaman una toma de partido a favor de uno y en contra del otro y viceversa. Si bien en estas circunstancias es imposible e inconveniente la posición de neutralidad terapéutica fría e imparcial, la alternativa de tomar partido por todos los participantes sirve para intensificar el conflicto entre ellos y también tiende a poner a prueba la experiencia profesional y de vida del terapeuta. Sólo el terapeuta que puede empatizar con la posición de cada miembro de la familia podrá tomar sucesivamente partido a favor de cada uno de ellos. El o la terapeuta deberían desarrollar una capacidad de identificación con las dos partes de una relación conflictuada. Quizá pueda ayudarse a la familia haciéndole ver que el terapeuta es también un padre, o incorporando a otro terapeuta del sexo opuesto.

Pero las exigencias de la parcialidad multidireccional van más allá de una rica experiencia de vida. La capacidad para alinearse multilateralmente con las partes en pugna, que combaten desde frentes opuestos de una relación, requiere también una flexibilidad con respecto a las propias posiciones relacionales del terapeuta. Muchos terapeutas están hondamente predispuestos contra los padres en general y tienden a una unilateral alianza con el hijo herido, para oponerse a los supuestos victimarios. Si el terapeuta no ha aprendido a empatizar con los aspectos de víctimas

que hay en el pasado de sus propios padres, no puede esperarse que se alinee genuinamente, tanto del lado de la generación de los padres, como de la de los hijos, en el curso del tratamiento familiar.

Así como no sería ni aconsejable ni apropiado que un terapeuta aplicara sus propios juicios de valores y prejuzgara a los miembros de una familia, desde un punto de vista humano tampoco es lógico pretender que mantenga una actitud insensible, neutral y distante con respecto al drama que se desarrolla ante sus ojos. Las máximas perspectivas de ejercer una influencia terapéutica y humana residen en la capacidad del terapeuta para tratar de alinearse con la posición relacional de cada miembro de la familia, de acuerdo con sus méritos.

Esta toma de partido sucesiva corresponde a una visión dialéctica de las relaciones, en la cual cada posición relacional es siempre complementada por la correspondiente posición inversa de la otra parte. En consecuencia, el terapeuta debería considerar toda situación humana como una situación en la cual tienen cabida ciertos factores atenuantes para todas las partes en litigio. De ninguna manera cabe aceptar que una parte es victimario absoluto, mientras otro es víctima cien por ciento. El terapeuta debe evitar ser atrapado por la idea de la verdad y la justicia absolutas.

La exitosa adopción de una actitud terapéutica de parcialidad multidireccional libera al terapeuta de tener que arribar a su propia conclusión sobre quién está bien o mal en un sentido absoluto. Sólo procurará elegir el mejor argumento posible para sustentar la posición de cada individuo comprendido en el sistema relacional. Las posiciones relacionales no sólo deberían ser entendidas desde puntos de vista emocionales o de manipulación del poder, sino también con un sentido humano de equilibrio de la justicia. Es una ventaja para el terapeuta que —contrariamente a lo que sucede en el rol de juez— no tenga que decidir quién tiene o no razón en última instancia.

Las relaciones estrechas deben contemplarse inmersas en explotaciones estructurales inadvertidas. Estos daños estructurales no sólo son inconscientes de parte de los explotadores, sino que, en realidad, no hay nadie en particular que haya sido el perpetrador. Por lo común, la justicia es el resultado de un arreglo estructural

multipersonal; no existe una intención personal. Generalmente no hay una motivación consciente ni inconsciente en nadie. Por añadidura —en un balance general de sus vidas— los aparentes perpetradores de actos de explotación, el malvado padre dominante o la madre aviesamente controladora son tanto víctimas como victimarios, por lo menos en igual medida. La amargura de ciertas experiencias de vida, de las cuales ellos mismos han sido precoces víctimas, debe haberlos convertido en "villanos". Por eso, la simple condenación surgida del prejuicio contra el miembro aparentemente nocivo de la familia confirmaría la injusticia en lugar de corregirla.

En resumen, la actitud de parcialidad multidireccional es efectiva porque corresponde a una más amplia verdad y justicia humanas: la comprensión dialéctica multilateral de las relaciones humanas cotidianas. Sin capacidad para la posición ética de parcialidad multidireccional, un terapeuta sólo puede planear estrategias terapéuticas de limitado alcance; y sin un sentido de responsabilidad personal, sólo puede desempeñar un rol "técnico" menor, ya sea que trate a uno o a varios miembros de la familia como "pacientes".

Defensa del niño y previsión en el contexto familiar

Muchos terapeutas individuales consagrados a la evolución infantil —por lo general, psicoterapeutas de niños— creen estar en una posición óptima para coordinar los distintos roles asumidos por la sociedad en defensa del niño. En esta creencia hay mucho de verdad, por cierto. Los especialistas en evolución infantil reúnen un enorme cúmulo de material diagnóstico y una amplia comprensión psicológica de los signos de un niño cuya vida es perturbada o dañada por el ambiente. Por supuesto, percibir las señales de auxilio inconscientemente emitidas por los niños y responder a ellas es de enorme importancia.

Pero el considerar las *estrategias de acción* tendientes a reparar o —lo que es más importante aún— *prevenir* los daños causados a los niños es algo muy diferente. Al aislar al niño como objeto de terapia se está eximiendo implícitamente al am-

biente familiar de una obligación: la de someterse a examen y cambiar. En lugar de eso se adjudica implícitamente al niño la responsabilidad de tener que producir un cambio no sólo en sí mismo, sino también en el sistema relacional entero, cuando lo cierto es que la incidencia del sistema sobre él es lo que lo ha convertido en víctima sintomática.

El enfoque tradicional de la terapia infantil no se ha preocupado por las necesidades de dependencia de los padres, en tanto partes de un sistema dinámico relacional. El enfoque relacional dialéctico, en cambio, integra el tradicional énfasis sobre el niño, con su premisa antitética: "¿De qué manera está llenando el niño las necesidades de dependencia de sus padres?" Este enfoque revela las múltiples facetas del uso inadvertido que se hace de los niños como sustitutos de los padres de los padres.

Parecería que en las dos primeras décadas de su historia, el enfoque dinámico relacional o familiar ha formulado más interrogantes que los que es capaz de contestar. Más que una simple técnica o una ocasional apertura conceptual, constituye un punto de vista revolucionario que influirá sobre todas las concepciones preexistentes acerca del bienestar de los seres humanos.

SUMMARY

This presentation deals with a subject much broader than therapeutic technique. Yet, while it examines the premises of intergenerational family theory, family therapy, or psychotherapy in general, it aims to keep focus on practical matters of therapeutic strategy.

The risk of a mainly technical or instrumental description of psychotherapy lies in a necessary extent of over-simplification which not only remains silent about the fundamental personal premises of the therapist but leaves the issue of the scope and range of the subject matter of psychotherapy undefined. Just as the blind man who after having gotten hold of the elephant's tail, declares that the animal resembles a snake, it is proposed that the traditional, that is individual or psychologically based descriptions of psychotherapy, tend to misrepresent and underestimate the scope of phenomena they propose to deal with.

Hijos y padres en un mundo cambiante (Referencias africanas)

Hospital de Rehabilitación "Catherine Mills". Monrovia, Liberia.
Trabajo presentado en el VI Congreso de Psiquiatría,
Honolulu, U.S.A., agosto 28 - setiembre 3, 1977,
Traducción del doctor Manuel Trilnik.

E. F. THEBAUD

Clinical Director, Greenwell Springs Hospital,
Greenwell Springs, La 70739, U.S.A.

Recientemente, muchos estudios se han ocupado del problema de la salud mental de los jóvenes de Africa. Vale la pena mencionar entre éstos al Seminario de Trabajo de Mauritius (1970), el Tercer Congreso Psiquiátrico Pan-Africano en Khartoum (1972) y la Conferencia en Dakar (1973), todos sobre el mencionado tema. Otros grupos trabajaron sobre "Alcoholismo y Drogadicción". De los temas tratados durante estas reuniones, se ve claramente que sus participantes están cada vez más preocupados por diferentes formas de comportamientos irregulares de la juventud y subrayan que instituciones tradicionales, en particular la familia, como resultado de su propia desintegración, no pueden contener a los jóvenes. Un repaso de la literatura psiquiátrica africana mostraría una cantidad considerable de estudios dedicados a la delincuencia juvenil, salud mental estudiantil, abuso de droga, etcétera.

El título de este trabajo es ambicioso, por lo que requiere

cierta clarificación, siendo peligroso hablar de África en general. África es un vasto continente, el segundo más grande del mundo. Contiene climas muy variados, mediterráneo, desértico, la sabana y el bosque de lluvia. También es un continente de muchas agrupaciones raciales y étnicas.

Las sociedades africanas no eran estáticas antes de la conquista europea. En el oeste se había logrado contacto con el mundo árabe y europeo a través de las rutas del Sahara y ya en la Edad Media la costa este realizaba intercambios con el lejano oriente. Estos contactos produjeron mezclas de razas y culturas.

Lo siguiente tratará del África del sub Sahara o África negra. No es un área homogénea y comprende muchos países y gentes que, no obstante, en esta etapa de su historia tienen ciertas similitudes. Todos se han visto sometidos a la colonización por potencias occidentales que trajeron economías monetarias y han impuesto nuevas ideologías e instituciones sobre el marco de los sistemas tradicionales. En el mejor de los casos hubo una incómoda coparticipación, cuando no un conflicto declarado entre lo viejo y lo nuevo. Los jóvenes que están en el muy especial momento de transición entre juventud y madurez viven este conflicto como una pérdida de comunicación con la generación de sus padres.

Consideraciones sobre la demografía africana

Faltan datos fehacientes sobre la población africana. Los informes de censos son aceptados como estimaciones, más que como datos ciertos. No obstante lo cual, uno podría hacer las siguientes observaciones:

- a) Estudiando la distribución por edad, aparentemente hay una población predominantemente joven en África. En Liberia, donde se pudieron recoger datos, el 51 % de la población tenía menos de 20 años.
- b) A pesar de la tendencia hacia una rápida urbanización, la mayoría de la población africana vive en zonas rurales. La población urbana varía de país a país: del 3,4 % en Rwanda al 36,3 % en Zambia.

- c) La tasa de analfabetismo es muy alta en la mayoría de los países: 79 % en Liberia. En este país asisten a la escuela sólo el 13,4 % de los jóvenes.

El alto porcentaje de la gente joven nos permite evaluar la magnitud del problema de aculturación de las jóvenes generaciones. Por otro lado, sería erróneo presumir que la baja población urbana haga que las zonas rurales hayan permanecido ajenas a influencias extranjeras. No hay zona que se haya salvado del proceso de cambio cultural, a tal punto que sólo se puede hablar de un medio relativamente tradicional.

La familia africana

Para entender mejor el conflicto potencial entre niños o, mejor dicho, generaciones jóvenes y sus familias, conviene entender la estructura de la familia ampliada, el lugar del individuo en dicha estructura, y la interacción entre el individuo y el grupo.

El ambiente habitual es generalmente el "bosque tupido" donde apenas se ve el sol, y la sabana. Es donde uno puede hallar animales salvajes y "malos espíritus". Muy tempranamente, el niño aprende a no apartarse demasiado lejos en este medio ambiente hostil sin algún tipo de protección: arma o talismán. La vida es muy precaria y la existencia se ve permanentemente amenazada por peligros naturales, sequías, lluvias, inundaciones, insectos destructivos. La cohesión del grupo es esencial para poder sobrevivir en estas condiciones. Toda la instrucción primaria de un individuo lo preparará para verse y funcionar como parte integrante del grupo. Los hombres de la tribu son también parientes y sienten que provienen de un antepasado común. El extraño es un elemento disociador. En una aldea cercana a Monrovia, cuando se desarrollaba una ceremonia tradicional, se colocó el siguiente cartel: "Prohibido pecadores". Entiéndase por pecadores, a los no miembros. Esto demuestra los resquemores, si no la franca desconfianza que se tiene a los extraños.

El jefe tiene poderes espirituales y temporales. Su autoridad no se discute, pues ha adquirido sapiencia y conocimientos,

principalmente en virtud de su edad. Es el nexo entre los que viven y los muertos, los antepasados y los que aún no han nacido. Si ocurre una calamidad, él ofrece una explicación: se ha descuidado a los antepasados y hay que remediarla a través del ofrecimiento de algún sacrificio. El jefe tribal también es el nexo entre su grupo y el gobierno. Ha ocurrido en algunos países que la medida del gobierno tendiente a inducir a jóvenes a trabajar en labores rentables ha sido implementada por autoridades tribales.

En la organización tribal la meta de la educación no es la obtención de la independencia individual. En cambio, se establecen como ideales la sociabilidad e integración en el grupo. El individuo sólo existe en relación con otros. No obstante, sería erróneo pensar que el individuo no existe. Todos tienen su lugar, aun antes de nacer. Un niño podría ser la reencarnación de un antepasado, por lo que tiene especiales privilegios desde el nacimiento.

Se prepara al hombre de la tribu para cumplir su rol a través de un sistema educacional que merece ciertas consideraciones.

Algunos autores han llamado simbiosis extrauterina a la relación entre madre e hijo. En realidad, a través del hecho de transportar en las espaldas al bebé, éste está en permanente contacto físico con la madre. Se puede ver a chicos durmiendo en las espaldas de sus madres mientras éstas cocinan, venden en el mercado o reman en la laguna. Se da el pecho hasta los 18-24 meses y siempre está disponible para ser tomado y succionado por el bebé. La falta de frustración oral deja profundas influencias sobre la organización de la personalidad del adulto.

El bebé, además de la de su madre, cuenta con muchas otras espaldas en su medio. Los contactos físicos se incrementan conjuntamente con otras formas de comunicación no verbal.

El control de esfínteres se logra libremente, probablemente a través de un proceso de identificación con el adulto, más que a través de coerción.

Debemos recordar que la maternidad y la paternidad no son conceptos biológicos en la familia africana. Los tíos son como padres, tías y coesposas (donde existe poligamia) como madres.

La adolescencia está marcada por ceremonias que buscan

subrayar la integración del individuo en el grupo. En algunas zonas, además del grupo de pares, encontramos las "escuelas de iniciación", también conocidas como las "sociedades secretas". Esta es una de las pocas maneras mediante las cuales sociedades iletradas pueden transmitir conocimientos de una generación a otra. La importancia de estas sociedades puede verse por el hecho de que los pigmeos, que son recolectores y nómades, dejan a sus hijos para que concurran a las "escuelas de iniciación" de las tribus sedentarias vecinas.

Las sociedades secretas no son mixtas. En Liberia, Sierra Leona y ciertas zonas de Guinea y Costa de Marfil, los varones asisten a la sociedad Poro y las mujeres a la sociedad Sande. Estas organizaciones, altamente estructuradas, tienen una gran variedad de funciones, que abarcan desde el arte de la medicina, actividades recreacionales, hasta las reglas de conducta sexual. Al finalizar esta iniciación, el adolescente está preparado para cumplir sus roles productivos y reproductivos dentro de la sociedad. Durante este período se acuerda el casamiento de las chicas. En este caso, no se trata de la unión de dos individuos, sino de dos familias. La finalidad de la sexualidad es la procreación y los intereses de la pareja se mantienen sometidos a los intereses del grupo. Marido y mujer deben rendir cuentas a sus familias, que proveerán para que la unión se mantenga viable.

Se ha cerrado el círculo y los hijos nacidos de dicha unión se criarán para sentirse parte integrales de la familia ampliada, del clan y de la tribu. No hay una línea demarcatoria clara entre su ego y sus parientes.

¿Debemos presumir por estas observaciones que las sociedades africanas tradicionales ignoraban conflictos y ansiedades? No había conflictos entre generaciones porque cada individuo tenía su vida proyectada de antemano. Un sistema de referencia daba explicaciones para las causas más o menos previsibles de ansiedades y también daba los medios para superarlas. Las gentes no dudaban de la sabiduría que inspiraba las decisiones grupales.

Veamos ahora el impacto de cambio sobre el funcionamiento del grupo y sus consecuencias en el joven.

La familia africana en un mundo cambiante

La estructura familiar arriba descrita corresponde a un tipo de sociedad muy simple, que vive con una economía de subsistencia, empleando medios técnicos muy elementales para manejar su medio. Las principales preocupaciones de la gente eran: la fertilidad de la tierra, la fertilidad de las mujeres y la salud de los hombres. Las pocas tareas a realizar requieren poca especialización y se planifican de una vez para siempre.

Esta cohesión se mantuvo intacta hasta que las potencias occidentales trajeron dinero, asalariados y firmas capitalistas de economía en gran escala. Comenzó un proceso de migración hacia las ciudades, plantaciones y minas. Algunos emigrantes intentaron congregarse de acuerdo con sus afinidades en las nuevas poblaciones, pero la familia ampliada mostró una tendencia irreversible hacia la nuclearización. La dominación del sistema capitalista sobre el sistema económico tradicional tiene su contrapartida ideológica. Se dominaban nuevas pericias gracias a conocimientos adquiridos a través de libros. El nuevo fenómeno, "aprendizaje a través de libros", afectó la relación padres-hijos negativamente, porque la edad era antes la única fuente del conocimiento y la sapiencia. En las escuelas, generalmente de misioneros, los jóvenes africanos conocieron nuevos valores. El inglés y el francés eran ahora superiores a las lenguas africanas, la monogamia a la poligamia, la competencia a la confiabilidad del grupo, etcétera.

Las autoridades tribales no tuvieron opción, teniendo que conciliar con la nueva corriente. Por ejemplo, la duración de las clases de iniciación, que duraban años, tuvieron que reducirse a meses, cuando no a un par de semanas, para evitar conflictos con los programas académicos.

El autor pudo observar durante la *Bush breaking* ceremonia que significa el fin de la escuela de iniciación, que los trajes de la mayoría de los alumnos eran una extraña mezcla de ropa tradicional hecha con paja y collares occidentales, broches y anillos. Muchos usaban anteojos de sol y carteras. Las decoraciones de los rostros y cuerpos eran también una mezcla de arcilla, lápiz de labios y pintura de uñas. Después de observar todos los ritos tribales, las chicas fueron llevadas a una casa donde una

habitación había sido especialmente preparada para ellas. Se podía observar un inmenso ventilador trabajando a todo vapor y un tocadiscos tocando música pop. Cuando se consultó a las autoridades de la tribu sobre estas combinaciones, contestaron que los jóvenes habían vuelto al mundo al cual pertenecían.

Las dudas y actitudes ambivalentes de los padres ante los cambios se ejemplificaban por la siguiente historia. Un hombre que trabajaba como cocinero en la ciudad durante 30 años se convirtió al cristianismo. Todos sus hijos nacieron y vivieron en la ciudad y son también cristianos. Contra toda lógica, decide mandar su hija a una escuela de iniciación que dura dos semanas, durante las vacaciones. Explicó su decisión de la siguiente manera: "No sirve para la escuela. No llegará lejos. Si no la mando a la escuela Bushi, no pertenecerá a ningún lado".

El joven africano en un mundo cambiante

El individuo joven, que ha sido entrenado para vivir y compartir con otros, se encuentra ante la vida solitaria e individualista de la ciudad. Todo aspecto de su funcionamiento social y psicológico se verá afectado por el conflicto entre los sistemas de valores. En clase, si se lo ve comunicándose con un compañero, escuchará con asombro a la maestra diciéndole que es erróneo compartir sus conocimientos.

A veces el estudiante es el único entre sus hermanos que ha sido escogido para asistir a la escuela. Ni bien pueda ganar algún dinero, se le envían sus hermanos más jóvenes y la familia espera que mande algo de sus ingresos. Vive con el temor de fracasar y en la ansiedad creciente de las épocas de exámenes, porque entiende que es el depositario de mucho orgullo y esperanza.

Estos jóvenes solitarios se buscan ansiosamente. Mucho tiempo que debería usarse para estudio se utiliza en visitas frecuentes. Muchas veces se sienten "embrujaos" por gentes celosas. En esas circunstancias se visita el pueblo para lograr la protección, pero ocurre que ya el sistema de interpretación ofrecido por la familia para las desgracias ha perdido sus fuerzas

de apaciguación. No sorprende que cada vez con mayor frecuencia se encuentren en la ciudad interpretaciones persecutorias y que a la vez proliferen nuevas sectas religiosas que ofrecen soluciones a nuevas ansiedades.

Caso Nº 1

G. Un hombre estudiante de enfermero es enviado al psiquiatra por comportamientos extraños durante su trabajo. Pide frecuentemente disculpas a sus superiores por faltas que no ha cometido y ruega que no se lo eche de la escuela. Siempre promete mejorar su rendimiento. Su historia nos cuenta que en su tribu es costumbre, cuando muere un hombre, que su hijo primogénito herede todas sus mujeres, con la excepción de su propia madre, por el tabú del incesto. Por lo que, cuando murió su padre, su madre fue la esposa de su hermano mayor y tuvo hijos con él. El hermano es alcohólico y no puede hacer frente a sus nuevas responsabilidades. G. vive con el temor permanente de ser expulsado de la escuela de enfermeros, sabiendo que sólo el sueldo de un profesional le permitirá mantener a su madre y a los hijos de ésta.

Contrariamente a lo que ocurre en culturas occidentales, África considera que la iniciación sexual es un evento social. A través del paso de la niñez a la adultez, el adolescente realiza ciertos actos rituales en grupo. Se marca su cuerpo con marcas tribales y en algunas tribus se les hace la circuncisión a los varones y a las niñas se les efectúa clitoridectomía.

El origen y significado de estas costumbres son aún una cuestión incierta que produce no poca controversia y especulación. Deben verse simbólicamente como una forma de integración en el mundo adulto. A continuación de esas ceremonias se realizan matrimonios prefijados para las chicas. Los muchachos se casan en una etapa posterior de sus vidas, cuando ya pueden pagar el "precio" de las novias.

Como no ocurre con su contraparte occidental, en ese momento crucial de la vida, lleno de ansiedades, el joven africano se siente acompañado. La sexualidad se considera una función normal, aprobada y codificada por el grupo. No obstante, expues-

to a las enseñanzas cristianas, el adolescente aprende que lo sexual es pecaminoso cuando se da fuera del matrimonio, siempre que éste sea cristiano. Se le enseña a sentir que es producto de un pecado de sus padres y los tiene por personas pecaminosas. La apreciación de su herencia cultural y de sí mismo se ve muy afectada. Nombres "nativos" se cambian por nombres "cristianos" o "civilizados" para facilitar la integración en la cultura dominante.

Lo sexual se transforma en una función misteriosa y angustiante. En el África tradicional un individuo se siente culpable por lo que sueña, por lo que un sueño erótico o, aún peor, incestuoso, puede ser una fuente de ansiedad y culpa.

A través de lecturas y medios de información, el joven africano occidentalizado aprende que la elección de una compañera puede ser un asunto muy personal y le cuesta ahora aceptar la ingerencia de la familia en tales asuntos.

En el pasado, los padres elegían un compañero para su hija tomando en cuenta ciertos parámetros como la fortuna, pero también por pertenecer a un clan determinado, pues nadie se casaba con una persona de un clan inferior. No pueden admitir que hoy para sus hijos educados con un criterio occidental, la elección de la pareja puede basarse en otro criterio.

Caso Nº 2

Un joven empezó a perder peso. Su rendimiento laboral decayó. Parecía perdido. Explicó a través del siguiente relato: su tío le había elegido una chica joven como esposa antes de que él se fuese del pueblo para continuar con su educación. La chica también comenzó a asistir a la escuela primaria en el pueblo y llegó hasta el noveno grado. En el interín, el tío decide casarse con ella y lo logra a través de un acuerdo con la familia de la chica. Ella se escapa de la casa de su marido porque, de acuerdo con su versión, él tomaba demasiado, era analfabeto y le llevaba más de 25 años de edad. Se unió a C. en la ciudad y prometió que se suicidaría si la obligaban a volver con el marido. Cuando todo esto se supo, el marido insistió en que ella le fuese devuelta y la familia de ella estaba de acuerdo. C. también supo que la familia de la chica era poderosa y que lo podían matar en menos

de un año a través de la "ciencia africana". Aunque quería a la chica, decidió que, por su propio bienestar, ella debía volver con el tío. Se realizó un encuentro familiar sin la presencia de la chica y se decidió que ella debía volver a su marido, el tío.

Conclusión

Dentro de los límites de este trabajo, no ha sido posible tratar todas las complejidades del problema que afecta a los padres africanos y a sus hijos. Todos los días se ven nuevos enfoques de los problemas creados por los rápidos cambios sociales. Por ejemplo, el Kwashiorkor, que ahora predomina en zonas urbanas, se consideraba una simple deficiencia de proteínas. Ahora se acepta como una forma de "anorexia nerviosa", una reacción del chico al rechazo por parte de la madre cuando ésta tiene un nuevo bebé. Podríamos también hablar de dificultades de aprendizaje, debidas a métodos de enseñanza y metas académicas importadas que no toman en cuenta las realidades africanas. La alta frecuencia de desórdenes psíquicos asociados al nacimiento, merecen ser destacadas en este contexto, pues las niñas pueden casarse y tener hijos desde los trece años. En las ciudades, grupos de adolescentes vagos y marginados se han desarrollado en asociaciones de delincuentes y drogadictos. Mientras los misioneros traen tabúes sexuales, métodos anticonceptivos se tornan accesibles a un número cada vez mayor de jóvenes.

Los padres ya no saben cuál es su rol y qué actitud han de tomar. Algunos renuncian a sus responsabilidades mientras otros intentan usar coacción y ambas actitudes son igualmente nocivas. Otros grupos tratan de conciliar, manteniendo ciertos ritos tradicionales, pero para muchos, estos ritos han perdido todo significado. Por ejemplo, la circuncisión que marcaba el paso de la niñez a la madurez, ahora se realiza como un acto médico.

A pesar de lo específico en la situación africana, en Africa, padres e hijos están viviendo el mismo dilema que sus contrapartes en el resto del mundo: ¿Cuál es el camino? No hay solución mágica. Es utópico pretender cambiar el curso de la historia y volver al Africa precolonial. Al cuestionar el valor del individualismo y

la competencia occidental, uno debe reconocer que ciertos aspectos de la cultura tradicional deberían ser reafirmados en una sociedad moderna.

No obstante, demasiado frecuentemente en su búsqueda de progresos materiales, líderes africanos descartan valores tradicionales sin tener en cuenta su reemplazo por algo significativo para la gente. Olvidan que para los cambios que afectan sus vidas sean realmente válidos, las personas deben estar identificadas con ellos. Tal enfoque podría aliviar algunas de las tensiones y dilemas que afrontan las nuevas naciones africanas.

Bibliografía

ARTICULOS:

1. H. COLLOMB, "La position du conflit dans les structures familiales en voie de transformation", *Canadian Psychiatric Association Journal*, Vol. 12, 1967.
2. H. COLLOMB, "Psychopathologie et environnement familial en Afrique", *Psychopathologie Africaine*, Vol. 2, 1968.
3. H. COLLOMB, R. GUENA y B. DIOP, "Facteurs psychologiques dans la pathologie de la puerperalité", *Proceedings of 2nd Pan-African Psychiatric Workshop*, Mauritius, 1970.
4. H. COLLOMB, B. DIOP y S. VALENTIN, "La malnutrition protidique chez L'enfant", *Proceedings 2nd Pan-African Psychiatric Workshop*, Mauritius, 1970.
5. B. DIOP y H. COLLOMB, "Problèmes éducationnels au Senegal, Relations intra-familiales, Modèles et autorité dans la société Wolof", *Proceedings of 2nd Pan-African Psychiatric Workshop*, Mauritius, 1970.
6. E. F. THEBAUD, y E. F. RIGAMER, "Some considerations on student mental health in Liberia", *African Journal of Psychiatry*, Vol. 2, N° 1, 1976.
7. E. F. RIGAMER y E. F. THEBAUD, "Psychiatric observations of Liberian youth", *Proceedings 8th International Congress of Child Psychiatry & Allied Professions*, Philadelphia, 1974.

LIBROS:

1. P. HANRY, *Rites d'Initiation sexuelle de l'adolescent*, Editions Universitaires, 1972.
2. KENNETH LITTLE, *West African Urbanization*, Cambridge, 1965.
3. KENNETH LITTLE, "The Role of the Secret Society in Cultural Specialization". In *Cultures and Societies of Africa*, editado por Simon and Phoebe Ottenberg, Random House, New York, octubre, 1969.

E. F. Thebaud

4. C. M. TURNBULL, *The african condition, in the child in his family: children at psychiatric risk*, John Wiley & Sons, 1974.

DOCUMENTOS:

1. Bureau of Planning, Research and Development - Ministry of Health and Social Welfare, Republic of Liberia, 1977, *Basic information for a country profile*.

SUMMARY

Within the limits of this paper, it has not been possible to deal with all the complexities of the problems facing African parents and their children today. Every day new implications of these rapid social changes are being demonstrated. For instance, Kwashiorkor which is now prevalent in urban areas used to be considered as a simple protein deficiency. It is now accepted as a form of anorexia nervosa, a reaction of the child to the rejection by the mother when a newborn arrives. We could also mention learning difficulties due to imported teaching methods and academic goals that do not take into consideration the African realities. The high frequency of Psychiatric disorders associated with childbirth deserves to be mentioned in this context, since girls may get married and become mothers from the age of thirteen. In the cities, groups of vagrant marginal adolescents have become associations of delinquents and drug users. While missionaries are introducing sexual taboos, contraceptive methods are becoming available to larger numbers of young people.

Parents are uncertain about their role and about which attitude to adopt. Some abdicate their responsibilities while others use coercion, and each attitude is equally harmful. Another group tries to compromise by keeping certain traditional rites, but for many, those rites have lost all their meaning. For instance, circumcision that used to punctuate the passage from childhood to adulthood may be now practiced as a medical act.

In spite of the specificity of the African situation, parents and children in Africa are facing the same dilemma as their counterparts, the world over: Which way? There is no magic solution. It is utopic to try to reserve the trend of history and to return to pre-colonial Africa. While questioning the value of Western individualism and competition, one must admit that certain aspects of the traditional culture need a reassessment in a modern society.

However, too often, in their search for material progress, African leaders discard traditional values without replacing them by anything meaningful to the people. They must bear in mind that a requirement for the validity of changes affecting their lives, is that the people identify with them. Such an approach might help to relieve some of the tensions and dilemmas which face the emerging African nations.

Aspectos ecológicos en la psicoterapia de la esquizofrenia. Un desafío para el terapeuta

Esquizofrenia 75. Psicoterapia, estudio de familia, investigación.

Editores: Jarl Jorstad y Endre Ugelstad.

El autor reconoce con gratitud la colaboración de Ms. Joan F. Timmis en la preparación de este trabajo.

Traducción del doctor H. Bleiweiss.

DAVID RUBINSTEIN

Introducción

La joven mujer, de 23 años, estaba acostada en el diván en el *living room*. Sus cabellos rubios estaban despeinados y su vestimenta desarreglada. Cuando entré en la habitación, tenía los ojos muy abiertos con expresión de terror; luego de una pausa dijo muy suavemente: "¿Sabe usted que trataron de matarme? ... La madre de Johnny fue asesinada..... Voy a casarme con Johnny..... ¡Salga de la habitación!... ¡No quiero verlo!... ¡Usted está despedido!" Continuó murmurando por un momento para caer entonces en lo que parecía un estado de indiferencia. Ese fue mi primer contacto con Sandi.

Sus padres me habían llamado por una consulta y la escena precedente tuvo lugar en su casa. Durante las últimas semanas Sandi estuvo la mayor parte del tiempo en estado de languidez

sobre el diván y tuvo también dificultades para continuar con sus actividades en el último año.

Estuvo enferma por un período de no menos de cinco años y lenta pero progresivamente se fue recuperando lo suficiente como para ser dada de alta del hospital. Estuvo empleada como secretaria y había comenzado a ponerse en contacto con viejos amigos.

Durante un año fue capaz de manejar un trabajo rutinario y socializarse en un mínimo.

Psicoterapia y fenotiazinas fueron los principales enfoques de su tratamiento durante ese período.

Sólo pocas semanas antes de esta nueva y completa recaída le habían sido suspendidas las fenotiazinas que había estado tomando durante dos años o más. Parecieron haber servido, mientras fueran prescritas, como una barrera protectora contra los estímulos abrumadores y la ansiedad creados por presiones externas y el caos de su mundo interior.

Es importante destacar que lo que me había dicho no había sido totalmente irrelevante. Durante el mes previo la paciente experimentó dos episodios terroríficos. Ladrones habían entrado en su casa mientras estaba sola y, luego de inmovilizarla, registraron la casa. Además, pocos días después, la madre de su novio fue asaltada y asesinada durante un intento de robo.

Es obvio que esas dos experiencias, asociadas con la suspensión de la medicación, fueron también amenazantes para su frágil ego y su deterioro fue muy rápido.

A esta altura Sandi estaba tan desorganizada, asustada y agresiva, que fue necesario hospitalizarla antes de considerar cualquier tratamiento futuro.

Estuvo impulsiva y delirante la mayor parte del tiempo, la corriente del pensamiento era laxa e incoherente.

La hospitalización significaba sin embargo que la paciente habría de ser separada del ambiente familiar y de su casa y transferida a un ambiente extraño con gente nueva y nuevas reglas. Este no es un dilema sencillo de resolver para la familia o para el médico.

En esta situación particular, las posibilidades fueron limitadas por la continuación del deterioro de su conducta.

En el hospital hubo una pequeña disminución de algunas de sus conductas impulsivas y erráticas.

Las regulaciones y horarios impuestos por el personal del hospital fueron eventualmente aceptados por la paciente después de muchas pruebas y de recordarle continuamente lo convenido. El desorden de su pensamiento y afecto no parecieron mejorar a pesar de dársele dosis masivas de fenotiazinas.

Por un período de seis meses parecía que la paciente no se recuperaría de su extrema regresión. Característicamente, cuanto más psicótico era el actuar de la paciente, el personal desarrollaba más sentimientos de resentimiento y hostilidad. Este fue especialmente el caso después que algunos miembros del equipo habían mostrado un interés genuino en Sandi. En respuesta a los sentimientos negativos del equipo del hospital, la paciente se introvertió y evitaba el contacto con la gente, excepto para mostrar sus sentimientos desesperanzados y para poner énfasis en cuánto extrañaba su casa y su familia. La depresión de la paciente y la desesperación del equipo profesional parecían incrementarse paralelamente.

La continuación del contacto humano

El punto culminante fue cuando el terapeuta decidió poner una persona para que cuidara continuamente de la paciente. La persona elegida era una mujer de 29 años con algún entrenamiento en psicología e interesada en la psicoterapia de pacientes esquizofrénicos. Dicha persona debía acompañar a la paciente continuamente durante 5 días por semana y 8 horas por día; por ejemplo si Sandi quería estar en su habitación, la compañera se quedaría con ella, si iba a comer, la compañera compartiría la comida con ella, si la paciente iba a realizar cualquier actividad, la compañera la acompañaba.

Lo racional fue proveer a la paciente de una presencia humana continua y un medio humano conveniente de su campo de experiencia.

El medio humano existe en el medio hospitalario, pero el equipo asistencial está sobrecargado con tantas tareas diferentes que

ello hace que se produzca un mínimo de contacto humano con los pacientes. Se puede calcular que como promedio y en las mejores circunstancias las auxiliares pueden estar con un grupo de seis pacientes mirando televisión, con un mínimo de interacción verbal por períodos de media hora. Enfermeras y personal altamente entrenados permanecen ocupados en la enfermería o en sus consultorios u oficinas realizando otras tareas. Los médicos ven a los pacientes un promedio de 4 ó 5 horas por semana, por lo tanto la mayor parte del tiempo los pacientes están en "terapia ocupacional" haciendo cosas simples u otras actividades que requieren un mínimo de contacto de persona a persona.

Para evitar esa pérdida de contacto humano, para llenar el "vacío humano" el paciente crea delirios y experiencias alucinatorias que le proveen un "medio" sustituto. Este sistema ecológico especial está hecho de viejos recuerdos, sueños deseados, piezas simbólicas de una existencia distorsionada y enmarañada, terrores nocturnos (Sechehaye 1956). El paciente esquizofrénico no sólo resiste a la realidad de la cual trata de escapar sino que continuamente intenta evitar la realidad con la fantasía creada por el proceso psicótico.

Con el objeto de crear un medio humano especial, nosotros debemos proveerle entendimiento, presencia humana neutral, no reactiva. Debemos poder descifrarle el proceso primario y darle sentido a lo incoherente. Debemos llenar las uniones que faltan en la corriente de producciones y asociaciones experimentadas por el paciente. Esto significa que el compañero sustituye la función del ego del paciente que es deficiente.

Más importante es que el compañero tiene que ser capaz de ayudar al paciente a interpretar estímulos del medio, organizar actividades simples para el paciente y guiar dentro de modelos estables para relacionarse consigo mismo y con otras. Por ejemplo, el modo particular de Sandi de mostrar su desesperación y depresión por la pérdida de la relación de objeto era una mezcla de llanto primitivo y agresión; durante seis meses, entre gestos infantiles y llorando sin lágrimas, ella gritaba que "quería ir a casa" y que el terapeuta era "el diablo que me llevó". La paciente solía cerrar los ojos, adoptar una posición fetal sobre su cama y rechazar alimentarse, hablar o vestirse.

El primer día en que Peg, su compañera, apareció en su medio, Sandi la recibió con su acostumbrada conducta agresiva. Peg no vaciló. Le explicó que no se moriría como lo venía anunciando Sandi, ni dejaría que ella muriese, y que no la dejaría.

En el curso del tercer día Sandi comenzó a mostrar interés en el nuevo agregado a su ambiente. Le preguntó nuevamente su nombre, de dónde venía y su edad. La paciente quería particularmente saber cuánta experiencia tenía y cuando Peg le dijo "dos años", Sandi ansiosamente repuso "¿cómo me va ayudar usted... ¡yo tengo 5 años! Ese fue un modo de decir que estaba psicótica desde hacía 5 años. Fue la primera expresión de la paciente acerca de su necesidad de ayuda. Al quinto día Sandi dejó la cama, arregló la habitación, se arregló también ella, comió bien y comenzó a preguntar cuándo estaría completamente curada de su "locura". La medicación fue reducida a un mínimo, a un cuarto de la dosis previa y fue posible mantener con ella un diálogo entendible.

Función y propósito del compañero (auxiliar)

Una función importante del auxiliar es medir la cantidad y calidad de la interacción verbal. Puede haber largos períodos de silencio durante los cuales una presencia física cercana es necesaria. En otros momentos, las frases deben ser simples, coherentes, cortas, reaseguradoras y deben tratar un tema específico por vez. Esto se puede lograr sólo cuando la auxiliar se halla libre de ansiedad.

En la mayoría de los casos, en el medio humano que rodea al esquizofrénico, especialmente la familia, los mensajes son complejos, cargados de ambigüedades e incongruencias, y confusos (Lidz, 1963). El paciente puede ser incapaz de manejar situaciones tan complejas o alternatively responder con una estructura del pensamiento similar, bloqueando el contacto con esas conductas amenazantes o mostrando una ansiedad progresiva y perplejidad. La auxiliar no debe temer a la desorganización psicótica del paciente y debe saber que el pánico que experimenta el paciente (y percibido por su yo residual), fácilmente contamina el medio. Las personas

que están en contacto con el paciente temen lo que teme éste; por ejemplo, la pérdida de control, las interpretaciones erróneas que confunden, el pánico experimentado por la pérdida de contacto con la realidad objetiva. Si el paciente percibe que no entiende cuáles son sus experiencias y las otras personas en el medio tampoco, como consecuencia puede sentirse catapultado hacia más pánico. Por ello éste debe saber que la auxiliar tiene control y puede ejercerlo sobre el medio a pesar de la confusión, las alucinaciones, las distorsiones de la realidad y las experiencias de autismo.

El paciente es frecuentemente controlado por ambivalencias primitivas, por ejemplo el miedo por la pérdida de la persona a la que se ha ligado y este temor es expresado por una mezcla de sentimientos depresivos y accesos de violencia primitiva. El miedo, más precisamente, es el de no ver a la persona otra vez, que, en efecto, fallezca.

Por eso, la ausencia por sólo un día es suficiente para producir las fantasías de muertes asociadas con temor a la violencia. Si el auxiliar no está alertado sobre el significado de estas ambivalencias, su respuesta va a ser defensiva y confusa. Es esencial que la auxiliar esté preparada para manejar esta actitud y entender que dichas experiencias ambivalentes pueden ser perfectamente desplazamientos repetitivos de experiencias de la infancia, como resultado de intensas relaciones de transferencia.

En muchas ocasiones Sandi reaccionaba con violencia hacia Peg, cuando volvía después de un día de ausencia.

Interpretar correctamente consiste en mostrar paciencia y comprensión respecto de cuánto Sandi ha extrañado a Peg el día anterior.

Subsiguientemente, Sandi pudo asociar y, llorando, descubrir sentimientos reprimidos respecto de la muerte de la madre de su novio. Las fantasías de la paciente están también dominadas por pensamientos mágicos. La combinación insidiosa de narcisismo y autismo lleva a la omnipotencia, a lo que la paciente teme más.

En la realidad subjetiva de la paciente puede ocurrir que hable o piense respecto de la separación o muerte de su compañera. En esas ocasiones, cuando Sandi se ponía violenta con Peg o con el terapeuta, uno de sus sentimientos fue que su expresión de rabia

podía convertirse en realidad. Como resultado, Sandi permanecía silenciosa y no expresaba sus sentimientos terroríficos. Después de ganar cierta confianza fue capaz de comunicarle esto a Peg.

La auxiliar debe operar en el mismo nivel asegurando a la paciente que no morirá y que sus pensamientos son solamente expresión de su propia rabia. Debe convencer a la paciente de que será protegida y de que ningún daño ocurrirá a pesar de sus sentimientos de hostilidad. La "magia" de la paciente debe ser neutralizada por el poder de la "magia" de la auxiliar y del terapeuta.

Es muy útil si la auxiliar consigue hacer un programa diario de actividades con la paciente, lo escribe y lo sigue. La ansiedad por no tener un programa exacto puede forzar a la paciente al programa de estar pasivamente sentada y regresando a expéncias autísticas (Arietti 1974).

El compañero debe apoyar y alentar al paciente en su sentido de sí mismo.

Mientras esto se hace, es necesario proveer el marco referencial de la realidad que el paciente prueba y del cual carece. El auxiliar debe ser honesto, ya que el paciente percibe las actitudes deshonestas como una amenaza de traición y posible abandono.

El compañero debe tener conocimiento del sentido de tiempo del paciente. Lo que Sandi pudo haber expresado como hechos corrientes puede haber sido expresión de fragmentos de hechos que ocurrieron en el pasado o eventos que desea o teme ocurran en el futuro.

La fragmentación en el funcionamiento del Yo puede ser tan severa que la secuencia de hechos y la regulación del tiempo se hallen perdidos. Es responsabilidad del compañero llenar estos vacíos de tiempo e interpretar correctamente la secuencia de cada evento. Durante el proceso de tratamiento, varios sentimientos despertaron en el compañero y uno que observé frecuentemente es el ansia de ayudar al paciente.

Fantasías de rescate aparecen especialmente por el progreso mostrado en los primeros días de trabajo. A medida que el paciente muestra signos de mejoría, el auxiliar se interesa en exceso por ayudar y ofrecerle asistencia y apoyo.

Esto lo hace con la expectativa de que el paciente evidencie

mayor progreso por la gratificación narcisista de ser necesitado por el paciente.

Estas expectativas deben ser controladas y supervisadas por el terapeuta para evitar ambivalencia en el auxiliar. Si el paciente muestra hostilidad o desagrado o sentimientos depresivos o cualquier conducta psicótica, es posible que el auxiliar pueda sentirse agraviado por dichos sentimientos o conducta.

La extrema dependencia del paciente puede también seducir al auxiliar y llevarlo a una sobreprotección perjudicial para el tratamiento. Como resultado, algunas defensas surgen en el auxiliar con el propósito de definir sus límites y no permitirse a sí mismo estar completamente atado a la dependencia del paciente.

Con el objeto de contrarrestar dichos sentimientos negativos, el terapeuta debe estar disponible para la discusión de los sentimientos del auxiliar y también mantener un control sobre sus expectativas y sentido de realidad. Un enredo con el paciente es una de las complicaciones más frecuentes del tratamiento de esquizofrénicos.

Otra ventaja de la presencia del auxiliar es que el terapeuta puede explicarle algunos de los síntomas y conflictos del paciente en presencia del paciente. Por ejemplo, cuando Sandi se vuelve enojada y abatida, una explicación del terapeuta hacia Peg de que la paciente se sentía muy triste porque las personas por las que se preocupa la dejan por las tardes y eso la hace sentir sola y asustada, es un modo muy efectivo de hacer llegar esta interpretación a la paciente. Generalmente mi experiencia de que esta maniobra de explicación, no al paciente directamente, sino hacia el auxiliar, atrae la atención del paciente más efectivamente, mientras, al mismo tiempo, permite al auxiliar entender al paciente cuando no está el terapeuta.

El compañero ofrece el entendimiento básico, que posiblemente lleva a un medio familiar y humano tolerante, aunque no se espere que haga terapia en el sentido tradicional.

¿Qué es ecología en esquizofrenia?

La experiencia de Sandi hizo surgir numerosas dudas. Algunas de ellas relacionadas con el tópico corriente de la ecología y su rol en la causa, perpetuación de los síntomas y tratamiento de la esquizofrenia.

Este trabajo puede solamente revisar un breve segmento en el amplio campo de la ecología de los desórdenes mentales. No revisará los factores ecológicos recientemente presentados por Levy y Rowitz (1973), como distribución espacial e incidencia de la hospitalización, analizados en términos de algunas variables específicas.

Mi preocupación son los factores ambientales, especialmente el medio humano que rodea al paciente esquizofrénico y la continua interacción entre el paciente y las personas que están diariamente en contacto con él. Por observaciones clínicas he podido formular algunas preguntas importantes. ¿Qué es la ecología del paciente? ¿Incluye solamente las variables mencionadas en la mayoría de los estudios ecológicos o incluye también el medio humano por ejemplo, el contacto diario que el paciente establece con otra gente? ¿Incluye el medio delirante creado en la realidad subjetiva del paciente?

¿Hasta qué punto la familia es parte de este sistema ecológico? ¿Qué funciones cumple como parte de la ecología del desorden mental del paciente? ¿Qué hay respecto de las interrelaciones entre el paciente y su familia en sus manifestaciones patológicas? ¿Es esto parte de la ecología del desorden mental? ¿En qué medida la familia del paciente es parte de este sistema ecológico? ¿Qué funciones ejerce como parte de la ecología de la perturbación mental del paciente? ¿Qué hay respecto del sistema de interrelaciones entre el paciente, su familia y las manifestaciones patológicas? ¿Es esto parte de la ecología del desorden mental?

Además, y más importante: ¿cuáles son las implicaciones para el tratamiento? ¿Puede hacerse algo para mejorar el medio humano del paciente? ¿Qué técnicas serían las adecuadas?

¿Qué cambios en los métodos terapéuticos? ¿Cuáles serían

las ventajas? Es fácil imaginar que el medio le ofrece al esquizofrénico una variedad de estímulos que él o ella difícilmente puedan manejar (Scarles 1960).

Algunos estímulos pueden ser manejados por el paciente como percepciones y reaccionan a ellos como lo haría cualquier persona "normal". Por otra parte, algunos de los estímulos son distorsionados de acuerdo con la realidad subjetiva del paciente y algunos son totalmente bloqueadas como inexistentes. Además, el grado de atención puede variar de un momento a otro y de acuerdo con las circunstancias inmediatas; además el proceso perceptivo se vuelve errático e impredecible. Sin embargo, esto no es verdad en todos los esquizofrénicos. Muchas esquizofrenias paranoides no tienen el mismo tipo o grado de dificultad cognoscitiva como los hallados en esquizofrenias agudas o en procesos crónicos.

En general, se puede asumir que están más o menos disminuidos cognoscitivamente, dependiendo de la tarea específica y del medio en el que se encuentren.

Los pacientes pueden tener una mejor *performance* y responder más coherentemente si el medio es menos *stressante*.

Las variables significativas parecen ser la extrema sensibilidad y la reactividad específica evidenciadas por muchos esquizofrénicos.

Una correlación directa de esta variable es la calidad y tipo de la organización yoica. Consecuentemente, uno no puede considerar las respuestas del paciente y su conducta aisladamente del medio. Paciente y medio son una unidad en interacción. Por lo tanto, las insuficiencias que se notan en el paciente no son una manifestación exclusiva de las características patológicas del paciente —ellas están relacionadas con un paciente específico— sino combinaciones ecológicas que varían con el tiempo y las circunstancias.

El sistema ecológico del esquizofrénico es experimentado por el paciente en diferente forma de como es observado por otros.

Desde el punto de vista subjetivo, el paciente se puede ver a sí mismo como cazado en una serie de "trampas" en la red ecológica. Estas "trampas" son el resultado de:

a) Una deficiencia cognoscitiva que hace difícil percibir correctamente ya sea a los individuos en la familia o a sus relaciones como las redes creadas por sus relaciones y significados.

b) Las distorsiones creadas por la calidad de los afectos y el pobre manejo de sus pulsiones instintivas.

c) La experiencia subjetiva de la realidad, los delirios o distorsiones autísticas teñidas por alteraciones del pensamiento, ilusiones y miedos primitivos.

d) Distorsiones de mensajes y lenguaje.

El esquizofrénico puede, no sólo comunicarse pobremente, sino que puede también interpretar erróneamente mensajes e intenciones. Además, se puede sentir forzado a responder a comunicaciones patológicas provenientes de otros miembros de la familia (Arietti 1974).

Como resultado de esos diversos niveles de distorsiones, el sistema ecológico del paciente es diferente y puede variar de acuerdo con el nivel de regresión, cuanto más regresivo está el paciente, más estrecho y alterado es su sistema ecológico subjetivo. A medida que el paciente mejora y aumenta su objetividad, su ecología subjetiva se enriquece y simplifica y puede entonces responder con menos distorsiones de su mundo (Scarles 1962).

Desde un punto de vista terapéutico es importante hacer una distinción entre el sistema ecológico objetivo del esquizofrénico y su experiencia subjetiva de realidad (sistema ecológico autístico). Me parece que la experiencia subjetiva de realidad es verdaderamente una red ecológica del paciente desde un punto de vista psicodinámico y psicoterapéutico.

Variables familiares en la ecología de la esquizofrenia

Estuve confundido por un tiempo por el hecho de que algunos pacientes parecen mejorar rápidamente después de su crisis psicótica, mientras otros tienen muchas dificultades en recuperarse. Independientemente de cuáles pueden ser los factores etiológicos últimos en la esquizofrenia, uno de los elementos

importantes a ser considerados es el medio familiar y su psicodinámica (Lidz 1973).

Estos factores familiares parecen jugar un rol en:

1. La duración y cronicidad del proceso psicótico.
2. El tipo de proceso psicótico presentado por el paciente.

Esto pone en consideración el hecho de que el tipo de esquizofrenia depende de:

- a) Los mecanismos de defensa usados por el paciente.
- b) La cantidad y calidad de los mecanismos regresivos.
- c) La cantidad de desintegración yoica y su capacidad de reintegración.

El medio familiar constituye el sistema ecológico inmediato del paciente. Como ha sido mencionado antes, el paciente y su sistema constituyen una unidad sistémica de interacción con mutuas influencias y continua realimentación, que lleva a la conducta resultante de cada parte. Una serie de variables en la familia parecen afectar, positivamente o negativamente, el resultado del proceso psicótico y la calidad e intensidad del derrumbamiento del funcionamiento del ego en el paciente.

Los siguientes pueden ser considerados como factores *positivos* en la familia, que previenen más recaídas o que facilitan la recuperación, una vez que hay evidencia de psicosis. Ellos también ayudan al paciente una vez que la recuperación se ha producido.

1. CAPACIDAD PARA TOLERAR LA PSICOSIS

Vivir con un paciente esquizofrénico es muy difícil. Ello acciona mecanismos regresivos en aquellas personas que constituyen el sistema ecológico humano. Si la familia ya está demostrando características patológicas (Lidz, Wynne y Singer, Laing, Rubinstein) la coexistencia con el paciente aumenta el funcionamiento patológico de la familia y viceversa. Una familia capaz de tolerar la conducta psicótica del paciente es un elemento favorable en el pronóstico.

2. APOYO MUTUO

Enfrentados con el esfuerzo debido a la conducta psicótica del paciente, y si los familiares son capaces de apoyarse mutuamente en su proceso de interacción, el paciente encuentra un medio consistente para su estabilidad y recuperación. Un proceso cismático en el sistema familiar actúa negativamente en la recuperación del paciente.

3. CAPACIDAD PARA ALCANZAR DECISIONES

Muchas familias de pacientes esquizofrénicos muestran una seria pérdida de esta habilidad que es significativa en los términos del pobre funcionamiento yoico del paciente. El esquizofrénico requiere ser conducido para organizar su vida. Es necesario para el paciente encontrar en la familia un apoyo ecológico que lo libere del proceso doloroso de tomar decisiones hasta que él sea capaz de hacerlo individualmente para cuando el funcionamiento del yo se halle reconstituido.

4. HABILIDAD PARA ENTENDER EL PROCESO PRIMARIO

Los mensajes del paciente son expresados fundamentalmente a través de procesos de conducta primaria. Esto puede ser completamente ininteligible y confuso para la familia, la que puede excluir al paciente debido a una acumulación de sentimientos negativos. He usado la técnica de hacer entendible dicho simbolismo a la familia (Rubinstein 1972, 1974). Cuando la familia es capaz de entender ese lenguaje primitivo, algunos de los síntomas del paciente desaparecen junto con una disminución de la ansiedad y confusión en el sistema familiar.

5. HABILIDAD PARA RESOLVER CONFLICTOS

Las familias de esquizofrénicos se caracterizan frecuentemente por tener una historia de crisis no resuelta debido a conflictos interpersonales y con la realidad, para los cuales parecen no encontrar nunca solución.

Frecuentemente esos conflictos encuentran vías fáciles a tra-

vés de acuerdos mutuos y pseudo mutuales entre miembros de la familia o por un proceso expiatorio de alguien de la familia, especialmente los hijos de los esquizofrénicos. Un grupo familiar capaz de resolver sus conflictos vitales se previene de proyectar en el paciente sus dificultades para vivir y así proveer al esquizofrénico un medio menos dañino.

6. CAPACIDAD PARA DEFINIR UNA POSICION DEL SELF

El enredo individual en familias con límites del ego mal definidos es una de las características destacadas del sistema familiar en la esquizofrenia. Un objeto principal consiste en intentar ayudar a dichos individuos a desarrollar una posición del *self* y a diferenciarse cada uno para crear individuos que funcionan individualmente. Las familias con un mal pronóstico son aquellas que son difícilmente diferenciables en sus miembros individuales, por el contrario, aquellas familias que permiten desarrollar un *self* individual son las que proveen de un medio familiar mejor para los miembros esquizofrénicos. Hay otros factores que pueden ser considerados *negativos* porque su presencia interfiere con el proceso de recuperación de la esquizofrenia o por crear relaciones patológicas. He observado las siguientes:

1. SOBREPOTECCION Y MUTUA SOBREDEPENDENCIA

La exageración de estas características llevan a lo que se conoce como relación simbiótica y ego indiferenciado (Bowen 1961). Ello crea una intensa ambivalencia en todos los miembros participantes, resultante en confusión y sentimiento de culpa y borramiento de los límites del ego. La recuperación del paciente puede ser seriamente frustrada por su necesidad de perpetuar relaciones simbióticas con un miembro de la familia, mientras esto está siendo fomentado por el compañero en la simbiosis. Evidentemente, no puede tener lugar más crecimiento emocional mientras existan las relaciones regresivas (Christensen 1974).

2. FUNCIONES PROVISTAS POR EL MIEMBRO PSICOTICO A LA DINAMICA DE OTROS INDIVIDUOS Y DEL GRUPO FAMILIAR

Observaciones múltiples (Lidz, Fleck y Cornelison 1965) han apoyado la idea de que los pacientes psicóticos proveen de una función definida a otros miembros, lo que justifica su necesidad de cuidarlos.

Las relaciones así creadas permiten a los protectores no sentir un vacío en sus propias existencias y proveerse ellos mismos de una crianza gratificante o con experiencia masoquista. En ausencia de esto, el protector puede tener que afrontar conflictos personales insoportables o una ansiedad productora de vacío. Además, la conducta regresiva del paciente le da a él y a todos los relacionados con el esquizofrénico una oportunidad de descargar sus conflictos personales no resueltos, con la esperanza de resolver dichos conflictos. Por ejemplo, un complejo de Edipo no resuelto en el paciente esquizofrénico, permite a los protectores curarse ellos mismos a través de acompañarlo en el conflicto resolución o a través de proyectar que el conflicto no existe en el protector pero sí en el paciente.

La esquizofrenia puede tener también la importante función de crear una cobertura para todos aquellos conflictos que existen entre los miembros de la familia.

La conducta del paciente puede ser tan demandante y agotadora que no se le preste atención a cismas o sesgos maritales (Lidz y Lidz) o a una deficiencia de la personalidad o a relaciones interpersonales que son negativas en otros miembros de la familia. Este es el caso del así llamado "buen hermano". La conducta usual en este caso es fomentar la conducta sintomática en el paciente y resistir confrontaciones personales o interpersonales. El resultado es que cualquier intento hacia la maduración del paciente crea cierta ansiedad en otros miembros de la familia en cuanto que otros "problemas" pueden surgir.

Sobrevigilancia e intolerancia de la mínima expresión de ansiedad en el paciente se convierten en esfuerzos por volverlo nuevamente loco a pesar de todos los esfuerzos profesionales concernientes a la salud y al bienestar del paciente.

3. NATURALEZA Y CUALIDAD DE LAS DEFENSAS OPERACIONALES EN LA RED FAMILIAR

En el proceso de enfermedad o recuperación el esquizofrénico encuentra una serie de mecanismos de defensa utilizados por otros en la red familiar, los cuales pueden dificultar seriamente un pronóstico terapéutico bueno. Estos pueden incluir:

a) Negación y distorsión de síntomas o motivaciones

El paciente puede ser obviamente psicótico, pero la familia no ve la patología, lo designan más bien como "un poco extraño". El paciente puede desear auténticamente disminuir la dependencia extrema o las ligaduras simbióticas, pero la familia denuncia dichos esfuerzos hacia una autonomía, como locos. Cualquier expresión o sentimientos en el paciente que puedan amenazar la homeostasis familiar pueden ser descalificados y tratados como no existentes. Tristeza, furia o amor son escondidos y negados como si dichos acontecimientos emocionales no estuvieran sucediendo. Durante una sesión, un adolescente esquizofrénico confesó confundido en un llanto doloroso, que él había intentado tener relaciones sexuales con su hermana antes del comienzo de la enfermedad. Su afecto y su culpa fueron ignorados por ambos padres hablando de tópicos irrelevantes de su propia infancia.

Otra adolescente confesó que el daño cerebral que tenía era debido a un intento de suicidio, a través de la inhalación de monóxido de carbono. La familia negó el intento de suicidio, sosteniendo que hallarla inconsciente, en el garage de la casa y con el motor del coche encendido y la manguera fijada al silenciador del motor, fue un accidente, muy misterioso sin embargo.

b) Racionalizaciones

La paciente cree que alguien la está mirando o intenta dañarla. La familia se une en la creencia paranoide y cree que todos los vecinos están en contra de ellos y que debe haber alguna forma de conspiración contra la familia.

El paciente crea el delirio de que es el hijo de Dios. La familia perpetúa el mito, pero creyendo que el paciente puede haber tenido algún tipo de revelación y está destinado para algún rol especial con el cual él puede salvar a la familia.

c) Mecanismos de proyección

Creencias paranoides compartidas son comunes en muchas familias como en el ejemplo de la conspiración en contra del grupo familiar.

En familias de esquizofrénicos se halló frecuentemente un proceso mutuo de proyecciones. Los miembros de la familia proyectan recíprocamente sus conflictos, sentimientos o pensamientos personales.

Una madre le dice a su hija esquizofrénica "tú me odias", cuando en realidad ella está sintiendo su propia ira hacia su hija.

Los mecanismos de proyección se pueden volver tan intensos que llegan a borrar los límites del ego, convirtiendo al grupo familiar en una "masa de ego indiferenciado".

d) Evitación

Miembros de la familia pueden pretextar no ingerencia en la vida del paciente y evitar así enfrentamientos dolorosos con síntomas y con responsabilidades. Esto lleva a alejamientos defensivos del *self* del paciente.

Hermanos sanos comúnmente se conducen como si ellos no quisieran formar parte de la psicodinámica familiar y se excluyen defensivamente para proteger la propia fragilidad de su salud. El mejoramiento del paciente crea un reordenamiento en la psicodinámica interpersonal y puede producir una crisis en los hermanos sanos, o en uno de los padres, demostrando que la persona está defendiéndose.

e) Identificación con el agresor, propia culpa y manifestaciones depresivas

El paciente es percibido como un agresor, que frustra los deseos paternos de gratificación. Durante las etapas de desarrollo prepsicótico, el hijo enfermo puede haber sido una amenaza para el deseo de los padres de realizar sus vidas a través de la del hijo.

Una manifestación común es el uso de la creencia de que el padre hizo algo dañino que terminó en la psicosis del hijo. La culpa resultante y los síntomas depresivos en el padre pueden convertirse en maniobras para forzar al paciente a no estar enfermo, ya que es el padre quien está sufriendo ahora. Un deseo de repara-

ción alivia la culpa paterna, mientras mantiene controlados los síntomas del paciente. En cambio, esto puede interferir con el sentido del *self* en el paciente, quien se siente responsable por la infelicidad paterna.

4. MODOS CARACTERISTICOS DE COMUNICACION

La comunicación patológica en la red familiar puede interferir con un proceso de recuperación de la esquizofrenia. Puede reforzar la necesidad del paciente de comunicarse de manera patológica. También le crea al paciente la imposibilidad de traducir mensajes que pueden fatigar al más sano de los participantes. Dobles vínculos, incongruencias, descalificaciones transaccionales, errores de abstracciones contextuales, pueden crear modelos caóticos e incoherentes que llevan a la incomunicación en la red familiar (Bateson 1972, Watzlawick 1964).

La familia puede no haber aprendido nunca a codificar la metacomunicación apropiadamente y puede no tener una organización lógica en sus modelos de pensamiento, confundiendo así niveles de abstracción que hagan por ejemplo, que el recuerdo del paciente de ser amenazado por un ladrón, tenía como respuesta que es necesario tener un sistema de alarma mejor para la casa. La pérdida de amigos debido al progreso de la enfermedad tiene como respuesta la sugerencia de que el paciente necesita ir a una escuela para mejorar su estilo y modos sociales. Una carta que demuestra severo desorden del pensamiento tiene como respuesta la sugerencia de que el paciente debe volver a la escuela y mejorar su caligrafía. Es obvio que en dicho medio el paciente va a tener que realizar una difícil tarea. Es casi imposible desarrollar un proceso de pensamiento lógico, adecuado y organizado, si el paciente debe arreglárselas con su propias deficiencias cognitivas al tiempo que trata de evitar el caos en la comunicación.

5. EXPECTATIVAS DEL ROL

Como ha sido mencionado antes, el paciente esquizofrénico pudo haber estado en una posición insostenible en cuanto a expectativas del rol cumplido por cualquiera de los padres o por ambos. Algunos de esos roles están ligados con el sexo o relacionados con el

orden de nacimiento, según con cuál de los padres crea la expectativa para el cumplimiento de sus propias necesidades (Fleck *et al.* 1965). Mientras las expectativas existan, el paciente tendría dificultad en cambiar a partir de una relación distorsionada.

Otras expectativas están relacionadas con el total de las percepciones culturales de lo que debe ser una persona con éxito. Muchos niños son criados para ser "princesas o príncipes", siguiendo un bien definido modelo de conducta y expectativas de sí mismos una vez que crezcan y sean adolescentes o jóvenes adultos. La falla o el éxito atribuidos al objetivo logrado en estos roles en nuestra sociedad y en la familia dependen mucho del grado de desviación de las normas impuestas por la sociedad y la familia.

Muchos chicos son criados creyendo que ellos pueden lograr gratificación y aprobación solamente a través del éxito; otros son imbuidos con el concepto de que aunque intenten firmemente lograr dichas expectativas, están sin embargo condenados al fracaso. La psicosis es percibida como un fracaso por la familia y el intento de revertir la situación a partir de la psicosis es comparada con las expectativas de triunfar. Hacer depender tan altos valores del éxito o del fracaso, interfiere definitivamente con el proceso de recuperación, ya que el individuo está abrumado por él mismo o por la familia con ideales muy distorsionados del yo. Además, esto puede luego complicarse por el hecho de que un importante elemento etiológico en la psicodinámica de la recaída psicótica puede haber sido la lucha con el ideal del yo impuesto por la familia y la sociedad. Los pequeños pero progresivos adelantos mostrados por el psicótico en el proceso de recuperación pueden ser calificados como insuficientes por la familia como si no hubiese nada suficiente para satisfacer las intensas demandas de expectativas y necesidades de gratificación del superyó de los padres.

Factores ecológicos: un desafío para el terapeuta

La psicoterapia de la esquizofrenia es verdaderamente un desafío para el terapeuta. Tiene que trabajar en una variedad de funciones simultáneamente. Esto es particularmente cierto si el

paciente está internado e interactúa con un medio, que es el hospital, la sala y el personal, mientras está en frecuente contacto con su familia. Desde un punto de vista ecológico el terapeuta se vuelve:

- a) un agente del sistema hospitalario,
- b) un agente para el paciente,
- c) un mediador entre ambos —regulador de la mutua realimentación entre varias partes del sistema creado por el paciente, la familia y el hospital.

En un trabajo previo (Rubinstein, 1974) he postulado que el terapeuta debe interpretar y educar a la familia en cuanto al sentido de la conducta del paciente. Esto es también cierto en cuanto al personal de la sala. Si el simbolismo y las maniobras defensivas del paciente no son comprendidas, él mismo puede asustarse.

Cuando Sandi se volvió agresiva, dicha conducta tuvo que ser traducida como un signo de ambivalencia, despertado por el temor a la pérdida de personas significativas en su mundo inmediato. De otro modo su hostilidad se hubiera encontrado con más frustración y hostilidad de parte de las enfermeras, ya que sus maniobras defensivas no habían sido comprendidas. La ideación paranoide de otra paciente, de que estaba siendo vigilada por el F.B.I., fue explicada a la familia como un mensaje distorsionado, como una pérdida de la estima de sí misma y un continuo fracaso en lograr su rol y propias expectativas de ser una exitosa "princesa judía", que falló en encontrar una adecuada pareja para mantener su posición mítica en la familia.

Cuando el paciente muestra un brusco aumento de su conducta psicótica en el curso de las relaciones con el personal de guardia, otros pacientes o miembros de la familia, el síntoma es tomado como un mensaje que expresa tensión en las relaciones entre los varios sistemas que constituyen la ecología del paciente. Una interpretación correcta puede llevar a una corrección en las relaciones y así a una desaparición o disminución de los síntomas. El rol esencial del terapeuta como un mediador en las influencias ecológicas es hacer racional y comprensible aquello que parece irracional e incomprensible. El terapeuta debe también ser suficientemente sensible a la conducta de todas las partes interrelacionadas

en la unidad paciente-ecología de modo que se puedan realizar maniobras apropiadas para evitar "trampas" disfuncionales entre los diferentes niveles. El propósito del terapeuta es servir como catalizador para obtener el máximo de eficacia y crecimiento en ambos, el paciente y el sistema ecológico. La psicoterapia es esencialmente un proceso que apoya la maduración y encuentra otras alternativas para suplantar aquéllas que se han vuelto ineficaces para resolver viejos problemas. Un terapeuta experimentado es capaz de controlar los aspectos disfuncionales de todo el complejo creado por el paciente, la familia y el medio social. Para corregir esto es necesario establecer un programa terapéutico que incluye varias etapas. Cada etapa en el programa debe tener un propósito y debe llevar a la etapa siguiente. Un paciente puede comenzar el tratamiento estando internado y entonces ser medicado con fenotiazinas, mientras comienza una breve terapia de apoyo. Al mismo tiempo, son evaluados la dinámica familiar y social, como así también la psicodinámica personal del paciente. La primera etapa de evaluación puede llevar a un programa combinado de psicoterapia individual, psicoterapia familiar y terapia del medio. Esta primera etapa está centrada principalmente en el paciente.

Enfatizo la importancia de controlar el medio humano del paciente por medio de la utilización de un auxiliar. Esta medida es muy útil con esquizofrénicos muy regresivos y psicóticos severos. Cuando el tratamiento progresa, se inicia un cambio en el enfoque del sistema ecológico, con el paciente fuera del centro. Algún otro puede ocupar esta posición a medida que la dinámica familiar se reorganiza y otro miembro de la familia se vuelve sintomático, o el grupo social que rodea al paciente se vuelve disfuncional. El programa de tratamiento se adecua a las mayores necesidades creadas por las manifestaciones disfuncionales de cualquiera de las varias partes de la trama humana que sirve de substrato a la esquizofrenia.

En la cura de la esquizofrenia es un objetivo importante reestructurar el sistema ecológico que rodea al paciente, de manera que ambos sirvan como mejores alternativas que la masa previa del ego familiar indiferenciado y el medio disfuncional. El terapeuta es el médico de todo el grupo familiar, siendo a veces quien evalúa, hace un diagnóstico, coordina el tratamiento indicado por

servicios auxiliares; supervisa la rehabilitación, interviene en las situaciones de crisis.

En esas múltiples funciones, el terapeuta provee los servicios necesarios para el desarrollo de todo el grupo ecológico, paciente incluido, para el logro de su máximo potencial.

SUMMARY

Psychotherapy of schizophrenia is indeed an important challenge for the therapist. He has to operate on a variety of levels and perform a series of functions simultaneously. This is especially true if the patient is hospitalized and is interacting with one milieu, the hospital ward and personnel while in frequent contact with her family. From an ecological point of view the therapist becomes:

(a) an agent of the hospital system

(b) an agent for the patient

(c) a mediator between both — regulator of the mutual feedback among various parts of the system created by the patient, the family and the hospital.

In a previous paper (Rubinstein 1974) I postulated that the therapist has to interpret and educate the family as to the meanings of patient's behaviour. This is also true of the ward personnel. If the symbolism and defensive maneuvers of the patient are not understood he or she may become frightened.

When Sandi became aggressive this behaviour had to be translated as a sign of ambivalence aroused by the fear of loss of significant people in her immediate world. Otherwise, her hostility was met by further frustration and hostility by nurses, aids and family members. Her confusion would therefore increase since her defensive maneuvers were not understood.

Another patient's paranoid ideation that she was being watched by the F.B.I. was translated and interpreted to the family as a distorted message of her loss of self-esteem and continuous failures in achieving her role and self-expectations to be a successful "Jewish princess" who failed to find a suitable mate to maintain her mythical position in the family.

When the patient shows a sudden increase of psychotic behaviour in the course of the relationships with the ward personnel, other patients, or family members, the symptom is taken as a message which expresses strains in the relationships among the various subsystems that constitute the patient's ecology. A correct interpretation may lead to a correction in the relationships and thus to a disappearance or diminution of the symptoms. The essential role of the therapist as a mediator in the ecological influences is to make rational and comprehensible what seems irrational and incomprehensible. The therapist also has to be sufficiently sensitive to the behaviour of all the inter-related parts

in the unit patient-ecology so that appropriate moves can be made to avoid dysfunctional "traps" in the interfaces among the many different levels. The purpose of the therapist is to serve as a catalyst to obtain maximum efficiency and growth in both the patient and the ecological system. Psychotherapy is, essentially, a process of fostering maturation and finding other alternative solutions for those that have become ineffective in resolving old problems.

An experienced therapist is capable of monitoring the dysfunctional aspects of the whole complex created by the patient, family and social environment. To correct these it is necessary to establish a therapeutic program which includes various graded steps. Each step in the program must have a purpose and it must lead to the next step. A patient may be started in treatment by hospitalization and then be medicated with phenothiazines while some brief supportive therapy is initiated. At the same time the family dynamics and the social dynamics, as well as the personal psychodynamics of the patient are being evaluated.

The first stage of assessment may lead to a combined program of individual psychotherapy, family psychotherapy, and milieu therapy. This stage is primarily patient-centered.

I emphasized the importance of controlling the human environment of the patient by the utilization of a companion. This measure is most helpful with very regressed schizophrenics and severe psychotics. As treatment progresses, the shift is toward focusing on the ecological system with the patient off-center. Someone else may occupy that position as the family dynamics get revamped, as someone else becomes symptomatic, or as the social group surrounding the patient becomes dysfunctional. The treatment program tailors itself to the rising needs created by the dysfunctional manifestations of either one of the various parts of the human web serving as substratum to schizophrenic illness.

If it is an important goal in the cure of schizophrenia to restructure the individual's personality, it is not less important to restructure the ecological system surrounding the patient so that both serve as better alternatives than the previous undifferentiated family ego mass and dysfunctional milieu.

The therapist is the physician to the whole family group being at times an evaluator, a diagnostician, a coordinator of treatment provided by ancillary services, a supervisor of rehabilitation, an intervenor in crisis situations. In these multiple functions the therapist provides those services necessary for the development of the whole ecological group, with the patient included, for the attainment of its maximum potential.

Enseñanza y aprendizaje de la terapia de familia

"Familiendynamik", Revista interdisciplinaria
para la práctica y la investigación.
Separata del N° 1, 1976, Editorial Ernts Klett, Stuttgart.
Traducción de Nélida M. de Machain.

JOSEF DUSS-VON WERDT - HELM STIERLIN
ROSMARIE WELTER-ENDERLIN

Dr. phil. Joseph Duss. von Werdt, Institut für Ehe und Familie,
Wiesenstrasse 9/Postfach 258, CH-8032 ZÜRICH;
Prof. Dr. med. et phil. Helm Stierlin, Abteilung für psychoanalytische
Grundlagenforschung und Familientherapie der Universität Heidelberg,
Mönchhofstr. 15 A, D-69 Heidelberg 1; Rosmarie Welter-Enderlin,
M.S.W., Ehe-und Familientherapeutin, Freiestr. 24, CH-8610 Uster)

Consideraciones básicas

La terapia de familia es una forma de terapia social: la unidad de tratamiento (*Behandlungseinheit*) es la familia actual, físicamente existente (por consiguiente no la familia recordada o la simplemente internalizada). La terapia de familia se entiende aquí como alternativa al tratamiento de uno o varios individuos aislados. La familia a tratar puede ser completa o incompleta, puede estar constituida por más de dos generaciones que conviven o que sólo se reúnen por motivos terapéuticos (terapia plurigeneracional). Aun cuando el terapeuta trate a un solo individuo, siempre lo verá en función de su familia, como hijo, como cónyuge, etcétera, es decir, siempre en un papel que supone "una relación con...". Por consiguiente, en

este caso, la terapia individual no se aplica por principio sino por razones prácticas (por ejemplo, puede efectuarse en forma paralela al tratamiento de la familia entera o se cumple de esa manera porque no es posible motivar a otros miembros de la familia para que presten su colaboración, etc.). Pero lo común es que se procure hacer intervenir en el hecho terapéutico a la mayor cantidad posible de personas que constituyen una familia. La delimitación no siempre es fácil y, con frecuencia, tales límites no coinciden con los previstos por las definiciones sociológicas y con los modelos sociales de familia.

El solo enfoque de la familia como "paciente" impone métodos específicos. Tales métodos tienen como fundamento de una determinada concepción teórica, una determinada forma de ver las cosas. ¿Un concepto? ¿Una teoría? Si la terapia familiar hubiera tenido su origen en un determinado personaje o en un determinado grupo, considerado como fundador de la escuela, podría existir una concepción unitaria. Pero ocurre que la terapia de familia apareció en lugares geográficamente muy distantes y por iniciativa de personas cuyas ideas y maneras de actuar en nada se asemejaban. Por eso, el paradigma que le sirve de base es aún nuevo y por lo tanto desacostumbrado, no consolidado, controvertido y a veces contradictorio. Y justamente por tratarse de algo nuevo e incompleto se hace difícil prescribir cómo ha de enseñarse y aprenderse la terapia familiar.

Replanteo

La acción orientada por una idea nueva exige, en primer lugar, un *replanteo*. Es preciso revisar las formas habituales de razonamiento; es necesario poner en tela de juicio la actividad terapéutica cumplida hasta hoy. La autoconcepción y la identidad del terapeuta adquieren nuevas dimensiones. Las instituciones consagradas hasta ahora al tratamiento individual requieren reformas (véase el filme *Family Life Haley*, 1975). Las estructuras jerárquicas —relaciones entre supervisores y profesionales que están especializándose o entre médico y asistentes sociales— se resquebrajan. El modelo de pensamiento médico y el sociopsicológico entran en conflicto. Es

excepcional que los seguros por enfermedad acepten los argumentos basados en el enfoque de la terapia familiar. Y en lo que se refiere específicamente al tema que estamos tratando, es importante preguntarse si los modelos y centros de capacitación actuales pueden adaptarse a los nuevos objetivos o si es preciso crear algo nuevo. Todo lo nuevo provoca no sólo la fascinación, sino también resistencias ocultas o manifiestas de la más diversa índole. Así, por ejemplo, existe el peligro de que la terapia familiar se aplique como "última posibilidad" en los casos en que ha fracasado una terapia individual de años. Citaremos un caso a manera de ilustración.

La extraña conducta evidenciada en la escuela por el menor de los 4 hijos varones de una familia hace que —a la edad de 10 años— el niño sea sometido a un tratamiento ambulatorio en una clínica psiquiátrica. Diagnóstico: síndrome psicoorgánico; terapia individual una vez por semana, entrevista semestral con los padres. Objetivo del tratamiento: lograr que el niño supere, en la relación con el terapeuta, un supuesto abandono en su primera infancia, y que elabore los problemas con las personas con quienes mantiene una relación directa, sobre todo por medio de la ludoterapia. Luego de 5 años de tratamiento individual, el séptimo terapeuta del adolescente advierte que dos de los hermanos de éste presentan síntomas curiosamente análogos. Como, por añadidura, tanto la escuela como la comunidad ejercen una presión masiva para que se interne al paciente, cuya conducta sigue siendo extraña, y los padres se resisten a adoptar semejante medida, el terapeuta ofrece, como última posibilidad, una terapia de familia en el consultorio de un colega. La familia concurre expectante. El terapeuta familiar reconoce rápidamente la problemática de un sistema familiar denso y rígido (L. Hoffmann, 1975), que coarta en forma dramática la libertad individual. Procura reducir la intensidad y rigidez del modelo de relación vigente, para crear más libertad en la relación entre los padres y dejar más campo abierto a cada uno de los hijos. Pero en su intento tropieza con dos (previsibles) obstáculos masivos: en primer lugar en el transcurso de un proceso de socialización de cinco años de duración, durante el cual el carácter de "paciente designado" del menor de los hermanos quedó confirmado por la terapia indivi-

dual, los restantes miembros de la familia habían aprendido a comprometerse, a lo sumo, como co-terapeutas, pero nunca como "co-pacientes", y muestran gran resistencia a cualquier cambio en sus posiciones. Por otra parte, el terapeuta familiar se encuentra sometido a la presión de sus colegas, que esperan una mejoría espectacular del paciente designado. De no producirse esta mejoría espectacular quedaría demostrado que la terapia de familia no sirve para nada. Trascurridos tres meses y en vista de que siguen llegando quejas de la escuela sobre el comportamiento del hijo menor, la familia decide hospitalizarlo e interrumpir la terapia familiar.

Es lógico suponer que las perspectivas de la terapia de familia son mucho mejores cuando se formula por primera vez el problema de relación y no exclusivamente como problema de personalidad. El ejemplo antes citado demuestra que la terapia familiar no debe utilizarse como última posibilidad de curación después de haber intentado sin éxito una prolongada terapia individual del paciente designado.

Por eso, es preciso reconocer las resistencias desde el comienzo y trabajar sobre ellas. De lo dicho surgen dos elementos importantes: por un lado está la labor esclarecedora, que debe abarcar a la mayor cantidad posible de personas que ejerzan profesiones asistenciales, es decir, médicos, psicoterapeutas, asistentes sociales, pedagogos, sacerdotes, etcétera. Esto pone de manifiesto la necesidad de incorporar a los planes de enseñanza de las diversas universidades e institutos especializados, nociones sobre dinámica y terapia de la familia. Sería muy conveniente iniciar el tratamiento de estos temas en las carreras de medicina, de psicología y de asistencia social, es decir, ya en la etapa de la *formación básica*.

Y no se trata tanto de incorporar estos conocimientos en forma de "materia" independiente y delimitada, sino como un enfoque que debe analizarse en diversos campos. Al margen de esto es necesario ofrecer a los médicos, psicoterapeutas y asistentes sociales ya activos, la posibilidad de una especialización en este terreno. También es preciso difundir la idea de la terapia de familia —a través de los distintos medios de comunicación— entre los sectores más amplios de la población. En segundo lugar,

la terapia familiar exige en forma específica que los responsables de la institución en las cuales actúan los candidatos a la especialización estén convencidos de la necesidad de ese proceso formativo. La experiencia ha demostrado que, si no es así, las rivalidades y los conflictos de lealtad que surgen indefectiblemente en tales instituciones, sabotean la capacitación o imposibilitan la terapia familiar.

¿De acuerdo con qué concepción debe capacitarse al terapeuta?

El hecho de que en materia de terapia familiar no se reconozcan ni se sigan conceptos, formas y técnicas de terapia de validez general, también da origen a múltiples problemas. Como ya se señalara, a diferencia del psicoanálisis, la terapia familiar no ha tenido su origen en las teorías de una personalidad genial; desde el comienzo fue la obra de un grupo de pioneros que diferían mucho entre sí en cuanto a origen, orientación teórica, estilo terapéutico y forma de capacitación. Por esa causa, hasta ahora no ha podido establecerse un método *standard* de terapia familiar, que habría permitido entender y enseñar las diversas formas de terapia como derivaciones, parámetros o etapas evolutivas de ese método *standard*. Pese al paralelismo y a las coincidencias de los enfoques teóricos y clínicos de los diversos terapeutas, hasta ahora la terapia familiar ha dado origen a los brotes más disímiles. Entre ellos figuran las múltiples formas de terapia de pareja o matrimonio, la terapia de grupo familiar, la terapia de impacto múltiple, la terapia de intervención en la crisis (*Kriseninterventions-Therapie*), la terapia de confrontación (*Streit-Therapie*), la terapia de redes relacionales, etcétera. Todas ellas son interpretadas y enseñadas actualmente —sobre todo en Estados Unidos— en una u otra forma, como variantes de la terapia de familia.

Pero muchas de las diferencias también se deben a que esta forma de terapia se aplica en los más diversos terrenos: "El campo de acción de la terapia familiar se extiende desde la psiquiatría infantil y los trastornos psíquicos de la adolescencia, hasta el tratamiento de dificultades en la relación matrimonial y abre nue-

vas perspectivas a la geriatría y a la medicina somática" (Kaufmann, 1975).

Los comentarios que siguen y el énfasis sobre determinados tópicos tienen su fundamento en lo que los autores consideran esencial, sobre la base de su experiencia y en función de sus objetivos. Se han tenido en cuenta, sobre todo, dos corrientes o modelos teóricos y terapéuticos considerados como decisivos para un perfeccionamiento de las bases de la terapia familiar: el modelo estructuralista y el modelo de la elaboración de conflictos o conciliación.

Ambos modelos tienen en común el enfocar como centro fuerzas sistémicas que el terapeuta familiar debe aprender a reconocer y a manejar. Sin embargo, la naturaleza de estas fuerzas y las intervenciones consideradas como necesarias son objeto de concepciones muy diversas. El modelo estructuralista presta especial atención a los *patterns* de interacción firmemente consolidados (homeostáticos). Según este modelo, se llega a la fusión de los miembros de la familia entre sí, a las reacciones emocionales repetitivas, a la rígida adjudicación de roles, pero también a una disolución de límites y a la indiferenciación. (consúltese la bibliografía al respecto, sobre todo Stierlin, *Von der Psychoanalyse zur Familientherapie*, 1975). Para quebrar estas estructuras o *patterns* tan firmemente consolidados se requieren intervenciones relativamente masivas por parte del terapeuta familiar (o de los terapeutas familiares). El terapeuta manipula, por ejemplo, el orden en que se sientan los miembros de la familia, el estilo en que éstos se expresan o el tiempo durante el cual hacen uso de la palabra, distribuye tareas, rompe alianzas existentes (para lo cual él mismo se alía tan pronto con un miembro de la familia, tan pronto con otro), interviene en la trama de los roles familiares y perturba el equilibrio de proximidad y distancia entre los distintos familiares. Cobran particular importancia las intervenciones tendientes a lograr la transformación de estructuras y de estilos de comunicación firmemente consolidadas. En ese proceso desempeñan un papel muy importante las prescripciones paradójicas (por ejemplo, la "prescripción del síntoma", cf. Watzlawick y otros, 1974, Selvini, 1974, 1976, etc.). Estos terapeutas consideran secundario el diagnóstico o la comprensión de los procesos conscientes o in-

conscientes. Participan de este punto de vista, entre otros Haley (1971), Watzlawick (1974), Selvini (1974). (Por su papel terapéutico podría calificárselo, como lo han hecho Beels y Ferber [1969] de *conductors*.)

El segundo modelo, el de elaboración de conflictos y conciliación, a diferencia del enfoque anterior, toma elementos del psicoanálisis. Su foco se concentra en los conflictos inconscientes y conscientes de la familia, que a veces obligan a remontarse mucho en la historia familiar y, por lo general, implican una perspectiva plurigeneracional. El terapeuta familiar distingue fuerzas sistémicas activadas y esenciales: lealtades invisibles (I. Boszormenyi-Nagy, G. M. Spark, 1973), proyecciones narcisistas de los miembros de la familia entre sí (H. E. Richter, 1963, 1970), vínculos de pudor y de culpa (Stierlin, 1975), cuentas corrientes de méritos (*ledger of merits* - I. Boszormenyi-Nagy, 1973), que por lo general actúan en forma encubierta, procesos de duelo bloqueados (N. Paul, 1975) y procesos de delegación (Stierlin, 1974) dentro de las relaciones familiares. Para lograr una modificación del sistema, el terapeuta debe ser capaz, ante todo, de empatía, rectitud y lo que se ha definido como parcialidad multidireccional o como imparcialidad que toma partido interiormente. Estas características le permiten analizar los conflictos de mandatos y cometidos, descontar la vergüenza y la culpa, iniciar la elaboración del duelo y poner en marcha un diálogo reconstructivo entre los miembros de la familia y entre las generaciones, que tienda a una clara delimitación de la propia responsabilidad y del *self*, a un retiro de las proyecciones, a un saldar de cuentas, a la justicia y a la conciliación. Los objetivos de esta terapia obligan a revisar las manipulaciones masivas que desempeñaban un papel central en el primer modelo. L. C. Wynne, I. Boszormenyi-Nagy, H. E. Richter y H. Stierlin pueden considerarse como representantes de esta concepción terapéutica (y, según Beels y Ferber, como *reactor-analysts*).

A pesar de las diferencias entre ambas concepciones teóricas y terapéuticas comienza a esbozarse por lo menos en forma parcial— una integración o conciliación, como lo demuestra la evolución del psicoanálisis y de la terapia conductal (*Behaviour Therapy*) en los Estados Unidos. A pesar de la marcada diferencia en la orientación teórica y en los métodos terapéuticos de ambos mo-

delos, en el transcurso de los últimos años se ha producido un acercamiento que ha dado lugar a una terapia conductal de orientación psicoanalítica o psicodinámica (C. Rhoads y Feather, 1974). El ejemplo de este proceso de integración viene muy al caso, además, porque los dos modelos de terapia familiar aquí considerados contienen elementos de terapia conductal (modelo estructuralista) y elementos psicoanalíticos (modelo de conciliación y elaboración de conflictos), que poco a poco comienzan a integrarse. Esto significa, por ejemplo, que la empatía y la comprensión de los conflictos cobran importancia para el enfoque estructuralista, mientras que los terapeutas de orientación analítica comienzan a aplicar las intervenciones modificadoras de sistemas descritas por los terapeutas de la escuela estructuralista.

Ahora bien, no debe pasarse por alto el hecho de que, tanto el psicoanálisis como la terapia conductal, por su evolución histórica tiene carácter monádico, es decir, que contemplan al individuo como unidad de tratamiento. Ni los terapeutas de una escuela ni los de la otra dan por sentado que se pueda ir más allá de la mónada paciente o de la diada paciente-terapeuta, para encarar un sistema de relación triádico o más amplio aún, y ejercer una influencia sobre él. Para captar las fuerzas sistémicas de las cuales ya hemos hablado, y para trabajar con ellas, tanto un modelo como el otro deben ser complementados por elementos de las teorías sobre comunicación humana y sobre sistemas humanos.

Desde un punto de vista teórico purista es perfectamente comprensible que semejantes síntesis de elementos con raíces teóricas tan diversas sean rechazados tanto por los tradicionales representantes de la escuela psicoanalítica y de la terapia conductal, como por los paladines de la teoría sistémica (con Bertalanffy). En efecto, el pensamiento causal y determinista de las terapias de orientación monádica no puede fusionarse así con el fundamento cibernético de una terapia de orientación sistémica. Pero lo cierto es que estas preocupaciones son más cosa de los teóricos que de los prácticos en el terreno de la terapia de familia.

La creciente conciliación de ambos modelos hace pensar que en la capacitación del terapeuta familiar pueden intervenir elementos de *ambos* enfoques.

Contenidos de un posible plan de capacitación

¿Cuáles deben ser, pues, los contenidos de un posible plan de capacitación para terapeutas familiares? El interrogante puede abarcar tres dimensiones:

1. ¿Quién debe ser terapeuta familiar? (Predisposición)
2. ¿Qué debe dominar el terapeuta familiar? (Métodos y técnicas)
3. ¿Qué debe saber? (Contenidos cognoscitivos)

Las preguntas se han ordenado según su importancia.

Esta pregunta abarca dos aspectos diferentes: por un lado está la formación básica y por otro la predisposición natural. Respecto de la formación básica podríamos preguntarnos —justamente a raíz de lo comentado en párrafos anteriores— en qué medida puede resultar útil una formación previa en terapia conductal y en psicoanálisis, como base para la especialización en terapia familiar. (Al hablar aquí de capacitación, nos referiremos, pues, a la especialización y no a la formación básica.) Son muchos los argumentos tanto en favor como en contra de la conveniencia de una preparación previa en alguna de esas formas de tratamiento, para una ulterior especialización en terapia familiar. Por ejemplo, la terapia conductal tiene a su favor la disposición a intervenir en forma activa y a acordar con el paciente objetivos claramente definidos, que tanto éste como el terapeuta se comprometen a perseguir. El argumento en contra de la conveniencia de una formación previa en este tipo de terapia es que en ella se concede poca importancia a la empatía y se deja bastante de lado la dinámica de la transferencia y contratransferencia. En el caso de una preparación previa en psicoanálisis, en cambio, cabe esperar una mayor capacidad de empatía y una bien desarrollada habilidad para reconocer y manejar los fenómenos de transferencia y contratransferencia. El aspecto negativo es que la actitud más bien pasiva e introspectiva del terapeuta con formación analítica puede tener un efecto desfavorable pues, bajo determinadas circunstancias, estimula procesos regresivos en la familia, que paralizan la iniciativa y la responsabilidad individual de sus miembros. Además, un terapeuta

de orientación psicoanalítica puede sucumbir a la tentación de sobreidentificarse con el paciente designado, que desde el punto de vista psicoanalítico puede ser visto como el chivo expiatorio, como la única víctima; pero con eso estará pasando por alto la parte de los otros y los aspectos sistémicos del campo.

Por supuesto que la formación psicoanalítica en el terreno de la terapia conductal no es el único requisito previo para una especialización en terapia familiar. De ser así no se tendría en cuenta a los asistentes sociales para esos fines.

Un poco al margen de la formación básica, se plantea la segunda pregunta: ¿cuáles son las condiciones personales que debe reunir un terapeuta familiar?

Al terapeuta familiar se le exige una medida de actividad que contrasta con la llamada "abstinencia" del terapeuta individual de la escuela analítica, la cual en su forma más extensa concibe al terapeuta como una pantalla, sobre la cual el paciente proyecta sus deseos y conflictos inconscientes. Richter, sobre todo, ha señalado hasta qué punto la terapia familiar invita más a la acción que la terapia individual. Eso hace surgir el peligro de que en el terapeuta se movilicen ideas de grandeza y pretensiones carismáticas latentes. El "animado escenario de la terapia familiar puede resultar un estímulo activante" (Richter, 1970, pág. 157), sobre todo para los terapeutas con rasgos depresivos.

Por otra parte, en el caso de terapeutas que —por su historia didáctica personal o por su formación— miren con temor la actividad propia (aunque para ellos el "actuar" sólo tiene connotaciones negativas), la terapia familiar puede no llegar siquiera a ponerse en marcha en determinadas circunstancias. El terapeuta inhibido en cuanto a acción procura permanecer fuera del sistema familiar hasta un punto tal, que su pasividad ejerce un efecto paralizante sobre la familia. Minuchin describe, en cambio, con el verbo *accomodate* (crear libertad de acción, hacer que alguien se sienta cómodo) una serie de posibilidades del terapeuta de convertirse pasajeramente en miembro del sistema familiar y así poner en marcha el proceso terapéutico.

Otro de los problemas es el planteado por la contratransferencia. Wynne (1965) subraya, sobre todo, tres condiciones que debe reunir un terapeuta familiar: en primer lugar, debe ser capaz de

solucionar complejos problemas de contratransferencia. A diferencia de lo que ocurre con el terapeuta individual —que puede eludir los problemas de contratransferencia no resueltos, evitando a determinados pacientes (por ejemplo, hombres maduros, "dominantes", que pueden activar en él problemas de autoridad no resueltos)—, un terapeuta de familia no tiene escapatoria.

Pero el lugar que ocupan la transferencia y la contratransferencia en la escala de valores de la terapia familiar difiere por completo del que le concede la terapia individual: el sistema familiar tiene más poder con respecto al terapeuta, que el paciente individual. Esto queda demostrado, por ejemplo, en el hecho de que las alianzas constituidas entre el terapeuta y diversos miembros de la familia suelen ser rápidamente corregidas por las reacciones de los demás. "La idea de que éstas (las relaciones entre el terapeuta y los individuos de la familia) son lo bastante poderosas como para hacer conflictivos los vínculos en la familia y corregirlos a través de la transferencia, escapa al concepto de que las relaciones familiares son por lo general más fuertes" (Kaufmann, 1975, pág. 690).

En segundo lugar, Wynne señala que el terapeuta debe ser capaz de mantener un interés permanente y comprometido, dadas las fuertes resistencias opuestas por el sistema familiar. Como tercer requisito afirma que el terapeuta debe estar en condiciones de intervenir en el acontecer de la familia en forma activa e imponiendo límites.

Las tres condiciones parecen ser elementos de lo que I. Boszormenyi-Nagy (1973) ha definido como *multi-directional partiality* (parcialidad multidireccional) y Stierlin (1975) como capacidad de imparcialidad interiormente comprometida.

Teniendo en cuenta estas consideraciones cabe preguntarse en qué medida es preciso suministrar técnicas y en qué medida ha de desarrollarse la empatía en cualquier proceso de formación de un terapeuta de familia. Los autores de este trabajo no dejan de reconocer, por cierto, que las técnicas son importantes; pero consideran que, en última instancia, la empatía con los problemas, la dinámica de las relaciones y las "cuentas corrientes de méritos" de los miembros de la familia es lo que decide qué técnicas han de aplicarse.

¿Pero cómo puede estimularse esa empatía en el futuro terapeuta de la familia y a qué debe concederse atención preferente en ese proceso?

a) La empatía no se concentra en un individuo sino en todos los miembros de la familia y —llegado el caso —hasta en representantes de diversas generaciones. Eso se ajusta al postulado de la *multi-directional partiality* o de la "imparcialidad interiormente comprometida".

b) El terapeuta familiar debe tratar con frecuencia a personas que difieren mucho de él en cuanto a edad y a experiencia de vida. Por lo común le resulta más fácil identificarse con aquellos miembros de la familia que están más cerca de él en esos dos aspectos. Por esa razón, los colegas caen con facilidad en una encubierta postura de defensa respecto de los miembros mayores de la familia, mientras que los más entrados en años se solidarizan o sobreidentifican a veces demasiado con los padres de mediana edad. Y no sólo las diferencias de edad pueden constituir un impedimento para la empatía y el entendimiento; también las diferencias sociales entre la familia y el terapeuta pueden representar un escollo. El estrato social, la profesión y la pertenencia a alguna subcultura con su lenguaje propio, sus propias normas y valores pueden constituir un escollo o un puente. La terapia familiar es siempre, al mismo tiempo, "sociología familiar aplicada" (Duss-von Werdt, 1976).

¿Cómo puede estimularse en el proceso de capacitación una empatía que abarque la gama más amplia posible de grupos sociales y de edad, e incluso de generaciones?

c) En este aspecto adquieren importancia esencial la vivencia y la elaboración de las propias relaciones familiares. Se advierte aquí un paralelismo con los conceptos de formación psicoanalítica. En ellos, la comprensión y elaboración del proceso evolutivo de la propia personalidad y de los propios conflictos; en el trascurso del análisis didáctico, se convierten en un factor esencial de la capacitación del terapeuta. En la terapia familiar es esencial la comprensión y elaboración de la propia problemática familiar.

Pero cuando hablamos de la problemática familiar propia debe tenerse en cuenta que son dos y hasta tres los grupos familiares importantes con los cuales está ligado el candidato a la especialización: en primer lugar está su familia de origen, en el cual él es o

ha sido hijo (o hija), hermano (o hermana); en segundo lugar su familia actual, en la cual funciona como cónyuge y/o como padre (o madre); en tercer lugar puede estar su "familia laboral", es decir el grupo dentro del cual trabaja y dentro del cual posiblemente tiene obligaciones, vínculos y conflictos análogos a los que surgen entre parientes.

1. ¿Quién debe ser terapeuta familiar?

La elaboración de la problemática familiar propia puede materializarse de diversas maneras en los cursos de capacitación para terapeutas familiares:

—por representación de roles familiares o *family sculpting*: los miembros de un grupo, dirigidos por un terapeuta familiar experimentado, deben representar papeles o escenas de su propia historia familiar (cf. Papp y otros, 1973).

—por medio de seminarios en los cuales los candidatos analizan y discuten por turno la dinámica o la problemática de su propia familia, por lo común dentro de una perspectiva plurigeneracional. Esta forma de seminario familiar ha sido practicado y difundido, sobre todo, por el terapeuta familiar estadounidense M. Bowen (en Framo, 1972). Bowen también ha brindado un ejemplo de cómo alguien puede constituirse en terapeuta de su propia familia.

—por medio del "análisis didáctico familiar": como el análisis didáctico del psicoanálisis, el análisis didáctico familiar tendría por objeto estimular la capacidad de empatía del futuro terapeuta, de alertarlo ante la dinámica de la transferencia y la contratransferencia y de liberarlo de los llamados escotomas. Además debe proporcionarle la oportunidad de poner en movimiento el modelo de relación congelado de su propia familia y de intervenir en esa familia, tanto estableciendo confrontaciones como conciliando. Pues cada vez son más los terapeutas familiares que apoyan la tesis de que un terapeuta sólo puede ayudar a sus pacientes en la medida en que esté o haya estado en condiciones de manejar en forma constructiva los problemas de su propia familia. Esta exigencia de un análisis familiar didáctico, que durante los últimos años se ha manifes-

tado cada vez con mayor firmeza, sobre todo en Estados Unidos, tropieza hasta ahora con inconvenientes de índole práctica y psicológica, muy comprensibles por cierto. De cualquier manera, en Estados Unidos ya existen centros de capacitación en donde comienza a ponerse en práctica el análisis familiar didáctico o la terapia didáctica, por ejemplo, a través de conferencias de cierta duración —un fin de semana— a las cuales se invita a los miembros de la familia de los interesados en la especialidad. Esto reviste gran importancia, sobre todo, para el cónyuge que no está cumpliendo el curso de capacitación. Pues la parte del entrenamiento orientada hacia el estudio de la personalidad del propio interesado, desenchada en él procesos y crea nuevas posibilidades de aprendizaje social, que deben repercutir necesariamente sobre su matrimonio y sobre su familia. Es más fácil evitar conflictos cuando el cónyuge "que permanece en casa" puede recorrer parte del camino junto con el que interviene en forma activa en el proceso de capacitación. Por otra parte cuando se realizan esos esfuerzos en común resulta más difícil eludir la pregunta de por qué alguien busca capacitarse en terapia familiar. Porque uno de los elementos motivantes puede muy bien ser un conflicto en el propio matrimonio o en la propia familia, que el interesado procura eludir o resolver por esa vía.

—por medio de un análisis didáctico tradicional: también éste es un camino posible para entender la propia dinámica familiar y para aprender a elaborar los problemas familiares existentes. Pero debe tenerse en cuenta que, en este caso, la elaboración se realiza sin la participación de los personajes más importantes en la relación familiar, sólo en el campo de tensiones de la situación de transferencia que se produce entre el analista y el analizado, lo cual implica una sustancial diferencia con la situación habitual en la terapia de familia.

—por medio del análisis y la discusión de la "familia laboral" o del grupo que está cumpliendo su proceso de capacitación, en sesiones que tienen mucho de grupo terapéutico. También éste pueden ser un camino para aumentar la comprensión de la dinámica familiar.

2. ¿Qué debe dominar el terapeuta familiar?

Otro contenido importante del proceso de capacitación es el entrenamiento en métodos y técnicas específicos, aun cuando se lo subordine a la parte de la capacitación que contempla la personalidad del propio candidato. No es posible aquí efectuar una enumeración y descripción de técnicas. Se ha insistido, más bien, sobre la manera de adquirir las herramientas metódicas; con otras palabras: sobre cómo se aprende en la práctica la terapia familiar.

El entrenamiento práctico debe aproximarse, por definición, todo lo posible al ejercicio práctico de la especialidad. Eso obliga a que, desde el comienzo mismo, el candidato practique, asuma una responsabilidad y así pueda aprender de sus éxitos y fracasos.

¿Cómo concretar eso?

Una forma de aprender (y de enseñar) es la *co-terapia* con un colega experto. En este caso, el terapeuta en formación no asume toda la responsabilidad. Puede apoyarse en su "maestro", puede adaptarse a la forma de intervención de éste, pero va desarrollando iniciativas propias a medida que aumentan su experiencia y su seguridad. Es inevitable que surjan problemas en el trabajo en común de un equipo constituido por un terapeuta experimentado y uno no tan experimentado. Es preciso elaborar dichos problemas, y esto constituye una posibilidad más de aprendizaje. Además de la práctica en la actividad terapéutica (en asociación con otros), otra de las posibilidades de aprendizaje consiste en la *observación de los terapeutas experimentados*, de su estilo y de sus técnicas. En eso reside la importancia de los talleres o seminarios de corta duración, que permiten a los terapeutas noveles observar a colegas más experimentados y conocidos, en su trato con las familias, y luego discutir con ellos el procedimiento. El aprendizaje sobre la base de modelos posibilita complejos procesos de aprendizaje en el plano cognoscitivo y emocional, que no se dan en las tradicionales sesiones de supervisión y control. El espejo unidireccional (cámara de Gesell) y el *video-tape* son auxiliares de no

table importancia para este tipo de aprendizaje. Aparte de la observación breve de terapias familiares, es muy importante la observación sostenida durante meses y años. Sólo así se pueden percibir los procesos y las reestructuraciones del sistema. Por añadidura, el terapeuta familiar novel vive la experiencia de formar parte de un equipo que no sólo es necesario para él, sino que necesita de él. (En la mayoría de los centros de terapia familiar de Estados Unidos, la sesión terapéutica dura, por lo general, una hora, y la discusión que sigue y en la cual participan los observadores, se extiende por media hora más.) Una observación que se prolonga a través de un lapso considerable permite al "novato" comprobar que también los terapeutas experimentados cometen continuamente errores y nunca dejan de aprender. Esta experiencia, como ninguna otra, hace desaparecer los temores del candidato a la especialización, fortalece su confianza en sí mismo y contribuye a que se cree una atmósfera de equipo no jerárquica.

Pasaremos ahora a comentar el aprendizaje por medio de *supervisión individual o de grupos*. También en este caso son importantes auxiliares el espejo transparente de un lado, las cintas magnetofónicas y el *video-tape*. Todos esos medios permiten participar directamente en una terapia y adquirir una imagen clara de la dinámica familiar en cuestión.

Mencionaremos, finalmente, el *role-playing familiar* o *family sculpting*. Este no sólo sirve para fines didácticos, sino que se suele emplear también en algunas terapias como medio muy efectivo e intensivo.

El hecho de que en el caso de la terapia de familia no se logre exponer con precisión las técnicas puede señalarse como un inconveniente; sin embargo, la precisa exposición de técnicas no significa que éstas lleguen a aprenderse y dominarse. El *learning by doing* (aprendiendo a través de la experiencia) se presta más para ello, pero sólo es lo bastante eficiente cuando se puede llegar a *pensar* en categorías de familia. Es entonces cuando se desarrolla realmente la capacidad de observar a los demás y a sí mismo y se agudiza la sensibilidad para detectar el momento propicio para la intervención. La observación de sí mismo se refiere, por un lado, a las funciones y roles del terapeuta *entre* los miembros de una familia y, por otro lado, a lo que la familia hace con el terapeuta.

La observación social tiene por objeto la relación entre varias personas y no se concentra en el individuo sino en las interacciones de éstos.

3. ¿Qué debe saber el terapeuta familiar?

La sola pregunta ya nos indica que el terapeuta debe poseer conocimientos teóricos sobre la familia. En términos generales, debe conocer la literatura general y específica sobre sistemas de familia y de pareja, sobre comunicación y sobre interacción. Pero para no encerrarse en un *ghetto* de terapia familiar, también deberá interesarse por la situación social, económica, pedagógica y ecológica de la familia, así como por los roles de cada sexo, por la emancipación y por las alternativas de las formas tradicionales de familia. Porque, como ya se señalara en párrafos anteriores la terapia familiar es sociología y antropología aplicada no sólo en lo que se refiere a familia sino también en lo referente a cada sexo. Todo esto contribuye a la tan necesaria revisión de las propias posiciones, normas y escalas de valores que influyen consciente o inconscientemente sobre la acción terapéutica.

Capacitación para determinados grupos de profesiones

Como ya se señalara antes, la capacitación se ha considerado aquí como especialización y perfeccionamiento de la formación básica adquirida ya por determinados profesionales.

A continuación se mencionarán algunas profesiones que pueden aplicar en su ejercicio los conocimientos y habilidades exigidos por la terapia de familia. Al margen de éstas, están aquellas profesiones que deberían adquirir una mayor sensibilidad en lo que a la dinámica de la familia se refiere, pero que no guardan relación alguna con la práctica terapéutica. En realidad, no hay profesión asistencial o social, tanto en el orden privado como en el público, para la cual no sea importante el enfoque familiar.

1. MEDICOS

En Estados Unidos y en muchos otros países se va imponiendo cada vez más la costumbre de conferir al clínico general el *status* de especialista, al considerarlo *médico de familia* (*family physician*). (En la Universidad de Rochester, Estado de Nueva York, existe, por ejemplo, un programa de capacitación en medicina familiar, que equivale a una especialización en medicina interna o en cirugía, en lo que a tiempo insumido y a conocimientos brindados se refiere.) Como su nombre lo indica, el deber primordial del médico de familia consiste en tratar a todo el grupo familiar y en mantenerse en permanente contacto con él. Esto exige, entre otras cosas, una capacitación en "somática familiar", enfoque según el cual los síntomas físicos de un miembro de la familia no deben estudiarse sólo desde el punto de vista de la terapia individual, sino que deben ser vistos en función de la familia. H. E. Richter, en su libro *Patient Familie* (1970) ha descrito importantes aspectos de la dinámica esencial en este terreno. El estudiante de medicina debería aprender a conocer esta dinámica en el trascurso de su formación universitaria, por ejemplo como parte de la psicología médica, y debería profundizar en ella a través de la práctica, en los semestres clínicos. La observación directa podría concretarse en casi todas las materias clínicas. Para iniciar este proceso sería conveniente que en todas las cátedras importantes, como medicina interna, cirugía y pediatría, se contara con profesores capacitados en terapia familiar que pudieran exponer el enfoque de la terapia y la dinámica familiares en clases aisladas o en seminarios, como ya se hace en diversos centros de estudios médicos de Estados Unidos.

2. PSIQUIATRAS

La formación profesional de los psiquiatras debería tener en cuenta la importante evolución experimentada por la terapia de las psicosis y neurosis en función de la familia, que se ha hecho patente en Estados Unidos, Holanda y los países escandinavos durante la última década y ha dado prueba de indiscutible eficacia. En este sentido podrían tomarse como modelo universidades estadounidenses como Harvard, Yale y Rochester, en las cuales la te-

rapia de familia constituye una parte muy importante del programa de formación de un psiquiatra, junto con el psicoanálisis, la teoría de grupos y la psicofarmacología. También debería tenerse en cuenta la actividad de los Community Mental Health Center, en los cuales las actividades se concentran cada vez más en la prevención y asistencia social de las enfermedades psiquiátricas.

3. ESPECIALISTAS EN PSIQUIATRÍA INFANTIL

Desde el punto de vista de la terapia familiar, el especialista en enfermedades mentales infantiles desempeña un papel de particular importancia dentro de la psiquiatría. Más que nunca puede sostenerse la tesis de que la psiquiatría infantil (y también el psicoanálisis de niños) es ante todo psiquiatría de familia. Casi no se justifica ya tratar en forma individual, independiente de la familia, a los niños con problemas mentales.

4. PSICOTERAPEUTAS Y PSICAGOGOS

En estas profesiones se agudiza de manera muy particular la problemática de la reubicación y del replanteo. Porque hasta ahora, los cursos de capacitación como psicoanalista y como psicagogo, por lo general, no incluyen información o, por lo menos información suficiente en el terreno de la dinámica familiar y de la terapia de familia. La tradición individualista del psicoanálisis y de la medicina han impedido hasta el día de hoy esa apertura. Una de las consecuencias de tal situación es que, con frecuencia, la terapia individual es defendida contra la terapia familiar y de grupo, como si estas dos últimas fueran un peligroso intruso. En adelante, los modelos de la dinámica familiar, de la patología familiar y los importantes principios y técnicas de la terapia de pareja y de familia deberían dejar su papel marginal, para constituir temas centrales de los cursos de capacitación en psicoterapia y psicagogía. Pero esta exigencia no se podrá satisfacer en tanto no se aclaren más las posibilidades de integración de los conceptos psicoanalíticos, psicoterapéuticos y los referentes a la dinámica familiar, y en tanto el psicoanálisis y la terapia de familia hayan encontrado lugar en una teoría y terapia psicoanalítica de la familia de mayor alcance.

5. ASISTENTES SOCIALES Y SOCIOPEDAGOGOS

Pocas profesiones están vinculadas en forma tan directa y múltiple con los problemas familiares como la de asistente social. Esto sólo basta para preguntarse en qué medida se contempla el problema en la formación básica y en el perfeccionamiento de estos profesionales. Por añadidura, el asistente social debe ocuparse —literalmente como "última instancia"— de familias que ya han recorrido un largo camino que pasa por muchos organismos o que no están en condiciones de recorrerlo.

6. TEOLOGOS, PEDAGOGOS, JURISTAS ...

Sería demasiado pedir si pretendiéramos que estos profesionales obtengan la posibilidad de adquirir conocimientos que los capaciten para la terapia familiar. Lo único que se pretende es que se enteren de lo que es la dinámica familiar. No podemos extendernos sobre lo que eso significaría para cada una de esas profesiones; pero debemos señalar que todas ellas tienen en común el contacto directo con miembros aislados de la familia, sea por razones de trabajo (maestro-alumno; sacerdote-fiel; jurista-cliente en cuestiones de divorcio, patrimonio, etc.), o de manera informal. Por lo general, las relaciones tienen una exclusividad diádica: el abogado en un asunto de divorcio representa los "intereses" de su cliente, el maestro se limita al alumno, el sacerdote "recibe la confesión" y está obligado a mantener el secreto, etcétera. Sería conveniente considerar la posibilidad de brindar a estas profesiones la oportunidad de una capacitación o de una especialización que los habilitara más para el "trato con familias". Uno de los autores de este artículo —el mencionado en primer término— puede brindar la breve exposición que sigue, sobre la base de su propia experiencia en un curso de capacitación en materia de pedagogía curativa: para comenzar, propuso la unidad temática "Dinámica y pedagogía" y procuró trabajar, en lo posible, con métodos didácticos basados en vivencias personales, recurriendo a *role playing* con situaciones dadas, para ilustrar las estructuras y las transformaciones dentro de la familia, para la observación de los cambios en la dinámica familiar por efecto de la intervención de un tercero (por ejemplo, del maestro), etcétera.

Se pudo comprobar que esto trajo consigo cierta elaboración de la situación en la propia familia de origen o en la familia actual.

Posibilidades de capacitación, problemas pendientes y postulados

1. Los centros e institutos existentes deben desarrollarse en dos aspectos: por un lado, deben fomentar la capacitación de terapeutas familiares, que a su vez puedan formar nuevos terapeutas. Por otro lado deben modificarse los planes de estudio de las universidades, institutos, academias y centros de formación análogos, de modo que encuentren más cabida en ellos la dinámica y la terapia familiares.

2. Mediante simposios, talleres, seminarios y visitas recíprocas puede fomentarse el intercambio y contribuir a encontrar la identidad de esta joven especialidad y de sus representantes. Una de las intenciones de esta revista (*Familien Dynamik*) es prestar su apoyo para el logro de tal objetivo. Si bien ya se ha instado a la reunión de los terapeutas familiares en asociaciones regionales más o menos libres y ya se ha discutido el tema, aún no se ha concretado ninguna medida al respecto.

3. Es preciso introducir reformas en la legislación de la profesión, sobre todo, en lo que se refiere a las disposiciones sobre seguros de salud que la terapia familiar tenga un lugar reconocido, junto a otros métodos de tratamiento. Este tema se encuentra en discusión.

4. Sería conveniente contar con centros de capacitación, en los cuales se entrenara en forma conjunta a representantes de diversas profesiones.

5. Además, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, Inglaterra y los países escandinavos, sería interesante organizar breves talleres e invitar a reconocidos terapeutas de familia de distintas partes del mundo.

SUMMARY

Training and Teaching in Family Therapy. Some basic Thoughts.—There does not exist yet one generally accepted conception of family therapy. Most of the approaches which have become more widely known have different origins. When training is considered, this gives rise to questions of principles as to the methods and goals such training should envisage. In the present contribution mainly two theoretical and practical conceptions are considered. One is the structural approach, the other one has its focus on conflict resolving respectively reconciliation. According to the authors' opinion an integration of both conceptions in training is possible.

Three major points have to be considered when training for family therapy is concerned. One has to do with the therapist's *educational and personal prerequisites*. The capability to develop empathical understanding for more than one member of a family, together with a willingness to scrutinize, with a mind to improve, his present and former family relationship are here considered to be of vital importance. The acquirement of *technical and methodical ability* is then a second goal, which is in close relationship with the trainee's own professional activity and the possibilities offered in training for practical experience. Last but not least, any kind of training programme should comprise space for the acquirement of *specific knowledge* directly related to the two other goals.

Ateneo clínico

Inauguramos hoy una nueva sección de la revista, cuya finalidad es la de promover encuentros entre terapeutas de familia de distinta extracción teórico-clínica. Las semejanzas y diferencias orientarán al lector en el camino de una integración que no sólo dé una nueva síntesis enriquecedora sobre el hecho clínico sino que permita conocer también en un lenguaje coloquial, parte de las preocupaciones cotidianas de quienes enfrentan esta difícil, pero apasionante tarea.

Integrantes

Lic. Juan Carlos Nocetti
Dr. Octavio Fernández Mouján
Dr. Alfredo Canevaro

Paciente

RAFAEL: 17 años, argentino, soltero; hijo de Susana Lidia y Guillermo X.

No trabaja. Estudia bachillerato primer año (repitió dos veces). Vive con su madre, hermanastro mayor, hermana mayor y abuela materna.

Composición familiar

MADRE: Susana Lidia, 50 años, argentina. No trabajó nunca. Estudia psicología, último año.

PADRASTRO: Guillermo B; fallecido a los 49 años por insuficiencia cardíaca y renal. Procurador público, no ejercía. Hacía trabajos diversos no fijos. Fallece durante el transcurso del tratamiento.

PADRE: Guillermo X; amigo de Guillermo B, padrastro del paciente.

HERMANASTRO: Marcos, hijo de Susana Lidia y Guillermo B; 26 años, soltero, argentino. Estudiante 3er. año medicina. Trabajos esporádicos.

HERMANA: Lidia, hija de Susana Lidia y Guillermo X, 21 años, soltera, argentina. Estudia psicología 1er. año. Comenzó a trabajar como empleada venta automotores.

ABUELA: Susana, madre de Susana Lidia; 68 años, viuda aunque separada de su marido desde hace 49 años. No trabaja en la actualidad, lo hacía como azafata de la Marina Mercante. Realiza todas las tareas del hogar. A partir de su separación no mantiene relación de pareja con ningún hombre.

Motivo de consulta

MADRE: Preocupada por la conducta agresiva y solitaria de su hijo. Considera que puede haber influido el desconocimiento de su padre real. Narra tratamiento fallido anterior con compañero suyo de la facultad.

RAFAEL: Deseaba hablar con alguien porque se sentía muy solo. Lidia, su hermana, única confidente hasta ese entonces, se puso de novia. Muy silencioso.

Diagnóstico presuntivo

Esquizofrenia simple.

Tratamiento

Individual 4 veces por semana durante 3 años; a partir de lo cual, por *crisis familiar* se realizan algunas entrevistas a la familia. Internación un mes por intento de suicidio; se interrumpe por dificultades económicas.

Tratamiento individual de Rafael pagado por Clara, hermana menor, soltera, del padrastro.

Internación pagada por abuela Susana.

Historia familiar

Susana L, madre del paciente, es hija única de matrimonio mal avenido; las relaciones entre los cónyuges eran muy enojosas; su madre, de origen español, viajaba por su trabajo de continuo y su padre también de igual origen, era viajante de comercio. Durante los viajes de la madre la niña quedaba al cuidado de Titi, su madrina, con quien su padre mantenía en forma descubierta relaciones extramatrimoniales. A los pocos meses de nacer Susana L, su padre se va de la casa con otra mujer, no volviéndolo ésta a ver más. 25 años más tarde se entera en forma casual de su muerte. A la muerte del marido de Titi, ésta pasa a vivir con Susana L y su madre; lo hace hasta su muerte, acaecida dos años antes del comienzo del tratamiento.

Guillermo B, padrastro del paciente es hijo mayor de matrimonio bien avenido. Su madre trabajaba en su casa y su padre estaba al frente de un almacén. Muy apegado a su madre, se recibe de Procurador Público por deseo de ésta, profesión que nunca ejerce pues su vocación era la música, actividad que su madre detestaba. Tímido con las mujeres, se casa con Susana L, impresionado por su fuerza e independencia, deseoso de no vivir en su casa materna, pues la muerte de su padre a los 18 años le tornó insoportable el clima asfixiante familiar. Al dejar su casa paterna, su hermana se hace cargo del cuidado y mantenimiento de su madre enferma y postrada en cama.

Susana L y Guillermo B se conocen en taller artístico, donde él estudiaba piano y ella arte escénico. Luego de corto noviazgo

se casan. Susana L aduce dificultades en la relación matrimonial desde su inicio acusando de *abulia y falta de responsabilidad a su marido*. Crisis fóbicas agudas de Susana L. Nace Marcos al año de casados. Susana L establece relación extramatrimonial con Guillermo X, amigo de su esposo con el cual tiene 2 hijos, Lidia y Rafael, haciéndole creer a su marido que él era el padre. A partir del nacimiento de Rafael esa relación extramatrimonial se deteriora en forma rápida, a tal punto que Guillermo X sólo ve a Rafael pocas veces, cuando éste es un bebé. Para aquel entonces la relación matrimonial es inaguantable para ambos cónyuges: en un principio duermen en camas separadas y luego Susana L echa a su marido de la casa, quien se va a vivir con su madre y su hermana Clara.

Al poco tiempo Guillermo B enferma de gravedad, identificado con la madre y es internado en un hospital, siendo atendido por su hermana. Marcos y Lidia lo van a ver pocas veces, Rafael no va nunca a verlo. Muere por insuficiencia cardíaca y renal. La enfermedad de Guillermo B acaece después de una fuerte pelea con su esposa Susana L quien, enojada, le cuenta que Lidia y Rafael no son sus verdaderos hijos.

Susana L describe a su esposo como irresponsable y dependiente: solía tener *grandes e irrealizables proyectos económicos* que fracasaban estrepitosamente, con gran deterioro de los bienes hasta ese momento obtenidos; mudanzas por falta de pago de alquiler; cortes de luz, de gas, embargos por iguales motivos. Dado que *Susana L*, madre del paciente, *nunca trabajó*, la casa era mantenida por su madre, que en un principio trabajaba en la Marina Mercante, así como también vendía artículos que traía en forma clandestina del extranjero y, luego, del importe de su jubilación, Marcos ayudaba en su casa con trabajos temporarios y con una pensión por invalidez, obtenida por sordera contraída durante el servicio militar.

Luego del nacimiento de Marcos, Susana L padecía agudas crisis fóbicas; por largos períodos se mantenía *recluida en su habitación*, mientras Marcos era atendido por su abuela y Titi. Por aquel entonces la situación económica era estable, Guillermo B jugaba y salía con su hijo. Con los nacimientos de Lidia y Rafael, Guillermo B se desentiende de los niños, acuciado por

problemas conyugales y por sucesivos fracasos económicos. Las peleas entre los esposos son constantes, en su mayoría frente a los chicos. Susana L sólo se ocupa de Lidia, con la cual establece una relación muy estrecha, dejando al cuidado de la abuela y Titi a Marcos y a Rafael. Marcos, más independiente, pasa su tiempo estudiando, jugando con sus amigos en la calle o en casa de su abuela paterna. Rafael, en cambio, juega solo; no tiene amigos y se encierra la mayor parte del día en su habitación.

Elección y adjudicación de nombres a los hijos

MARCOS: Lo elige Susana L con aval de Guillermo B. Nombre perteneciente al abuelo paterno.

LIDIA: Lo elige Susana L (Guillermo B se entera luego de su inscripción), es el segundo nombre de la madre del paciente Susana L.

RAFAEL: Lo elige Susana L (Guillermo B se entera luego de su inscripción), no sabe por qué lo eligió.

Historia del tratamiento

Susana L solicita entrevista para tratamiento de su hijo Rafael. Había sido derivada por su terapeuta. Manifiesta preocupación por la conducta agresiva y extremadamente solitaria de Rafael. Pudo hasta ese momento "soportarlo", dado que ella estaba en tratamiento, pero a raíz de haberlo interrumpido por problemas de pago, consideraba que Rafael "requería otra ayuda". La entrevista gira en torno a su problemática, narrando muy al pasar que su marido estaba moribundo en el hospital. Expresa resistencia, pero al final se aviene a traer autorización por escrito de Guillermo B para que Rafael inicie tratamiento; éste sería pagado por Clara, hermana de Guillermo B, con quien tiene poca y mala relación; siendo el nexo para obtener el pago, Marcos, único miembro de la familia que visitaba a su abuela paterna y a su tía.

Rafael establece una buena relación transferencial, pasando

de una etapa autista a otra en la que comienza a leer escritos preparados en su casa y su diario que, prolija y detalladamente, escribía todas las noches desde los 8 años. A la muerte de Guillermo B, Rafael queda impresionado por la "farsa" del velorio y a partir de esa fecha la imagen paterna comienza a preocuparlo, diciendo "mi madre *los* (se rectifica) *lo* mató".

Se realiza entrevista con Clara, Susana L y Rafael, a raíz de dificultades en el pago de honorarios, en la cual se dicen reproches y agresiones mutuas, por lo cual el terapeuta resuelve mantener algunas entrevistas familiares sin la presencia de Clara, para luego ser derivados a un terapeuta familiar.

En la primera de las entrevistas familiares, Marcos y Lidia manifiestan agresivamente la irresponsabilidad y carencia de maternidad en Susana L. quien se defiende (?), narrando la verdadera historia de la paternidad de sus hijos; ante el asombro de Marcos e indiferencia de Lidia y Rafael, quienes decían suponerla.

Rafael hace en esas semanas siguientes un intento de suicidio, hiriéndose levemente con una hoja de afeitar en brazos, piernas y cintura en el baño de su casa, hecho que sólo relata a su terapeuta frente al desconocimiento de su familia. Razón por la cual, y ante la carencia de soporte familiar, es internado.

Durante ese momento, la situación ambiental y familiar era explosiva, llegando en varias oportunidades a golpearse y pegarse entre sí Marcos y Lidia; Marcos y Rafael; Lidia y la abuela Susana.

Internación y tratamiento interrumpido por falta de pago.

Registro de fragmento de una sesión familiar (durante la internación de Rafael).

PRESENTES: Susana L.; Marcos; Rafael.

AUSENTE: Lidia.

R: ¿Y Lidia?

S: Lidia dijo que no podía venir, mandó a decir que estaba muy cansada porque trabajó mucho.

Silencio.

R: ¿Cómo? ¿qué trabajó?

S: Consiguí un trabajo bárbaro, es vendedora de autos en una agencia y vos (*a Rafael*) sabés como es... vende muchos coches. Más que los viejos vendedores.

Silencio.

TERAPEUTA: ¿Cómo saben que es Lidia?

S: Requeteseductora, hace lo que quiere. Lo que pasa es que a ella sólo le importan sus cosas. Ahora que trabaja viene a casa como a una pensión. Me habla sólo para exigir que todo esté listo, ropa, comida y si no están se pone a gritar como una loca. Nadie existe más. A mi mamá la tiene a mal traer. Me da bronca que ahora que dispone de plata ¡y mucha!, sólo se ocupa de ella, sabiendo lo que pasamos y la internación, no aporta nada y todavía grita y exige. Esto es inaguantable. Le voy a decir que mi casa no es una pensión.

Silencio.

S: Rafael me dijo que se quiere ir a vivir con ella; que se van a ir juntos cuando salga de la clínica. De todo me entero cuando está ya cocinado.

M: Yo también lo voy a hacer cuando pueda.

S.: (*Quejosa*). Me sacan todo; se derrumba la familia.

R: Es el cambio del feudalismo a la monarquía sin poder real.

M: Es una evolución lógica, además yo no puedo apuntalar a nadie a costa de mi muerte; ellos (*refiriéndose a Rafael y Lidia*) la juegan a recibir todo, exigen y ahora se agarran de que son ilegítimos.

R: Yo nunca quise vivir con mamá; me quise matar cuando Lidia empezó a irse de casa. No se derrumba nada; nunca existió nada. Sos una abeja reina (*a Susana L.*).

T: Podemos pensar a partir de esta situación donde los hijos dicen querer irse y la madre se queja de esto, que hay una búsqueda de parte de ellos de un poder real o una monarquía con rey.

S: Todo sería diferente si tuviesen menos miedo (*a Rafael*). Yo estoy sola y peleo, aunque me adjudiquen la culpa de todo, soy el tacho de mierda de todos, siempre fue así... Entiendo que te vayas vos, Marcos; incluso podría ser Lidia pero *nosotros*

(*a Rafael*) *somos iguales*, estamos en la misma situación, sólo ustedes (*a Marcos*) se van, pero la casa, yo, quedamos. Quieren llevarse a Rafael para joderme y joderlo, porque con lo enfermo que es ¿quién lo va a cuidar? ¿ustedes? Se hacen los salvadores de la patria, pero sólo quieren cagarme la...

M: (*La hace callar con un chistido*). Vos hiciste siempre las cosas a tu manera, nunca te importó nada más que vos y ahora te hacés la víctima.

Discusión

Lic. Nocetti: Lo primero que se me ocurría con respecto a esta familia y quizás a casi todas las familias de este tipo es que plantean un doble problema. Un problema teórico, de comprensión. Ese no es un problema muy serio; en general se encuentran modelos, sino muy orgánicos y totales, modelos que permiten entender la familia. El problema más grave es un problema más bien técnico, de operación, ahí está el obstáculo mayor, me parece a mí (Dr. O. F. M.: estoy de acuerdo, para mí es el problema fundamental: cómo abordar). Encaremos primero el problema de la comprensión, tomaría en cuenta dos parámetros para entender una familia: un parámetro diacrónico y un parámetro sincrónico. El parámetro de los datos históricos que yo tengo acá, al principio, y un corte en una sesión para ver qué otro tipo de datos podemos obtener de ahí y ordenarlos, y en tercer término establecer relaciones entre los dos. Me parece que sólo puede hacerse algún tipo de enunciados con carácter científico de una familia si las relaciones no son arbitrarias, es decir si hay algún tipo de reglas que determine las relaciones que esta familia mantiene. Voy a saber si eso es así en la medida en que encuentre redundancias en este material. A partir de eso lo sé. La existencia de redundancias hace que existan constricciones y esas constricciones son el lugar de algunas reglas que van a estar determinando lo que a ellos les pasa.

A partir de esto yo comenzaría con el material directamente. Lo primero que encuentro es que el paciente tiene 17 años. Mi pregunta a partir de eso es ¿a qué viene esta gente? Si el paciente tiene 17 años, hace 17 años que conviven; es un momento en que

la familia seguramente está planteándose un problema de separación; me parece que por acá debe pasar el eje del problema de esta familia. 17 años de convivencia en la edad de una familia plantea inmediatamente el problema de exogamia. En segundo lugar, un dato que me llama la atención es que no trabaja, simplemente porque figura así; después veo que repitió dos veces y me pregunto inmediatamente qué pasa con las repeticiones; después hay una descripción de la familia que me llama un poco la atención: no veo varones, y a continuación tengo la composición familiar.

Ese primer dato de que no trabaja encuentra su réplica en que la madre no trabajó nunca; cuando leí el material me di cuenta de que habían interrumpido, por motivos económicos y lo primero que me pregunto es qué pasa con los ingresos en esta familia; qué pasa con el sistema económico. Cuando hice el diagrama de la familia me llamó la atención esta organización familiar, una organización familiar que no tiene varones y además que registra una repetición de relaciones extramatrimoniales que no es frecuente, digamos, en el ámbito en que yo me movería con mi familia. Lo primero que se me ocurrió es que ésta es una familia rara, así ingenuamente, y entonces me pregunto inmediatamente si el universo de significaciones que yo he constituido a partir de mis experiencias familiares tendrá algo que ver con el universo de significaciones de esta familia y si yo no voy a tener que hacer un enorme esfuerzo de comprensión para colocarme dentro del universo de esta familia que, seguramente, será muy distinto del mío. Esto apuntaría ya a problemas técnicos, de diálogo con una familia de este tipo. Hay otro dato que me llama la atención y que no entiendo bien de qué se trata: ella hizo un tratamiento con un compañero, esto se agrega a la sensación de que acá pasan cosas raras; primero, no sé si es un compañero de ella con quien se trataba, si es un compañero de ella con quien se trataba el hijo, y después me pregunto: si ella es estudiante ¿era un estudiante esta persona que trataba a este paciente? todo esto me suena a cosas no comunes, como si esta familia se moviera con algunas reglas que yo seguramente no conozco y que no comparto, no desde el punto de vista valorativo, sino desde la experiencia. La relación entre trabajar y no trabajar encuentra acá un tercer término entre dos personas que trabajan esporádicamente.

Relacioné esto con los ingresos, con el sistema económico y con las interrupciones por motivos económicos en dos situaciones, en dos momentos.

Bueno, quizás para centrarme en el problema que me parece más fácil con esta familia y que tiene que ver con lo que me planteaba al principio —que esta familia seguramente, viene a ver cómo puede hacer para separarse— tiene que ver con cómo está organizada esta familia desde el punto de vista del sistema de parentesco.

El diagrama de la familia muestra que es un sistema organizado matrilinealmente aunque por el sistema de apellidos, que no conozco, me imagino que será patrilineal. Es extraño, porque este modo de organización de una familia, formada por una abuela, su hija y los hijos de esta hija, corresponde a un sistema muy primitivo de parentesco, donde el núcleo familiar está formado por los parientes maternos y los maridos tienen una única función de procrear; una vez que procrean se van. Una institución organizada matrilinealmente puede funcionar de esta manera, no requiere la presencia constante del marido. Un matrimonio estable y duradero es atributo de una sociedad más bien patrilineal porque por la transmisión del apellido los maridos necesitan contar con una mujer que permanezca durante nueve meses por lo menos al lado de él y en algunas culturas más tiempo por la crianza. Así que ésta es una familia organizada con un sistema que no corresponde al que tiene organizado nuestra sociedad. Todo tipo de sistema de parentesco está organizado en función de una definición particular, del modo de organizar el tabú del incesto, de realizarlo.

La forma de realizar el tabú del incesto de esta familia no concuerda con lo que está prescripto en nuestra sociedad. Se puede pensar que los maridos sean meros procreadores y ésa sea su única función; una vez que procrean no son más necesarios. Rafael es el último hijo; cuando Rafael nace comienzan los problemas con el marido, ya no hace más falta. El marido de la madre de Susana Lidia desaparece al poco tiempo, ella tenía muy poquitos años, todo esto me hace pensar en la función del padre, del esposo en esta familia, es una función meramente procreativa. En nuestra cultura, tal como está definida la prohibición del incesto, la función del marido es muy importante, porque tie-

ne que ver con el ingreso en la cultura de los vástagos, de los hijos. Si yo relaciono esto con los problemas de separación tengo que pensar inmediatamente en cómo van a resolver los miembros de esta familia el problema que se les plantea de una unión exogénica, si el sistema de parentesco que ellos han elaborado no concuerda, no engrana con el sistema de parentesco de las mujeres a quienes ellos van a tener que ir a buscar. Difícilmente encuentren otro sistema parecido en esta sociedad. Esto no es mero hecho porque la organización del superyó y del ideal del yo se forma a partir de esta organización del sistema de parentesco y la elección de alianza matrimonial está determinada por este sistema. Otros datos que me hacen pensar en que esto debe ser así es que tanto Marcos como Rafael no trabajan establemente, no parecen poder ser maridos posibles de nadie, mientras la mujer, la hija parece que en este momento sí, como si ella cumpliera ahora en una nueva vuelta de tuerca el papel que cumplía la abuela, que sí trabajaba, en este sistema de oposiciones que yo he establecido entre trabajar —no trabajar— trabajar esporádicamente; como si Lidia se estuviera preparando para reproducir en un nuevo ciclo el mismo sistema de parentesco que ellos habían elaborado; para ello va a necesitar un marido con quien ella tenga relaciones esporádicas y que cuando tenga hijos cumpla las mismas funciones que los maridos anteriores. Otro dato que me hace pensar en que el problema está en la dificultad para resolver la separación es el hecho de que los tratamientos son pagados por la hermana del esposo, con quien Susana Lidia había roto hace tiempo. ¿Qué clase de ruptura es ésta en la que el dinero para mantener el tratamiento del hijo proviene de una familia con la cual ellos habían roto relación? Por otro lado, el otro dinero proviene de la madre, de la madre de la madre, como si fuera el sostén económico de esta familia, función que en nuestra sociedad está prescripta para el varón. Vale decir que el lazo con la familia de Guillermo B no está resuelto. Esto quiere decir que para que este sistema de parentesco se instaure, no bastan las personas que están incluidas en las sesiones, sino que hace falta que otra familia colabore y otras personas colaboren en la institución de este sistema de parentesco, como Titi (y su marido) con quien el marido de la abuela mantenía relaciones extramatrimoniales

abiertas. El planteo entonces es: lo que esta familia viene a tratar de resolver es cómo incluirse en un sistema de parentesco donde el padre cumpla una función vital y en esta familia esa función no existe. Creo que eso, sin saberlo ellos, es lo que vienen a buscar al tratamiento. Yo me plantearía problemas en torno al pronóstico viendo la distancia que hay entre esta idea mía del motivo de consulta y lo que pensaría que ellos tienen que resolver y lo que ellos vienen a buscar y cómo lo plantean. Esta distancia me plantearía a mí problemas acerca del pronóstico terapéutico. No parece que esto es suficiente para comprender; vendría ahora el problema técnico y del corte sincrónico de sesión; si quieren lo dejamos para otra vuelta.

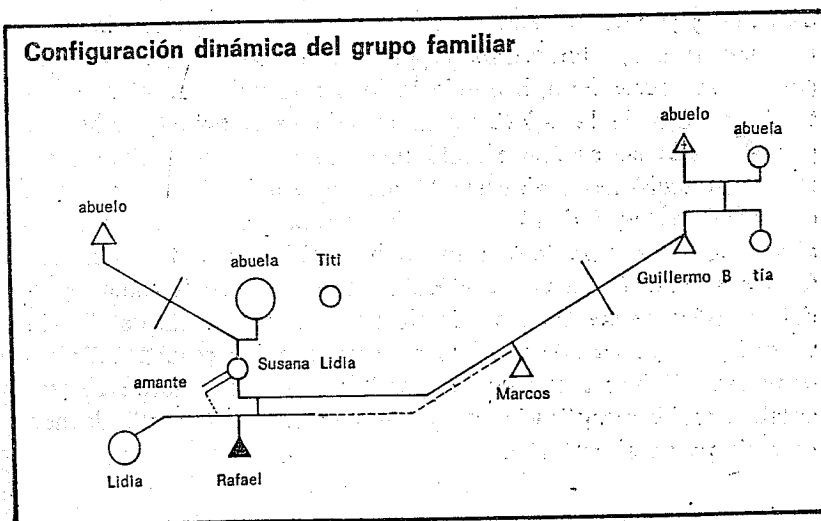
Dr. Fernández Mouján: Yo quería plantear algunas premisas de las cuales yo partiría como referencia para entender esta familia, para después también, como recién se dijo, pasar quizás un poco más al material y a una modalidad de intervención posible en una familia de este tipo y en esta situación de crisis tan aguda.

Cuando empiezo a escuchar una familia reunida en sesión trato lógicamente de detectar cuál es el factor de cohesión, mucho más en una familia como ésta que, como decíamos recién, lleva 17 años de convivencia. Es decir, detectar cuál es la estructura que los une, no tanto la estructura que los junta; o lo que los separa es una manera de rearmar la casa, la mesa, como símbolos, como lugar no espacial, que es de todos justamente porque no es de ninguno; sería la familia en sí que trataría de rescatar. Una pregunta que puedo hacer es cómo poder llegar a lo temido y peligroso sintiendo que el factor cohesión existe para enfrentar los momentos más difíciles. Generalmente trato de que los momentos o lo que realmente aparece como más peligroso aparezcan cuando la familia se siente más contenida. Mientras ese factor, ese lugar no aparece, el terapeuta tendría que ocupar ese lugar antes de que se provoque lo que podríamos llamar las explosiones tan comunes en estas familias aglutinadas que por algún motivo también se llaman epileptoides. Rota la aglutinación, el peligro deja de estar adentro y pasa a estar afuera, entonces esto parece comúnmente y creo que hay varios elementos que lo confirman en el material: la fobia de la

madre, el encierro del hijo, etcétera, lo cual también plantearía una duda sobre el diagnóstico de Rafael. Esta familia, si bien entra dentro de lo que yo podría llamar una familia aglutinada, tiene algunas particularidades como familia aglutinada en sí. La familia aglutinada responde a un nivel cultural que generalmente llamamos el matriarcado, así como la familia uniformada corresponde en nivel cultural a lo que generalmente llamamos el patriarcado. Generalmente entendido el matriarcado dentro de un proceso madre-padre madre-padre, etcétera, permanentemente, en el cual todos son contenidos dentro de este matriarcado, pero de una manera indiscriminada; evitando la individuación con la sobreprotección. Aquí tenemos un caso de matriarcado, a mi juicio, donde la aglutinación está mantenida por el terror, viven aglutinados por el miedo, si enfrentan el miedo, enfrentan a la madre pues es ella la que tiene "la bomba", la amenaza: "hemos matado al padre" (llevan tres generaciones repitiéndolo). Sería esa generalmente la verdad explosiva que todos temen y que la madre domina y con ese dominio mantiene la cohesión de esta familia. Y ésta es para mí una de las explicaciones sobre qué "juntaría" la familia. Todavía no he podido explicarme por qué están unidos. La culpa es lo que nadie quiere "cargar" siendo su asunción lo que yo supongo que los uniría. Todos disparan ante el cadáver muerto, acusador, del padre, tienen vida mientras era un tótem amenazador que la madre poseía y de esa manera los aglutinaba. El derrumbe familiar es el fin del matriarcado, diría yo, no como dice Rafael, y la búsqueda de un patriarcado sin padre y sin rey, como dice él. Están buscando evidentemente un padre porque se les ha roto el matriarcado; era un matriarcado, como vuelvo a decir, muy particular, que yo no estoy acostumbrado a ver y que está basado en el terror. Generalmente lo que uno acostumbra a ver está basado en la sobreprotección, en determinados roles maternos exagerados en familias con ausencia de padre, generalmente. También Marcos dice en otro lugar, "yo no puedo ocupar el lugar de un muerto, los que exigen, lo que me están exigiendo acá, las víctimas, porque se creen ilegítimos". Por otra parte Marcos pienso que es lo más rescatable, es el único que dice "si puedo", "cuando pueda"; no hay reparación maníaca en él, por lo menos aparente. La familia aglutinada y la uniformada, en realidad no son familias en sí

mismas, son estructuras compensatorias de una falla central. Si no hay pareja matrimonial, la venida de los hijos se hace fuera de lugar y el hijo jamás evocará *padres*; sino solamente padre o madre pero por separado. La pareja de los padres cuando es en sí crea un lugar mítico-simólico que no es de la madre, es de los dos. "Tomaréis del mismo vino; pero de una copa diferente" dice el poeta. Justamente este lugar es el espacio vacío que posibilita el cambio, pues transforma el conflicto en resolución, es orientador, tiene autoridad. El hijo como rol es posible entonces de esta manera, no es de ninguna parte, él participa en la vida de los dos sin dejar de ser él. Ese mismo poeta nos va a decir "los hijos no son nuestros, son de la vida". Actitud de desapego fundamental para reconocer lo personal en el otro. Esta familia careció, a nivel de existencia no de esencia, de esta estructura. Los hijos, para S. L., son cargas, son objetos, cosas, y los padres, para estos hijos, son objetos que exigen y que usan. Por eso la madre dice "me sacan todo", como diciendo que los hijos son algo tenido y que después se los sacan, no es algo que son y que no se puede sacar. Sin embargo la familia funcionó "juntos"; yo también me hago la pregunta, sobre los 17 años. La cohesión no tenía autoridad, no había algo superior que los uniera, que no es de nadie y por eso que es de todos; todo lo contrario: funcionaron encerrados, atemorizados por una realidad acusadora. Por eso vivían acusándose, llegando incluso a la pelea en el momento de ruptura de la aglutinación; cuando se rompió la cohesión por el miedo no se les ofreció una nueva cohesión. Esto plantearía un problema realmente técnico que después me gustaría discutir —es aquí donde podría hacer observaciones concretas al manejo de este paciente y de su familia. Entonces tenemos una familia aglutinada en vías de desintegrarse porque la madre perdió el poder de aglutinarlos. Era la amenaza que hacía estallar la verdad, que ya estalló y aparecen entonces los muertos. Entonces tratan de huir despavoridos por la culpa persecutoria; es que estaban todos complicados en lo más profundo. A partir de acá entraría ya en el material.

Dr. Alfredo Canevaro: Yo hice una configuración dinámica de este grupo familiar¹, vendría a ser un mapa inconsciente de la situación familiar. Yo veo así el material, lo divido en dos partes: el estudio del material histórico y la configuración del organigrama familiar, y el proceso terapéutico. Yo vería así dos familias aglutinadas, cohesivas, centrípetas, unidas por dos miembros borderline o prepsicóticos con deficientes identificaciones con su propio sexo. La búsqueda del cónyuge para resolver algo no resuelto en la propia familia original. La madre tiene que relacionarse en forma clandestina con el hombre padre-amante tratando de burlar el control materno. El padre Guillermo B, identificado con su madre y hermana busca un cónyuge fuerte "independiente" para salir de una atmósfera "asfixiante", el incesto, sin haber conseguido que su propio padre lo sacara. La búsqueda se realiza entonces con fuertes expectativas en ambos de un objeto idealizado que facilite la ruptura narcisista y la maduración personal no lograda. El matrimonio es tomado entonces como escape de una situación de encierro y como complemento patológico de la situación de cada grupo familiar original, más que como elección madura de objeto, la elección madura de objeto realizada previo desprendimiento



¹ Ver diagrama adjunto.

del grupo original de cada uno de los cónyuges. Frente a tanta carga, estos cónyuges fracasan sin conseguir a través del otro ese desprendimiento. A falta en cada uno de una buena relación con la pareja de padres en el registro de la identificación y de la relación objetal, fracasan. G.B., por deficiente relación con su propio padre, no se puede identificar positivamente con él y queda identificado en cierto sentido persecutoriamente con su madre y su hermana. La madre, Susana L., por deficiente relación con su padre, a quien prácticamente no conoció, se identifica con éste en los aspectos diríamos anecdóticos, hace una pseudoidentificación, por ejemplo, con las relaciones extramatrimoniales de éste y las repite en su propia vida familiar.

Cada cónyuge lleva entonces una carga narcisista, homosexual, muy intensa, que no puede ser resuelta en la pareja, se unen más por sus carencias que por sus logros y no pueden desprenderse mutuamente del encierro psicótico del que son portadores. A medias psicóticos, a medias sanos, transmiten a sus hijos modelos de identificación diversos; Marcos, por ejemplo, toma del padre el anhelo de ser como su propio padre, o sea su abuelo, su ideal del yo y, de alguna manera, se salva. Lidia toma de la madre los aspectos de identificación con la abuela trabajadora, con un área de realización personal aparentemente exitosa. Rafael, el único que lleva un nombre distinto, el representante de la exogamia anhelada, resume el fracaso de sus padres; es la identificación negativa, representa los aspectos ocultos de éstos; perversión o psicosis. Es una familia de mujeres, donde los hombres son zánganos que fracasan en su papel de objetos maduros, sólo alcanzan a proporcionar una transmisión aparente a otra generación, al servicio de una situación narcisista con gran temor a la relación objetal. Las grandes idealizaciones fracasan, "el vuelo de perdiz" provoca un retorno de ambos cónyuges a su familia original. En realidad podríamos decir que Susana nunca salió. Pero de cualquier manera, simbólicamente retorna cada uno a su familia original. El tratamiento se presenta como la posibilidad de ruptura de ese quiste, siempre y cuando él o los terapeutas sean suficientemente fuertes como para tolerar ese gran impacto transferencial, donde van a ser tremendamente idealizados y anhelados, a la vez que fuertemente rechazados y denigrados, que es lo que se verá más tarde

en el proceso terapéutico. Yo diría que el proceso terapéutico es un tratamiento con mal pronóstico, en el sentido de la falta de una apoyatura estable para encauzarlo. No hay que sorprenderse de que esto pase con las familias de psicóticos, pero esta familia está especialmente mal constituida, inmadura, improvisada, no nos olvidemos de las características de ambos abuelos maternos: viajeros, viajeros. Al contrario de la familia paterna que es más sedentaria, la familia materna está caracterizada por la inestabilidad, el contrabando. Es un grupo con grandes tendencias a la actuación, cosa que tampoco nos tiene que sorprender, pero que da un carácter especial al tratamiento. Es el tipo de familia que muchos terapeutas no tomarían por la dificultad de establecer un contrato terapéutico. Yo creo que la indicación correcta para su tratamiento es el grupo familiar múltiple o grupo multifamiliar, que brindaría un contexto emocional de mayor seguridad psicológica, tanto para los integrantes como para los terapeutas. La indicación de una terapia de grupo familiar nuclear como vemos en este fragmento de sesión nos muestra un grupo de pares, por así decir, una madre que no puede asumir su rol, desvalorizada por sí misma y por sus hijos, que sólo ve como destino posible cuidar un hijo enfermo, como ella lo dice, a su igual, a su fracaso de ella como hombre anhelado y como persona. El muchacho parece ser bien inteligente, debe percibir esto, sin poder salir de esta trampa, pues debe percibir también que dejar sola a esa madre puede llevarla al suicidio. Yo creo que ese es el dilema mayor de este muchacho y su mayor sometimiento también —no ser para que la madre pueda existir. Este tipo de simbiosis con un fondo tan doloroso sólo puede ser resuelto, a mi juicio, en este caso, si los hijos, superada la fase de resentimiento contra esta madre-hermana, pueden ayudarla a desprenderse de sus sometimientos internos y externos y acompañarla en la larga depresión a que esto puede llevarla, para entonces organizarse mejor como grupo familiar y quizá que la madre pueda formar una mejor pareja, más estable. Como se ve es una tarea titánica y pienso que podría lograrse mucho mejor con la ayuda de otras familias mejor constituidas, con mayor experiencia terapéutica y que brinden modelos de identificación más saludables o, por lo menos existentes para este grupo humano.

Lic. Nocetti: Lo que tendría para preguntar parte de una distinta concepción que me parece tenemos acerca de cuál es el objetivo. Qué buscaría poner de manifiesto para que esta familia pudiera resolver su problema. Cuando los escuché a ustedes me parecía que estaban demasiados pegados a las personas y es que más bien yo apuntaría a las reglas, cosa que ellos no tienen más remedio que cumplir en la medida en que cada acción de ellos lo que hace es recrear las condiciones para reproducir estas reglas. Me da la impresión de que quedarse demasiados pegados a las personas nos conduce a un camino que permite mucha mayor comprensión individual, pero poca comprensión del sistema, porque tenemos muchas hipótesis de tipo psicoanalítico para entender lo que le pasa a cada uno pero carecemos de hipótesis más globales para comprender a la familia totalmente. Con respecto a lo que vos decías, Alfredo, que los hijos comprendan este papel de la madre, yo apuntaría a que todos fueran capaces de comprender las reglas que organizan el sistema de relaciones y las regulaciones que se requieren para que ese sistema se mantenga. Hace por lo menos 17 años que están juntos. ¿Cómo están juntos? Aparentemente se pelean, se llevan mal. Pero eso es lo manifiesto; en realidad esta organización es muy fuerte, muy estable, los mecanismos de regulación que los mantienen deben ser terriblemente rígidos y la menor desviación debe ser vivida como sumo peligro; justamente cuanto más rígida es la regulación más cerca de la disolución está el sistema; por eso los mecanismos se hacen cada vez más rígidos. Ninguno es responsable de esto, ninguno de ellos personalmente, y yo pensaría que no pasa simplemente por las dificultades personales; más bien las dificultades personales son un efecto de este sistema de relación. Es como si pensáramos una cosa distinta en cuanto al objetivo terapéutico y en cuanto a qué cosas habría que poner de manifiesto. Yo más bien los pienso a ellos como mensajeros que ponen de manifiesto algún aspecto que yo tengo que descubrir de una estructura oculta, estructura en el sentido formal y abstracto del término.

Dr. Canevaro: Yo creo que lo que vos planteás es un problema importante porque ¿cuál es la gran dificultad para el tratamien-

to de grupos familiares y de grupos familiares de psicóticos? Yo creo que la gran dificultad es el compromiso emocional, es decir, yo creo que el enfoque tuyo es importante, inteligente, pero lo veo más centrado en el estudio de un sistema familiar, con la falta de compromiso emocional que es algo así como en este caso repetir un rol pasivo que el padre cumplió, que los hombres cumplieron en esta familia. Creo que lo difícil de este caso, ya particularizando, es aceptar el desafío de un compromiso emocional que yo no diría que esté signado por el fracaso posible, sino que es tremendamente difícil, porque el terapeuta o los terapeutas, como dije antes, deberían tolerar primero un impacto transferencial caracterizado, creo yo, por una intensa carga de resentimiento y de envidia por quien pueda ocupar un rol que no ocupó nunca nadie en varias generaciones en esa familia. Quiero decir que al terapeuta que se arrogue ese rol yo le recomendaría que no trabajara aislado porque probablemente sería a costa de un gran esfuerzo, con un costo emocional muy intenso, aunque pudiera llegar a ser exitoso. Segundo, tendría que ser una persona con una capacidad de tolerancia y de "resignación" terapéutica muy grande, porque probablemente esta familia pueda modificarse, pero muy difícilmente se lo puedan reconocer al terapeuta. Probablemente realicen un proceso muy difícil, muy complejo, muy exigente, rompan el trabajo terapéutico y después de un tiempo vayan haciendo cambios algo así como fuera de la presencia del terapeuta. Entonces yo recomiendo un grupo familiar múltiple no sólo para ayudarlos a ellos sino también para el terapeuta, para poder ofrecerles quizás un modelo de convivencia más saludable que ese modelo exogámico de intenso resentimiento con un ataque que encubre el terror pero de cualquier manera ataque al fin, dirigido al que de afuera pretende romper una tradición, pretende como enfrentarse con esos fantasmas que pueblan esta sesión terapéutica. Esos fantasmas son por suerte reales, o sea, uno podría convocarlos, la abuela, la tía, pero en este caso yo no lo aconsejaría por temor al borramiento de la figura de Susana Lidia. Yo creo que ella debe ser enfatizada, no como culpable, como quizás se entendió mal, pues yo creo que nadie es culpable de nada; a lo sumo cada uno será responsable de su propia persona o del rol que tiene que ejercer. Yo tácticamente insis-

tiría en abordar o en enfocar el problema con Susana Lidia quizá para neutralizar su actuación probablemente desorganizada, psicopática, pero que contribuye al encierro psicótico de Rafael. Descentraría el enfoque sobre Rafael, para centrarlo en la madre y la ayudaría a que ella pudiera elaborar esa especie de fracaso como hombre anhelado en el sentido del salvador de la familia. Evidentemente alguien tiene que salvar a esa familia. Marcos no pudo, y se salvó a medias del fracaso, eludiendo la responsabilidad hábilmente aun siendo hermano mayor y Rafael sucumbe, aunque yo diría que mostrando una inteligencia muy grande. Es como si no tuviera recursos emocionales, y yo como terapeuta, le prestaría el cuerpo, por así decir.

Lic. Nocetti: Marcos y Lidia tenían un padre, hasta ese momento la familia contaba con un padre, después de Rafael el padre desaparece. Por las hipótesis que estamos manejando acerca de la presencia del padre, Rafael no contó con esa presencia.

Dr. Canevaro: Aunque evidentemente la presencia ausente del padre diría yo debe haber sido tan lamentable que quizás la ausencia real facilite el proceso de elaboración de este duelo. Yo creo que es mucho más difícil elaborar el duelo frente a la presencia ausente de un padre que frente a la ausencia real.

Lic. Nocetti: Yo lo pensaba en términos de algo que ustedes dijeron y yo también pensaba en la idealización; justamente la ausencia permite la idealización y aparece claro en la sesión.

Dr. Canevaro: Sin duda. Pero yo creo que el terapeuta debe asumir este compromiso, es una especie de desafío, de reto, lo debe asumir sabiendo los riesgos que corre porque si no este tipo de familia no puede modificarse nunca.

Dr. Fernández Mouján: Yo haría un aporte; yo pienso que lo que planteaba Nocetti recién, marca tres posibilidades de enfoque. Yo no me sentí muy comprendido. Estoy en desacuerdo con que en esta familia hay que tomar cierta distancia, vos (a Nocetti) to-

más distancia desde el sistema de reglas culturales, hacés un análisis digamos más a través de una búsqueda de reglas que puede hacernos entender esta familia; el otro problema es que yo tampoco me entraría a meter solamente en lo que podríamos llamar habitualmente el campo de las identificaciones, es decir ligarnos demasiado a los individuos en este caso. Lo que me parece a mí fundamental para realmente meterse y estar con ellos y dentro de las experiencias de ellos y no quedarnos, ni correr el riesgo de estar afuera, es a través de poder captar cuál es la estructura subyacente, porque yo no creo que se hayan mantenido juntos 17 años, sin que haya habido alguna estructura que los mantuviera unidos (no sólo juntados). Y yo estoy en la búsqueda de esa estructura, por eso digo que no me sentí comprendido porque yo estoy en la búsqueda de esa estructura pero no quizá desde la estructura cultural, no quizá desde una regla que viene desde afuera sino que me voy a poner en la búsqueda de una regla que viene desde adentro de esta familia, una estructura mítica que esta familia viene heredando y de la cual nadie puede salir y cuya portadora es la madre, evidentemente, en esta casa. Acá podría tomar cualquiera de estos caminos pero elijo aquél con el que mejor me manejo, por eso voy a leer ahora cómo interpretaría este material, queriendo captar el campo imaginario estructurado, o sea el mítico. Quiero decir ahora que evidentemente no me estoy ligando a los individuos, al contrario estoy buscando esa subestructura que va a la persona justamente y que es lo que podría sacarlos a ellos de un conflicto que así, de esta manera, es insoluble o solamente con la actuación.

Ahora propondría lo que quiero decir con esto, ya en concreto, porque si no esto sería una cosa más o menos teórica. Para mí se pelean y acusan entre ellos tratando de poner afuera el perseguidor, que es interno. Lidia asume el rol maníaco de reparación, por un lado de Rafael, que asume por otra parte el rol de víctima identificado con el muerto: "me quise matar cuando Lidia se fue". La verdad es que cuando el padre murió se quiso matar y buscó en Lidia su salvadora; esto es muy frecuente en los intentos de suicidio. Quiero aclarar que para mí este intento de suicidio es totalmente benigno, es fundamentalmente simbólico: busca un salvador. Cuando el intento de suicidio es benigno lo que busca

es un salvador maníaco que generalmente aparece en los intentos de suicidio benignos. Aquí era Lidia y cuando Lidia se puso de novia y se fue de la casa, Rafael vuelve otra vez a caer. Sólo Marcos dice "cuando pueda". Uno se pregunta ¿podrá? de todas maneras es el único que se plantea una solución diferente.

¿Cómo intervendría yo en esta sesión? Ante semejante caos, por otro lado común en las familias aglutinadas, que por algo se llaman también epileptoides, no podemos pensar en una intervención impecable desde el punto de vista de "la lectura del material". Aquí tenemos que intervenir totalmente, sin una disociación instrumental o sea no sólo con "atención flotante" sino que la participación del terapeuta en el grupo tiene que ser mucho más abierta que lo común. Estar afuera de una experiencia en crisis es tan negativo como estar totalmente adentro. Este es el riesgo de tratar familias aglutinadas: cómo mantenemos el equilibrio entre meternos totalmente adentro o quedarnos afuera, que es el peligro que a veces se corre con este tipo de familias. Yo me imaginé, leyendo el material, que había algo que los unía, volviendo a los 17 años, que me pareció una observación realmente muy atinada, y que no sólo los juntaba sino que en el fondo los unía. Intentaría hacer ahora una especie de interpretación "extensa", que el terapeuta que conoce la familia de esto podría sacar una síntesis de mi interpretación que yo jamás haría fuera del contexto. Cuando empiezan las peleas la madre dice "me sacan todo". No. Todos se han quedado sin lo anterior; por eso están en plena crisis, hay miedo en todos y subrayo *todos*. Antes había una reina y zánganos que vivían en un panal para sobrevivir. Roto el panal; hay que construir una familia con una estructura más humana. Todos buscan, incluso yo terapeuta, un rey organizador de este caos que está dentro del grupo y no afuera, que tenemos que buscarlo desde dentro, no en reglas que vengan desde afuera. La culpa nos divide en partes pero también la culpa es lo que tenemos de más común; es de todos porque nadie realmente la posee totalmente, es justamente eso que es de todos porque no es de nadie, todos la tienen. Sólo si nos unimos enfrentaremos el miedo a la culpa. Si nos quedamos solos, como están, no tendrán más remedio que disparar o buscar en otro la culpa intolerable en uno, o repetir la historia como yo pienso que

va a hacer Lidia. Todos fueron víctimas y victimarios, insisto en la palabra todos, "todos estamos aquí para reencontrarnos de alguna manera, si no no estaríamos aquí". Si nos detenemos, lo que he propuesto es una estructura con autoridad, o sea una estructura que oriente, es lo que estoy proponiendo en toda esta especie de interpretación extensa hipotética. Una especie de estructura con autoridad que esté por encima, no entre los conflictos, por eso es que saldría del campo de las identificaciones, creo que aquí es poder encontrar fuera de los conflictos esta estructura; en esta familia es encontrar la familia en sí y creo que ello es lo que en el fondo estamos buscando. Lo que estoy proponiendo acá es poder buscar esa estructura subyacente que me hace suponer la duración de esta familia y con esto me largaría a buscar una interpretación. Esto sería lo que yo propondría al terapeuta para que lo piense y que lo instrumente en una interpretación posible.

Lic. Nocetti: A mí me parece que todo esto es importante y estoy de acuerdo en el sentido de que el factor emocional va a contar y muchísimo. Estaba haciendo una lectura *a posteriori* de un material y tratando de entenderlo, faltaba referirse ahora a la sesión en sí. Lo que vos apúntabas (a Canevaro) me parece que es una inteligente formulación del concepto de transferencia; lo que ellos van a hacer es reproducir con el terapeuta ese sistema de relaciones y él no va a tener más remedio que vivenciar y sufrir emotivamente lo que ellos sufren en ese tipo de relación, con esa capacidad del terapeuta que vos señalabas de tomar distancia y poder observar y pensar. Pero el factor emocional de frustración, de constante amenaza a la estabilidad del tratamiento, eso lo va a tener que soportar también al terapeuta. En la medida que lo soporte va a poder entenderlos y ayudarlos, yo estoy de acuerdo, no me refería a dejar excluido el factor emocional. Estaba haciendo una lectura *a posteriori* del material.

Quisiera decir algo con respecto a la sesión. A mí la interpretación de T. me pareció una excelente síntesis, de lo que a ellos realmente les pasa; pero ellos no escuchan esa interpretación. Me parece que el problema con esta familia pasa por crear una oreja que escuche. Un diálogo analítico no es lo mismo que un diálogo en la casa. Un terapeuta habla y se dirige a un refe-

rente que es distinto del referente de un diálogo habitual, pero ellos no conocen ese modo de comprender un diálogo. Yo haría pasar casi todo el primer tiempo del tratamiento y casi todo el tratamiento en que ellos puedan comprender qué quiero decir cuando hablo, cómo uso, cómo me inscribo en un sistema de comunicación donde mi palabra es una información, no una inducción; para ellos las palabras son inducciones, y me atribuyen a mí la misma capacidad. Por eso creo que formularse una idea *a priori* de cómo ellos tendrían que resolver las cosas es meter en mis interpretaciones una inducción. Yo no sé cómo ellos van a resolver las situaciones; lo único que puedo saber es: si les digo cómo están organizados, cuáles son las reglas que organizan este sistema y en las cuales ellos están entrampados y no van a poder salir, ese conocimiento va a permitir que se organicen de otra manera. Eso depende de ellos.

Dr. Fernández Mouján: Fijate, yo te contestaría una cosa. Esa interpretación es impecable porque es una lectura impecable del material y justamente por eso es que no la escuchan. Ellos no están buscando una lectura impecable del material; eso lo estamos buscando nosotros. Lo que ellos están buscando en ese momento es alguien que se meta con ellos en el caos en que están viviendo y en el terror que están viviendo, justamente para que ese terror se distribuya, no en uno ni en dos, que es lo que cada uno de ellos cree sobre el culpable. Por eso se pasan la culpa sin que uno pueda rescatar lo que es de todos para aliviar, y desde ese "todos" se van a reencontrar. Pues a partir de ese todos (y que realmente no es de nadie, el "en sí" de la familia) surgirá la estructura que, pienso, los rescatará. Esa interpretación, es cierto, es impecable, pero por ser impecable no participa de la vivencia de caos, de culpa, de persecución, que en ese momento ellos están compartiendo, que es a lo que en este momento ellos están buscando alivio o si no, evidentemente, la única salida que tienen es la actuación.

Lic. Nocetti: ¿No te parece que si el terapeuta pudo hacer esa interpretación es porque se metió en la situación y les muestra que él puede meterse pero pensar, además?

Dr. Fernández Mouján: No del todo. Pienso que está demasiado disociado. Nos pasa muy frecuentemente esto, no es la posición del terapeuta. Muy frecuentemente, con material tan ansioso nos metemos pero demasiado disociadamente, entonces, cuando metemos la palabra, la palabra está muy lejos, por eso yo prefiero hablar, meterme en el campo imaginario de la sesión; entonces, si me meto en el campo imaginario desde los últimos sentimientos que tengo en la punta de mi pie hasta mi última abstracción están unidas. Eso es una estructura mítica, eso es el símbolo vivo, es desde ahí que pongo la palabra. Esto es lo que yo tiendo a buscar en una familia que funciona así, si no ¿quién los une acá? una formulación racional del terapeuta, solamente lo imaginario compartido une. A eso le pongo palabras.

Dr. Canevaro: Así es, ellos tienen el peligro, está implícito en la misma sesión, dice en un momento Rafael: "es el cambio del feudalismo a la monarquía sin poder real". Ya está anunciando al terapeuta que va a estar, por así decirlo, descalificado. Previo a la interpretación, fíjense en la primera página, cuando Susana dice "me sacan todo, se derrumba la familia", Rafael le dice "es el cambio del feudalismo a la monarquía sin poder real". Entonces yo propongo estratégicamente en un primer paso volver al feudalismo, en este caso centrado alrededor de la figura de hombre-padre, señor feudal, que pueda tolerar todos los ataques que Susana va a transmitir. Aunque yo a ella personalmente no la imagino como una persona consistente, sino una cáscara hueca, una pseudoidentificación condensadora de todas las mujeres de su familia, sin embargo creo que ella va a transmitir una serie de ataques; por eso insisto en la importancia del compromiso personal, estoy de acuerdo con Octavio, porque si no el riesgo posterior es quedar como una monarquía, ir de lo más primitivo a lo más elaborado. De la idealización a la desidealización del terapeuta, para suplir una carencia de este grupo familiar.

Dr. Fernández Mouján: Sí, o lo que vos decís de la multifamilia a mí no se me había ocurrido pero puede ser un enfoque interesante. A mí se me había ocurrido también como salida, si esta línea que propongo no tuviera resultado, la terapia vincular,

dado que acá los personajes del drama central son la madre y Rafael, hacer una terapia vincular, o sea buscar esa estructura mítica fundamental que los unió siempre, no que los juntó, pues pienso que es esto lo que nunca conocieron. Por algo el padre es el ausente siempre, por algo el padre es la imagen de "lo ausente", por eso el padre une como símbolo porque justamente está ausente, entonces es de todos y nadie lo puede agarrar. Ese justamente es el significado de la estructura simbólica. Si no diera resultado esto que propongo, este enfoque de interpretación, me parece que lo que dice Alfredo puede ser interesante, lo de la multifamilia; también por ahí se podría intentar con la terapia vincular madre-hijo dado que son los personajes fundamentales de este drama. Y evitaría las actuaciones.

Dr. Canevaro: Un problema técnico importante. Por ejemplo con multifamilias o en coterapia, para un terapeuta sería mucho más fácil poder salir de este campo tan intenso transferencial-contratransferencial si su coterapeuta, de alguna manera un poco más disociado emocionalmente consigue rescatarlo, eso podría ser un tipo de intervención; y mejor todavía que algunos de los integrantes de otras familias, otros padres por ejemplo, puedan servir de objetos transicionales para que el poder mortífero, por así decirlo, de ese impacto transferencial, se diluya un poco y el terapeuta quede más libre para poder trabajar interpretativamente con eso. De cualquier manera yo no evitaría el problema de las contraactuación terapéutica, por así decirlo, porque creo que solamente a partir de ese acercamiento, como bien decía antes, a partir de prestarle, de prestarles el cuerpo es como uno podría llegar al símbolo, llegar a la mente, pasando primero por todo lo que está tan intensamente condensado, todo lo que pasa, la culpa, el parricidio, el incesto...

Dr. Fernández Mouján: Si el incesto, la exogamia, todos esos dramas están, yo estoy muy de acuerdo contigo, ojo, ese nivel cultural yo te lo acepto plenamente, el asunto es cómo lo instrumentamos.

Lic. Nocetti: Es que me parece que la diferencia básica está cuando vos hablás de mito familiar, tal mito yo considero que es

una organización social, una organización que pone de manifiesto una estructura lógica, que es la que determina el modo de funcionamiento de todos ellos. Separarlos, tomar a la madre y al hijo como núcleo del asunto, me parece que es de nuevo quedarse pegado a las personas y perder de vista esta otra estructura que todos ellos en conjunto son los que la ponen de manifiesto, los que la realizan. Esta es una diferencia básica.

Dr. Fernández Mouján: Sí. Para mí el mito es una estructura simbólica y no social. Dejamos como para completar un poco la cosa que esto va a plantear una discusión larguísima porque mi concepto de mito es totalmente al revés. Para mí el mito es un "símbolo vivo", no una estructura social. Por considerar el mito una estructura social es que muchas veces se lo toma peyorativamente, "hay que desmitificarse". Pero si lo tomamos como una estructura fundamental la frase cambiaría: 'hay que buscar los mitos que nos estructuren y orienten'.

A manera de síntesis

STELLA MARIS MOLINA y RAFAEL SKIADARESSIS

En este encuentro que presenciamos nos fue delegado elaborar un resumen de las ideas expuestas, pero pensamos que además de reescribir los posturas de los participantes podíamos intentar una visión integrada a manera de síntesis.

TIEMPO DE LA TEORIA

J. C. Nocetti aborda el estudio del sistema de organización familiar desde un enfoque estructuralista, basándose en el sistema de parentesco y el universo de reglas. Desde el punto de vista diacrónico define el caso presente como un sistema de organización matrilineal con un universo de significaciones propio donde los varones, meros procreadores, no cumplen con su función (paterna). En lo que hace a esta función, la matrilinealidad obstaculiza la constitución del superyó y el ideal del yo, que sabemos por Freud común a toda familia.

O. Fernández Mouján, dentro del análisis de la familia nuclear,

intenta captar la estructura que los une para llegar a la estructura mítica latente. En esta familia aglutinada, que contrapone a las uniformadas, la mentira cumple la función de unir y la verdad provoca el derrumbe del sistema matriarcal y pone de manifiesto el parricidio y la culpa persecutoria; de la cual todos son cómplices y a la que todos escapan.

Ambos coinciden en cuanto a descubrir una estructura mítica, aunque difieren con respecto al concepto de mito. Consecuentemente, también están de acuerdo en no quedarse en el nivel de los individuos, más cercano al análisis de las identificaciones.

A. Canevaro considera esta familia como del tipo cohesivo y encara el significado de la unión conyugal de los padres y el problema de una exogamia mal resuelta. El paciente designado resulta ser un síntoma de la exogamia anhelada y fallida. Luego analiza la línea de identificaciones en tres niveles generacionales, hipótesis de trabajo planteada por L. Hill y M. Bowen.

TIEMPO DE LA TECNICA

En cuanto al abordaje sincrónico de esta familia, J. C. Nocetti propone que el diálogo terapéutico tenga como objetivo crear una "oreja" que escuche para que la familia reciba información (y no inducción), que les permita comprender las reglas que organizan el sistema y cómo se mantienen en la búsqueda de una resignificación que implique una modificación estructural.

O. Fernández Mouján hace hincapié en el compromiso emocional, pero en la medida adecuada para no quedar atrapado en el análisis de los individuos ni disociado de éstos. Indica inicialmente la terapia de la familia nuclear y, como alternativa, la terapia vincular madre-hijo. Aunque considera también interesante la posibilidad de la terapia multifamiliar.

A. Canevaro acentúa la necesidad del compromiso emocional "prestando el cuerpo" del terapeuta al paciente carente de recursos emocionales e indica la coterapia o la terapia multifamiliar, debido al mal pronóstico de la familia en cuestión por la probabilidad de que ataquen con resentimiento y envidia a quien por su lugar (terapeuta) represente el lugar del que carece esta estructura familiar.

MOMENTO DE CONCLUIR

En un transcurrir progresivo de lo más general a lo particular, desde la propuesta de Nocetti de descubrir las reglas, pasando por la de Fernández Mouján de descubrir el parricidio y llegando a la de Canevaro, que intenta deslindar las consecuencias del drama en el análisis de las identificaciones terapéuticas, todos vuelven al punto de partida, que es la comprensión de esta familia con respecto a otras en la búsqueda de la ley del Padre.

El momento de concluir esta mesa redonda, en tanto encuentro real, nos reenvía a otra dimensión: la del tiempo para comprender, que todavía no ha concluido porque subsiste la necesidad de la constitución de un cuerpo de doctrina en el campo de la Terapia Familiar.

Libros

PASOS HACIA UNA ECOLOGIA DE LA MENTE GREGORY BATESON

Ediciones Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1976

Cómo pensar acerca del pensamiento

"...es necesario modificar nuestros enfoques sobre el pensamiento y los mecanismos del proceso del pensar, es probable que esta modificación, si es tan importante como yo lo creo, exija la modificación también de la forma en que producimos 'pensamientos' y los métodos que empleamos al usarlos."

W. R. BION, *Aprendiendo de la experiencia*

Hay exploradores del pensamiento que se internan, solitarios, en la maleza de los interrogantes sin respuesta y nos señalan, de improviso, nuevos senderos en la selva del conocimiento. Abren picadas que luego

otros explorarán con mayor detenimiento. Sus obras, por pioneras, distan de la perfección y la elegancia que puede esperarse de una producción científica acabada, no carecen de callejones sin salida ni de incer-

tidumbres, pero algunas de sus ideas brillan por derecho propio, en general logran cambiar la perspectiva intelectual imperante, proponen una manera diferente de pensar los viejos problemas, ponen sobre el tapete otros que no habían sido percibidos.

Los hay que, desde esta nueva perspectiva, consiguen reunir esas ideas dispersas y alcanzar una síntesis mental. Desde ella puede percibirse que aquellos exploradores solitarios no navegaban a la deriva, que construían, generalmente sin saberlo claramente, partes de un mismo edificio. Bajo una óptica integradora aparecen las conexiones entre los distintos descubrimientos, se desarrollan así sus consecuencias y esta visión integradora logra a veces guiar a generaciones de científicos.

Arthur Koestler describe, en una historia maravillosa, llena de encanto y sorpresas, esta situación (*Los sonámbulos*, EUDEBA, 1963). Compara la aventura intelectual de la Grecia del siglo VI precristiano con una orquesta (Tales de Mileto que creó la geometría abstracta, Anaximandro que presenta el primer modelo mecánico del universo y otros que colaboraron en la quiebra de la tradición mitológica) donde cada músico estaba absorto en la afinación de su instrumento... "De pronto se produce un silencio. El Director entra en escena, golpea tres veces con su batuta y la armonía surge del caos" (pág. 25). Este Director fue, alrededor del 530 a.C., Pitágoras, cuya obra sigue marcando el destino de la ciencia en nuestros días.

En el siglo XVII la situación vuelve a repetirse. Copérnico arroja la

primera piedra contundente al dogma geocéntrico, Kepler formula, con la colaboración de Tico de Brahe, las leyes de los movimientos planetarios y Galileo sienta las bases de la *nueva ciencia*. El Director que unió los miembros de esta orquesta y creó una nueva armonía de las confusas disonancias fue, en esta ocasión, Isaac Newton. Concibió una síntesis monumental conciliando las arriesgadas ideas de sus predecesores, que sembraron el fértil camino, en una obra que por su rigor y sistematicidad orientó la visión del mundo durante más de dos siglos.

El cuadro que traza Koestler finaliza con esta apreciación: "Las dos ramas más importantes de la física moderna, la teoría de la relatividad y la mecánica de los cuantos, no se han integrado hasta ahora en una nueva síntesis universal... Mientras no aparezca un nuevo maestro... el modelo del universo seguirá siendo esencialmente el que trazó Newton..." (pág. 486).

Quizás estas divisiones en la historia de la Ciencia no sean todo lo exactas que pudiera esperarse, pero nos ayudarán a ubicar el pensamiento de Bateson en el panorama científico contemporáneo.

Bateson es uno de esos buceadores solitarios. Consciente de la necesidad de una nueva síntesis, enfoca su mira y dirige sus "pasos" hacia ese objetivo. Sus trabajos constituyen mojones en el camino hacia una nueva manera de pensar.

Señala Carlos Astrada en 1933 con respecto a la crisis sufrida por la Ciencia a partir de la última década del siglo XIX: "Hoy se trata, como diría

Nietzsche, de colocar a la ciencia bajo la óptica de la vida, de aproximarla a la existencia humana —su fuente— para ponerla en función de ésta" (*El juego existencial*, Bs. As. 1933, pág. 41).

Colocar a la Ciencia en función de la vida, producir el modelo de pensamiento que contenga en sí la posibilidad de predecir y controlar el potencial irreversible de destrucción que soporta inevitablemente el desarrollo científico y tecnológico de nuestro siglo es el *leit motiv* de la obra que comentaremos: *Pasos hacia una ecología de la mente* (Ediciones Carlos Lohlé, Bs. As., 1976).

Bateson propone una nueva manera de pensar que denomina "ecología de la mente" o "ecología de las ideas". Sus trabajos constituyen "pasos" hacia una disciplina que, si bien no existe aún como cuerpo orgánico de teorías, apunta a despejar el camino para dar una respuesta con sentido a la crisis contemporánea en lo que hace a la relación del ser humano con su ambiente. Piensa también como Von Bertalanffy que "...la cuestión de qué rumbo tomará la concepción científica del mundo es, a la vez la cuestión del destino de la humanidad". (*Teoría general de los sistemas*, Fondo de Cultura Económica, Bs. As., 1976.)

Confiesa que es hacia fines de 1969 cuando toma conciencia plena de lo que había estado tratando de hacer hasta ese momento. De la finalidad y unidad de una actividad científica polifacética e ininterrumpida desde 1926. Estudios sobre la simetría biológica, la cultura de los pueblos primitivos, la patología de las relaciones, las

falacias epistemológicas, los errores geopolíticos, se suceden en este tomo dejando traslucir un punto de vista común, un modo de pensamiento que va tomando forma en la mente del lector a medida que avanza en su lectura.

Arremete contra ciertos hábitos de la reflexión, contra quienes han sido "adiestrados para pensar y argumentar *Inductivamente*, desde los datos hacia las hipótesis, pero nunca lo fueron para verificar las hipótesis contrastándolas con el conocimiento derivado mediante la *deducción* a partir de los elementos fundamentales de la ciencia o la filosofía" (págs. 17/18).

Es necesario revisar esos elementos básicos y definir un conjunto de ideas que permita contrastar con ellas las hipótesis heurísticas orientadoras de nuestros desarrollos teóricos.

Pero, ¿cuál es ese conjunto de ideas fundamentales y dónde buscarlo?

Al igual que ese otro gran explorador de nuestro siglo —Lévi-Strauss— Bateson se dirige a los mitos primitivos. En los productos del "pensamiento salvaje", en esa "ciencia de lo concreto", que diez mil años antes de la aparición de lo que la civilización occidental llamo Ciencia, proponía modos de observación y de reflexión que constituyen aún su substrato. En esos sistemas de clasificación que, transformando el caos en orden, obraban como mediadores en la relación del hombre con la naturaleza. Es que... "esta exigencia de orden se encuentra en la base del pensamiento que llamamos primitivo, pero sólo en

cuanto se lo encuentra en la base de todo pensamiento..." (*El pensamiento salvaje*, Fondo de Cultura Económica, México, 1964, pág. 25).

Es así como Bateson encuentra en los primeros versículos del Génesis y en el mito de los orígenes entre los latmules de Nueva Guinea, no una descripción acerca del origen de las cosas, sino un intento de clasificación, de discriminación y de orden, un esfuerzo que culmina en la nominación.

Son éstos los elementos fundamentales de la ciencia. A través de un texto que compila, en más de 500 páginas, una serie de trabajos realizados a lo largo de medio siglo de esfuerzo intelectual (1926/1971), Bateson se propone "levantar un puente entre los hechos de la vida y de la conducta y lo que hoy sabemos sobre la naturaleza de los patrones y del orden" (página 25).

El aliento editorial que entraña la publicación de esta compilación no es desdeñable. Buena parte de su producción había ido apareciendo en revistas o *readings*, a veces de escasa tirada y, por lo tanto, de difícil localización, algunos trabajos nunca fueron publicados, otros no habían sido vertidos al castellano. Algunos de sus libros (como *Naven*) se agotaron y durante años no volvieron a reeditarse. La reunión de esta serie de artículos, algunos de ellos no traducidos hasta el momento, permiten contar con una visión más global de su obra y reconocer de esta manera el espíritu que fue guiando su vasta producción.

Atentaba también, sin duda, contra esta posibilidad, el hecho de que

sus publicaciones siguieron las vicisitudes de sus peregrinaciones en busca de subsidios para sus insaciables búsquedas: antropólogo de campo, primero, entre los baining de Nueva Bretaña; miembro, luego, del Saint John's College de Cambridge; investigador en Bali y Nueva Guinea (junto a Margaret Mead, su primera esposa); colaborador de Jurgen Ruesch en la Clínica Langley Porter, *lecturer* en Antropología Médica en la Escuela de Medicina de la Universidad de California; "etnólogo" en el Hospital de la Administración de Veteranos de Palo Alto; investigador (entre 1949 y 1962) en el Mental Research Institute de Palo Alto; codirector del Communication Research Institute en las Islas Vírgenes y, finalmente, desde 1963, en la Fundación Oceánica de Hawaii y en el Instituto de Aprendizaje de la Cultura del Centro Este-Oeste de la Universidad de Hawaii.

En este largo y accidentado trayecto recibió subsidios de distintas fundaciones y concibió muchos de los artículos incluidos en este volumen. La diversidad de campos y de temas que abarca hace difícil un comentario profundo de cada uno de ellos. Preferiría hacer una recorrida por las seis secciones en que ha sido dividido. Ello permitirá ofrecer al lector interesado una idea de cuáles son los límites de este nuevo territorio científico que Bateson intenta poner en descubierto y cuáles los modelos teóricos que guían sus "exploraciones".

Cada una de las sesiones agrupa, en orden cronológico, trabajos de un mismo contenido temático. Luego de una breve introducción, la primera parte incluye siete de sus "metálogos"

(seis de ellos ya habían sido publicados aquí).

Indudablemente cada uno de ellos merecería un comentario profundo. Su originalidad radica en el intento —no siempre logrado— de articular la estructura de un diálogo, entre padre e hija, con la naturaleza del tema que lo provoca. Así, la organización formal del primero de ellos —"Por qué se revuelven las cosas"— y los efectos entrópicos, que es su tema dominante, aunque no explícito, logran constituir dos planos que se implican mutuamente. ¿Cómo referirse a las consecuencias comunicacionales del segundo principio de la termodinámica sin reproducir un diálogo cuya estructura se vea enfrentada con la amenaza de desorganización? Este metálogo logra transmitir, por su forma y por su contenido, esta dificultad.

De la misma manera en los sucesivos va encarando problemas vinculados con los "juegos sin fin", la comunicación analógica, los hábitos del pensamiento, las categorías del conocimiento, las relaciones entre el orden real, el orden lógico y el lenguaje; la participación de la metáfora en la producción de enunciados pertenecientes al campo de la ciencia, la religión y el arte; los niveles de comunicación, la función de los modelos científicos, etcétera. En todos ellos la estructura y el tema forman por momentos un curioso entrecruzamiento. Estos metálogos constituyen una adecuada introducción al estilo y al modo de reflexión de su autor, sus contenidos serán encarados, desde distintas perspectivas, a lo largo de la obra. Una lectura posterior permitirá al lector "saborar" mejor la riqueza de sus sugerencias

y la ingeniosidad puesta de manifiesto en la resolución de los problemas que tal transcripción plantea.

La segunda parte incluye sus artículos antropológicos. En su comentario final sobre esta sección se refiere a la labor científica interdisciplinaria. Me gustaría citarlo *in extenso*, porque ello permitirá trazar las coordenadas que orientan su pensamiento y vislumbrar, al mismo tiempo, quiénes pueden ser sus "compañeros de viaje".

"El hombre que estudia la disposición de las hojas y ramas cuando crece una planta en flor puede observar una analogía formal entre las relaciones formales que existen entre diferentes clases gramaticales de palabras que integran una oración. Pensará en una hoja no como algo plano y verde sino como algo relacionado de alguna manera particular con el tallo del cual crece y con el tallo secundario (brite) que se forma en el ángulo que cae entre la hoja y el tallo primario. De manera similar, el lingüista moderno piensa en un 'nombre' no como el 'nombre de una persona, lugar o cosa', sino como miembro de una clase de palabras, definidas por su *relación*, dentro de la estructura de la oración, con los 'verbos' y otras partes de ella."

"Quiénes piensan primero en las cosas que son relacionadas (los *relata*) rechazarán por rebuscada cualquier analogía entre la gramática y la anatomía de las plantas. Después de todo, una hoja y un sustantivo no se asemejan entre sí por su apariencia externa. Pero si pensamos primero en las relaciones y consideramos los términos relacionados como definidos exclusivamente por sus relaciones, comenzamos a asombrarnos.

¿Es que existe una analogía profunda entre la gramática y la anatomía? ¿Existe una ciencia interdisciplinaria que se ocupe de tales analogías? ¿Cuál sería el objeto formal de esa ciencia? ¿Y por qué deberíamos esperar que tales analogías tengan significado?" (pág. 181).

Las mismas cuestiones pueden ser rastreadas en otros textos. "...el método bosquejado por Kroeber en su análisis de la moda no solamente se asemeja al de la lingüística estructural: se lo puede también comparar con provecho con ciertas investigaciones en ciencias naturales, particularmente con las de Teissier sobre el crecimiento de los crustáceos. Este autor ha mostrado que es posible formular leyes del crecimiento, con la condición de retener las dimensiones relativas de los elementos que componen los miembros (por ejemplo, las pinzas) y no sus formas... La zoología científica no tiene, pues, por objeto, la descripción de las formas animales, tal como se las percibe intuitivamente, se trata sobre todo de definir relaciones abstractas pero constantes, que traducen el aspecto inteligible del fenómeno estudiado. Yo he aplicado un método análogo al estudio de la organización social y sobre todo de las reglas de matrimonio y los sistemas de parentesco como una especie de lenguaje, es decir, un conjunto de operaciones destinadas a asegurar, entre los individuos y los grupos, cierto tipo de comunicación... Postulamos pues que existe una correspondencia formal entre la estructura de la lengua y la del sistema de parentesco." (*Antropología estructural*, EUDEBA, Bs. As. 1968, págs. 55/58).

Pero este texto no es de Bateson, es de Lévi-Strauss. Cualquiera de ellos podría firmar esta afirmación del primero: "Todo el contenido de esta especulación se torna casi un lugar común cuando advertimos que lo mismo la gramática que la estructura biológica son producto de un proceso de comunicación y organización" (página 128).

El análisis estructural, la ecología de la mente y la teoría general de los sistemas están quizás esperando un Director que armonice las disonancias que parecen impedir su articulación.

En la sección tercera se encuentran reunidos una serie de trabajos sobre psicopatología. Es quizá entre nosotros la vertiente más conocida de Bateson. Sus teorías acerca de deuteroprendizaje y el doble vínculo; sus desarrollos a partir de la teoría de la información, la teoría de los juegos, la cibernética y la teoría de los tipos lógicos. En su comentario sobre esta parte nos advierte sobre el error heurístico de pensar el contexto como una variable independiente. Existe una constancia en la relación entre el sujeto y su ambiente, "es la ecología la que sobrevive y evoluciona lentamente" (pág. 369). Estos argumentos lo llevaron a proponer en 1962 un nuevo marco conceptual para meditar acerca de la esquizofrenia. A partir de allí, "la esquizofrenia, el deuteroprendizaje y el doble vínculo dejan de ser asunto de la psicología individual y se convierten en partes de la ecología de ideas o sistemas de 'mentes' cuyos límites dejan de coincidir con la piel de cada uno de los participantes individuales" (pág. 370).

A esta altura del libro comienza

uno a preguntarse seriamente qué entiende Bateson por "mente".

Luego de anunciarnos en la sección IV (Biología y evolución) que "acaso 'epistemología' sea sólo otra palabra para designar el estudio de la ecología de la mente" (pág. 426), dedica las restantes secciones a la exploración de este concepto y a la evaluación de sus alcances.

La parte V contiene cinco artículos que abarcan el período 1967/70. En el último de ellos, "Forma, substancia y diferencia", uno de los más originales del libro, de los más sugerentes y ricos en aperturas, se pregunta acerca del lugar de la mente, en tanto principio explicativo, en el pensamiento científico contemporáneo. Sostiene que ese lugar ha sido usurpado por el concepto de "energía", y que los modelos analógicos contruidos a partir de él han demostrado su escasa productividad.

Retomando aquellos elementos fundamentales del pensamiento, propone partir de la noción de "diferencia". Una diferencia es algo abstracto y se encuentra en la base de toda posibilidad de transmitir una idea. En el mundo de la comunicación, los "efectos" son producidos por diferencias. El mundo mental es el mundo del procesamiento de esas diferencias. Las relaciones existentes entre el mundo mental y la imagen tradicional del mundo físico son las mismas que existen entre un mapa y un territorio. "Lo que hay en el papel del mapa es una representación de lo que hubo en la representación retiniana del hombre que hizo el mapa; y a medida que retrocedemos preguntando, nos topamos con una regresión al infinito, con una serie

de mapas. El territorio no aparece nunca en absoluto. El territorio es *Ding an sich* (pág. 485). El mundo de la mente es el mundo de las representaciones, "...es sólo mapas de mapas, al infinito. Todos los fenómenos son literalmente, 'apariencias'". En última instancia la mente es el sistema organizador de las relaciones. Es este sistema el que está en crisis y de esa crisis nos hablará en la última parte.

La mente incluye también el poder de trastornar el equilibrio del cuerpo, la sociedad, el mundo biológico. La parte VI, "Crisis en la ecología de la mente", está dedicada a revisar las consecuencias pragmáticas de los procesos mentales "patogénicos". Escaladas armamentistas, desequilibrios ecológicos, tecnología destructiva, falacias epistemológicas, superpoblación y otros desastres son encarados como resultados de la "insanía del sistema" y de la aplicación sistemática de un modelo erróneo de pensamiento, de la "concepción corriente pero equivocada de la naturaleza del hombre y de su relación con el ambiente" (pág. 521).

Sólo una "ecología mental" concebida como immanente en la relación del hombre con la naturaleza podrá producir un modelo de conocimiento orientado hacia la supervivencia y no hacia la autodestrucción. "No estamos fuera de la ecología para la cual planificamos: somos siempre e inevitablemente parte de ella" ... "las ideas de la ciencia se están convirtiendo irreversiblemente en parte de nuestro sistema ecosocial" (pág. 537).

Esta postura lo conduce a una revaloración de lo que se llamó "tote-

mismo", definido como la aplicación metafórica de ciertos índices tomados del mundo natural para la explicación de fenómenos de orden cultural. Si bien en algún sentido esto podría parecer absurdo, "el mundo natural que nos rodea tiene realmente esta estructura sistemática general, y por consiguiente es una fuente apropiada de metáforas para permitir al hombre comprenderse y comprender su organización social" (pág. 517).

Es que el problema central radica en la introducción de un comienzo de orden en el universo. "Cada cosa sagrada debe estar en su lugar" —cita a Lévy-Strauss y agrega— "Inclusive, podríamos decir que es esto lo que la hace sagrada, puesto que al suprimirla, aunque sea en el pensamiento, el orden entero del universo quedaría des-

truido... (*El pensamiento salvaje*, página 25).

He querido citar estos puntos de contacto entre el pensamiento de Bateson, Lévy-Strauss, Von Bertalanffy y Bion porque no me parecen casuales. Porque pienso que en textos como los mencionados pueden rastrearse los gérmenes de un nuevo paradigma científico que comenzó su gestación en los umbrales del siglo y que está reclamando la confluencia de los esfuerzos dispersos para darle unidad y coherencia.

Porque tengo la certeza, además, de que el modelo de pensamiento que ellos proponen no puede ser soslayado por quienes intentamos aportar a la teoría y la terapéutica de las relaciones familiares. Relaciones no excluidas, por supuesto, de una "ecología de la mente".

Marzo de 1978

Lic. Juan Carlos Nocetti

LA FAMILIA

JACQUES LACAN, Ed. Homo Sapiens, Buenos Aires, 1977

La famille, artículo aparecido en *Encyclopédie Française*, t. VIII.

"Yo sé que todo privilegio, aunque oscuro, es de linaje de milagro

y mucho lo es el de participar en esta vigilia, reunida alrededor de lo que no se sabe: del Muerto reunida para acompañar y guardar su primera noche en la la muerte".

J. L. BORGES, *La noche que en el sur lo velaron*

Ante todo debemos caracterizar este texto de 1938 escrito para una enciclopedia, necesitado de claridad, donde nos encontramos con las huellas del derrotero lacaniano y su relación a Otro (Freud).

Quizá pudiéramos permitirnos decir que este escrito es complementario de otra tesis de una carrera doctoral: "De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad" (1932), en cuya introducción nos dice: "Es verdad

que, en el estudio de la psicosis, cada día parece aportar una correlación orgánica nueva, si se presta atención, se verá que estas correlaciones que no pensamos discutir, tienen sólo un alcance parcial, y el interés que ofrecen les viene únicamente del punto de vista doctrinal que pretenden reforzar. No bastan, sin embargo; para construirlo. No se hagan ilusiones quienes acumulan esa clase de materiales, los hechos de nuestra ciencia no permiten hacer a un lado la preocupación por el hombre" (1).

Pensamos que en el sentido de esa "preocupación por el hombre", surge la preocupación de aquello que lo instituye como tal, la familia. Así el texto, que si bien sigue las vicisitudes del sujeto, lo hace con relación a la estructura familiar que padece; desarrollando una formulación de pleno sentido freudiano, concepción que quizá nos permita encarar la construcción de un cuerpo de doctrina, aun en formación sobre la familia y sus posibilidades terapéuticas. En ese sentido Freud nos dice que el ideal del yo es familiar, social... (2) y como ideal lo sabemos inserto en el discurso del sujeto, el que fuera escindido desde que el algoritmo Conc/Inc lo constituyó en sujeto del inconsciente.

Pensamos que de esta manera se trasciende el hecho fenomenológico y la estructura del sujeto y de la familia se conformarán en una diacronía generacional, desde donde deberá ser pensada la función.

Lacan divide esta obra en una introducción y dos capítulos, de estos últimos, el primero "El complejo factor concreto de la psicología familiar", se-

rá el sustento teórico del segundo "Los complejos familiares en patología".

En la introducción, el texto no deja lugar a dudas, lo biológico, de lo que podrá dar cuentas no sin interés la etología, queda sometido a lo social. La especie humana establece relaciones sociales que se caracterizan por la comunicación mental y una economía paradójica de los instintos.

Así las instancias sociales dominan a las naturales, por ello, toda comparación con sociedades animales es imposible, y en sus variados comportamientos adaptativos, la dimensión humana en una obra colectiva constituye la cultura.

De ese paso de la naturaleza a la cultura nos hablará C. Lévy-Strauss basándose en ese misterio universal y terrible: "La prohibición del incesto" —que— "posee, a la vez, la universalidad de las tendencias y de los instintos y el carácter coercitivo de las leyes y de la institución". (3)

Por ello la dimensión cultural es específica a la familia humana, que es una institución soportada por las formas de organización de la autoridad familiar, las leyes de su transmisión, los conceptos de descendencia y parentesco, etcétera.

La familia, de esta manera, cumple un papel básico en todos los grupos humanos: la transmisión de la cultura, herencia psicológica ésta, contrapuesta a la contingencia de un parentesco biológico que, aunque en la familia occidental coincida numéricamente con la familia biológica, descarta, nos dice Lacan, las hipótesis de los defensores de la institución como célula social.

Es así como la familia primitiva

ya se constituye en institución por las prohibiciones y leyes que la regulan, por ello el autor afirma: "En efecto el grupo reducido que compone la familia moderna no aparece, ante el examen, como una simplificación sino más bien como una contracción de la institución familiar. Muestra una estructura profundamente compleja, en la que más de un aspecto puede ser aclarado en mayor medida por las instituciones positivamente conocidas de la familia antigua que mediante la hipótesis de una familia elemental que no se encuentra en lugar alguno"; pero... "que es necesario atribuirle a la influencia dominante que asume en ese caso el matrimonio, institución que se debe distinguir de la familia. Es así que podemos calificar como excelente el término de 'familia conyugal' con el que la designa Durkheim".

En el primer capítulo se desarrolla una categoría formal, "el complejo", condicionado culturalmente. Al preguntarnos qué define al complejo, el autor nos responde: "El hecho de que reproduce una cierta realidad del ambiente y lo hace en forma doble. 1) Su forma representa esta realidad en lo que tiene como objetivamente distinto, en una etapa dada del desarrollo psíquico; esta etapa especifica su génesis. 2) Su actividad repite en lo vivido la realidad así fijada en toda oportunidad en la que se reproducen algunas experiencias que exigirían una objetivación superior de esta realidad; estas experiencias especifican el condicionamiento del complejo".

"Esta definición, por sí sola", continúa diciendo, "implica que el complejo está dominado por factores cul-

turales; en su contenido, representativo de un objeto, en su forma ligada a una etapa vivida de la objetivación; por último, en su manifestación de carencia objetiva frente a una situación actual, es decir bajo un triple aspecto de relación de conocimiento, de forma de organización afectiva y de prueba de confrontación de lo real, el complejo se comprende en su referencias al objeto. Ahora bien, toda identificación objetiva exige ser comunicable, es decir que se basa en un criterio cultural; por lo general, también es comunicada por vías culturales. En lo que se refiere a la integración individual de las formas de objetivación, ella es el resultado de un proceso dialéctico que hace surgir toda nueva forma de los conflictos de la precedente con lo real.

En este proceso es necesario reconocer el carácter que especifica al orden humano, es decir la subversión de toda rigidez instintiva, de la que surgen las formas fundamentales, plenas de variaciones infinitas, de la cultura".

Pero no por el hecho de que el complejo pertenece a la cultura anula su relación con el instinto, sino que éste podría ser ilustrado por su relación con el complejo. Por ello... "podríamos confrontar punto por punto: 1) la relación de conocimiento que implica el complejo con la connaturalidad del organismo y el ambiente en el que se encuentran suspendidos los enigmas del instinto; 2) la tipicidad general del complejo en relación con las leyes de un grupo social, con la tipicidad genérica del instinto en relación con la fijeza de la especie; 3) el proteísmo de las manifestaciones del complejo que, bajo formas equivalen-

tes de inhibición, de compensación, expresa el estancamiento ante un mismo objeto, con la esterotipia de los fenómenos del instinto, cuya activación, sometida a la ley del "todo o nada", permanece fija ante las variaciones de la situación vital".

Pero para salir del estatismo en el complejo o la rigidez en el instinto, deberemos recurrir a los importantes conceptos que nos aporta el estudio de la vida psíquica. Así el complejo freudiano y la imago imponen una ruptura con toda filosofía del *cogito*; Freud define al complejo como Inconsciente, revelándose como actos fallidos, sueños, síntomas. El carácter diferente de estos efectos psíquicos determina como elemento fundamental del complejo una representación inconsciente, la imago.

Sobre esto Lacan nos dice: "Complejo e imago han revolucionado la psicología, en especial la de la familia, que se reveló como el lugar fundamental de los complejos más estables y más típicos; la familia dejó de ser un tema de paráfrasis moralizante y se convirtió en objeto de un análisis concreto".

Así puede considerarse los sentimientos como complejos emocionales conscientes y a los sentimientos familiares a menudo imagen invertida de complejos inconscientes; como lo vemos en el neurótico, mientras que en la psicosis, en las creencias delirantes por ejemplo, el sujeto afirma un complejo como si se tratase de una realidad objetiva.

Así, "Complejos, imagos, sentimientos y creencias serán estudiados en relación con la familia y en función del desarrollo psíquico que organizan,

desde el niño educado en la familia hasta el adulto que la reproduce".

Siguiendo a Lacan en una constelación de complejos e imagos vemos que, desde la indefensión por la prematuración, el "complejo de destete" instaura la primera crisis del psiquismo, la que se resolverá en intención mental (no por lo consciente), modelará así las experiencias psíquicas ulteriores; pero además este complejo estará en relación con una interrupción más primaria aún, sustentada en la imago del seno materno. Así, el amamantamiento nos mostrará cómo la madre recibe y satisface el más primitivo de todos los deseos; pero esta imago, de no ser sublimada, se convertirá en factor de muerte.

En la familia las relaciones fraternas (semejantes) determinarán en el individuo el "complejo de intrusión", allí el destino lo ubicará como heredero o usurpador. De esta manera, las identificaciones se realizarán en relación con otro, en éstas veremos cómo la imago del semejante está ligada a la estructura del propio cuerpo y la agresividad será soportada por esa identificación con el otro, objeto de la violencia.

Lacan introduce aquí el estadio del espejo y la consecuente estructuración narcisista del yo, donde la unidad de las tendencias pulsionales contribuirán a la formación de ese yo. Pero ante la satisfacción especular aparecerá un intruso, en el cual el sujeto encontrará al otro y al objeto socializado.

Hasta aquí el grupo fraterno en sí tiende a favorecer "las identificaciones más discordantes del yo", como el doble fálico de la mujer neurótica, por

ejemplo; o veremos también conexiones con la paranoia, que se manifiestan en los temas de filiación, de usurpación o de expoliación. Por ello, dirá Lacan que el... "grupo familiar, reducido a la madre y a la fratría, da lugar a un complejo psíquico en el que la realidad tiende a mantenerse como imaginaria o, a lo sumo, como abstracta. La clínica demuestra, efectivamente, que el grupo así descompletado (descomplété) favorece en gran medida la eclosión de las psicosis y que en él se observan la mayor parte de los casos de delirios de a dos".

Continuando con el desarrollo del texto, Lacan nos introduce en el "complejo de Edipo", elemento psicológico que constituye, para Freud, la forma específica de la familia humana; conduciéndonos, en su revisión, a situar en la historia a la familia paternalista y, mostrándonos su valor a través de los accidentes en la historia del sujeto, nos dice: "...se puede precisar, incluso, que cuando esos accidentes afectan la situación edípica como traumas en su evolución, se repiten más bien en los efectos del superyó, si la afectan como atípicas en su evolución se reflejan sobre todo en las formas del ideal del yo". Así, veremos como sus productos, las inhibiciones de la actividad creadora o las inversiones de la imaginación sexual. Vinculado íntimamente con esto, el "complejo de castración" aparecerá como prototipo de la represión edípica.

En cuanto a las funciones del complejo, y desde una postura crítica, el autor las sintetiza en: a) maduración de la sexualidad; b) constitución de la realidad, c) represión de la sexualidad y d) sublimación de la realidad; desde

donde nos advierte acerca de... "el defecto más notable de la doctrina analítica: descuidar la estructura en beneficio del dinamismo". Así, la identificación edípica estará sustentada por la imago del padre, ya que... "polariza en los dos sexos las formas más perfectas del ideal del yo, en relación con las que es suficiente señalar que realizan el ideal viril en el hombre y el ideal virginal en la niña".

Desde aquí, el texto se abre a lo sociológico pasando por el matriarcado y el patriarcado donde, no por separado, sino por la articulación de las funciones (materna y paterna) y por la fecundidad del complejo edípico: "...la Imago paterna proyecta la fuerza original de la represión en las sublimaciones"...; de ahí la importancia de la declinación de esta imago.

Así, nos continúa diciendo el autor: "El complejo de la familia conyugal crea los logros superiores del carácter, de la felicidad y de la creación para realizar en la forma más humana el conflicto del hombre con su angustia más arcaica, para ofrecerle el recinto más leal en el que le sea posible confrontarse con los rigores más profundos de su destino, para poner al alcance de su existencia individual el triunfo más completo contra la servidumbre original".

El segundo capítulo Lacan lo sintetiza en dos tesis donde nos dirá: "Los complejos familiares desempeñan una función formal en la psicosis: temas familiares que predominan en los delirios por su conformidad con la detención que constituye las psicosis en el yo y en la realidad; en las neurosis los complejos cumplen una función causal: incidencias y constelaciones fami-

liares que determinan los síntomas y las estructuras, de acuerdo con los cuales las neurosis dividen, introvierten o invierten la personalidad". Estas tesis serán de un ejemplar desarrollo psicoanalítico.

Pero volviendo al comienzo de este comentario, hablamos de la necesidad de un cuerpo teórico, el que pensamos debe dividirse en dos momentos; uno teórico-teórico y, otro, una teoría de la práctica (técnica).

En ese sentido vemos, cómo los trabajos de autores norteamericanos, quedándose en datos empíricos, limitan su alcance, sin por ello dejar de mostrarnos una interesante concepción de la práctica.

El importante grupo de Palo Alto coincide con Lacan, el paciente no es un ser aislado, sino un lugar de relaciones: rompiendo con el clasicismo de los procesos intrapsíquicos para incorporar un entorno. Este grupo utiliza la cibernética y el estudio del sujeto como lugar de caja negra, la comunicación (campo de la palabra) y referencias logicomatemáticas (Frege, Russell, etcétera).

Pero a pesar de la convergencia con Lacan, a su vez divergen, ya que la lógica se sitúa en el nivel de la pala-

bra dicha y el lenguaje, reducido a la comunicación, se ubica en una perspectiva behaviorista.

El discurso del paciente, en relación a la paradoja, queda en lo consciente; Lacan por el contrario, ve el lenguaje (comunicación mental) en la relación del sujeto con el significante que se articulará con el deseo. Así, será sujeto de la palabra y, en su relación familiar, constituido por el discurso de los padres.

De esta manera pensamos que el síntoma del paciente ocupa en el discurso familiar el lugar de una verdad no dicha: necesario entonces para defenderse contra el saber de esa verdad, por eso, tratar un síntoma es rechazar a quien lo padece.

En nuestro país esto lo hemos comprendido bien, en la búsqueda teórica y clínica de una concepción de la familia y su patología, ya en el pensamiento de E. Pichon-Rivière o en los numerosos aportes de J. García Badaracco, quienes, en su originalidad, incluyeron al individuo en su entorno, no desechando el giro copernicano que para las ciencias del hombre, fue el descubrimiento del inconsciente; topos del sujeto, el que, en función de la estructura familiar, por lo formal o lo causal, padecerá.

Rafael Skiadaressis

Bibliografía

- (1) LACAN, J., *De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad*, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1976, pág. 17.
- (2) FREUD, S., *Obras Completas*, Ed.

Biblioteca Nueva, Madrid, 1967, pág. 195.

- (3) LEVI-STRAUSS, C., *Las estructuras elementales del parentesco*, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1969, pág. 43.

TERAPIA FAMILIAR INTENSIVA. Aspectos teóricos y técnicos

IVAN BOSZORMENYI-NAGY y JAMES L. FRAMO, Editorial Trillas, México, junio de 1976, 569 págs. Traducido por Francisco González Aramburo. Revisión técnica: Raymundo Macías Avilés, Miguel Foncerrada Moreno y Roberto Derbez Muro. *Intensive Family Therapy: Theoretical and Practical Aspects*, Harper & Row, Publishers, Inc., Hagerstown, Maryland, EE. UU., 1965.

Esta obra, que con tanto retraso llega a los lectores de habla castellana, constituye un verdadero ensayo teórico y técnico producto de largos años de investigación y práctica clínica, no sólo de los autores, sino también de todos los que han abordado terapéuticamente la familia desde distintas ópticas. Existe una sólida articulación entre los tópicos elaborados por los numerosos autores, pues los directores de la edición solicitaron contribuciones originales y específicas que desarrollaran importantes aspectos de la Terapia Familiar, tales como: marco teórico y fundamento filosófico, aspectos técnicos, teoría de la esquizofrenia y de la enfermedad emocional en general desde el punto de vista de la familia, indicaciones y contraindicaciones, contratransferencia, investigación y otros.

Este cambio de enfoque en psicopatología, que dio lugar a una redefinición de la enfermedad mental y a nuevas técnicas terapéuticas, ha sido producto de muchos fracasos terapéuticos o de restricciones en cuanto al efecto del proceso de curación al quedar excluidas importantes variables. Así, un cambio en la concepción del hombre y el desarrollo de modernas ciencias que han constituido como objeto de estudio los sistemas, posibilitaron modelos teóricos más integrados en cuanto a la génesis y terapéutica de la enfermedad emocional.

La doctrina de la terapia familiar tendrá que constituirse, no meramente como una reformulación de la psicopatología, sino producir además hipótesis nuevas y propias que den cuenta de un fenómeno complejo, como el de las relaciones familiares y sus leyes. En ese camino encontramos esta obra, que aporta lo suyo.

Desde la Introducción los autores se sitúan en una perspectiva psicoanalítica profunda, claramente influida por Fairbairn, apreciable sobre todo en los primeros capítulos. Conciben la Terapia Familiar Intensiva (a diferencia de la terapia de apoyo) como aquella que pretende la comprensión de las deformaciones de transferencia inconscientes que afectan las relaciones familiares estrechas, con el fin de que sus miembros se ayuden entre sí a superarlas. Se hizo necesaria a partir de las *Impasses* en que entraban los tratamientos individuales de pacientes esquizofrénicos debido a la colusión regresiva inconsciente entre el paciente y su familia. Las relaciones familiares son constituyentes de la condición psiquiátrica de que se trate, y el paciente es también un agente que ayuda a mantenerla. La Terapia Familiar supone que la familia posee el potencial para un cambio.

En el Capítulo 1, Gerald H. Zuk y David Rubinstein presentan una revisión histórica de investigaciones y abordaje terapéuticos que jalonaron el

surgimiento del enfoque familiar en psicopatología y en psicoterapia, recordando cómo se fue pasando paulatinamente del individuo a la díada (década del 40 y 50), a la tríada (década del 50 y 60), para llegar al mayor esfuerzo de síntesis y mayor nivel de integración que representa el enfoque familiar. Investigaciones, ensayos técnicos, hipótesis, necesidad de métodos adecuados para la exploración de procesos muy complejos y para la evaluación de los resultados demuestran, según Framo (1962) que "el estudio del tratamiento familiar se encuentra aún en la etapa de formación de hipótesis" pero explorando niveles distintos de la psicopatología.

En el Capítulo 2, que anuncia "Una teoría de las Relaciones: experiencia y transacción", Ivan Boszormenyi-Nagy, a partir del método dialéctico y de la filosofía hegeliana, repiensa la psicopatología psicoanalítica. Nos muestra al Yo constituyéndose en la relación con el Otro, dando primacía al delineamiento y al mutuo y a la individuación sobre la descarga de impulsos. Para comprender las relaciones familiares necesita un lenguaje transaccional y una teoría relacional de la psicopatología y terapéutica de la Personalidad y la Relacionalidad. Esta concepción toma como unidad las organizaciones o sistemas de acción compuestos por una o varias personas, pero donde toda acción, ya se atribuya a una persona o a un sistema, presupone un sujeto y un objeto. Cada transacción delinea simbólicamente dos entidades: el o los que actúan (sujeto) y aquél o aquéllos sobre los que se actúa (objeto). "Independientemente de la forma de descarga o de los patrones

de comunicación empleados, la necesidad de un determinado tipo de relación delineadora del Yo posee su propia función configuracionalmente dinámica... El principio dialéctico describe una fuerza dinámica que determina la elección de objetos relacionales sobre la base de las propiedades antagónicas y complementarias". El sentimiento de relación resultante ayuda tanto al sujeto como al objeto a crecer en individuación (proceso dialéctico), en tanto que la identificación primaria o fusión a través del *acting out* tiende a reducir el grado de individuación. Según el autor, el concepto de relacionalidad estaría implícito en Freud cuando define al Yo como "un precipitado de catexias de objeto abandonadas" o bien como "una alteración del carácter" capaz de "conservar relaciones de objeto" o cuando encontramos la cualidad transaccional que tiene la dinámica del aparato psíquico mismo.

El ser objeto, en vez de sujeto, en una relación, es una cuestión de diferencial de iniciativa o de "fuerza". Mientras que la aceptación de ser objeto significa generalmente el desempeño de un papel relacional cautivo, la fusión conduce a una extinción, al menos parcial y transitoria, de la persona como entidad dinámica discreta. La búsqueda de un delineamiento del Yo puede manifestarse en acciones, fantasías y modos relacionales inconscientemente estructurados y simbólicamente significativos. Cuanto más consistente es la demarcación Yo-Otro de una persona, tanto mejor quedará protegida contra la ansiedad de pérdida de objeto y su miedo a la despersonalización concomitante. Distingue seis modos relacionales que van de la irre-

lacionalidad hasta la relacionalidad: frontera intrasujeto, diálogo interno, fusión, ser el objeto, ser el sujeto y diálogo. Los conceptos de complementariedad y complementariedad patológica, afinidad relacional, diálogo, etcétera, muestran que el marco teórico es más configuracional que cuantitativo, reduciendo el acento puesto sobre la descarga impulsiva y poniendo de relieve las propiedades dinámicamente estructurantes de las complementariedades mutuas sujeto-objeto entre personas.

Aplicando el modelo dialéctico a las relaciones familiares, postula unidades transpersonales o multiindividuales de discriminación sujeto-objeto. Cualquier relación real o propuesta puede ser entendida en términos de una relación o frontera sujeto-objeto. Uno o más participantes pueden constituir cualquiera de los términos de la relación. La contraposición sujeto-objeto es un requisito básico del diálogo y considera que la familia sana o diferenciada consiste en una red de relaciones de tipo dialógico, más que de fusión. Define el diálogo como una transacción basada en la retroalimentación, donde cada término es sujeto y objeto alternativamente, en un clima de confianza y anticipación, donde la posición del compañero se convierte en meta motivacional secundaria y es un medio para obtener las satisfacciones de las necesidades primarias.

Describe la familia simbiótica como un continuo intersubjetivo (fusión) opuesto a los Otros Extrafamiliares, donde todo se vuelve pronosticable, no existen alianzas ni secretos y no se permite el cambio autónomo a ningún miembro. Todos con-

tribuyen a mantener este sistema cerrado porque reduce el peligro de separación y las consiguientes experiencias de despersonalización. La vivencia del Yo cobra las características de un "nosotros amorfo" (Buber). La familia autística carecería de esta última experiencia. A su juicio, el beneficio obtenido en el mantenimiento de estos sistemas no sería el placer de la descarga sino la seguridad conseguida "al no agitar el agua", y aquello que los mantiene, al igual que en la compulsión repetitiva, se encontraría más allá del principio del placer.

Describe además hipótesis de proceso, tanto del desarrollo de la personalidad como de la evolución relacional familiar, entre las que marca una interrelación. Para el desarrollo de la personalidad delimita las fases autística, simbiótica, de individuación, de separación y de reingreso a una nueva relación. Estas mismas fases son retomadas para caracterizar el proceso relacional, que consta así de "fases consecutivas de integración creciente de percepciones y aptitudes relacionales internas y externas".

Aplicando el modelo dialéctico, desarrolla una teoría relacional donde rescata la importancia del Otro en la estructuración del Yo. Sería interesante pensar si esta teoría pudiera fundamentarse también antropológicamente en lo que se refiere a la organización familiar.

En el Capítulo 3, donde el mismo autor propone "La Terapia Familiar como proceso" plantea desde el comienzo que "en la familia existe una lucha individual y colectiva, cuyas metas opuestas son la identidad autónoma, por una parte, y la seguridad, a tra-

vés de la fusión simbiótica, por la otra". Al referirse al programa de investigación llevado a cabo en el Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute (institución estatal de investigaciones) desde 1958, nos relata cómo le fue pareciendo cada vez más claro que "el estudio de los conflictos relacionales psicóticos tiene que cobrar mucho más sentido en el contexto de las relaciones primarias originales de la persona". Comenzaron realizando reuniones de terapia familiar múltiple, luego el tratamiento de cada familia por separado, y por último agregaron a éste sesiones de terapia con varias familias. Este modo de trabajo terminó por poner en duda el valor de la hospitalización y permitió encarar el tratamiento no sólo de la esquizofrenia sino también de neurosis graves y caracteropatías. Paulatinamente se fue transitando de una terapia primordialmente individual a una orientación terapéutica casi exclusivamente familiar.

Fenomenológicamente considera que la patología de los miembros de una familia está constituida por patrones repetitivos de *acting out*, el que estaría en la línea fronteriza entre la determinación intrapsíquica y la relacional. Considerada como sistema multipersonal, la patología familiar no consiste exclusivamente en una serie de descargas motoras, sublimaciones, proyecciones y desplazamientos, sino en una estructura interconectada de maniobras conservadoras de objeto, que tiene carácter de proceso primario, donde cada miembro puede asignar un papel parental, inconscientemente deseado, a otro. El sujeto parentalizado se ve reducido al estado de "ser un objeto" en conflicto con sus

propias aspiraciones autónomas de crecimiento emocional, y los miembros que participan en la asignación conclusiva de un papel parental de fantasía (transferencia) a otro, evitan su propio crecimiento a través de la individuación, aplazando el doloroso proceso que conduce a la separación de los objetos parentales perdidos. La transferencia repetidamente "actuada" entre miembros de una familia y la consiguiente deformación de las relaciones familiares presentes, encubren un deseo infantil no satisfecho (de ser abrazado, alimentado, corregido...). Si las necesidades de transferencias del otro miembro complementan las del primero, ese mutuo investimento constituye un sistema interaccional compartido. Cada sujeto posee su propio patrón de necesidades relacionales instituidas en una fantasía específica, cuya exploración profunda es posible en el contexto de la terapia familiar. Estas relaciones de transferencia entre miembros de una familia y de una familia con el terapeuta son explorables en tanto se dé el libre juego espontáneo de los patrones repetitivos de *acting out*, así como es fundamental para el psicoanálisis la capacidad para la asociación libre.

La experiencia del trabajo en equipo (dos coterapeutas; consultas y cuasi supervisiones mutuas entre los ocho miembros del equipo) deja como saldo que las ventajas superan los inconvenientes. Las personalidades de los coterapeutas deben ser de alguna manera compatibles y la mutua elección espontánea. La lectura de este capítulo tiene especial interés por las reflexiones sobre los objetivos terapéuticos, las limitaciones de las po-

sibilidades de cambio, las indicaciones de la terapia familiar, los problemas específicos del proceso terapéutico intensivo y el papel desempeñado por la familia en la vida moderna. Finaliza sosteniendo que: "La terapia familiar sólo tendrá éxito si la sociedad no le hace una demanda imposible de satisfacer a la vida familiar y a los papeles desempeñados por los padres". Podría pensarse si tal reflexión pudiera ser extensiva a los destinos de otras psicoterapias.

En el Capítulo 4, James L. Framo se refiere a los "Fundamentos y técnicas de la terapia familiar intensiva". Sostiene que el sistema familiar posee "mecanismos reguladores propios" y que "hay algo más que la dinámica inconsciente de cada persona". Cada miembro utiliza a los demás para compensar su propia patología dentro de las reglas de juego del sistema. Cada familia contiene sus propios "restos fósiles" heredados de generaciones pasadas, que determinan en gran medida lo que sucede en el presente. El paciente designado sacrifica su autonomía con el fin de llenar los vacíos en las vidas de sus padres y queda sujeto al "síndrome del yo-yo": es atraído cuando los padres lo necesitan e ignorado cuando manifiesta sus necesidades. Describe una interesante faceta del deterioro de la realidad cuando la irre realidad de la mente de los padres se convierte en la del hijo, quien no tiene otro recurso que ajustarse a ella, dado que si insiste en una búsqueda de la realidad, será inculpa do de traición o deslealtad. Intenta comprender algunos síntomas de la esquizofrenia (perplejidad, desarmonía

del afecto) a partir de la experiencia particularmente frustrante y desconcertante que es la posición receptora de la proyección de la imagen interna de otra persona, si es alguien de quien se tiene necesidad vital. La enfermedad emocional, cualquiera sea, constituye una reacción lógica, adaptativa a un sistema familiar ilógico, descompuesto, donde el que más pierde es el paciente designado.

Evitan la hospitalización, salvo cuando es absolutamente necesaria para no confirmar el diagnóstico y los manejos de la familia, poniendo el acento sobre el sistema familiar, en lugar de la patología individual. Al referirse a las fases iniciales de la Terapia Familiar, describe sustanciosamente el delineamiento de los criterios de admisión, las formas en que suelen presentarse los conflictos familiares, los cambios en las técnicas de abordaje. Estas etapas preliminares permiten las adaptaciones y ajustes entre familia y terapeutas, la integración del equipo de coterapeutas, la lucha por alcanzar posición y una comprensión parcial de la patología familiar. "Los terapeutas tratan de irrumpir en el sistema familiar y la familia de tenerlos a raya. Si se llega a las fases intermedias, entonces los terapeutas están en la familia". Estas últimas fases son definitorias. Implican un proceso largo, arduo, irregular, de profundización y trans elaboración de las transferencias entre sí y para con los terapeutas; donde utilizan técnicas cada vez más activas. Algunas resistencias tienen una cualidad distinta y propia en la terapia familiar y se agregan a las descubiertas en la terapia individual y de grupo: resistencia masiva, domi-

nio pasivo, maniobra del miembro ausente, resistencia al cambio. Sostiene que las resistencias son siempre función de un complejo juego recíproco entre las variables de la familia y las de los terapeutas.

El tratamiento de los problemas matrimoniales en la Terapia Familiar da lugar a un interesante estudio, a partir de una tesis de Kubie, quien sostiene que "la fuente de desdicha matrimonial estriba en las discrepancias existentes entre las demandas conscientes e inconscientes que se hacen uno al otro y también al matrimonio". Las deformaciones de la transferencia se manifiestan para con los terapeutas entre sí, como una transferencia del sistema familiar en su conjunto y, además, en los terapeutas, cuando eligen o aceptan una familia para terapia o "cuando reaccionan de acuerdo con sus propias inclinaciones y preconcepciones irracionales". Las fases finales son un doloroso proceso, donde la familia oscila entre las resistencias por mantener una antigua modalidad y la desorientación por no contar con una nueva que la reemplace. En suma, nos coloca frente a la familia concreta y a las dificultades del proceso terapéutico, entre las que incluye las vicisitudes relacionales del equipo terapéutico.

En el Capítulo 5, Murray Bowen, refiriéndose a la "Psicoterapia familiar de la esquizofrenia en el hospital y en la práctica privada", describe "un método específico de psicoterapia familiar para el tratamiento de la esquizofrenia... que se fue desarrollando como parte integrante de una premisa teórica acerca de la naturaleza y el origen de la esquizofrenia. La pre-

misa se amplió más tarde hasta convertirse en un concepto familiar de la esquizofrenia y más recientemente, en una teoría familiar de la enfermedad emocional"... Se interpreta a la esquizofrenia como parte del espectro total de la adaptación humana. La comprensión de los tipos menos severos de enfermedad emocional puede hacer mucho en favor de la comprensión de la esquizofrenia".

Inicialmente se sometió a terapia individual a todos los miembros de las familias (1949-1954). Luego se encaró un programa de investigación donde las madres vivieron en la sala donde estaban internados los pacientes esquizofrénicos, de manera que las acciones y respuestas relacionales se hicieron más intensas. Más tarde se amplió la hipótesis hasta incluir a toda la familia en la premisa teórica, permitiendo que todos los miembros viviesen en el pabellón del paciente y la psicoterapia individual cedió paso a la familiar (1964-1959). Simultáneamente se trató a un número creciente de familias con pacientes externos. Desde 1959 el autor se limitó a la terapia familiar con pacientes externos y a la práctica privada.

Todos los dinamismos familiares de la esquizofrenia se presentaban también en las familias que tenían problemas menos graves y en las llamadas "normales" o asintomáticas. La "unicidad emocional" de la simbiosis madre-hijo no era sino un fragmento de una "unicidad emocional" de la familia. Estas observaciones llevaron al concepto de "la familia como unidad de enfermedad" y de allí a la teoría familiar de la enfermedad emocional. Clínicamente la masa indiferenciada de

egos es equivalente a un solo ego. El terapeuta familiar se dirige a dicha masa de la misma manera como se relaciona con un solo ego en la psicoterapia individual. Las personas tienden a casarse con otras que tienen niveles idénticos de diferenciación del yo. Los padres de un esquizofrénico tienen un nivel muy bajo y el hijo que se convertirá en esquizofrénico el nivel más bajo. Considera a la esquizofrenia como producto de un proceso familiar en el que, en cada generación, un hijo sufre mayor deterioro que sus padres (los hijos menos envueltos en el proceso pueden alcanzar niveles de diferenciación del yo mayores que sus progenitores). El proceso se repite durante varias generaciones hasta que aparece un vástago con un bajo nivel de diferenciación del yo quien, al contraer matrimonio, sufrirá un deterioro en la masa de egos de los padres, suficiente como para producir esquizofrenia en un hijo. El proceso de proyección familiar es el mecanismo predominante en la esquizofrenia, por el que se transmite al hijo el conflicto de los padres. Este proceso puede comenzar mucho antes de la concepción del hijo, cuando los pensamientos, sentimientos y fantasías de la madre comienzan a prepararle un lugar en su vida. El hijo luego funciona como estabilizador para los padres y transformaría la inestable masa de egos madre-padre en una tríada más sólida funcionando como el "triádico". Toda amenaza de dejar vacante esta función provoca ansiedad en los padres.

En cada episodio del proceso de proyección se dan tres pasos, cuyo objetivo es localizar la perturbación y ubicarla fuera de la madre y que se

repiten cuando la familia solicita auxilio psiquiátrico para el colapso psicótico: a) sentimiento de la madre, que se transforma en pensamiento sobre su hijo, b) examen y rotulación en el hijo del defecto que mejor armoniza con el sentimiento de la madre, c) tratamiento del hijo como si su diagnóstico fuera exacto. El enfoque psiquiátrico tradicional encaja paso a paso con el proceso de proyección familiar: confirma la proyección de los padres, cristaliza la enfermedad y contribuye a cronificarla. Contrariamente la orientación clínica de Bowen consiste en pensar y actuar con las familias de acuerdo con la concepción familiar de la enfermedad emocional, evitando el tratamiento del triádico como si fuese un enfermo y dirigir la atención hacia la ansiedad de los padres que alimenta la proyección.

Reflexiona además sobre la práctica hospitalaria y privada, concluyendo que el hospital no es el lugar más apto para propiciar el cambio en la Terapia Familiar y que los mejores resultados clínicos se obtuvieron con pacientes externos y en la práctica privada. Se adelanta mucho cuando puede evitarse la hospitalización. Opina que "cuando la esquizofrenia es grave, la masa familiar de egos no es solamente indiferenciada sino, según (su) experiencia, 'indiferenciable', pero la terapia familiar ha sido eficaz para conseguir en las familias ajustes asintomáticos, sin cambiar el problema subyacente. La teoría familiar de la enfermedad emocional que expone Bowen implica una ruptura no sólo en cuanto al punto de vista tradicional de la etiología de la enfermedad mental, sino también una comprensión y

tratamiento coherentes con el significativo cambio de denominación.

En el Capítulo 6, "Dinámica familiar y reversibilidad de la formación de delirios: estudio de un caso en Terapia Familiar", Nathan W. Ackerman y Paul F. Franklin parten de la interdependencia fundamental del trastorno homeostático del individuo esquizofrénico y el desequilibrio homeostático del grupo familiar. El tratamiento familiar dio como resultado la inversión de la experiencia psicótica de la paciente a medida que se fue desentrañando su determinación familiar y develando los conflictos con la agresión y el sexo en la pareja de los padres y la digitación de la abuela materna. El terapeuta desempeñó un papel activo introduciendo en la atmósfera emocional de la familia los ingredientes que faltaban: calor humano

y afecto, aceptación natural y franca del sexo, articulación del sexo y el afecto e imágenes más adecuadas de los papeles familiares de hombre, mujer y niña, al mismo tiempo que neutralizó a la abuela como un "abuelo" omnisciente y omnipotente, pero también prudente, benigno y bien intencionado. La paciente fue retirando paulatinamente su interés del mundo psicótico e invirtiendo cada vez más sentimientos en su lucha por encontrar un nuevo lugar en su familia.

La lectura de este interesante caso está complementada con una descripción sintética y clara del proceso terapéutico, las estrategias y los pasos seguidos, que no conforman una terapia manipuladora sino una experiencia correctiva que devuelve el derecho a la vida y a la salud.

Stella Maris Molina

II Congreso Internacional de Terapia Familiar Florencia, junio de 1978

Hacer comentarios pormenorizados de este Congreso nos remite a la edición de las Actas, tal como planea hacer la Sociedad Italiana de Terapia Familiar, entusiasta organizadora de esta reunión de distintos especialistas internacionales.

Por ende, preferimos la impresión del programa de actividades, que es elocuente *per se*, ya que nos muestra cómo se han enfocado con sencillez y claridad temas generalmente hablados "en los pasillos" de los Congresos organizados en forma tradicional.

Así por ejemplo, el que se discu-

ta sobre la formación de los terapeutas familiares, la institución, la supervisión *in vivo*, la coterapia, etcétera, significa para quienes tenemos experiencia institucional, encontrar un ámbito que facilita el diálogo sobre aspectos sumamente importantes para el quehacer de nuestra disciplina.

La importancia de la formación de los terapeutas de familia y la dificultad de organizarla en forma adecuada fueron subrayadas por especialistas de distintos lugares del mundo, lo que nos muestra un problema común de no fácil solución.

El mismo Congreso constituyó una tribuna donde se expuso este problema desde distintos ángulos y no siempre de la mejor manera.

Los contestatarios políticos intentaron sabotearlo, denunciando la super tecnificación del terapeuta como una forma sutil de dominación y represión de realidades gremiales postergadas. La enorme cantidad de participantes (unos 800) dificultó la posibilidad de discutir a fondo estos problemas y sobre todo condicionó una respuesta de los panelistas no siempre pertinente a los problemas teóricos y prácticos presentados.

Invitado a participar de las conclusiones finales del Congreso, junto con representantes de otras partes del mundo, señalé la importancia de considerar los factores emocionales que llevan a alguien a elegir la carrera de psicoterapeuta. La presencia inevitable de problemas no resueltos en el grupo familiar, agravado por la juventud de esta terapéutica, en la que todavía no hay tratamientos didácticos familiares, puede constituir una fuente importante de problemas, si no se le da un sentido de búsqueda de maduración del propio terapeuta. Enfatiqué la importancia de que estos factores, sumados a la fascinación que este enfoque despierta, no constituya una

suerte de "moda" que provoque el fenómeno contrario. De ahí la importancia de separar un posible movimiento sociológico de una disciplina teórica que vaya echando bases sólidas para la creación de un cuerpo de teoría que sustente los resultados terapéuticos promisorios que fueron expuestos. La necesidad de diferenciar teoría de doctrina, axioma de dogma y ciencia de proselitismo fueron palabras quizás algo duras para un auditorio que necesitaba probablemente otras respuestas.

Una de las cosas más rescatables del Congreso fue la necesidad manifiesta de organizar reuniones científicas enfatizando el encuentro entre los expositores y la concurrencia, procurando clarificar modelos de abordaje técnico de las distintas escuelas y sobre todo poder conocer más la persona de los terapeutas y las dificultades que éstos han encontrado en su ejercicio profesional.

Para finalizar, este Congreso, junto con el de Francia, parece mostrarnos un deseo de los europeos de reivindicar su tradición teórica, contribuyendo en una suerte de movimiento circular con otros países y en especial con Estados Unidos y Canadá, a enriquecer un campo hasta ahora poco desarrollado.

Dr. Alfredo Canevaro

Sociedad Italiana de Terapia Familiar
Segunda Conferencia Internacional
TERAPIA FAMILIAR EN LA COMUNIDAD
Florencia, Junio 21-24, 1978

Estructura de la Conferencia: Paneles, Mesas de Trabajo, Seminarios.

Los *paneles* sobre los temas principales se celebrarán con todos los participantes en sesiones plenarias con la contribución de los oradores.

Las *mesas de trabajo*, formadas aproximadamente por 25 personas cada una, enfocarán temas específicos bajo la dirección de los oradores.

Los *seminarios*, formados aproximadamente por 80 personas, discutirán algunos temas de investigación presentados por los oradores. Los seminarios son programados simultáneamente todos los días.

ORADORES

P. ABRAHAMSEN, Instituto de Psiquiatría de la Universidad. Oslo.
M. ANDOLFI, Presidente de la Sociedad Italiana de Terapia Familiar.
D. BLOCH, Director del Instituto de Familia N. Ackerman.
L. BOSCOLO, Centro para el estudio de la familia. Milán.
M. BOWEN, Director del Centro Familiar Georgetown. Washington DC.
P. CAILLE, Director del Centro de Conducta Familiar Sagene. Oslo.
L. CANCRINI, Profesor del Instituto de Psiquiatría de la Universidad. Roma.
G. CECCHIN, Centro para el estudio de la Familia. Milán.
M. ELKAIM, Profesor, La Gerbe. Bruselas.
J. FRAMO, Profesor, Universidad de Temple. Filadelfia.

M. FRAMO, Terapia Familiar del Servicio Familiar de Montgomery Co. Filadelfia.

C. GIROLAMI, Psicólogo clínico del Instituto de psicología de la Universidad. Oslo.

J. HALEY, Director del Instituto de Terapia Familiar. Washington DC.

K. LAPERRIERE, Director de Educación del Instituto de Familia N. Ackerman. Nueva York.

P. MENGHI, Sociedad Italiana de Terapia Familiar.

S. MINUCHIN, Director del Centro de Entrenamiento de Terapia Familiar, Clínica de Orientación infantil. Filadelfia.

A. M. NICOLO, Sociedad Italiana de Terapia Familiar.

W. PASINI, Director de la Unidad Psicósomática y de Sexología de la Universidad. Ginebra.

G. PRATA, Centro para el estudio de la Familia. Milán.

C. SACCU, Vicepresidente de la Sociedad Italiana de Terapia Familiar.

A. SCHEFLEN, Profesor del Colegio de Medicina Albert Einstein. Nueva York.

M. SELVINI PALAZZOLI, Director del Centro para el Estudio de la Familia. Milán.

R. SKINNER, Presidente del Instituto de Terapia Familiar. Londres.

B. SORBYE, M. S. W. Guía Familiar, Centro de Buskerud Country. Drammen.

G. VELLA, Director de la Segunda Clínica Psiquiátrica de la Universidad. Roma.

M. WALTERS, Director Ejecutivo del Centro de Entrenamiento de Terapia

Familiar, Clínica de Orientación Infantil. Filadelfia.

J. ZWERLING, Presidente del Departamento de Ciencias de Salud Mental, Colegio Médico Hahnemann. Filadelfia.

COMITE CIENTIFICO EN FLORENCIA

Anzilotti, Julie Ann; Carta, Maria Grazia; De Bernart, Rodolfo; Dobrowolski, Cristina; Giacometti, Katia; Meoni, Carla; Montagano, Silvana; Pannello, Adriana; Vanon, Francesca.

PROGRAMA

Miércoles 21 de junio.

TERAPIA FAMILIAR EN LA COMUNIDAD

Historia del movimiento familiar, Bowen.

Terapia familiar y la intervención de la comunidad, Zwerling.

El futuro de la terapia familiar, Bloch.
Indicaciones y límites de la terapia familiar en Italia, Andolfi.

Jueves 22 de junio.

TERAPIA FAMILIAR Y TERAPIA DE PAREJA
PANEL

Terapia de Pareja

PARTICIPANTES

Andolfi, Bloch, Bowen, Framo J., Selvini Palazzoli, Skinner.

Intervalo.

MESAS DE TRABAJO SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS

1. Formación del sistema terapéutico con familias con un paciente esquizofrénico, Andolfi - Nicolo.
2. El chico en la terapia familiar, Bloch.

3. Hipótesis y evaluación de nuestra metodología de trabajo, Boscolo - Prata.

4. Principios y técnicas en terapia familiar, Bowen.

5. Terapia de pareja desde una perspectiva sistémica, Caille.

6. La condición esquizofrénica, Cancrini.

7. Un acercamiento integrado con dos casos de anorexia nerviosa, Elkaim.

8. Terapia de pareja, Framo J. - Framo M.

9. Terapia con jóvenes psicóticos, Haley.

10. El ciclo vital de la familia, Laperriere.

11. Tratamiento con familias psicósomáticas, Minuchin.

12. La familia con un paciente anoréxico: estrategias de intervención, Saccu - Menghi.

13. Falta de comunicación verbal en familias con un paciente esquizofrénico, Scheffen.

14. Grupo analítico de terapia de pareja, Skinner.

15. Cónyuges y paternidad en patología internacional, Vella.

16. La primera entrevista, Walters.

17. Terapia familiar con grupos minoritarios, Zwerling.

SEMINARIOS

1. Interacción en sistemas rígidos: modelo de intervención, en familias con un paciente esquizofrénico, Andolfi - Menghi - Nicolo - Saccu.

2. Un sistema respecto de la esquizofrenia, Bowen.

3. Comunicación analógica y digital en la relación terapéutica entre el

terapeuta y la familia psicótica, *Caille - Abrahamsen - Girolami - Sorbye*.

4. Control social y terapéutico con pacientes esquizofrénicos, *Haley*.
5. Problemas comunicacionales y perceptuales del paciente esquizofrénico, *Schefflen*.
6. Terapia con familias con transacciones esquizofrénicas, *Selvini Palazzoli*.

Viernes 23 de junio.

FAMILIA E INSTITUCION A TRAVES DE UN ACERCAMIENTO SISTEMICO

MESAS DE TRABAJO

1. Análisis e intervención sistémica en la escuela, *Andolfi - Menghi*.
2. Terapia de divorcio y formas de nueva familia, *Bloch*.
3. Procesos emocionales dentro de instituciones, *Bowen*.
4. Interacción entre familia y sistema escolar en el origen de la psicopatología infantil, *Caille*.
5. ¿Es el entrenamiento psicoterapéutico necesario para los trabajadores comunitarios? *Cancrini*.
6. Familia e institución, *Elkaim*.
7. Terapia familiar en un Centro Comunitario de Salud Mental, *Framo J.*
8. El contrato terapéutico: dónde y cuándo intervenir, *Laperriere*.
9. La participación de los chicos en la terapia familiar, *Minuchin*.
10. Conducta sexual como comunicación, *Pasini*.
11. Un acercamiento relacional en psiquiatría infantil: un modelo de intervención en un servicio de pacientes externos, *Saccu - Nicolo*.
12. El uso de equipo audiovisual en el

estudio de transacciones de grupo, *Schefflen*.

13. El psicólogo como comunicante en una institución (grupo de investigación del Instituto de Psicología. Universidad Católica. Milán), *Selvini Palazzoli*.
14. Terapia familiar en un hospital de día, *Skinner*.
15. Terapia de familias psicóticas en un hospital estatal, *Vella*.
16. Implicancias sistémicas en el trabajo con familias en una agencia, *Walters*.
17. Cambio del tratamiento custodial de un hospital a un tratamiento activo, operación con enfoque comunitario, *Zwerling*.

PANEL

Diversas experiencias de la intervención comunitaria.

PARTICIPANTES

Caille, Cancrini, Elkaim, Saccu, Zwerling.

Intervalo.

SEMINARIOS

1. Sistemas de trabajo y sistemas de familia: conceptualizando una interrelación, *Bloch*.
2. Una intervención relacional en el sistema escolar, *Cancrini*.
3. Sistema familiar y sistema social: una intervención en un ghetto de Bruselas, *Elkaim*.
4. Intervención de la crisis como una alternativa de la hospitalización de chicos, *Saccu - Nicolo*.
5. Modelos relacionales en macrosistemas: evaluación de pautas redundantes, *Selvini Palazzoli*.
6. Servicios sociales comunitarios en el área urbana, *Zwerling*.

Sábado 24 de junio.

ENTRENAMIENTO EN TERAPIA FAMILIAR

PANEL

Entrenamiento en Terapia Familiar. Intervalo.

MESAS DE TRABAJO

1. Modelos terapéuticos: co-terapia y supervisión, *Andolfi - Menghi*.
2. El ciclo de la vida familiar y su aplicación por el terapeuta, *Bloch*.
3. Del entrenamiento en terapia familiar al análisis de contextos, *Boscolo - Cecchin*.
4. La familia del terapeuta de familia, *Bowen*.
5. El uso del único modelo y supervisión de vida en el entrenamiento de terapeuta familiares, *Caille*.
6. ¿Hay una diferencia básica entre psicoanálisis y terapia relacional?, *Cancrini*.
7. Supervisión en el proceso de entrenamiento, *Elkaim*.
8. Familia de origen y crecimiento del terapeuta de familia, *Framo J.*
9. Supervisión y terapia familiar, *Haley*.
10. Entrenamiento básico en terapia familiar, *Laperriere*.
11. Supervisión de vida, *Minuchin*.
12. Técnicas de acción en entrenamiento, *Saccu - Nicolo*.

13. Falta de comunicación verbal en un grupo de terapeutas de familia, *Schefflen*.

14. Entrenamiento en terapia familiar como una experiencia en crecimiento, *Skinner*.

15. Problemas en el entrenamiento de terapeutas de familia: ¿crecimiento o estrategias?, *Vella*.

16. Entrenamiento para profesionales, *Walters*.

17. Programas universitarios en terapia familiar, *Zwerling*.

Clausura de la sesión de la mañana.

SEMINARIOS

Entrenamiento en terapia familiar.

1. Sociedad Italiana de Terapia Familiar, *Andolfi*.
2. Instituto de Familia N. Ackerman. Nueva York, *Bloch*.
3. Centro Familiar Georgetown, *Bowen*.
4. Instituto de Terapia Familiar, *Haley*.
5. Clínica de Orientación Infantil. Filadelfia, *Minuchin*.
6. Colegio Médico Hahemann, *Zwerling*.

Intervalo.

Discusión en sesión plenaria.

Consideraciones finales del Congreso.

Segundas jornadas de terapias familiares
Lyon, Francia - 18, 19, 20 de mayo de 1978

Las segundas jornadas de Terapias Familiares se llevaron a cabo en Lyon Villeurbanne, Facultad de la Doua, los días 18, 19 y 20 de mayo de 1978.

Reunieron más de 300 participantes venidos de países de Europa. Por primera vez se encontraron reunidos trabajadores sociales (enfermeras psiquiátricas, asistentes sociales, educadores), psicólogos, psiquiatras, directores de hospitales, en torno de una jornada de presentación de las teorías de la comunicación de la escuela de Palo Alto representada por Paul Watzlawick ("una lógica de la comunicación", "cambios y paradojas", "la realidad de la realidad", Ediciones du Seuil).

La segunda jornada estuvo consagrada a una decena de grupos de trabajo en los cuales los animadores de los horizontes más diversos (belgas, franceses, noruegos, suizos, yugoeslavos) hicieron percibir las violencias de las interacciones en el seno de los grupos familiares, los métodos de desbloqueo y de delimitación de las resistencias en la conducta. El trabajo en general con el grupo familiar. Y sobre las familias simuladas y con la ayuda de técnicas de video.

La última semijornada estuvo destinada a la concreción de las necesidades y proyectos elaborados con las prácticas frecuentemente aisladas hasta el momento. Ella dio por resultado la formación de un comité y la decisión de publicar un boletín que facilite el conocimiento de los lugares de práctica y de formación en terapias familiares, que haga conocer mejor las tra-

ducciones de los artículos principales que permita considerar la preparación, permitiendo así el desarrollo de supervisiones.

La relación de las diferentes técnicas de terapias familiares con las ciencias fundamentales no está olvidado y especialmente el vínculo con la dinámica de sistemas. Esta orientación, poco difundida en Francia, pasa lista en efecto a los conceptos nacidos de los análisis de los procesos de interacciones en los grupos. La evolución se hace rápidamente después de la identificación del enfermo con su enfermedad, por el reconocimiento de la pareja madre-niño, hacia la consideración de una intercomunicación que estructura a los individuos.

Las consideraciones muy pragmáticas de la escuela allende el Atlántico están sobre todo centradas en "aquí y ahora". Ellas desplazan el interés del "porqué" al "qué hacer". Como todas las ideas nuevas, su deformación y su anulación por el fenómeno de moda corre el riesgo de conducir a desarrollos anárquicos, si no se tiene cuidado de crear lugares de formación que ofrezcan garantías; dando al entrenamiento de grupos simulados, luego a las familias reales, toda su primacía sobre los aportes libresco. Esta restauración de la "forma" después de decenios de psicoterapias centradas mucho más sobre los contenidos, se encuentra a menudo refutada en nombre de un comportamiento caricaturesco. De hecho, como todo trabajo psicoterapéutico que involucra a la persona en su integridad, el trabajo en

terapias familiares no puede ser realizado sin un compromiso personal a la vez simple y abierto, tomando en cuenta el grupo familiar y no sólo al "paciente designado", yendo hacia un desbloqueo de situaciones asilares. No obstante, debe adquirir una técnica segura, al mismo tiempo que se desarrolla el trabajo experimental si el terapeuta no quiere verse él mismo anquilado y anulado en sus funciones terapéuticas por las fuerzas homeostáticas de la familia.

Dr. Yves Colas
Comité de Organización

COMUNICACIONES

1. La formación en terapias familiares, *Joseph Duss Von Werdt* (Zurich).
2. Intervenciones de tipo familiar con fin preventivo, *Marceline Elod, M. H. Frankhauser* (Lausanne).
3. Qué llega a ser la relación familiar-terapeuta después de la intervención familiar, *Elvira Pancheri, J. L. Ruiz de Munain* (Prilly-Lausanne).
4. Terapias individuales y terapias familiares, *Jacques Rudrauf, Guy Ausloos*.
5. La evolución conceptual sistémica en el desarrollo y tratamiento del alcoholismo, *Branko Gacic* (Béograd).

MESAS DE TRABAJO

- A. Evolución y cambio. Trabajo por medio de una escultura evolutiva, *Guy Ausloos* (Génova).
- B. La primera entrevista en terapia familiar, *Jacques Beaujean* (Lieja).
- C. Cómo se trabaja con la familia (la exploración de las fronteras, de las estructuras y de los mitos por la "escultura familiar", *Bella Borwick* (Bruselas).
- D. Psicoterapia del psicótico y de su familia. El proceso terapéutico en el marco de la teoría de los sistemas, *Philippe Caille* (Oslo).
- E. Resistencias al cambio en terapias familiares (resistencias hacia la terapia; a la interacción en el sistema; específicas que se reencuentran en las familias, del terapeuta), *Siegi Hirsch* (Bruselas - Vaucresson).
- F. Una aproximación práctica de la familia como sistema en una consulta médico-psicológica, *Evelyn Le-maire* (Versailles).
- G. La terapia familiar. ¿Por qué hacerla? ¿Cómo hacerla?, *Reynaldo Perrone* (St-Etienne).
- H. Oír al otro y oír a los otros. Desfocalización de la escucha psicoterapéutica: del individuo al grupo familiar, *Jacques Rudrauf* (París).
- I. El trabajador social y la aproximación al sistema familiar del adolescente, *Pierre Segond* (Vaucresson).

Jornadas del Ateneo de Psicología Social y Medicina Psicosomática RELACIONES FAMILIARES

Entre los días 18 y 19 de agosto se desarrollaron unas Jornadas especialmente dedicadas a los psicodinamismos, diagnóstico y tratamiento de las relaciones familiares. Fueron organizadas por el Ateneo de Psicología Social y Medicina Psicosomática que preside el Prof. Dr. Mario Cukierman y cuya Secretaría General es la licenciada Elisa Cervi.

Tuvo el apoyo de distintos profesores de la Universidad de Buenos Aires y de psicoanalistas con reconocida trayectoria en su especialidad.

A continuación reproducimos el programa.

TEMARIO

1. PSICODINAMISMOS DE LAS RELACIONES FAMILIARES.
2. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS RELACIONES FAMILIARES.

PROGRAMA

Día 18. Acto inaugural.
Palabras de los Profesores Dres. Luis Munist y Alfredo Givré.
Relato oficial TEMA I.
Prof. Dr. Mario Cukierman.
"Francisco", Película realizada por el Dr. M. Materazzi con técnica Grupal Programada.

PANEL

Relatores:

Prof. Dr. Alberto Chattás
Prof. Dr. Miguel Materazzi
Prof. Dr. Osvaldo Tieghi
Lic. Hugo Svetlitz
Lic. Celia Elzufan
Escritora María Dubeck
Lic. Ana Quiroga
Coordinador: Lic. Elisa Cervi

Día 19. TEMA II

Relato oficial. Prof. Dr. Arnaldo Rasovsky.

PANEL

Relatores:

Lic. Elizabeth de Suzuki
Dr. Alfredo Canevaro
Dr. Hugo Bab Quintela
Lic. Juan C. Nocetti
Dr. Díaz Usandivaras
Lic. Gisella Ahlin
Lic. Graciela de Luxardo

Coordinador: Dr. Guillermo Kornblit

TEMAS LIBRES

La demencia. Su incidencia en un lugar de internación psiquiátrica, *Carlos Gary, Guillermo Bauducco.*

Abordaje Familiar en el diagnóstico de niños, *Emilia E. Salgado.*

Caracterización de la familia abandonada: consecuencias, *S. Pérez Alvarez.*

Orientación del adolescente en la Escuela Nueva. Problemas de conducta y situación familiar, *Elvira Marta Pujo.*

La familia masónica, *Cleto Santacolona.*

Tratamiento familiar y psicopatología adolescente, *Julia E. Duplessis.*

Tratamiento de una familia con utilización de técnicas dramáticas, *Graciela de Benghiat.*

Terapia breve en la rehabilitación de pacientes coronarios, *Celia Elzufan, Mirta de Perel, Claudia Matusevich, María de Winograd.*

Una aproximación a la psoriasis, *Estela Soolalian, Nilda Neves, Mario Daian, Carlos Méndez.*

Complementación clínica, *María Elena Frene, Cecilia de Carnaghi, María Magdalena Pecastaing, Nilda Neves, Carlos Méndez.*

A. el mellizo que no tenía lugar, *María M. Pecastaing.*

El paciente identificado y la detección de patologías de distinto grado en otros miembros de la familia a través de las entrevistas conjuntas, *Anny Speier, Norma Gari, Nélida Saporiti.*

Primeras jornadas del CIEP (Centro de Investigaciones en Psicopatología), ABORDAJE DE LA PSICOSIS

Días 1, 2, y 3 de setiembre

Estas Jornadas, organizadas por los Coordinadores del CIEP, doctores Jorge Presta, Carlos Lorusso y Jorge Kosin, versaron sobre Abordaje psicoterapéutico, familiar, institucional y biológico de las psicosis.

La mesa redonda al abordaje familiar estuvo constituida por los doctores Edgardo Rolla, Sergio Larriera, Alfredo Canevaro, Isidoro Guzmán y los licenciados Juan C. Nocetti y V. Topf.

MESA

Fundamentos Estructurales de la Familia, *Dr. Edgardo Rolla,*
En busca del orden perdido, *Juan Carlos Nocetti,*
Un modelo de ficha clínica familiar,

Pata negra en adultos y niños. Un test específico familiar y evolutivo. Diapositivas, *Eva B. de Orlandi.*

Psicodinámica de un grupo familiar a través de la reeducación de una niña con síndrome de Down, *Liliana Botaya.*

Alfredo Canevaro,
Esquema psicoanalítico para la comprensión de la terapia familiar, *Isidoro Gurman,*

Familia de un suicida, *Lic. José Tops,*
Grupo de contención en psicosis agudas, *Dr. Sergio Larriera.*

Las siguientes dos mesas fueron coordinadas por el Dr. Jorge Cosin

Trabajos libres:

Psicosis, perversión, neurosis; tres organizaciones familiares contrastantes, *Lic. Nocetti, Lic. Marta Mor Roig, Lic. Suide.*

Comunicación preliminar sobre la incidencia de la estructura familiar en la evolución de un paciente discapacitado, *Lic. Barilari, Lic. Molina, Lic. Rosemberg*

Seminario sobre familia y psicosis

La Clínica, Gradiva organizó durante los meses de setiembre y octubre un Seminario constituido por cinco conferencias y una mesa redonda.

Los oradores y los temas fueron: Transferencia y contratransferencia en la terapia familiar, *Dr. Alfredo Canevaro,*
Análisis estructural de las relaciones familiares, *Lic. Juan Carlos Nocetti,*

El papel de la familia en la estructuración de la personalidad, *Lic. Frida Riterman,*

Historial de un tratamiento familiar. La elaboración de la psicosis en el marco familiar, *Dr. Juan A Yaria.*

Estudio clínico de la terapia familiar, *Dr. Miguel A. Bianucci.*

Mesa redonda de todos los conferencistas.

Creación de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar

El 16 de junio de 1978 se constituyó en Buenos Aires una asociación científica que se propone atender a la creciente necesidad de estudio, formación e investigación en esta área de la psicopatología y de la terapéutica. Al mismo tiempo, su concreción da cuenta del considerable desarrollo en nuestro medio de la terapia familiar tanto en el nivel institucional como en la práctica privada.

Para comunicar fehacientemente los propósitos que dieron lugar a su nacimiento, haremos referencia a los enunciados más significativos del *Acta de fundación*, suscripta por los socios fundadores que conforman la primera Comisión Directiva:

"Art. 1º: Con el nombre de Sociedad Argentina de Terapia Familiar créase una entidad social de carácter civil científico cuyos objetivos lo constituyen el estudio, la docencia y la investigación sobre la estructura, patología y terapéutica del grupo familiar, poniéndose especial énfasis en la organización de las relaciones familiares, en los vínculos de alianza, filiación y consanguinidad en una o varias generaciones.

"Art. 2º: Tendrá su domicilio en la Capital Federal, pudiendo establecer filiales y designar representantes en el interior y exterior de la República."

Para concretar sus fines, en el Artículo 3º se propone principalmente:

"Fomentar el espíritu de asociación entre sus miembros, ofreciéndoles un lugar de reunión para tratar toda clase de intereses lícitos derivados de su desenvolvimiento científico.

"Promover por todos los medios a su alcance el mayor perfeccionamiento y desarrollo de la especialidad.

"Adherir a otras instituciones o confederaciones cuyos fines no sean opuestos a los de esta Asociación, aceptando al efecto los Estatutos y reglamentaciones correspondientes.

"La creación de Unidades de Investigación, previendo un plan científico anual de la Asociación de Jornadas, Simposios, Congresos Nacionales e Internacionales. La creación de un departamento de Publicaciones y Biblioteca. Creación de un Comité Científico Honorario Nacional e Internacional, que contribuya con su asesoramiento para promover el desarrollo científico de la Sociedad."

La dirección y administración de esta Asociación estará a cargo de una primera Comisión Directiva que durará en sus funciones cuatro años y será reemplazada al vencimiento de su plazo de ejercicio por la que deberá elegirse a través de Asamblea General. Fueron designados:

Creación de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar

Presidente: Dr. Alfredo Canevaro
Vicepresidente 1º: Dr. Jorge García Badaracco
Vicepresidente 2º: Dr. Oscar Czertok
Secretario: Dr. Juan Alberto Yaría
Prosecretario: Lic. Stella Maris Molina
Tesorero: Dra. Ana María Zacco
Protesorero: Dr. Jorge Natalio Weil
Vocales: Dr. Jorge Presta
Lic. Juan Carlos Nocetti
Dr. Luis Albornoz
Dr. Jorge R. Alonso
Dr. Rafael Skiadaressis
Dr. Norberto Proverbio
Dr. Jorge Omar Cosin
Dr. Alejandro Roberto Sicardi
Dr. Miguel Angel Blanucci
Dr. Carlos Alberto Klighmann
Dr. Walter Martin de Oro

Al mismo tiempo se formaron las siguientes comisiones de trabajo con carácter provisorio:

- Comisión de redacción de Estatutos
- Comisión de elaboración del Plan Científico de la Institución
- Comisión de Relaciones Interinstitucionales
- Comisión de Organización de Jornadas, Simposios y Congresos nacionales e Internacionales.
- Comisión de Docencia e Investigación

En los próximos números de la Revista informaremos sobre los Estatutos que regirán la Asociación, el programa de actividades para el año 1979, la organización y la forma de participación.

Deseamos para esta Asociación Científica que la estructura y las reglas que se dé permitan el crecimiento y la creatividad en su seno.

Stella Maris Molina

Premio APTA - RIZZUTTO 1978

para la mejor revista científica argentina de 1977 otorgado a

Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina

A raíz de haberse otorgado tan importante galardón científico a una revista señera en nuestro país, queremos rendirle un cálido homenaje, extensivo a su *alma mater*, el doctor Guillermo Vidal, cuyo trabajo perseverante y entusiasta no tiene parangón en nuestra disciplina.

Acta salió a la luz en octubre de 1954. Al principio fue Neuro-psiquiátrica. En 1964 se extendió al campo de toda América latina. Hoy es, probablemente, la más importante revista de habla hispánica en su especialidad.

Durante casi un cuarto de siglo, **Acta** difundió lo más ponderable de nuestro pensamiento psiquiátrico, fomentó la investigación científica y puso en contacto a los psiquiatras y psicólogos clínicos de toda América Latina. Su criterio amplio, su política liberal, su seriedad editorial, permitieron que en sus páginas colaboraran los investigadores más destacados de todas las tendencias doctrinales que hoy recorren los dominios de la psiquiatría y ciencias del hombre.

De aparición trimestral—en tiempos mejores fue bimestral—la revista aparece regularmente en marzo, junio, setiembre y diciembre. Tirada actual: 4.000 ejemplares.

A partir de 1979, **Acta** publicará, además, dos suplementos anuales con investigaciones originales, y, en conjunción con el Centro Editor Argentino, una colección de *Cuadernos Temáticos*, serie de monografías integrada con apuntes de clase, trabajos ya publicados en revistas hispanoamericanas, informes de la OMS, etcétera.

Capita spesso di sentire l'esigenza di un incontro e di uno scambio tra operatori sociali, per formulare insieme proposte su metodi e interventi, in un lavoro in cui ci si sente sovente in difficoltà. L'incontro diventa allora un momento rassicurante perché evidenzia che conflittualità, contraddizioni e desiderio di cambiamento sono presenti in ciascuno di noi. Attraverso riflessioni, analisi e confronti si scoprono elementi comuni, si individuano differenze e si formulano alternative; così la 'crisi' dell'operatore sociale diventa momento propulsivo di crescita e di ricerca comune. La storia del nostro gruppo non appare dissimile da quella di altri gruppi nati in seguito al rifiuto di un'operatività troppo spesso disancorata dai bisogni dell'utente. Per molti di noi, dieci anni di preparazione medico-psichiatrica, sono serviti a riflettere sui limiti di una formazione teorica basata sulla ricerca delle cause di comportamenti etichettati grossolanamente o aprioristicamente 'patologici' e sulla risposta magica dell'esperto. Il rifiuto di questo modello ci ha motivati a percorrere una strada diversa in cui il disturbo mentale non fosse più considerato come dato individuale, ma piuttosto come disordine comunicativo e l'intervento diventasse, più che monopolio del tecnico, momento di confronto, partecipazione e crescita di un gruppo in una data situazione. Nella prospettiva di una ridefinizione del rapporto operatore-utente, cioè del rapporto stesso tra salute e malattia, le teorie sistemiche, pur nei limiti delle loro attuali elaborazioni teoriche e applicazioni pratiche, ci sono apparse spunto di ricerca incoraggiante. Se è vero che ogni organismo è un sistema, ciò è un ordine dinamico di parti e processi tra cui si esercitano interazioni reciproche, allo stesso modo si può ipotizzare che la famiglia, come ogni altro gruppo sociale, sia a sua volta un sistema costituito da molteplici sottosistemi in interazione dinamica. Esplorare le relazioni interpersonali, il contesto e le regole del gruppo in cui ciascuno è inserito diventa così un modo per guardare la realtà di comportamenti altrimenti definiti patologici, in una luce completamente diversa e per stimolare la capacità di ogni a riappropriarsi della propria realtà. Allo stesso tempo rappresenta un modo per ridimensionare l'operato del tecnico che non è più competente in quanto sa, ma perché partecipa a un processo di ricerca comune. Sarebbe tuttavia molto pericoloso se una metodologia di analisi e di intervento nello specifico diventasse una filosofia di vita o finisse per alimentare illusioni di alternative magiche, false e rapide. Da tali riflessioni nasce sia il senso del limite che la volontà di approfondire, stabilendo collegamenti interdisciplinari con operatori sociali anche di altri paesi. Dal bisogno di dare una risposta più matura e approfondita al nostro mandato di operatori si è costituita la Società Italiana di Terapia Familiare con l'obiettivo di studiare le relazioni familiari e dei sistemi ad essa correlati a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi. Dopo esserci cimentati in anni di ricerca operativa sul campo (intervento nelle situazioni e nei contesti in cui il disturbo prendeva forma, coinvolgendo di volta in volta scuola, famiglia, istituzioni, comunità) abbiamo sentito la necessità di dar vita a programmi di formazione aperti a operatori sociali provenienti da diverse parti d'Italia. Sono nati così training per operatori di Ospedali Psichiatrici, Centri di Igiene Mentale, della Scuola, di strutture assistenziali territoriali, corsi e seminari interdisciplinari. La partecipazione è stata massiccia, prova che una pseudoformazione tecnico-professionale spesso mascherata di generico

TERAPIA FAMILIARE

Rivista semestrale

Organo ufficiale della Società Italiana di Terapia Familiare (S.I.T.F.)

Direttore Responsabile: Maurizio Andolfi

Comitato Direttivo:

P. Menghi - A. Nicolò - C. Saccu

Comitato di redazioni nazionale:

C. Angelo (Bolzano), J. Anzilotti (Firenze), A. Berardi (Latina), M. Bertini (Roma), R. De Bernart (Firenze), T. Galbusera Colombo (Milano), K. Giacometti (Firenze), S. Montagano (Firenze), P. Pepe (Roma), R. Piperno (Roma), C. Pontalti (Roma), G. Sgritta (Roma), S. Soccorsi (L'Aquila), C. Truppi (L'Aquila), M. Vicini (Milano).

Comitato di redazione internazionale:

H. Aponte (Filadelfia), D. Berenson (New York), D. Bloch (New York), I. Boszormenyi-Nagy (Filadelfia), M. Bowen (Washington), M. Elkaim (Bruxelles), J. Framo (Filadelfia), H. Holm (Norway), K. La Perrière (New York), S. Minuchin (Filadelfia), M. Nevejan (Utrecht), P. Papp (New York), A. Schefflen (New York), O. Silverstein (New York), H. Sterlin (Heidelberg), C. Whitaker (Madison), I. Zwerling (Filadelfia).

Segretarie di redazione:

E. Bentivegna, G. Montinari, P. Valentini.

Redazione:

Via Reno, 30 - 00198 Roma - Tel. 86.42.61

La rivista esce in collaborazione con le riviste "Family Process", pubblicata dal Nathan W. Ackerman Family Institute di New York e dal Mental Research Institute di Palo Alto; *Journal of Marriage and Family Counseling*, pubblicato dall'American Association of Marriage and Family Counselors; *International Journal of Family Counseling*, pubblicato dalla National Alliance for Family Life.

Abbonamenti 1977

Italia Ordinario L. 11.000. Enti L. 20.000

Esteri: L. 15.000 o doll. 15

Sostenitore: L. 50.000

Animate arretrate: L. 15.000

Un numero separato: L. 6.500

I versamenti per gli abbonamenti vanno inviati a mezzo modulo di c/c postale N. 23889009 intestato a Rivista "Terapia Familiare" della C.T.F. s.r.l. via Reno 30, 00198, Roma.

Autorizzazione del Tribunale di Reggio Calabria n. 2467 di Reg. S. P. in data 2 marzo 1977.

Tipografia Visigalli-Pasetti - Via di Villa Pamphili 33, Roma.

ideologismo o peggio, ispirata ai principi di un intervento custodialistico, non reprime né la coscienza di un' inadeguata preparazione metodologica e terapeutica di base, né la volontà di colmare tale carenza nella prassi. Obiettivi principali del nostro lavoro sono stati la ricerca di un linguaggio comune e l'analisi sistemica delle modalità d'intervento in situazioni specifiche. Negli ultimi tre anni si sono coagulate intorno a queste prospettive le energie e le esperienze di individui e di gruppi operativi interessati a definire la propria identità e il proprio ruolo non più nei termini di una vaga quanto mistificante neutralità tecnica, ma di una concreta saldatura tra individuale, sociale e politico. Rivista è stata la logica. L'idea di dar vita ad una conseguenza del bisogno sentito da molti di un più vasto scambio di esperienze e di riflessioni finalizzate verso una continua e qualificante elaborazione critica.

Consapevoli dei limiti di una Rivista di "Terapia Familiare" abbiamo pensato fosse meglio definirci in tal senso piuttosto che cadere in facili, quanto poco significative, etichette omnicomprensive. Il nome stesso della rivista rispecchia la nostra scelta, anche se il contenuto, lungi dall'essere riduttivo, testimonia la volontà di un approccio relazionale applicabile in sistemi sociali più ampi della famiglia (istituzione, gruppi sociali, quartiere ecc.).

Partendo dall'analisi strutturale dello specifico con

cui l'operatore si confronta, e a cui deve dare una risposta concreta, si estende all'analisi del contesto socio-politico e della complessa realtà storica e culturale in cui ciascuno di noi vive ed opera. I collaboratori della Rivista, condividendo la nostra ottica, cioè un impegno pragmatico nel sociale, contribuiscono a costruire giorno per giorno la redazione di una rivista che lavora.

Journal of Marriage and Family Counseling

"In its fourth year of publication, the *Journal of Marriage and Family Counseling* shows a healthy trend of integration among the various clinical approaches to relational problems. I welcome the holistic attitude of the editorial policy which should lead to a better definition of priorities and connections in a growing and promising field."

Ivan Boszormenyi-Nagy, M.D., *Clinical Professor of Psychiatry, Hahnemann Medical College and Director of Family Psychiatry, Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute*

"The recent launching of the professional journal, *Journal of Marriage and Family Counseling*, by AAMFC reflects positively on the growing stature of this national organization and the field. Already, this journal is publishing some of the most significant articles on the cutting edge of the marriage and family counseling field. In addition the articles are helping to bridge the traditional gap that typically exists between theory, research and clinical practice. Congratulations on a great beginning!"

David H. Olson, Ph.D., *Professor, Family Social Science, University of Minnesota*



A publication of the American Association of Marriage and Family Counselors, the *Journal of Marriage and Family Counseling* is published to advance the professional understanding of marriage and family behavior, and to improve the psychotherapeutic treatment of marital and family dysfunction.

Florence W. Kaslow, Ph.D., *Editor*

ORDER FORM

Please enter my subscription to the *Journal of Marriage and Family Counseling*.

☐ INDIVIDUAL - one year/\$15

☐ Check Enclosed

☐ INSTITUTIONAL (libraries and multi-reader establishments) - one year/\$25

☐ Please bill me for this order.

NAME _____
Last First Middle

(OR INSTITUTION) _____

STREET _____

CITY _____ STATE _____ ZIP _____

MAIL TO: JMFC BUSINESS OFFICE, 225 YALE AVENUE, CLAREMONT CA 91711 USA

Family Process

A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF FAMILY STUDY RESEARCH AND TREATMENT

EDITOR/Donald A. Bloch, *New York, N.Y.*

EDITORIAL BOARD/Lyman C. Wynne, *CHRM., Rochester, N.Y.* Edgar H. Auerswald, *Mau, Hawaii.* Michael Goldstein, *Los Angeles, Calif.* Salvador Minuchin, *Philadelphia, Pa.* Jules Riskin, *Palo Alto, Calif.* Arthur G. Rosenthal, *Cambridge, Mass.* Margaret T. Singer, *Berkeley, Calif.* Carl Whitaker, *Madison, Wis.*

FAMILY PROCESS is the definitive Journal in the field of family psychotherapy, study, and research, published quarterly. Original articles report on the theory and practice of family treatment as well as on related research. Additionally, regular departments of FAMILY PROCESS are devoted to Books, Abstracts of relevant literature, Training Announcements, and news of Activities in the family field.

Among the many contributors to FAMILY PROCESS in recent years have been Nathan W. Ackerman, Edgar H. Auerswald, John E. Bell, Nathan B. Epstein, Andrew Ferber, Antonio J. Ferreira, James Framo, Jay Haley, Don D. Jackson, Walter Kempler, Frank S. Pittman, Ross V. Speck, and Gerald Zuk.

FAMILY PROCESS

149 East 78th Street
New York, N.Y. 10021

DATE _____

Gentlemen:

Please enter my subscription for FAMILY PROCESS

INDIVIDUAL SUBSCRIBERS

(paid by personal check)

☐ \$12.00 per year United States

☐ \$13.00 per year Canada & Latin America

☐ \$14.00 per year All other countries

INSTITUTIONAL SUBSCRIBERS

☐ \$20.00 U. S.

☐ \$21.00 Canada & Latin America

☐ \$22.00 All other countries

NAME _____

ADDRESS _____

CITY _____ STATE/COUNTRY _____ ZIP _____

All subscriptions are entered on a calendar year basis

CLINICA
GRADIVA



COORDINADORES:

Dr. MIGUEL A. BIANUCCI

Dr. JUAN A. YARIA

- TRATAMIENTO PSIQUIATRICO INTEGRAL
- INTERNACION
- CLINICA DE DIA
- CONSULTORIOS EXTERNOS
- URGENCIAS DOMICILIARIAS

Rivadavia 5840

Capital

T.E.: 631-7581/632-5565

Radiomensaje: 46-5329/3701 • 45-9392/9549 • Código 4777

centro de investigaciones en psicopatología

Ciep

• INTERNACION

• HOSPITAL DE DIA

• CONSULTORIOS EXTERNOS

Coordinadores:

Jorge Cosín, Carlos Lorusso y Jorge Presta

FRANKLIN D. ROOSEVELT 2296 esq. VUELTA DE OBLIGADO

Tel. 781-6929 (por radiollamado: 32-6383/84/85/86/87)

Códigos: 6800-6801 (especificando nombre, tel. y/o dirección)
1428 Buenos Aires - República Argentina

SERVICIO DE PSICOPATOLOGIA DEL "HOSPITAL ITALIANO"

Integrado al Dto. de Medicina

Guardia médica psiquiátrica activa permanente: de un médico de planta y un médico residente

- **Consultorio Externo:** Sectores de Adolescentes, Adultos y Personas de Edad.
- **Internación:** Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Recreación, Integración Corporal.
- **Hospital de Día:** Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Recreación, Integración Corporal, Psicodrama.

Jefa int.: Prof. Dra. Lía Ricón de Tenconi

Gascón 450

Tel. 811 - 4149

1968 - 1978

CLINICA PSIQUIATRICA

(Comunidad Terapéutica)

DIRECCION MEDICA Prof. Dr. Jorge E. García Badaracco
Dr. Norberto J. Proverbio
Dr. Alfredo A. Canevaro

Pone a disposición de los colegas una larga trayectoria de experiencia institucional privada en los trastornos psíquicos graves que requieran Internación total o parcial, incluyendo los más modernos recursos terapéuticos, desde los recientes avances de la investigación biológica hasta la experiencia clínica psicoterapéutica individual, grupal, familiar e institucional.

O'Higgins 2328/48

1428 - CAPITAL FEDERAL

Radiollamada Código 9807

Teléfonos: 781 - 1306/0557/7825

31 - 0056/59 y 32 - 6383/87

COMUNIDAD TERAPEUTICA DIURNA

DIRECCION MEDICA Prof. Dr. Jorge E. García Badaracco
Dr. Norberto J. Proverbio
Dr. Alfredo A. Canevaro

Ofrece a los colegas una nueva modalidad asistencial para aquellas personas que psicológicamente no hayan podido aún reintegrarse en forma plena a la sociedad.

Gorostiaga 1731

1426 - CAPITAL FEDERAL

TELEFONO 773 - 1308

RADIOLLAMADOS:

32 - 6383 / 87

31 - 0056 / 59

Código 9910

FE DE ERRATAS DEL N° 1 DE TERAPIA FAMILIAR

pag 79: El V Simposium sobre Psicoterapia de la Pareja y de la Familia fue realizado entre el 26 y el 29 de setiembre de 1977 en Zurich, Suiza.

pág 39: El trabajo del Dr. Carlos Sluzki fue publicado con su permiso. Antes había sido publicado en Soc. Sci. & Med. vol. 8 págs. 483 to 485. Pergamon Press 1974. Printed in Great Britain.

Indicaciones sobre los trabajos que se envíen como colaboraciones

Aquellos trabajos originales o comunicaciones sobre Congresos, conferencias y seminarios que traten el tema específico de la terapia familiar, deben ser enviados a:

Alfredo A. Canevaro, Gorostiaga 1731 - Cap. Federal (1426) - Rep. Argentina.

Las colaboraciones deberán ser originales y en dos (2) copias mecanografiadas a doble espacio, con un resumen final.

La propiedad literaria de los artículos enviados pertenece a la revista y ésta se reserva todos los derechos de reproducción y publicación.

FICHA DE SUSCRIPCION

Sres. de Terapia Familiar:

Solicito ser suscripto por el término de un año a vuestra revista para lo que acompaño los siguientes datos:

Nombre y Apellido

Dirección

Código Postal Localidad

Profesión

Adjunto Cheque o Giro a nombre de: Editorial ACE S.R.L., No a la orden, por pesos

Gorostiaga 1731, Capital Federal (1426), R. Argentina

PRECIO DE LA SUSCRIPCION ANUAL

Argentina \$ 20.000
Exterior u\$s. 22

FICHA DE SUSCRIPCION

Sres. de Terapia Familiar:

Solicito ser suscripto por el término de un año a vuestra revista para lo que acompaño los siguientes datos:

Nombre y Apellido

Dirección

Código Postal Localidad

Profesión

Adjunto Cheque o Giro a nombre de: Editorial ACE S.R.L., No a la orden, por pesos

Gorostiaga 1731, Capital Federal (1426), R. Argentina

PRECIO DE LA SUSCRIPCION ANUAL

Argentina \$ 20.000
Exterior u\$s. 22